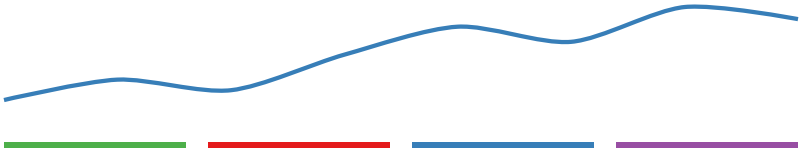
DOCUMENTO ESTATÍSTICO · PESQUISA EM SAÚDE PÚBLICA



Gestão Hospitalar no SUS

O Impacto do Modelo Institucional e Organizacional na Prestação de Serviços

Análise Exploratória e Estimação do Painel de Hospitais SUS/SP
Período: 2015 a 2025

Corpo Técnico e de Pesquisa

Priscilla Reinisch Perdicaris
Pesquisadora Principal
LinkedIn · Currículo Lattes

João Eduardo Pastori Garcia
Estatístico Responsável
LinkedIn · Currículo Lattes

Alberto Tomasi Diniz Tiefensee
Revisor e Responsável pelo Banco de Dados

São Paulo – SP
Setembro de 2026

Sumário

O painel de dados e como ler este documento **3**
O painel . . . 3
A escada de evidência . . . 4
Guia rápido de leitura dos gráficos . . . 5

Sumário executivo **6**

1 A rede inteira: o retrato dos 275 hospitais e por que nem todos fazem a mesma coisa **10**
1.1 Qualidade dos registros e cuidados adotados . . . 15
1.2 Como se distribuem os indicadores, e que formato cada um tem . . . 17
1.3 O perfil de cada categoria de gestão . . . 24
1.4 Complexidade e porte: os grandes divisores da rede . . . 33
1.5 O que anda junto com o quê: correlações e origem da variação . . . 42
1.6 A evolução no tempo e a marca da pandemia . . . 46
1.7 A distância até a melhor prática na rede inteira . . . 54
1.8 O contraste entre as redes, indicador a indicador . . . 56
1.9 Hospitais que não são comparáveis entre si: o recorte de comparabilidade . . . 61
1.10 A segmentação captura gradiente estrutural real . . . 64
1.11 O que os estratos separam, e o que eles não separam . . . 64

2 A Tabela SUS Paulista: o que uma mudança de financiamento move, e o que ela não move **65**
2.1 O que fica desta avaliação . . . 69
2.2 Indicador a indicador: o volume, o faturamento, o perfil dos casos e a produtividade 71
2.3 Um recorte próprio: os filantrópicos e os universitários juntos . . . 77

3 Onde a comparação se sustenta: quatro modelos de gestão entre hospitais equivalentes **78**
3.1 O retrato do grupo E3, indicador a indicador . . . 84
3.2 Os resultados em E3 . . . 92
3.3 A taxa de ocupação de internação eram duas perguntas, não uma . . . 95
3.4 A distância até a melhor prática entre hospitais equivalentes . . . 102
3.5 As quatro redes dentro do grupo E3, lado a lado . . . 107
3.6 O que a segmentação acrescenta . . . 113
3.7 As conversões de gestão: o que foram, e por que não sustentam leitura causal . 114

4 Fase qualitativa: as perguntas que o dado não fecha, e a quem fazê-las **116**
4.1 Por que entrevistar, e o que a entrevista responde . . . 117
4.2 Apresentação e método . . . 117
4.3 Os quatro blocos da seleção . . . 119

5 Síntese e Conclusão geral **131**

6 Material de apoio **135**
A Os hospitais por trás de dois números da Seção 1.2 . . . 135
A.1 Os 35 hospitais que nunca registram alta complexidade . . . 135
A.2 A alta complexidade e o seu complemento, por porte . . . 136
A.3 Os 48 hospitais que nunca tiveram leito de UTI do SUS . . . 138
B Material de apoio da segmentação estrutural . . . 140
C Roteiro-base e módulos de entrevista da fase qualitativa . . . 155
C.1 Roteiro-base comum aos blocos de gestão (a, b, c e d) . . . 155
C.1.1 Governança e desenho institucional . . . 155
C.1.2 Autonomia de recursos humanos e compras . . . 155
C.1.3 Contrato de gestão e metas . . . 156
C.1.4 Relação com a Secretaria e financiamento . . . 156
C.1.5 Gestão de leitos e fluxo do paciente . . . 156
C.1.6 Resposta à pandemia (2020 e 2021) . . . 156
C.2 Módulos específicos por perfil . . . 157
C.2.1 Módulo A: conversores da Direta para OSS (bloco a) . . . 157
C.2.2 Módulo B: desviantes positivos (bloco b) . . . 158
C.2.3 Módulo C: desviantes negativos (bloco c) . . . 158
C.2.4 Módulo D: pares casados (bloco d, sugeridos) . . . 159
C.3 Logística e esforço . . . 159
D Como estimamos os efeitos: a fronteira de eficiência e os demais indicadores . . . 160
D.1 A fronteira de eficiência (DEA): a fórmula e como ela vira nota . . . 160
D.2 Os demais indicadores: molde por indicador e salvaguardas . . . 160
E Robustez e diagnóstico dos modelos . . . 162
F A sensibilidade do contraste de eficiência: um universo e cinco escolhas do que descontar . . . 164
G Método e ressalvas da Seção 2 . . . 167
G.1 Quem a tabela alcança, e contra quem a Seção 2 compara . . . 167
G.2 Por que a categoria universitária sai da avaliação . . . 167
G.3 O que sustenta cada número . . . 168
G.4 O que esta avaliação não consegue dizer . . . 168
G.5 O desenho de comparação, por extenso . . . 171

O painel de dados e como ler este documento

Antes de qualquer conclusão sobre o efeito do modelo de gestão, é preciso conhecer em detalhe o material com que trabalhamos.

O documento segue em seis seções. A **Seção 1** descreve a rede inteira e mostra por que nem todos os seus hospitais fazem a mesma coisa: como se distribuem os indicadores de desempenho entre os hospitais, quem são os hospitais de cada categoria de gestão, o que aconteceu nos anos da pandemia e onde estão os problemas de qualidade de registro que precisam de cuidado. A **Seção 2** avalia o que uma mudança recente de financiamento moveu, e o que ela não moveu; é a única seção que pergunta pelo efeito de uma política, e não pela diferença entre modelos de gestão. A **Seção 3** é o veredito comparativo, e o faz no único grupo em que os hospitais fazem a mesma coisa; é lá também que se examina o que os dados mostram nos quatro hospitais que trocaram a administração Direta pela gestão por OSS (Subseção 3.7). A **Seção 4** leva a campo as perguntas que o dado não fecha, a **Seção 5** reúne o que ficou de pé, e a **Seção 6** traz o material de apoio.

O painel

A base é o painel consolidado do projeto, com **275 hospitais acompanhados ano a ano de 2015 a 2025, totalizando 3.025 observações** (uma observação corresponde a um hospital em um ano). O painel é **balanceado**: todos os 275 hospitais aparecem nos 11 anos, sem buracos, o que permite comparar a evolução de cada um deles em bases iguais. Esse conjunto resulta de um funil documentado de seleção que partiu de 830 estabelecimentos da base bruta do SIH/SUS e reteve apenas hospitais com porte mínimo (mais de 50 leitos na mediana dos anos), produção contínua no período e classificação de complexidade disponível, excluindo ainda os hospitais de campanha da pandemia e, na exclusão por incomparabilidade estrutural, 25 hospitais de populações incomparáveis com o hospital geral (pediátricos e onco-pediátricos, crônicos e de reabilitação, e psiquiátricos).

Os cinco indicadores oficiais do estudo foram todos analisados, sempre nas versões que excluem as internações por COVID: taxa de mortalidade hospitalar, tempo médio de permanência, faturamento por saída, taxa de ocupação e produção ajustada por complexidade, esta última reportada em todo o documento como **fração de alta complexidade**. **Um deles foi desdobrado em dois**, e por isso o documento trabalha com seis: a **taxa de ocupação** entra separada em **taxa de ocupação de internação** e **taxa de ocupação de UTI**. O motivo é operacional. O SIH registra a permanência em UTI apartada da permanência em enfermaria, e as duas capacidades obedecem a lógicas de gestão distintas: leito de enfermaria se abre com equipe de plantão, leito de UTI exige habilitação, intensivista e equipamento. Somar os dois numa taxa única apagaria exatamente o contraste que a pesquisa procura, porque um hospital pode operar com enfermaria folgada e UTI lotada, situação corriqueira na rede e invisível num número só.

Na forma como aparecem neste documento, os seis são: **mortalidade geral** (proporção de internações que terminam em óbito); **tempo médio de permanência** (TMP, em dias); **faturamento por saída** (valor pago por internação encerrada, em reais); **fração de alta complexidade** (proporção das internações classificadas como de alta complexidade); e as duas medidas de uso de leito, a **taxa de ocupação de internação** e a **taxa de ocupação de UTI**, em escala percentual. A fase de estimação acrescenta a esses seis uma **sétima quantidade modelada**, a **produção anual** (o número de saídas hospitalares), cujo formato está descrito na Subseção 1.2.2.4; é por isso que as tabelas de resultado daquela fase trazem sete linhas, e não seis.

Uma decisão sobre as duas medidas de leito precisa ficar dita, e ela vale para todas as taxas deste documento: o denominador é o *leito SUS* cadastrado, e não o total de leitos do hospital. A razão é de coerência entre numerador e denominador. O numerador vem do SIH, que registra apenas internações do SUS; dividir diárias do SUS pelo total de leitos, incluindo os que atendem convênio e particular, misturaria duas populações e subestimaria o uso justamente nos hospitais com maior atendimento não SUS. Medida assim, a taxa responde à pergunta do estudo: *quanto da capacidade SUS o hospital usou para atender demanda SUS.* A consequência que

o leitor precisa reter é a contrapartida disso. Em hospital com parcela grande de leitos fora do SUS, esta taxa descreve a operação SUS daquele hospital, e não a ocupação total do prédio. A escolha não é neutra, e o próprio painel mostra o quanto. Para comparar hospital com hospital, os 275 são separados adiante em três grupos pela estrutura que têm instalada, e esses grupos aparecem no documento inteiro pelos nomes **E1** (os que não têm UTI do SUS), **E2** (os que têm UTI e escore Barcelona abaixo de 4) e **E3** (os que têm UTI e escore Barcelona 4 ou mais); o corte está na Subseção 1.9.2. Pois bem: os leitos SUS são 79,5% do total em E1 e 81,1% em E3, mas apenas **63,9% em E2** (Apêndice B). O estrato do meio é o mais misto da rede, e é o único em que cerca de um terço dos leitos atende fora do SUS.

Três regras valem para todo o documento. Primeira: a categoria de gestão de cada hospital segue a classificação assistencial do SIH como definição adotada pela equipe, e são **quatro redes** (administração Direta, OSS, Filantrópico e Universitário). A quarta é a única que não vem da base: o registro de origem informa a natureza jurídica do prestador e não informa atividade de ensino, de modo que os **18 hospitais universitários** do painel foram identificados um a um pela equipe. Elas são **quatro em todo o documento**, e o hospital universitário entra na comparação de eficiência como as demais, com uma ressalva de leitura: a estrutura orçamentária e administrativa dele é distinta das outras três, e a nota dele precisa ser lida com esse dado ao lado (Subseção 1.9.4). E os hospitais de **titularidade municipal** não formam rede à parte: o rótulo administrativo deles reúne, sem distinguir, unidades de administração direta da prefeitura e unidades entregues a uma organização social, e por isso o modelo de gestão de cada um foi apurado em fonte externa, hospital a hospital, e cada um entra na rede que lhe cabe. Segunda: o **porte** de cada hospital é fixo, calculado sobre a mediana de leitos de todos os anos com os cortes oficiais (até 50 leitos, pequeno porte; 51 a 150, médio; 151 a 500, grande; acima de 500, especial); como o funil já excluiu os pequenos, o painel tem **149 hospitais médios, 116 grandes e 10 especiais**, e o rótulo anual do SIH, que oscila com o cadastro, não é usado. Terceira: a complexidade do hospital é medida sempre pela **complexidade Barcelona**, escore construído a partir da estrutura física e tecnológica do hospital, em todas as análises deste documento.

A escada de evidência

Sempre que este documento reporta uma diferença entre redes, ele a acompanha de um rótulo que diz *quanto peso* ela suporta. Os rótulos são quatro e valem do sumário executivo à conclusão.

Firme. A diferença aparece em todos os métodos aplicados e não depende de nenhum hospital em particular. É retrato de como as redes operam hoje.

Sugestiva. A diferença é medida comparando cada hospital consigo mesmo, antes e depois da conversão, e os quatro conversores disponíveis bastam para apontá-la, não para prová-la (Subseção 3.7).

Frágil. O número aparece no modelo, mas não resiste ao teste mais exigente. Esse teste monta um hospital de comparação a partir de hospitais que nunca mudaram de gestão, escolhidos e combinados de modo a reproduzir a trajetória do hospital convertido nos anos anteriores à mudança. Se a mudança de gestão tivesse efeito, os dois deveriam se separar depois dela. Não é o que acontece. O número **não deve ser citado** (Subseção 3.7).

Nenhuma. A diferença medida é menor que a própria margem de erro: os dados não distinguem as duas redes naquele indicador.

A esses quatro rótulos soma-se uma **regra de desempate**, porque vários indicadores são medidos mais de uma vez. **Quando a medida feita sobre a rede inteira não bate com a medida feita só entre hospitais de estrutura equivalente, vale a segunda**, pela razão que a Seção 3 desenvolve: é só entre os hospitais de maior capacidade instalada que as duas redes têm unidades em número suficiente para uma comparação de verdade. **O desempate escolhe qual número publicar, e não o quanto se pode confiar nele**: um achado que o teste do hospital gêmeo classificou como frágil continua frágil mesmo que a medida entre hospitais equivalentes aponte uma diferença clara, e é o caso da mortalidade (Seção 3 e Subseção 3.7).

Guia rápido de leitura dos gráficos

Alguns tipos de gráfico e de medida se repetem ao longo do documento; vale fixá-los uma única vez, em linguagem direta.

Mediana e média. A mediana é o valor do hospital do meio da fila: metade dos hospitais está abaixo dela, metade acima. A média é a soma dividida pelo total e é sensível a valores extremos: um único hospital muito caro puxa a média para cima, mas quase não move a mediana. Como nossos indicadores têm valores extremos legítimos, a mediana é quase sempre o retrato mais fiel do hospital típico, e por isso é a medida preferida aqui. Os **percentis** generalizam a ideia: o percentil 90 (p90) é o valor abaixo do qual estão 90% dos hospitais.

A taxa de ocupação pode passar de 100%. Ela não é a fatia de um total, e por isso não tem teto: é a razão entre o leito-dia que o hospital demandou e o leito-dia que ele tem cadastrado. Os dois números vêm de sistemas diferentes (o cadastro conta o leito oficialmente habilitado, e o sistema que paga a internação paga a diária de qualquer paciente internado, inclusive o do leito extra), e é por isso que a razão passa de 100% em 15,4% das observações (o mecanismo está no sumário executivo). Acima de 100% ela se separa em duas parcelas, o leito de fato ocupado e o que transborda, e a separação está formalizada na Subseção 3.3. **Nenhum número deste documento muda por causa disso**: a conta é a mesma de sempre, e o que a separação acrescenta é poder ler as duas parcelas quando isso importa.

Histograma. É a fotografia da distribuição: o eixo horizontal traz o valor do indicador e a altura de cada barra mostra quantas observações caem naquele trecho. Onde as barras são altas, os hospitais se concentram; caudas compridas para a direita indicam poucos casos com valores muito altos.

Boxplot. É o resumo da distribuição em cinco marcas, um por categoria. O boxplot vai do primeiro ao terceiro quartil, ou seja, contém a metade central das observações do grupo; a linha grossa dentro dele é a mediana, e é o número impresso ao lado. As hastes se estendem até a observação mais extrema que ainda está dentro de uma vez e meia a altura dele, e o que passa disso aparece como ponto solto, um por observação. A largura é sempre a mesma e não diz nada sobre o tamanho do grupo.

Escala logarítmica. Alguns gráficos usam eixo em escala logarítmica, em que as marcas avançam por multiplicação (100, 1.000, 10.000) em vez de soma. Isso permite enxergar ao mesmo tempo hospitais de R$ 500 e de R$ 20.000 por saída sem que os pequenos virem um borrão; os rótulos dos eixos mostram sempre os valores reais.

As convenções visuais abaixo valem para o documento inteiro e, por isso, não são repetidas figura a figura. Onde uma figura fugir de alguma delas, a exceção vem dita na própria legenda.

Área sombreada. Nos gráficos que acompanham um indicador ao longo do tempo, a linha é o hospital mediano e a área sombreada em volta dela contém a **metade central dos hospitais**, do quartil inferior ao superior.

Faixa cinza. Em qualquer gráfico com o ano no eixo horizontal, a faixa cinza vertical destaca o **biênio pandêmico de 2020 e 2021**.

Pontos anotados. Nas séries temporais, os pontos de **máximo, de mínimo e do último ano** aparecem marcados com o valor escrito ao lado.

Linhas de referência dos histogramas. A linha vertical **tracejada é a mediana**, com o seu valor escrito ao lado, e a **pontilhada é a média**. Quando as duas se afastam, é sinal de cauda longa puxando a média.

Barra de transbordo. Quando a cauda de um histograma é comprida demais para caber no eixo sem esmagar o resto, o gráfico é cortado num valor e tudo o que passa dele se acumula numa **barra na borda, em cor viva e distinta da do histograma**, com a contagem escrita. A cauda não desaparece: ela fica declarada ali.

Valores em reais. Todo valor identificado como **R$ de dez/2025** foi corrigido pelo IPCA (variação de dezembro a dezembro, IBGE) e está no poder de compra de dezembro de 2025. Valores correntes, ou nominais, são sempre identificados como tais.

Sumário executivo

Este documento compara o desempenho dos arranjos institucionais que administram hospitais do SUS no estado de São Paulo, sobre um painel de **275 hospitais acompanhados ano a ano de 2015 a 2025** (3.025 observações, sem buracos), destilado de 830 estabelecimentos da base bruta do SIH/SUS. O painel descreve **quatro redes**: Filantrópico, gestão por Organização Social de Saúde (OSS), administração Direta e Universitário. **A comparação corre entre as quatro.**

A resposta curta tem duas metades, e elas não são a mesma afirmação. A primeira é sobre **ritmo de trabalho**, e nela a gestão por Organização Social lidera com folga: as OSS entregam mais atendimento com a mesma estrutura. O resultado se mantém em todos os testes a que foi submetido, e sobretudo naquele que o separa do resto: medido **só entre hospitais distintos**, sem nenhuma contribuição dos que trocaram de gestão, ele fica onde estava, com a produção **44,7% maior** e o tempo de permanência **22,0% menor**, os dois com folga suficiente para descartar o acaso. Não é efeito de um caso isolado nem artefato de um método.

A segunda metade é sobre distância até a melhor prática, e ali o resultado firme ficou mais largo: há uma rede atrás e há rede à frente. Entre hospitais de estrutura equivalente, **a administração direta aparece mais distante da melhor prática do que a média das redes comparadas**, e esse contraste atravessa todos os descontos aplicados. **Do outro lado, o Filantrópico aparece mais perto da melhor prática que a média em todos eles**, e as Organizações Sociais, na maior parte deles. **O hospital universitário é o único que não se separa da média**: para ele os dados admitem tanto posições acima quanto abaixo dela. Quem opera com mais intensidade e quem opera com menos desperdício continuam sendo perguntas distintas, e agora as duas têm resposta com nome de rede.

A pergunta, porém, se decompõe em três, e a liderança precisa ser lida com precisão: quem opera com mais intensidade, quem transforma recurso em atendimento com menos desperdício e quem *provoca* melhor resultado clínico ao mudar de gestão são perguntas diferentes. As duas primeiras estão respondidas, e a favor das OSS. A terceira repousa sobre **quatro** hospitais convertidos, e apenas um deles tem mais de um ano de acompanhamento depois da troca: ela não é respondida aqui. O que segue está ordenado pela firmeza da evidência, não pela ordem dos métodos.

O que se sustenta

As OSS operam num ritmo que nenhuma outra rede alcança. Comparados hospitais de mesma complexidade, mesmo porte e mesmo ano, as OSS **atendem 32,9% mais pacientes**, com os leitos de internação **9,9% mais cheios** e a UTI **11,1% mais usada**, entre os hospitais que a possuem. Cada um destes indicadores foi estimado em mais de uma camada, e os números acima são os que prevalecem pela regra declarada logo acima, na escada de evidência. E a vantagem não depende da escolha de método: em produção física por leito SUS, são **56 saídas por leito nas OSS contra 43 na Direta**, ou seja, cada leito da rede OSS atende cerca de um terço a mais de gente por ano.

Na distância até a melhor prática do estado, o resultado é sobre quem fica atrás. Medida a distância de cada hospital até a fronteira das melhores práticas observadas, a nota mediana do período é de **0,708 no hospital universitário**, contra 0,677 nas OSS, 0,612 no Filantrópico e 0,523 na administração Direta. **A ordem das quatro é a mesma que a régua anterior dava**, e o que mudou foi a distância entre elas, que mais que dobra. O que esses números sustentam é **uma rede atrás, uma à frente e duas no meio**: descontando complexidade, porte e ano, a administração direta aparece mais distante da média das quatro e as Organizações Sociais, mais perto, e **as duas seguem assim quando se desconta também a gravidade dos casos, a mortalidade e a fração de cirurgias**. A ordem entre o Filantrópico e o hospital universitário não é classificação: ela muda conforme o indicador que se olhe. A desvantagem da administração direta é medida entre hospitais distintos, e não depende dos convertidos (Subseção 1.7). **Uma ressalva acompanha as duas separações desta fila**: boa parte do que afasta a administração

direta da média, e do que aproxima as Organizações Sociais, vem de um único hospital. É por isso que o veredito comparativo corre entre hospitais de estrutura equivalente, e não aqui.

Os dois traços acima são características das redes, medidas entre hospitais distintos, e valem como retrato de quem opera melhor hoje. Elas não são, por si, prova de que converter um hospital produz esse resultado: essa é a terceira pergunta, e é a que o dado disponível não fecha: com quatro conversores, dos quais um só com histórico posterior utilizável, a evidência causal deste documento se apoia em um único caso.

O que é sugestivo, e o que não se sustenta

Sugestivo, e não mais que isso: o paciente fica **6,8% menos tempo internado** sob gestão por OSS, medido dentro do mesmo hospital, antes e depois da conversão. **A diferença é pequena demais para se separar do acaso**, e as duas verificações adicionais chegam à mesma conclusão. Pesa contra ela, ainda, que o hospital convertido já vinha em trajetória própria antes da troca, o que impede creditar à conversão o que veio depois. Com quatro conversores e um único com histórico posterior utilizável, o que resta é **direção sem precisão**: o sinal aponta para o mesmo lado que a comparação entre redes, e não sustenta afirmação causal (Subseção 3.7).

Não se sustenta: a queda de mortalidade depois da conversão. Ela aparece nos dados brutos, mas não resiste ao teste mais exigente, o que monta um hospital de comparação a partir de hospitais que nunca mudaram de gestão, escolhidos de modo a reproduzir a trajetória do convertido nos anos anteriores à mudança: depois da conversão os dois seguem juntos, no único caso com histórico posterior utilizável. E, medida **entre redes** em vez de dentro do hospital, a diferença **não aparece**: a taxa vai de **5,6%** na administração Direta a **6,3%** nas OSS, e a faixa que os dados admitem para as OSS, de 4,7% a 8,3%, cai dos dois lados da Direta. **Nada neste documento autoriza afirmar que a gestão por OSS reduz a mortalidade** (Subseção 1.8 e Seção 5).

Sem diferença em método nenhum: o faturamento por saída. Aqui cabe uma ressalva de leitura importante para quem for usar o número em negociação de contrato: as OSS são custeadas por contrato de gestão, e não por reembolso de internação, de modo que o valor por saída pode estar refletindo o regime de pagamento e não o consumo de recursos.

Duas descobertas sobre os próprios números

Taxa de ocupação acima de 100% não é erro de cadastro: é hospital superlotado. Acontece em 15,4% das observações. O motivo é que dois sistemas contam leito de maneiras diferentes. O cadastro nacional registra apenas o leito oficialmente habilitado. O sistema que paga a internação paga a diária de qualquer paciente internado, inclusive o do leito extra que o hospital montou para dar conta da demanda. Esse paciente entra na conta de cima e não entra na de baixo, e é por isso que o resultado pode passar de 100%. O que está ali é informação verdadeira sobre sobrecarga, e não erro de dado.

Por isso o número precisa ser lido em duas partes. Um hospital com 115% diz duas coisas ao mesmo tempo: encheu os leitos que tem cadastrados e ainda atendeu 15% além deles. A conta que separa as duas se faz hospital a hospital, ano a ano: a parte até 100% é o **leito de fato ocupado** e o que passa dali é o **transbordo**. As duas parcelas sempre somam de volta o número publicado.

Separadas as duas, a vantagem das OSS quase não muda. Entre hospitais de estrutura equivalente, as OSS chegam a 91,9% e a administração Direta a 77,1%, uma diferença de 14,8 pontos. Repartindo essa diferença pelas duas parcelas, **14,1 pontos são leito de fato ocupado e 0,7 é transbordo**.

O que são esses 0,7 ponto. Ao longo de um ano, o hospital OSS usa, em média, **2,2% mais leito-dia do que tem cadastrado**, e o da administração Direta, 1,5%. A distância entre esses dois números é o transbordo, e é ela que vale 0,7 ponto. Traduzido para a operação: num hospital de 100 leitos SUS, os 2,2% das OSS são cerca de **790 diárias no ano, ou dois pacientes por dia** atendidos acima da capacidade cadastrada, e os 1,5% da Direta, cerca de 550 diárias, ou pouco mais de um paciente por dia. O transbordo responde por **4% dos 14,8 pontos**: a distância entre as duas redes é quase toda leito de fato ocupado, e as OSS operam mesmo em ritmo mais intenso (Seção 3).

Uma ressalva acompanha esse número: o transbordo é pequeno, mas é frequente. No painel como um todo, operar acima da capacidade cadastrada é episódico. **Nas OSS não é**: acontece em 66,1% dos hospitais da rede, por uma mediana de 4 dos onze anos. O hospital OSS passa da capacidade quase todo ano, e passa pouco de cada vez, o que é pressão assistencial contínua e não pico ocasional (Seção 3).

Só uma parte da rede permite comparar modelo de gestão com modelo de gestão. Comparação honesta exige hospitais de estrutura parecida, e por isso os 275 foram separados em três grupos, pela estrutura que têm instalada: os que não têm UTI do SUS (65 hospitais), os que têm UTI e escore Barcelona abaixo de 4 (90) e os que têm UTI e escore Barcelona 4 ou mais (120). Nos dois primeiros grupos a administração Direta e as OSS quase não aparecem: são **5 e 11 hospitais da Direta contra 6 e 13 das OSS**, ao lado de 54 e 66 filantrópicos. Em E1 as duas ficam abaixo do piso de dez hospitais que este documento exige de uma célula para lê-la; em E2 elas passam do piso, e o que mantém o veredito fora dali é a definição do estrato, que reúne hospitais de menor capacidade instalada. Sobra o terceiro grupo, com **43 hospitais de OSS contra 24 da Direta**: é o único em que a comparação se sustenta, e é exatamente ali que o contraste entre modelos de gestão foi medido, entre os **120 hospitais** do grupo, nas suas quatro redes de gestão. **O hospital universitário entra nessa comparação**, com uma ressalva de leitura que a Subseção 1.9.4 enuncia: a estrutura orçamentária e administrativa dele é distinta das outras três redes, e a nota dele precisa ser lida com esse dado ao lado. A análise que trata a rede inteira de uma vez não deixava essa limitação aparecer (Seção 3).

A limitação que condiciona tudo acima

A resposta causal repousa em quatro hospitais convertidos, **três deles com um único ano** de dados depois da mudança, e **nenhum é caso limpo**: quatro defeitos concretos comprometem as conversões, documentados um a um na Subseção 3.7. Restou, portanto, **um** hospital com janela posterior utilizável, e é justamente aquele que já vinha numa trajetória própria antes da troca de gestão. É por isso que a posição de cada rede está afirmada como retrato do que elas são hoje, e não como promessa de que converter um hospital produz o mesmo resultado.

Uso indicado

O que a pesquisa entrega com segurança é o **retrato do regime operacional e da eficiência produtiva das quatro redes**, e nele a **administração direta aparece mais distante da melhor prática que a média das redes comparadas, por margem que resiste a todos os descontos aplicados**, e o **Filantrópico aparece mais perto dessa média, também em todos eles**. **O que ela não entrega é uma hierarquia completa**: a rede sob Organização Social e a universitária ficam a distâncias da média menores do que a precisão desta medida, e ordená-las entre si seria ler ruído como resultado. O que a pesquisa expressamente não entrega é um veredito sobre qual modelo salva mais vidas: essa pergunta exigiria mais hospitais convertidos e mais anos de acompanhamento do que os dados de hoje oferecem. Os resultados foram construídos para serem lidos em conjunto e com o contexto metodológico completo; isolado desse contexto, qualquer número aqui fica vulnerável ao uso indevido.

1 A rede inteira: o retrato dos 275 hospitais e por que nem todos fazem a mesma coisa

Esta seção descreve a rede hospitalar inteira, do porte dos estabelecimentos ao que cada um registra de produção, qualidade e uso de leito. Responde a uma pergunta de reconhecimento: o que existe no estado sob o rótulo de hospital do SUS, e quanto isso varia. Varia muito, e a variação não é de grau: há hospitais que não fazem o que outros fazem, e indicadores que não se aplicam a todos. Dessa constatação sai o recorte de comparabilidade que o resto do documento usa. A seção também mostra a comparação que a rede inteira permite entre as suas quatro redes de gestão, e a mostra sob a ressalva que ela mesma constrói: diferença apurada sobre a rede inteira mistura hospitais que fazem coisas distintas. O que esta seção deliberadamente não faz é fechar essa comparação. **O veredito comparativo do documento não está aqui**: está na Seção 3, entre hospitais de estrutura equivalente.

O que vem nesta seção

1.1 Qualidade dos registros e cuidados adotados 15
Que defeitos o registro tem, e quais deles contaminam conclusão.

1.2 Como se distribuem os indicadores, e que formato cada um tem 17
Que forma tem cada indicador, e o que ela exige do modelo.

1.3 O perfil de cada categoria de gestão 24
Como cada rede de gestão se parece antes de qualquer desconto.

1.4 Complexidade e porte: os grandes divisores da rede 33
Quanto complexidade e porte separam os hospitais, sem olhar a gestão.

1.5 O que anda junto com o quê: correlações e origem da variação 42
Quais indicadores andam juntos, e de onde vem a variação deles.

1.6 A evolução no tempo e a marca da pandemia 46
O que mudou no período, e onde a pandemia deixou marca.

1.7 A distância até a melhor prática na rede inteira 54
Quão longe da melhor prática cada rede opera, e sob que ressalva.

1.8 O contraste entre as redes, indicador a indicador 56
Quanto cada indicador difere entre as redes, e quão firme isso é.

1.9 Hospitais que não são comparáveis entre si: o recorte de comparabilidade 61
Quais hospitais se comparam entre si, e por que nem todos.

1.10 A segmentação captura gradiente estrutural real 64
Se os estratos separam estrutura real, ou apenas recorte arbitrário.

1.11 O que os estratos separam, e o que eles não separam 64
Em que dimensões o corte separa muito, e em quais quase nada.

Antes de comparar: o que a rede produziu, em número bruto

Esta abertura não compara nada. Ela imprime o nível: quantas saídas a rede registrou, quantas foram de alta complexidade e quanto do leito ficou ocupado, ano a ano. Tudo o que vem depois nesta seção desconta complexidade, porte e ano, e por isso responde a outra pergunta. Aqui **nada está sendo comparado**, e nenhum número desta abertura entra na escada de evidência.

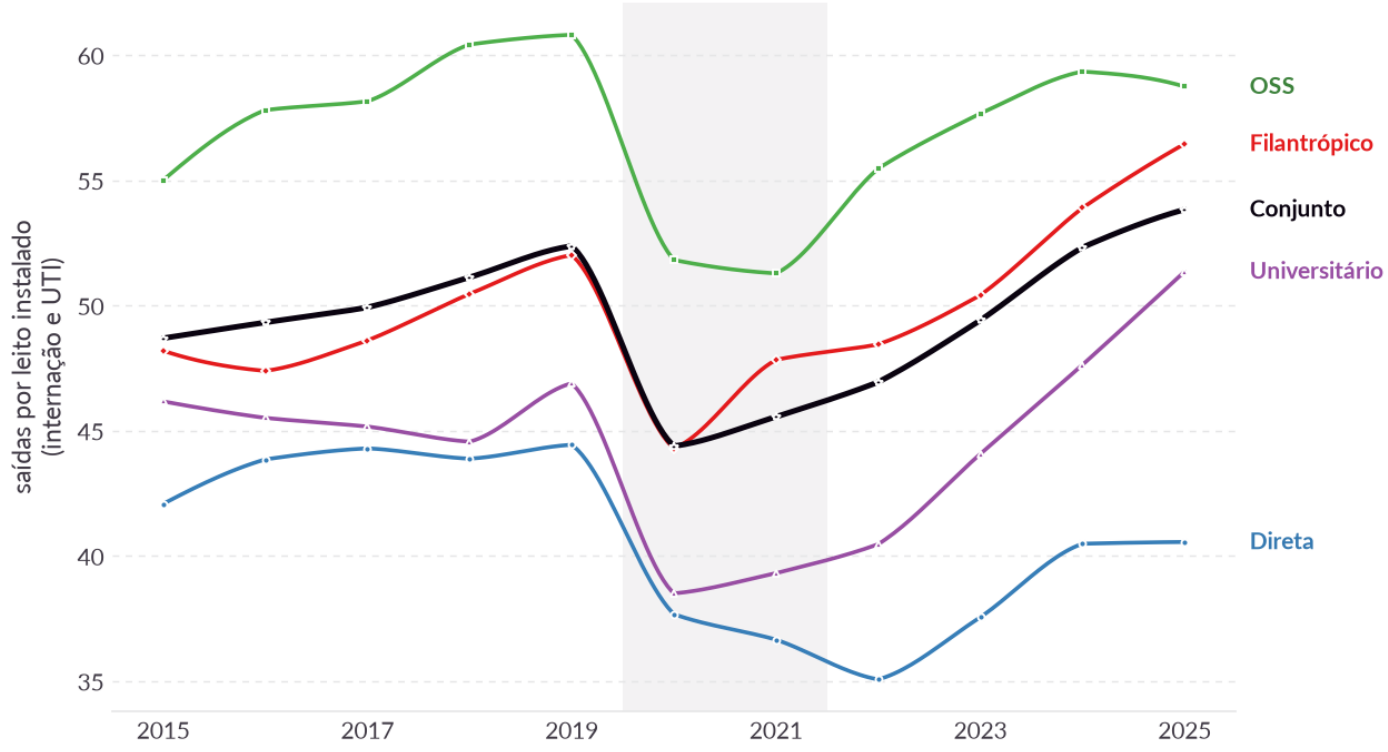
O universo é a rede inteira, com os seus 275 hospitais. As Seções 2 e 3 abrem por blocos iguais a este, em universos menores, e **os três se sobrepõem**: o mesmo hospital aparece em mais de um, e somá-los conta duas vezes quem está em dois.

A rede produziu mais em 2025 do que em qualquer ano da série. Foram **2.303.980 saídas**, contra 2.132.403 em 2019 e 2.107.662 em 2023, que é o último ano antes da Tabela SUS Paulista. **O hospital mediano acompanha**, e é isso que separa crescimento da rede de crescimento de alguns poucos: ele saiu de 5.478 saídas em 2019 para **6.198** em 2025.

A alta complexidade cresceu mais depressa que o volume total. Foram **271.405 saídas de alta complexidade** em 2025, contra 206.465 em 2019 e 217.569 em 2023. **No hospital mediano são 42** em 2025, contra 14 em 2019, e a distância entre esse número e o total diz o essencial: a alta complexidade da rede está concentrada em poucos hospitais.

E o leito ficou mais cheio. A taxa de ocupação do hospital mediano foi de 76,6% em 2019 a **78,5%** em 2025, com passagem por 75,5% em 2023.

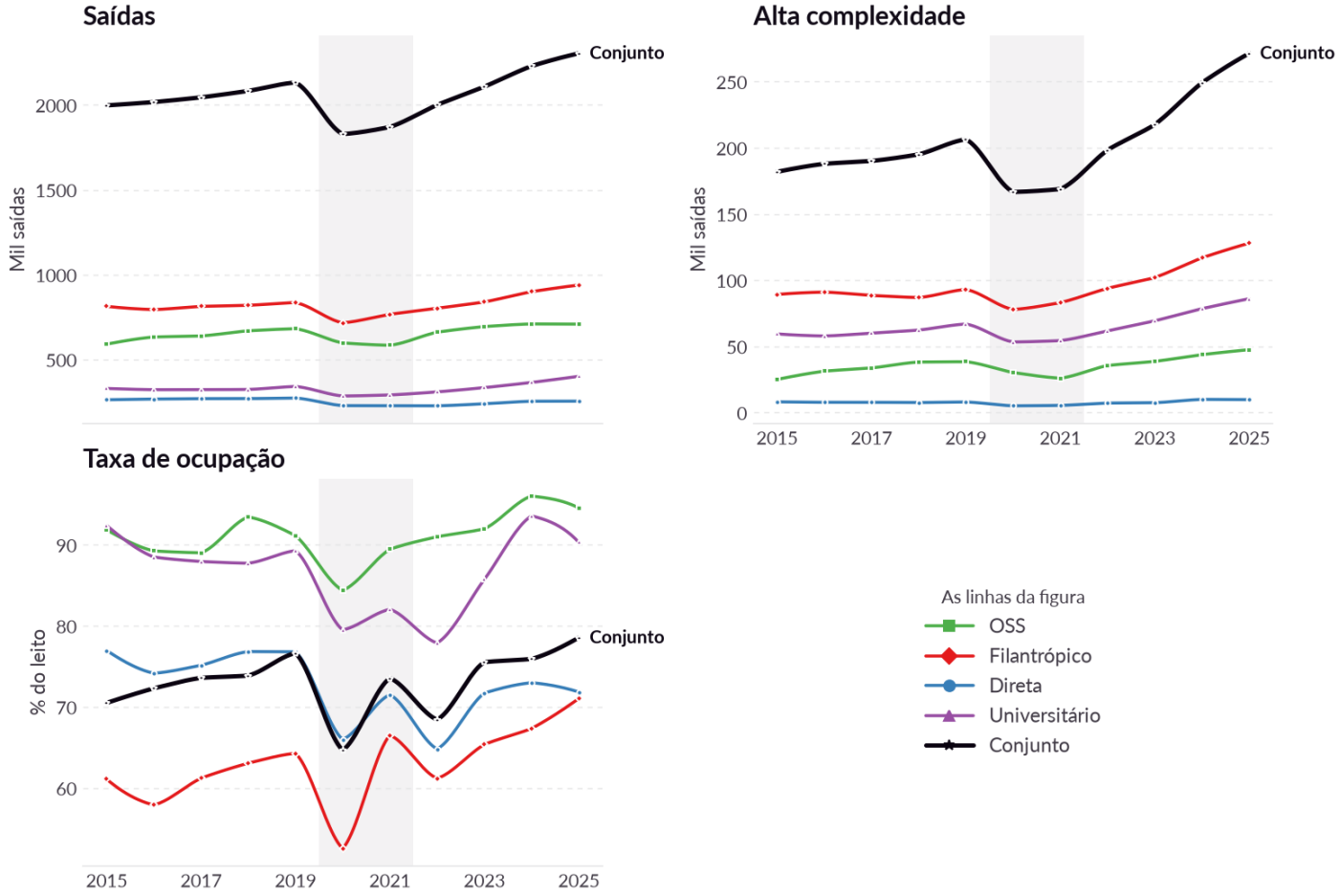
Nem tudo subiu, e as quedas são parte do retrato. A obstetrícia recuou **18,7%** entre 2019 e 2025, e **98 dos 275 hospitais fecharam 2025 com menos saídas do que tinham em 2019**. O crescimento da rede conviveu com mais de um terço dos hospitais perdendo volume.



Seção 1: a rede inteira. Contagem bruta; nada está sendo comparado.

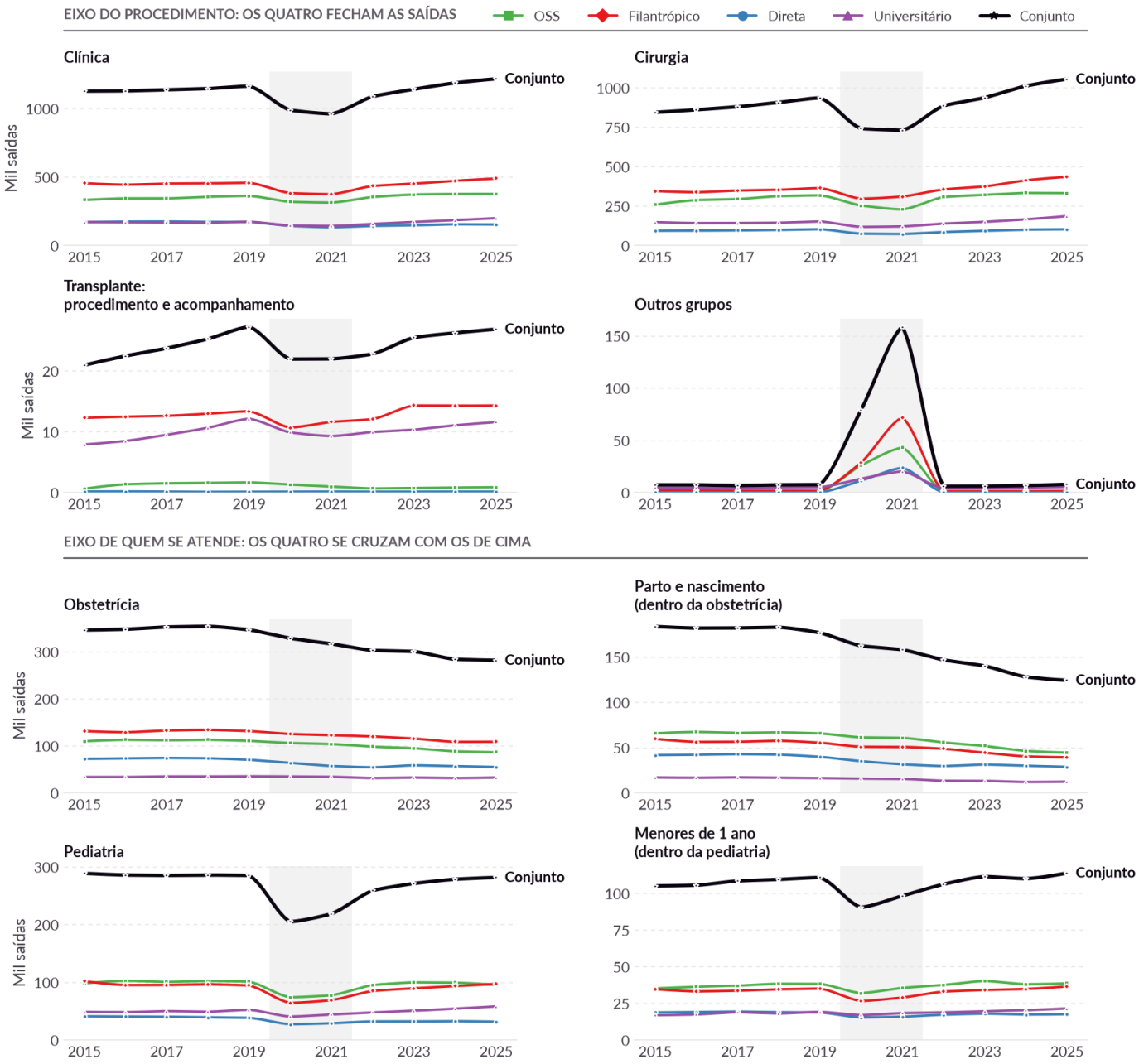
Figura 1: Saídas por leito instalado na rede inteira, por rede de gestão e no conjunto, ano a ano. A razão é as saídas do ano divididas pelos leitos SUS do ano, somados os dois no universo inteiro. **O denominador conta o leito de internação e o de terapia intensiva**, porque o numerador conta todas as saídas, inclusive as de terapia intensiva. Uma linha por rede de gestão, com o rótulo de rede fixado em 2023, e a linha escura do conjunto. A faixa cinza marca o biênio da pandemia. **A conta que mantém o leito parado no valor de 2023 não é desenhada aqui**: ela está no parágrafo seguinte, em número.

A rede fez mais saídas por leito, e não por ter menos leito. A razão foi de **52,4** saídas por leito instalado em 2019 a **53,8** em 2025, com 49,4 em 2023. **O leito cadastrado cresceu no período**, de 40.715 para 42.799 leitos SUS, e por isso a conta com o leito parado em 2023 chega a 2025 um pouco mais alta que a observada, em 54,0. O ganho de produção por leito é produção, e não denominador que encolheu.



Seção 1: a rede inteira. Contagem bruta; nada está sendo comparado.

Figura 2: Saídas, saídas de alta complexidade e taxa de ocupação da rede inteira, ano a ano, **em contagem**. As duas primeiras séries são a soma de todos os hospitais do universo; a terceira é taxa, e por isso sai no hospital mediano, porque somar percentual de hospital não dá percentual de rede. O rótulo de rede é fixado em 2023 nas curvas por rede, para que a produção de um hospital que trocou de regime não mude de linha no meio da série; a linha do conjunto não é fixada, porque o total não se altera com reclassificação entre redes. A faixa cinza marca o biênio da pandemia.



Seção 1: a rede inteira. Os dois grupos contam a MESMA internação por critérios diferentes e não se somam. Contagem bruta; nada está sendo comparado.

Figura 3: Perfil de caso da rede inteira, ano a ano, **em contagem** de internações, em dois grupos de quatro quadros. No grupo de cima, o **eixo do procedimento**, que é partição e fecha as saídas do ano; no de baixo, **quem se atende**, por especialidade e por idade, com cada total ao lado do seu recorte: o parto está dentro da obstetrícia e os menores de 1 ano dentro da pediatria. **Os dois grupos não se somam**: são **três eixos** do bruto de AIH, lidos de colunas diferentes, e por isso eles **se cruzam e não se somam**, já que uma cesárea em paciente de 30 anos entra na cirurgia, na obstetrícia e no parto ao mesmo tempo. **Outros grupos** reúne os procedimentos de finalidade diagnóstica, o **tratamento de COVID**, que existe em 2020 e 2021 e só neles, e as saídas que a fonte deixou sem grupo; ali o total do ano é pequeno e o movimento de um ano para o outro **não é leitura**. A escala é própria em cada quadro, e a âncora no zero impede que ela vire lupa.

O que a rede faz, por tipo de procedimento. Em 2025 foram **1.215.905 saídas clínicas**, **1.053.445 cirúrgicas**, **26.852 de transplante e acompanhamento** e **7.778 em outros grupos**. Os quatro somam exatamente as saídas do ano, de modo que eles podem ser lidos como partes de um todo. **O número do transplante não é o número de transplantes feitos**: o grupo inclui

o acompanhamento e as intercorrências do pré e do pós, e as ações de doação, que juntos são a maior parte dele.

E a cirurgia é a família que mais cresce. Ela passou de **934.856 saídas** em 2019 para as 1.053.445 de 2025, o que é um crescimento de **12,7%** no período. **Nada aqui diz por quê**: a figura não desconta complexidade, porte nem ano, e não há grupo de comparação. E a distância entre as redes nesta figura **é composição**: cada rede reúne hospitais de portes e perfis diferentes, de modo que quem ler modelo de gestão aqui estará lendo a carteira de casos de cada uma.

E quem a rede atende. Em 2025 foram **281.429 saídas de obstetrícia**, das quais **124.187 de parto e nascimento**, e **281.324 de pediatria**, das quais **113.820 em menores de 1 ano**. Os dois pares são de contenção e não de soma, e nenhum deles se soma às quatro famílias de procedimento: a mesma internação é contada em mais de um eixo.

Uma ressalva de aritmética, e ela vale onde as três medidas aparecerem juntas. Saídas por leito, taxa de ocupação e tempo médio de permanência dividem o mesmo numerador neste painel. As três se movem juntas por construção, e por isso concordarem não é três confirmações independentes: é a mesma conta lida de três maneiras.

1.1 Qualidade dos registros e cuidados adotados

Nenhuma base administrativa é perfeita, e parte do trabalho exploratório é localizar exatamente onde estão os problemas para que eles não contaminem as conclusões. A boa notícia: os problemas deste painel são poucos, identificados e circunscritos.

Operação acima da capacidade cadastrada. Na internação, 15,4% das observações (465) ultrapassam 100%; na UTI, são 193 observações, que correspondem a 8,2% daquelas em que a razão é definida e a 6,4% do painel inteiro. Em sua maioria isso é informação verdadeira de sobrecarga, e não deve ser apagado: o mecanismo que produz a conta acima de 100% está explicado no sumário executivo. **O que interessa a esta seção é outra coisa: onde ele deixa de ser sobrecarga e passa a ser defeito de registro.** O problema real está na cauda extrema da UTI: **os 15 maiores valores pertencem todos a 2020 e 2021**, liderados pelo **Hospital Irmãos Penteado e Santa Casa de Campinas (CNES 2022648)**, que registra 875% de ocupação de UTI em 2021: são 6.389 diárias divididas pelos **2 leitos SUS de UTI** então cadastrados, pois a razão do SIH é computada sobre os leitos SUS (introdução, p. 3). O cadastro total do hospital indicava 16 leitos de UTI, que ainda assim dariam 109% de ocupação. A explicação é operacional: na onda da pandemia os hospitais expandiram leitos de UTI às pressas e o cadastro não acompanhou, produzindo divisões por um denominador defasado. Parte dos valores acima de 100% tem origem em um **descasamento de calendário**: leitos que entraram no cadastro apenas no meio do ano (caso típico das UTIs expandidas na pandemia) convivem com diárias acumuladas em período maior que o de cadastro, inflando a razão. Esse viés não é corrigível com a granularidade anual do painel; a winsorização no percentil 99 e o tratamento da UTI em duas partes o mitigam, e ele deve ser lembrado na leitura dos anos de 2020 e 2021. O cuidado adotado: analisar a ocupação como razão positiva, tratar a UTI em duas partes (ter ou não UTI ativa; e, entre os que têm, a intensidade de uso) e aparar a cauda extrema (winsorização no percentil 99: 125% na internação e 171% na UTI), com atenção redobrada ao biênio pandêmico.

Denominadores frágeis na pandemia. Ao excluir as internações COVID, alguns hospitais poderiam ficar com pouquíssimas internações restantes, tornando suas taxas instáveis. No painel isso ocorre em **apenas 2 observações, ambas do Hospital Infante D. Henrique (CNES 2097613, São José do Rio Preto)**: 13 saídas não COVID em 2020 e somente 4 em 2021, ano em que o TMP calculado degenera para zero (o único zero de TMP de todo o painel). As duas observações recebem marcação de denominador frágil e ficam de fora das análises de resultado.

Ruído estatístico dos hospitais pequenos. A Figura 4 organiza essa discussão, e o resultado é que **cerca de 66% das observações caem fora até da faixa mais generosa** (1.033 acima e 1.051 abaixo). Isso diz duas coisas ao mesmo tempo: as diferenças de mortalidade entre hospitais são reais e estruturais, ligadas ao perfil assistencial, e não flutuação de sorte; e, abaixo de mil saídas por ano, o acaso passa a pesar de verdade, o que justifica a cautela extra com hospitais pequenos.

Valores extremos e completude. Pela regra usual de detecção (3 intervalos interquartílicos acima do terceiro quartil), há 18 observações extremas de mortalidade (acima de 17,2%), 90 de faturamento (acima de R$ 5.118, em R$ de dez/2025), 178 de alta complexidade e 33 de TMP. Quanto à completude, **o painel não tem nenhum valor faltante nos seis indicadores** nem nas variáveis de estratificação.

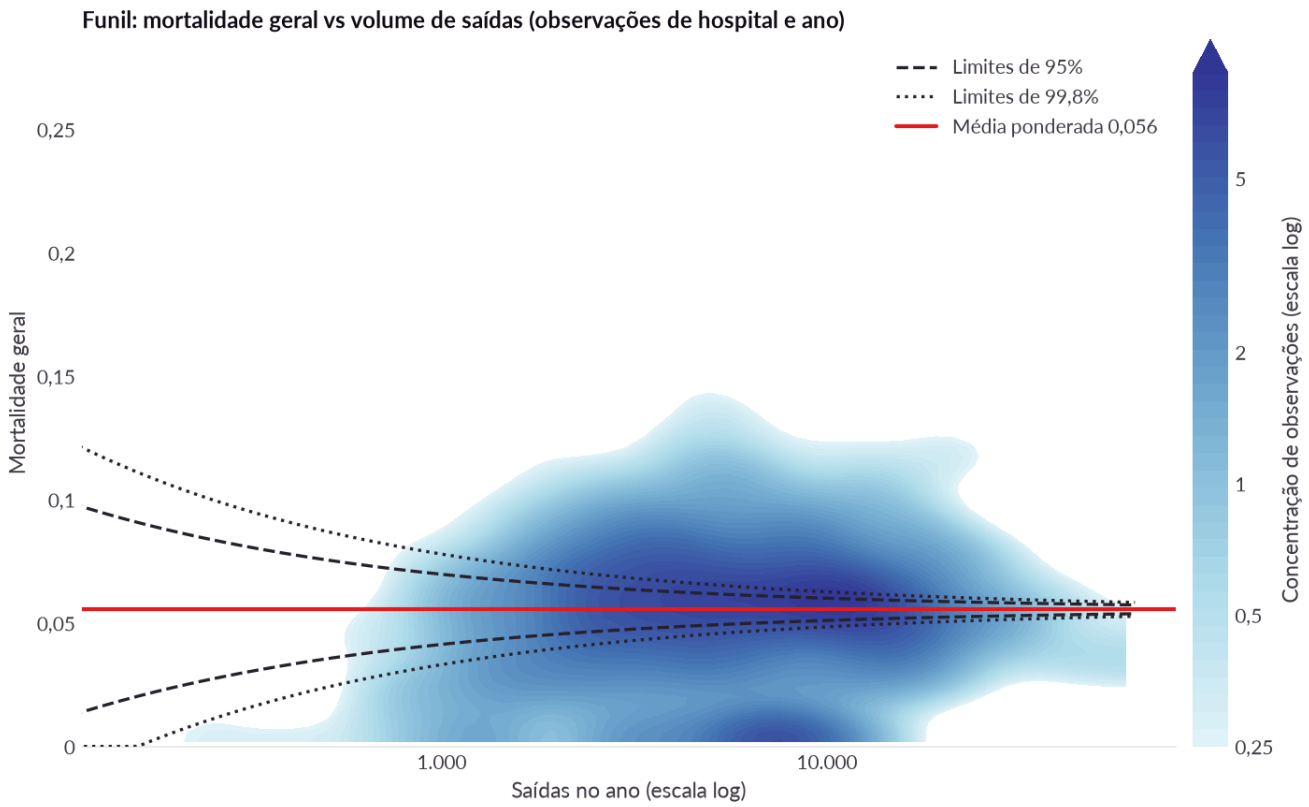


Figura 4: Funil da mortalidade: cada hospital-ano é posicionado pelo volume de saídas (eixo horizontal) e pela mortalidade (eixo vertical), e a cor de cada hexágono é quantas observações caem naquele pedaço do quadro, em escala logarítmica. A linha horizontal é a mortalidade da rede (5,55%) e as linhas curvas delimitam a faixa esperada por puro acaso estatístico (95% e 99,8%), calculada a partir do volume de saídas de cada hospital. Os 5,55% são **razão agregada**, óbitos da rede sobre saídas da rede, e não a média das taxas dos hospitais, que é 5,53% na Tabela 1: as duas respondem perguntas diferentes e por isso não coincidem. A cor do hexágono diz **quantas observações caem ali**, do azul quase branco (uma ou duas) ao azul escuro (dezenas). Hexágono fora das linhas curvas é mortalidade que o acaso não explica; à esquerda de mil saídas, leia a taxa com reserva.

1.2 Como se distribuem os indicadores, e que formato cada um tem

Esta seção responde duas perguntas encadeadas sobre os mesmos seis indicadores. A primeira é *onde* cada um se concentra, e é o retrato numérico que abre a seção. A segunda é *que formato* cada distribuição tem, e é onde os achados de forma aparecem: por trás de um histograma de aparência estranha costuma haver um fato concreto da rede.

1.2.1 Onde cada indicador se concentra

A Tabela 1 resume as distribuições dos seis indicadores e as Figuras 5 a 7 trazem os histogramas.

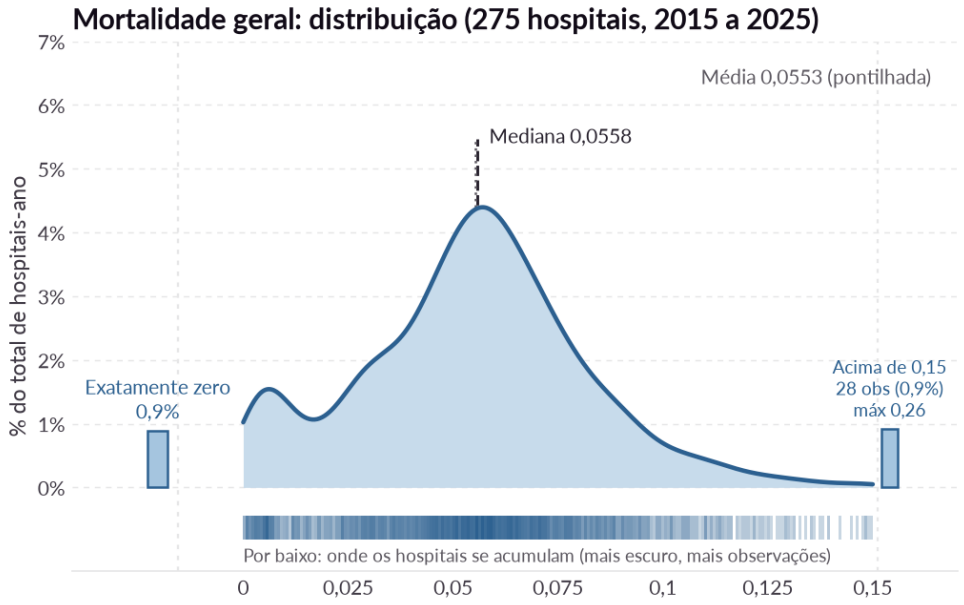
O hospital típico do painel tem **mortalidade em torno de 5,6%** (metade dos hospitais está entre 3,7% e 7,1%), **permanência típica de 4,3 dias** e **faturamento real de cerca de R$ 1.328 por internação encerrada**, em R$ de dez/2025. Mas os extremos importam. Na mortalidade há um segundo grupo de hospitais com taxas próximas de zero (maternidades e especializados) e **0,9% das observações têm mortalidade exatamente zero**. No tempo de permanência, a distribuição é assimétrica à direita, com máximo de 24,8 dias e **sem subpopulação de longa permanência**: os hospitais psiquiátricos e de cuidados prolongados saíram na construção do painel, por serem estruturalmente incomparáveis com o hospital geral. No faturamento, a cauda direita é longa: a mediana é R$ 1.323 e o máximo chega a R$ 14.590, e é por isso que a média (R$ 1.701) fica 29% acima da mediana. A fração de alta complexidade é o indicador mais concentrado: **31,8% dos hospitais-ano não realizam nenhuma internação de alta complexidade**, e **35 hospitais nunca realizam**, nomeados um a um no Apêndice A.1.

Duas medidas de leito pedem uma linha cada. **15,4% das observações de internação passam de 100%**, que é superlotação e não erro de conta (mecanismo no sumário executivo). E, na UTI, o que importa é *quem entra na conta*, ponto que a Figura 7 traz inteiro nas suas duas barras da esquerda: são **668 observações (22,1%)** de hospital sem nenhum leito de UTI do SUS cadastrado, para as quais a razão **não existe**, e **7 observações** de UTI habilitada sem nenhum dia de uso no ano, para as quais ela existe e vale zero. Sobram **2.357 observações** no denominador do indicador (Seção 1.3). Os **48 hospitais que nunca tiveram leito de UTI do SUS** estão nomeados no Apêndice A.3, e o maior valor da série, 875%, é problema de cadastro já examinado na Seção 1.1.

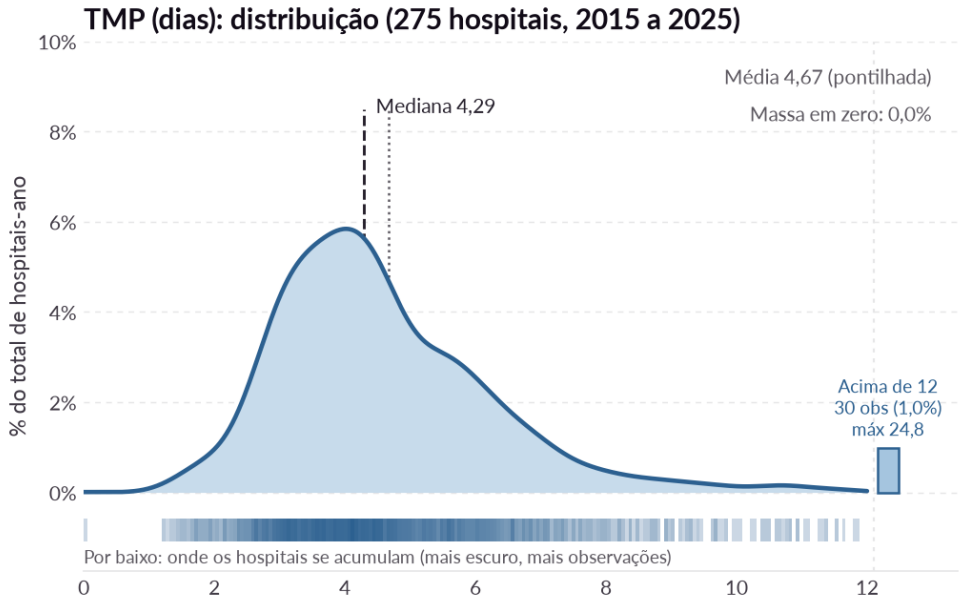
Tabela 1: Resumo estatístico dos seis indicadores, sobre as 3.025 observações de hospital e ano. Mortalidade e alta complexidade em proporção, ocupações em percentual e faturamento **real** em R$ de dez/2025; a ocupação de UTI **só sobre os hospitais com leito de UTI SUS cadastrado**, que é o recorte que ela carrega no documento inteiro. DP é o desvio padrão, e assimetria positiva indica cauda comprida à direita.

Indicador	Média	DP	Mediana	p90	Máximo	Assimetria	Zeros
Mortalidade geral	0,0553	0,0302	0,0558	0,0889	0,2602	0,84	0,9%
TMP (dias)	4,67	1,94	4,29	6,79	24,79	2,39	0,03%
Faturamento real (R$ dez/2025)	1.711,71	1.470,01	1.322,89	3.159,10	14.589,58	3,81	0%
Fração alta complex.	0,0697	0,1378	0,0026	0,2107	1,0000	3,15	31,8%
Taxa de ocupação, internação (%)	71,03	28,11	73,14	104,14	236,61	-0,03	0%
Taxa de ocupação, UTI (%)	77,03	35,80	76,76	98,64	875,21	7,57	0,3%

Na mortalidade, excepcionalmente, a média fica **abaixo** da mediana: aqui não é a cauda direita que domina, mas o grupo de hospitais de baixo óbito perto de zero, que puxa a média para baixo, o mesmo grupo que a Seção 1.2.2 identifica. Nos indicadores de cauda direita longa (TMP, faturamento e alta complexidade) vale a regra usual, com a média acima da mediana; nas duas ocupações a média também fica abaixo da mediana, pelo peso dos valores baixos e, na UTI, dos zeros.

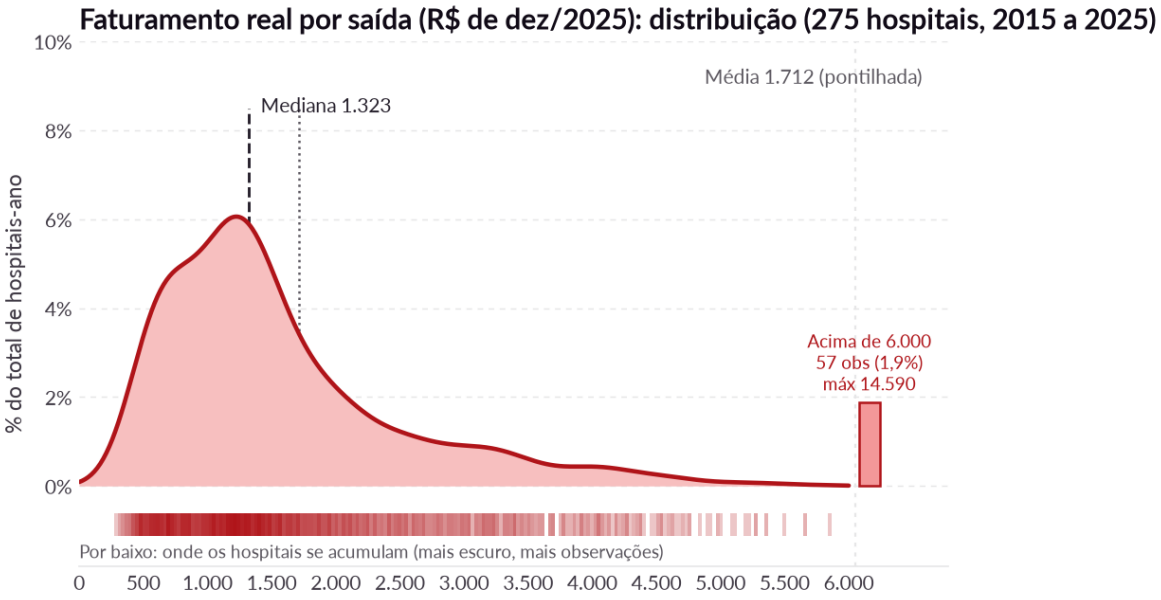


(a) Mortalidade geral

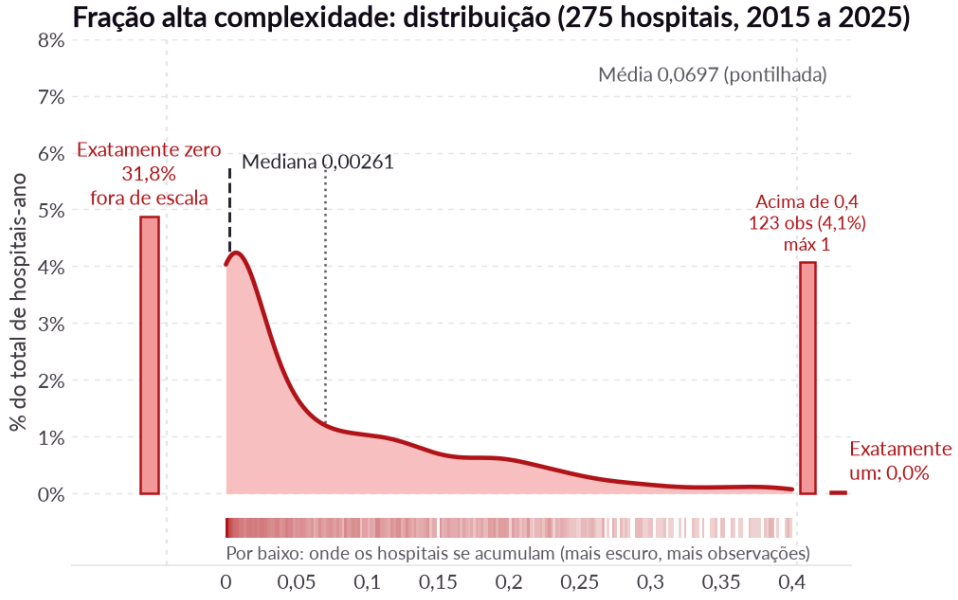


(b) TMP

Figura 5: Distribuição da mortalidade geral e do tempo médio de permanência (275 hospitais, 2015 a 2025). Em cada gráfico, a linha tracejada vertical é a mediana, com o seu valor escrito ao lado; a pontilhada é a média. O eixo vertical está em **percentual do total**: cada barra diz **que fatia das 3.025 observações de hospital e ano** do painel cai naquele trecho, e as barras somam 100%. Metade dos hospitais tem mortalidade entre 3,7% e 7,1%. Na mortalidade há duas corcovas: uma perto de zero, das maternidades e especializados, e a principal perto de 5,5%. No TMP quase todos ficam entre 3 e 7 dias.

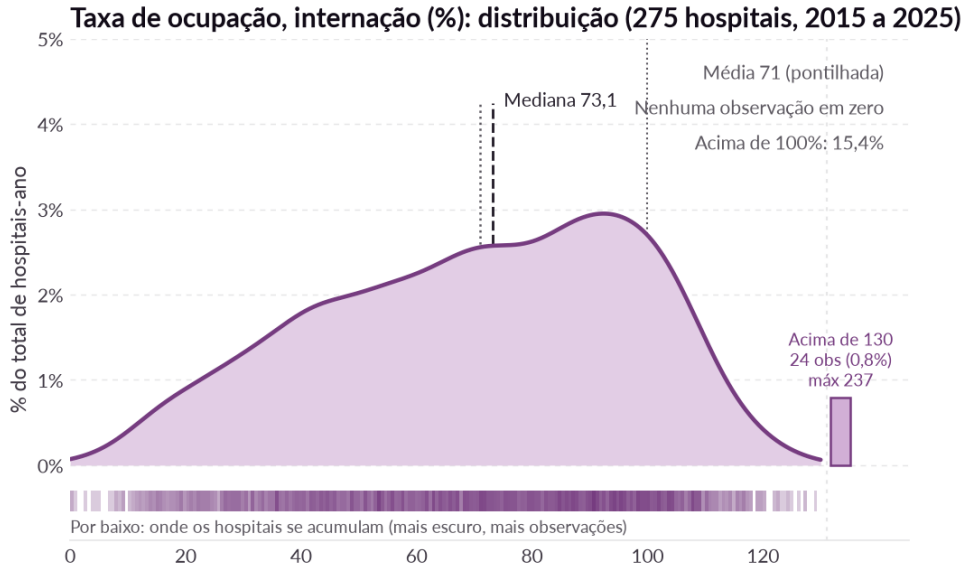


(a) Faturamento real por saída (R$ de dez/2025)

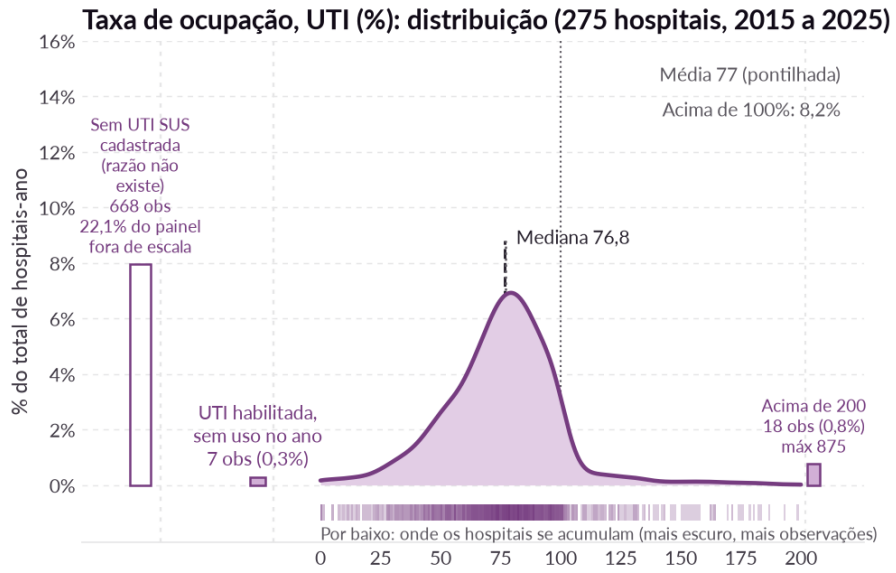


(b) Fração alta complexidade

Figura 6: Distribuição do faturamento real por saída (R$ de dez/2025) e da fração de alta complexidade. Como na figura anterior, o eixo vertical está em **percentual do total de hospitais-ano**. Metade dos hospitais fatura entre R$ 908 e R$ 1.959 por saída. No faturamento a concentração fica perto de R$ 1.300; a cauda vai a R$ 14.600 e o que passa de R$ 6.000 está na barra da borda. Na alta complexidade, **31,8% das observações valem exatamente zero** e a barra dos zeros sai fora de escala; do lado do um sobrou uma observação.



(a) Taxa de ocupação de internação



(b) Taxa de ocupação de UTI

Figura 7: Distribuição das taxas de ocupação de internação e de UTI, em escala percentual. O eixo *horizontal* está em percentual; o *vertical*, em **percentual do total de hospitais-ano**. A linha pontilhada marca 100%: à direita dela é operação acima da capacidade cadastrada. Na internação isso ocorre em 15,4% das observações e nenhuma está em zero. Na UTI, as duas barras da esquerda **não se leem como uma**: as 668 observações sem UTI SUS cadastrada, em que a razão não existe, e as 7 de UTI habilitada sem uso, em que ela existe e vale zero. As 18 observações (0,8%) acima de 200%, com máximo de 875%, estão na barra de transbordo. Somam-se as diárias do ano e divide-se pelo leito-dia disponível, que é a **contagem de leitos vezes 365**. UTI e internação saem do mesmo cálculo, cada uma no seu grupo de leito.

1.2.2 O formato de cada indicador

Cada indicador tem uma forma própria de variar entre os hospitais, e conhecer essa forma tem uma consequência prática para a gestão: dois perfis de hospital convivendo lado a lado, um acúmulo de zeros com significado, uma cauda que exige leitura em escala própria. Esta subseção reúne esses achados de formato. **São eles que decidem a família de distribuição de cada indicador na fase de estimação**: a mortalidade e a fração de alta complexidade entram em escala de proporção, com tratamento próprio para a massa em zero; o faturamento e o tempo

de permanência entram no logaritmo; e a produção entra como contagem com variação muito maior que a média. Aqui ficam os fatos sobre a rede, e a escolha que cada um força.

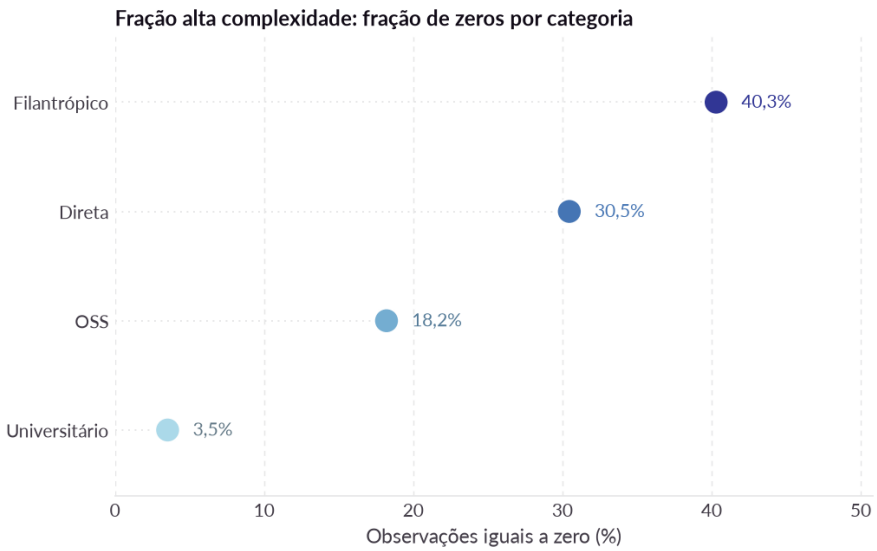
1.2.2.1 Mortalidade: dois grupos de hospitais, não um

O histograma da mortalidade tem duas corcovas, e essa forma estranha não é um defeito dos dados: é o retrato de **dois perfis assistenciais convivendo na mesma rede**. Um grupo de **35 hospitais de baixo óbito estrutural** (mortalidade mediana abaixo de 2%, sendo 16 especializados e 19 hospitais gerais de baixo volume) e os **254 demais**, hospitais gerais com mortalidade em torno de 6%. Existem ainda observações com mortalidade exatamente zero (0,9% do painel). **Estes 35 não são os 35 que nunca fazem alta complexidade** da subseção seguinte e da Tabela 5: são grupos distintos, definidos por critérios diferentes, que apenas coincidem em tamanho.

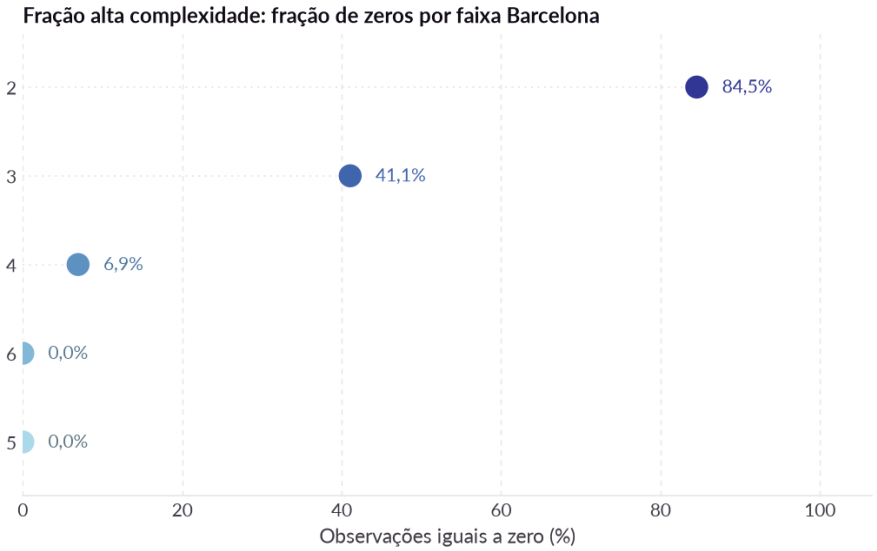
A consequência prática para a gestão é direta: **uma média única de mortalidade da rede não descreve hospital nenhum**, porque mistura dois perfis que atendem populações diferentes. Qualquer comparação precisa levar isso em conta, e é por isso que os modelos deste documento incluem sempre a complexidade e o perfil do hospital.

1.2.2.2 Alta complexidade: o peso dos zeros

A fração de alta complexidade também é uma proporção, mas com uma particularidade dominante: **um terço das observações vale exatamente zero** (hospitais-ano em que não houve nenhuma internação de alta complexidade) e uma única observação vale exatamente um, o hospital-ano em que toda a produção foi de alta complexidade. Esses dois acúmulos nas pontas exigem um tratamento estatístico próprio. Para a gestão, o que importa é que **os zeros não são aleatórios** (Figura 8): a proporção de hospitais-ano sem alta complexidade cai de 80,1% na faixa 2 de complexidade para zero na faixa 6, e de 37,5% nos Filantrópicos para 10,7% nas OSS. Ou seja, saber a complexidade, o porte e a categoria do hospital já diz muito sobre a chance de ele estar no grupo do zero. Os 35 hospitais que *nunca* saem dele, em nenhum dos onze anos, estão nomeados no Apêndice A.1.



(a) Por categoria de gestão



(b) Por faixa de complexidade

Figura 8: Percentual de observações com alta complexidade exatamente zero, por grupo de hospitais. A queda das barras da esquerda para a direita no painel (b) mostra que o zero é questão de perfil e estrutura: quase todos os hospitais de faixa 2 estão no zero, e nenhum de faixa 6 está.

1.2.2.3 Faturamento e tempo de permanência: valores com cauda longa

Faturamento por saída e TMP são valores positivos com cauda à direita[1], e a leitura prática que interessa à gestão é uma só: nos dois, **um punhado de hospitais muito caros ou de permanência muito longa puxa a média para cima** e a afasta do hospital típico. É por isso que este documento reporta a **mediana** sempre que descreve o nível de um grupo, e a média só ao lado dela, quando a distância entre as duas é ela mesma a informação.

1.2.2.4 Produção: contagens muito mais variáveis que o usual

A produção anual (o número de saídas hospitalares) varia entre os hospitais de forma **muito mais extrema do que se esperaria de uma contagem comum**. O que isso quer dizer na prática: a diferença de produção entre dois hospitais quaisquer da rede é enorme e não se explica por acaso, mesmo entre hospitais de porte parecido. Também dentro de um mesmo hospital, ao longo dos anos, a produção oscila mais do que o usual.

Para onde estes formatos levam. Os quatro achados de forma reunidos acima são a origem das escolhas de família de distribuição que a fase de estimação usa. A estratégia que as aplica está no Apêndice D.

[1] Guia dos tamanhos de amostra que aparecem no documento: **3.025** é o painel completo; **3.024** exclui a única observação com TMP igual a zero (CNES 2097613, 2021), incompatível com a escala logarítmica; **3.023** exclui as duas observações de denominador frágil da Seção 1.1, regra usada nos modelos da fase de estimação, e tira uma só a mais porque a do TMP zero é uma delas; e **2.355** são as observações com leito de UTI do SUS cadastrado, já sem essas duas. Cada conta foi conferida no painel.

1.3 O perfil de cada categoria de gestão

O painel contém **159 hospitais Filantrópicos, 62 sob gestão de OSS, 40 da administração Direta e 18 Universitários**. Os quatro hospitais que trocaram de gestão são contados **nas duas categorias** nas contagens por período; por isso a soma das categorias excede em quatro o total de 275 hospitais. Nas Figuras 13 e seguintes, cada hospital recebe **atribuição única pela categoria em que passou a maior parte do período** (os três conversores de 2025 entram como Direta; Sorocaba, com sete dos onze anos como OSS, entra como OSS). A Tabela 2 traz a mediana e a média de cada grupo, a Tabela 4 traz o agregado de cada rede e as Figuras 9 a 11 mostram a distribuição completa.

O retrato operacional é nítido e fala direto à gestão: **os hospitais OSS operam com taxa de ocupação mediana de 91,0% e os Universitários de 87,0%, contra 72,6% da administração Direta e apenas 63,2% dos Filantrópicos**. O tempo de permanência conta história parecida: **5,77 dias na Direta**, contra 5,50 nos Universitários, 4,74 nas OSS e 3,87 nos Filantrópicos. Essas diferenças brutas refletem, em parte, o papel que o Estado atribui a cada rede (as OSS receberam majoritariamente hospitais gerais de médio e grande porte em regiões pressionadas) e não devem ser lidas como ranking de gestão. Já a mortalidade mediana bruta tem **a administração Direta na posição mais alta (5,93%) e os Universitários na mais baixa (4,74%)**, com Filantrópicos (5,69%) e OSS (5,22%) entre as duas. Esse ordenamento depende fortemente da composição do painel: a exclusão dos hospitais estruturalmente incomparáveis retirou hospitais de baixa mortalidade concentrados na Direta e nos Filantrópicos. O ponto está discutido na Subseção 3.7. É essencial não tirar conclusões de causa dessas comparações brutas: as categorias atendem perfis diferentes de complexidade e porte, e essas diferenças precisam ser descontadas antes de qualquer julgamento. O faturamento real mediano por saída (R$ de dez/2025) varia pouco entre três delas (de R$ 1.243 nos Filantrópicos a R$ 1.356 nas OSS) e destoa na quarta: **R$ 2.757 nos Universitários**, mais que o dobro da mais cara das outras. É a mesma separação que a fração de internações de alta complexidade mostra, de 17,4% nos Universitários contra 0,1% a 0,3% nas demais, e é o que faz a nota do Universitário pedir uma ressalva de leitura própria (Subseção 1.9.4).

A ocupação de UTI só é definida onde existe UTI

A ocupação de UTI é calculada apenas onde há leito de UTI SUS cadastrado. As **668 observações restantes (22,1% do painel)** são **não-aplicável, nunca ocupação zero**, e a Figura 7 as mostra em barra própria. A consequência é o que importa aqui: contar hospital sem UTI como UTI vazia puxaria cada categoria para baixo na exata proporção em que ela concentra hospitais sem UTI.

E essa proporção é muito desigual. Entre os Filantrópicos, **31,6% das observações são de hospitais sem UTI SUS**; nas OSS são 9,7%, na administração Direta 12,3%, e entre os Universitários nenhuma. O Filantrópico tem, portanto, **duas vezes e meia** mais observações que sequer disputam esse indicador do que a Direta, e três vezes mais do que as OSS.

O que isso significa para a gestão. Medida apenas onde a pergunta faz sentido, a ocupação de UTI põe o Filantrópico na ponta da rede, e a estatística que ordena é sempre nomeada: **pela mediana, o Filantrópico** marca 79,7%, à frente do Universitário (77,6%), das OSS (75,3%) e da Direta (66,9%); **pela média, o Filantrópico** marca 80,5%, contra 69,1% da Direta. **Entre os hospitais filantrópicos que têm UTI SUS, ela é a mais cheia da rede.** O que distingue a categoria não é subutilizar UTI: é ter muitos hospitais de menor porte que não têm UTI nenhuma. São dois fatos diferentes, e somá-los num número só confunde os dois.

Uma precisão sobre o que é "não ter UTI". Das 668 observações sem leito de UTI SUS, **632 são ausência real** de UTI, em 73 hospitais. As outras **36 são o piscar cadastral** (leito de UTI que some do cadastro sem que a ala feche; ver Subseção 1.9.2), em 25 hospitais que num dado ano aparecem com zero leito cadastrado e mesmo assim registram diárias de UTI. As duas situações saem do cálculo pelo mesmo motivo (a razão continua indefinida), mas não são o mesmo fenômeno, e a distinção importa para quem for interpretar a capacidade instalada da rede. **O Apêndice A.3 reparte as mesmas 668 observações por outro corte**, o do hospital (nunca ter

tido UTI contra oscilar entre ter e não ter) em vez do hospital-ano, e por isso os seus totais não coincidem com os desta passagem.

Tabela 2: Mediana e média por categoria de gestão, período completo (mortalidade e alta complexidade em proporção; ocupações em percentual; faturamento real, deflacionado pelo IPCA para R$ de dez/2025, que é a regra de todo valor em dinheiro deste documento). A **mediana** descreve o hospital típico da rede; a **média** descreve a rede. Onde as duas se afastam muito, como na fração de alta complexidade, a distância entre elas é informação de gestão, e não ruído de cálculo: ela mede o quanto a rede depende de poucos hospitais. Cada observação hospital-ano entra na categoria *vigente naquele ano*: os quatro conversores contribuem para as duas.

Categoria		Mortalidade	TMP (dias)	Faturam. real (R$)	Alta complex.	Ocup. int. (%)	Ocup. UTI (%)
Direta	mediana	0,0593	5,77	1.270	0,0025	72,6	66,9
	média	0,0559	6,13	1.411	0,0436	73,7	69,1
OSS	mediana	0,0522	4,74	1.356	0,0033	**91,0**	75,3
	média	0,0532	4,76	1.538	0,0463	**84,9**	74,3
Filantrópico	mediana	0,0569	3,87	1.243	0,0010	63,2	**79,7**
	média	0,0565	4,18	1.681	0,0748	63,5	**80,5**
Universitário	mediana	0,0474	5,50	2.757	0,1736	87,0	77,6
	média	0,0508	5,53	3.205	0,1587	86,9	79,3

Onde a mediana e a média concordam, e onde elas se separam

Ter as duas medidas lado a lado responde uma pergunta que a mediana sozinha não responde: **o hospital típico desta rede representa a rede, ou a rede é a soma de hospitais muito diferentes entre si?** Onde as duas quase coincidem, o hospital do meio da fila é um retrato fiel do grupo. Onde se afastam, a rede depende de poucos hospitais, e citar só a mediana esconde isso. A Tabela 3 mede essa distância nas quatro redes.

Tabela 3: Quanto a média se afasta da mediana em cada rede, indicador a indicador. O número é a média dividida pela mediana: **1,00 significa que as duas coincidem** e o hospital típico descreve a rede; acima de 1, a rede é puxada para cima por poucos hospitais; abaixo de 1, por poucos hospitais de valor baixo.

Categoria	Mortalidade	TMP	Faturamento	Alta complex.	Ocup. int.	Ocup. UTI
Direta	0,94	1,06	1,11	17,44	1,01	1,03
OSS	1,02	1,01	1,13	14,03	0,93	0,99
Filantrópico	0,99	1,08	**1,35**	**74,80**	1,00	1,01
Universitário	1,07	1,01	1,16	**0,91**	1,00	1,02

Em quatro dos seis indicadores as duas medidas praticamente coincidem em todas as redes. Mortalidade, tempo de permanência e as duas taxas de ocupação ficam entre 0,93 e 1,08 nas quatro redes. Isso é uma boa notícia de leitura: nesses quatro indicadores, **a mediana da Tabela 2 pode ser citada sozinha**, porque não há hospital excepcional distorcendo o retrato.

Os dois indicadores em que elas se separam são o faturamento e a alta complexidade, e nos dois a rede mais desigual por dentro é a mesma. A distância entre média e mediana mede o quanto a rede depende de poucos hospitais, e o **Filantrópico está no extremo nos dois casos**. Na ponta uniforme, porém, as duas listas não coincidem: no faturamento a rede mais homogênea é a administração Direta, e na alta complexidade é o Universitário. No faturamento, a média fica 11,2% acima da mediana na Direta, 13,4% nas OSS, 16,2% nos Universitários e **35,2% no Filantrópico**. Na alta complexidade, a razão vai de 0,91 nos Universitários a **74,80 no Filantrópico**. O Universitário é a única rede cuja média fica *abaixo* da mediana nesse indicador: quase todos os seus hospitais fazem alta complexidade, e são os poucos que fazem menos que puxam a média para baixo.

A explicação é uma só, e é estrutural: a amplitude de porte de cada rede. Medida pela razão entre o maior e o menor hospital em leitos SUS, as OSS vão de 47 a 394 leitos (razão de 8), a Direta de 36 a 318 (razão de 9), o Universitário de 75 a 1.247 (razão de 17) e o Filantrópico de **8 a 972 leitos (razão de 122)**. O Filantrópico é a única rede que põe, na mesma linha de tabela, um hospital de 8 leitos e um de 972: o Universitário abriga o maior hospital do painel, mas não tem nenhum hospital pequeno embaixo dele. Não é defeito de medida: é o que a categoria é. Mas significa que **nenhum número único descreve a rede filantrópica**, e é por isso que ela precisa das três leituras da subseção seguinte.

Um achado de gestão que só aparece com as duas medidas juntas: depois do Universitário, a rede OSS é a mais uniforme das quatro. Medindo a dispersão interna de cada rede pelo intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil, dividido pela mediana, as OSS ficam em **segundo lugar em cinco dos seis indicadores** (mortalidade, permanência, faturamento e as duas taxas de ocupação) e em terceiro na alta complexidade. À frente delas fica apenas o Universitário, primeiro em quatro dos seis, o que se espera de uma rede de dezoito hospitais do mesmo tipo, e cuja nota carrega a ressalva de leitura da Subseção 1.9.4. Traduzido para a decisão: o desempenho mais alto das OSS **não vem de dois ou três hospitais de vitrine puxando a média**. Vem de uma rede em que os hospitais se parecem entre si, e essa uniformidade é, em contrato de gestão, um resultado tão relevante quanto o nível.

E há um caso em que a média está abaixo da mediana, com consequência prática. Na taxa de ocupação de internação, a média das OSS (84,9) fica **6,1 pontos abaixo** da mediana (91,0), a maior queda das quatro redes. O motivo está identificado: **93 hospitais-ano abaixo de 60% de ocupação, concentrados em 15 dos 62 hospitais** e espalhados por todos os onze anos, o que descarta efeito de pandemia. Sem esses quinze, a mediana das OSS sobe para 94,7% e a média para 92,5%. A consequência é direta: **usar a média em vez da mediana penaliza a rede OSS mais do que qualquer outra**, justamente no indicador que sustenta o principal achado do documento. Os dois números estão publicados lado a lado para que essa escolha seja visível em vez de silenciosa.

Por que a alta complexidade do Filantrópico parece baixa, e não é

Lida sozinha, a coluna da mediana sugere que o Filantrópico quase não faz alta complexidade: 0,0010, o segundo menor número da tabela. A leitura é falsa, e a própria tabela mostra por quê. A média da categoria é 0,0748, **quase 78 vezes a sua própria mediana**, a maior distância entre as duas medidas em toda a tabela, contra 5,4 vezes na administração Direta e 2,8 vezes nas OSS. As duas medidas não se contradizem: elas respondem perguntas diferentes, e é justamente o tamanho do vão entre elas que descreve esta rede.

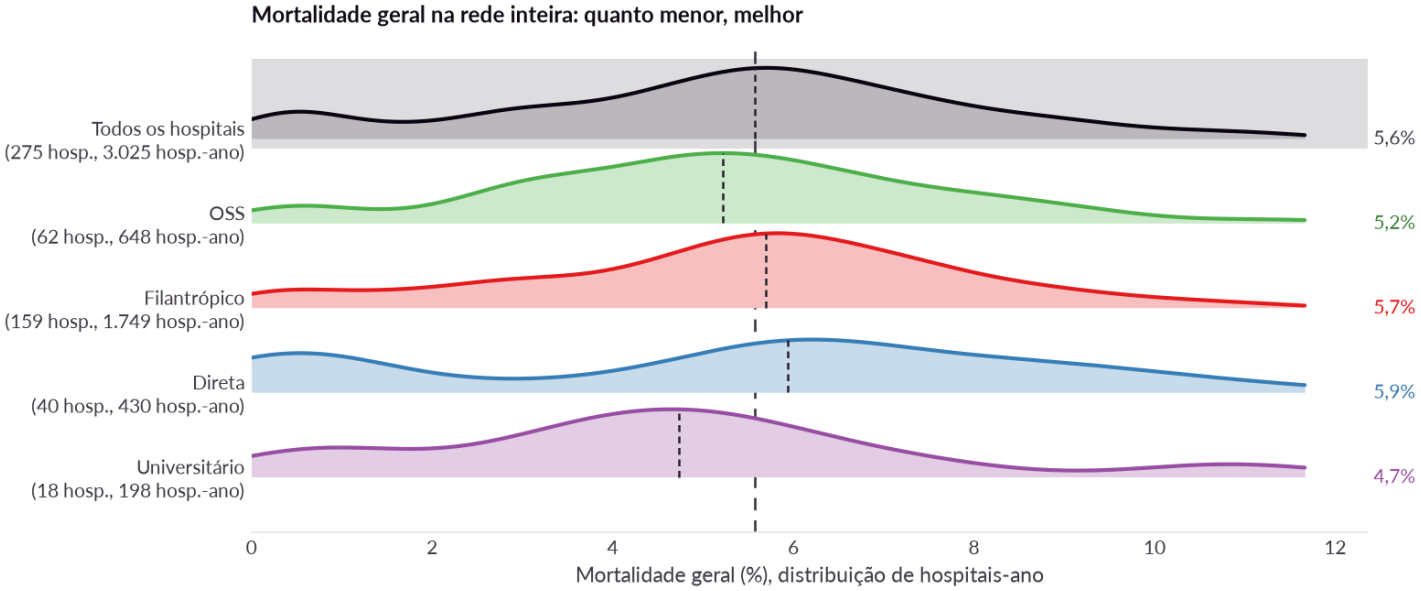
A mediana é o hospital do meio da fila de **159 hospitais**, e essa fila é a mais desigual do painel. **40% dos hospitais-ano filantrópicos não registram nenhuma internação de alta complexidade**, e esse contingente de Santas Casas pequenas empurra o meio da fila para perto de zero. Basta separar o grupo em dois para o retrato mudar: entre os **117 hospitais filantrópicos que têm UTI SUS**, a mediana de alta complexidade é de 1,7% e a média de 10,0%; entre os **42 que não têm**, as duas são praticamente zero. Na faixa 6 de complexidade, a mais alta, restam **dois** hospitais filantrópicos, com mediana de 20,3%: os outros oito hospitais de faixa 6 do painel são Universitários.

O que a rede filantrópica faz, medido em produção e não em hospital típico, é o oposto do que a mediana sugere. A Tabela 4 soma o numerador e o denominador de cada rede, que é como se mede o desempenho de uma rede e não de um hospital: nela o Filantrópico aparece com **11,6% das suas internações em alta complexidade**, à frente das OSS (5,4%) e da administração Direta (3,2%). Acima de todas fica o Universitário, com 19,6%, que é o que se espera da rede posta fora da comparação pela Subseção 1.9.4. Em volume, a distância é ainda maior: **47,0% de toda a alta complexidade do painel sai de hospitais filantrópicos**, contra 31,8% dos Universitários. Eles também detêm **36,8% dos leitos de UTI SUS** do painel. Não há contradição alguma entre ter a UTI mais cheia da rede e ter mediana de alta complexidade perto de zero: os hospitais que enchem a UTI e os que puxam a mediana para baixo **não são os mesmos hospitais**.

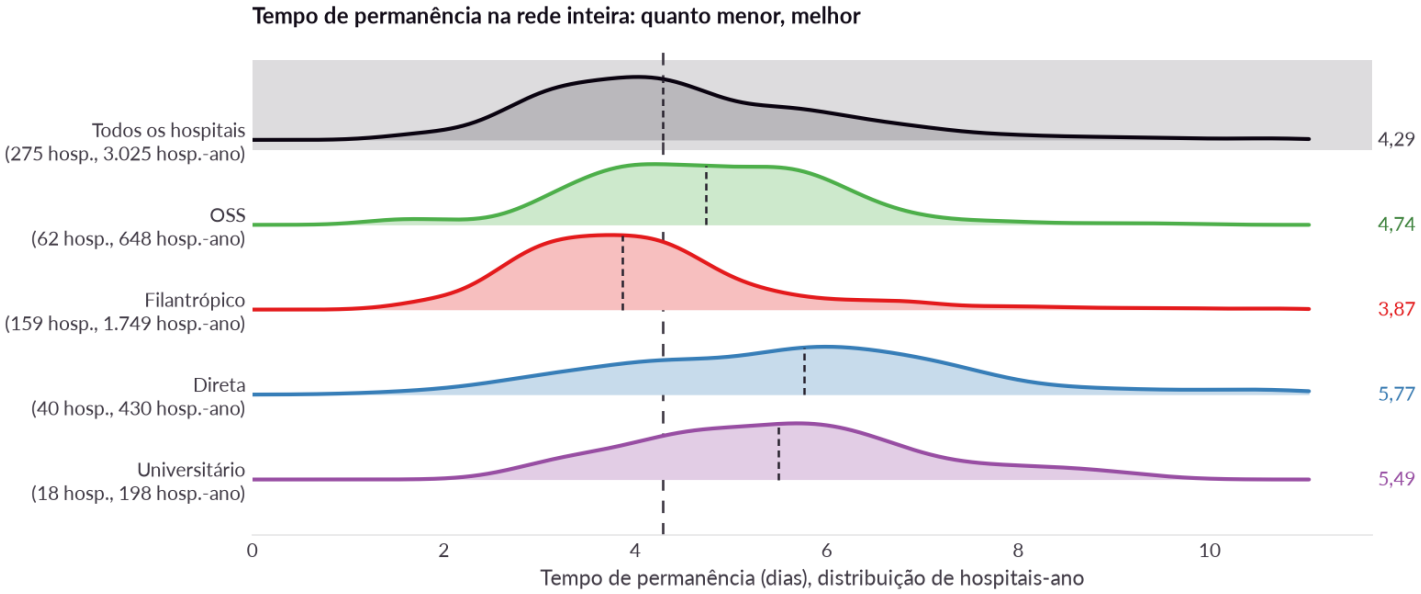
Tabela 4: O agregado de cada rede: soma dos numeradores dividida pela soma dos denominadores, e não média das taxas dos hospitais. É a leitura em que cada hospital pesa pelo que produz, e não um voto cada, e portanto a que responde "quanto desta rede é alta complexidade". As três últimas colunas trazem a fatia da rede no total do painel.

	Taxa da rede				Fatia do painel (%)		
Categoria	Mortal.	TMP	Alta complex.	Ocup. UTI (%)	Saídas	Alta complex.	Leitos UTI
Direta	0,0600	6,05	0,0315	65,6	12,4	4,0	13,5
OSS	0,0557	4,92	0,0538	74,0	31,6	17,2	27,5
Filantrópico	0,0612	4,57	0,1162	77,8	**40,0**	**47,0**	**36,8**
Universitário	0,0521	5,80	**0,1957**	79,4	16,0	31,8	22,2

Como usar as duas tabelas. Para perguntas sobre o hospital ("o hospital típico desta rede faz alta complexidade?"), use a mediana. Para perguntas sobre a rede ("de onde sai a alta complexidade do estado?"), use o agregado. Trocar as duas produz as duas conclusões erradas de sempre: tomar a mediana por retrato da rede subestima o Filantrópico em cerca de setenta e cinco vezes, e tomar o agregado por retrato do hospital sugere que a Santa Casa de sessenta leitos faz alta complexidade, o que em geral não é verdade.

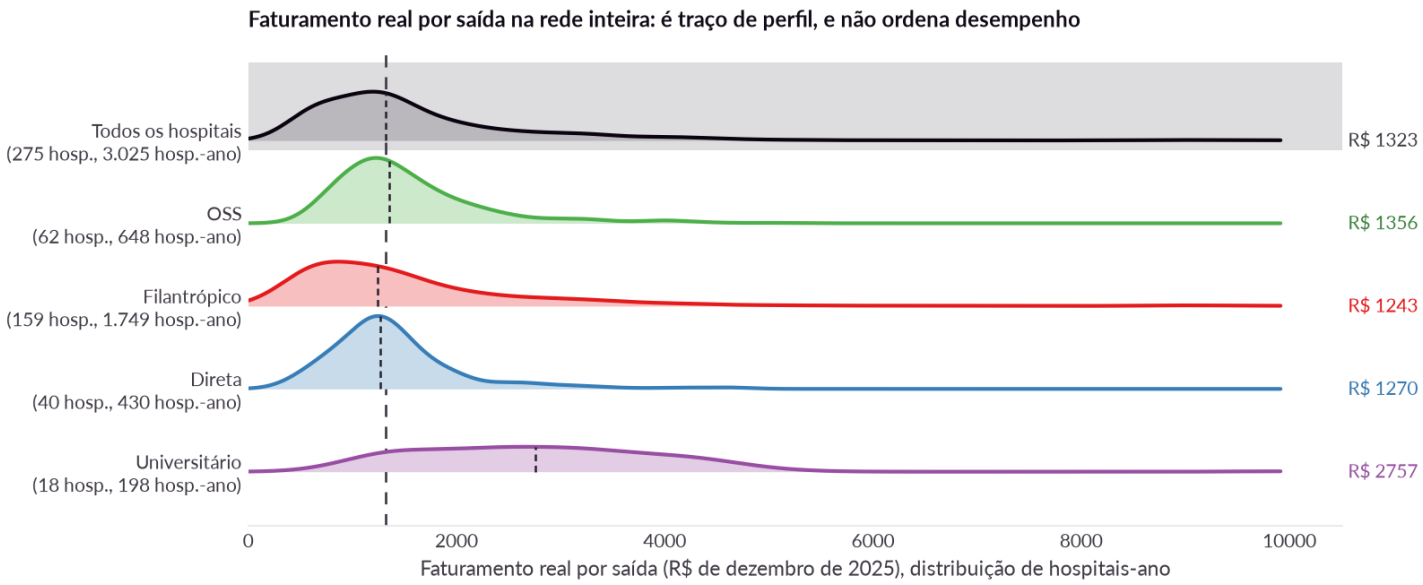


(a) Mortalidade geral

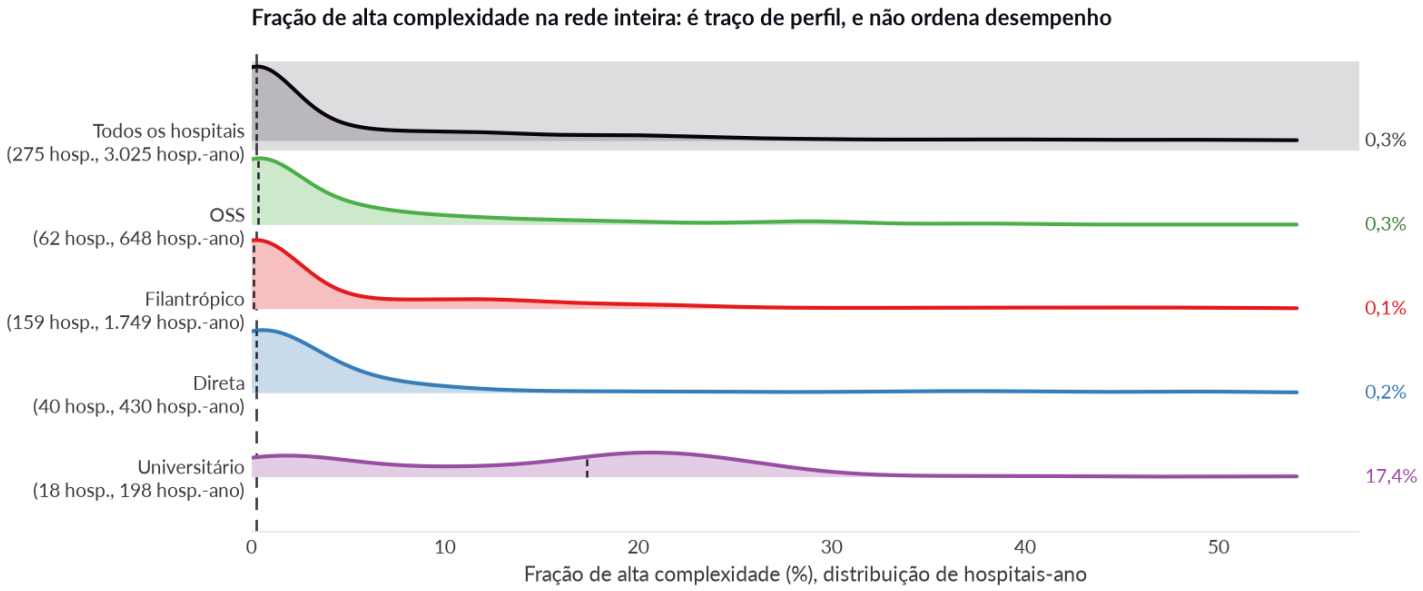


(b) Tempo de permanência

Figura 9: Distribuição da mortalidade e do tempo de permanência por categoria de gestão. São cinco curvas empilhadas: a de cima, **em preto e sobre faixa cinza**, é o conjunto das quatro redes, e a tracejada que atravessa a figura é a mediana dele. **A área sob cada curva vale o mesmo**, qualquer que seja o tamanho do grupo: a altura compara concentração, e não quantidade de hospitais. A haste dentro de cada curva marca a mediana daquela rede, repetida em número à direita, e o parêntese diz quantos hospitais e quantos hospitais-ano. O conjunto soma os **275** do painel, que são exatamente as quatro redes desenhadas. Cada curva é uma estimativa de densidade por núcleo, e a janela do eixo vai até o **maior nonagésimo quinto percentil entre as redes**, para que o corpo de todas apareça. **Nenhuma observação saiu do cálculo**: a mediana vem da série inteira, e a janela só decide até onde o quadro mostra.

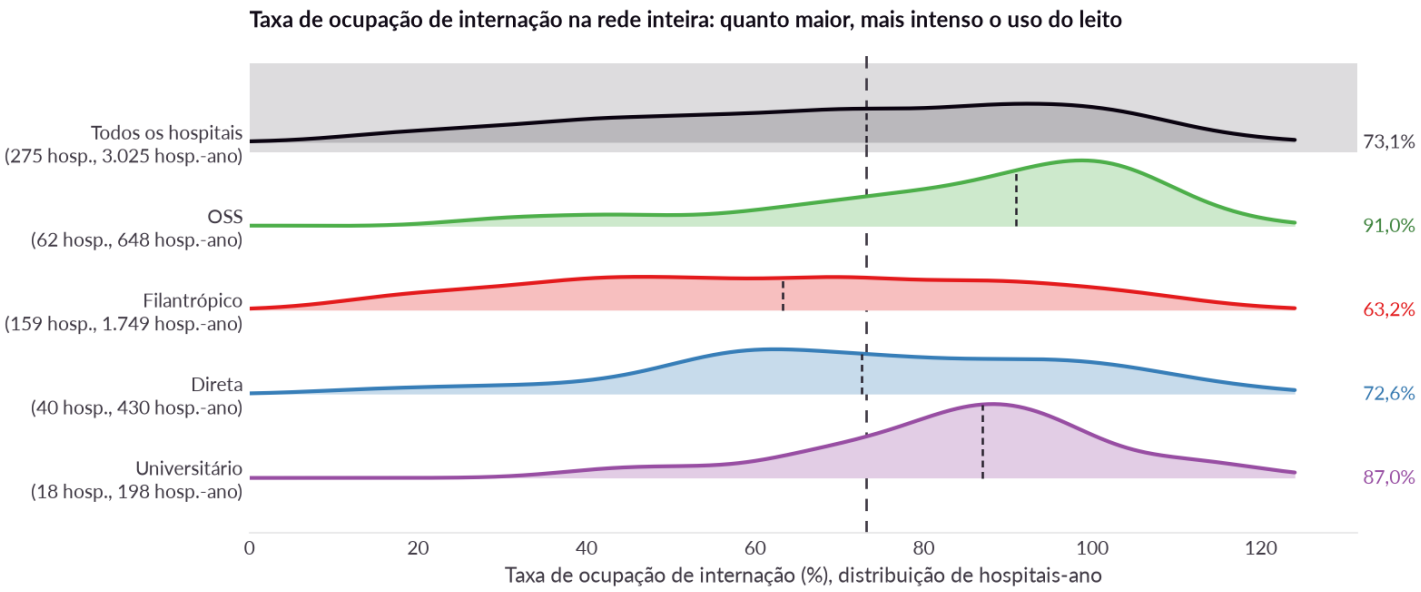


(a) Faturamento real por saída, R$ de dez/2025

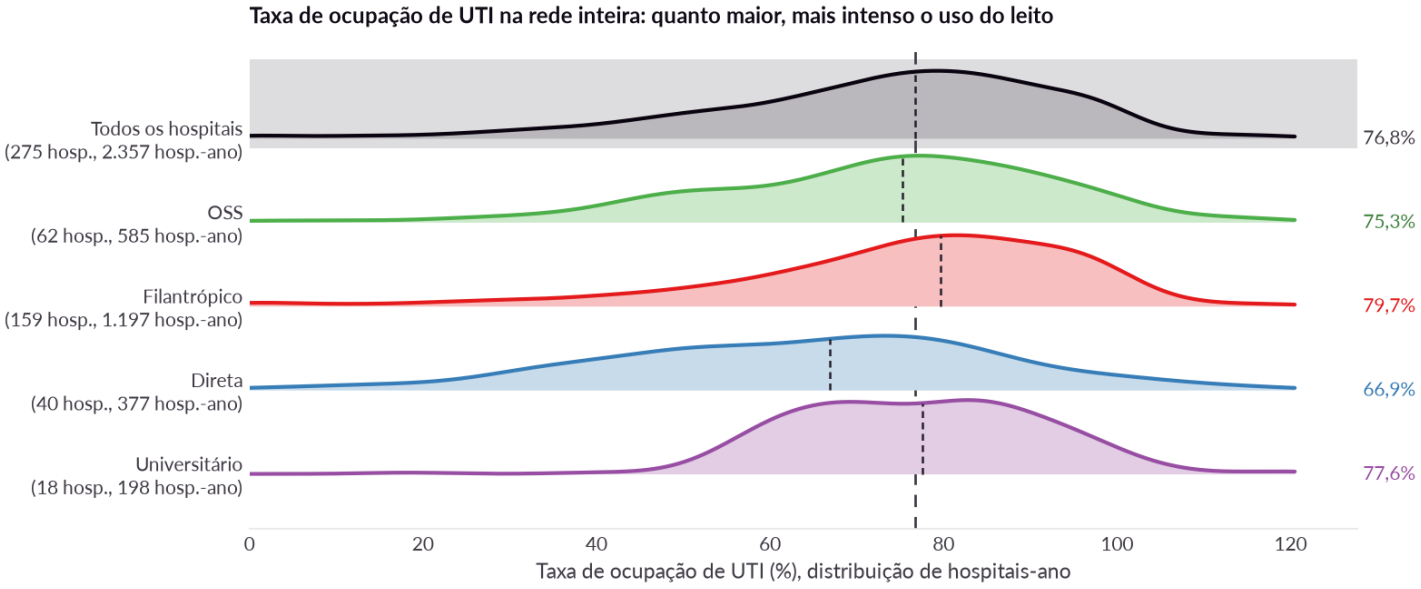


(b) Fração alta complexidade

Figura 10: Distribuição do faturamento real por saída (R$ de dez/2025) e da fração de alta complexidade por categoria de gestão. Três das quatro redes têm medianas de faturamento entre R$ 1.243 e R$ 1.356; o Universitário marca R$ 2.757. A curva larga e baixa do Filantrópico é a diversidade interna do grupo.



(a) Taxa de ocupação de internação



(b) Taxa de ocupação de UTI

Figura 11: Distribuição das taxas de ocupação de internação e de UTI por categoria de gestão (na UTI, apenas hospitais com leito de UTI SUS cadastrado; ver o quadro acima). Na ocupação de internação, OSS e Universitário estão inteiros à direita de Direta e Filantrópico. Na UTI as quatro curvas se parecem, e a do Filantrópico é a mais à direita.

Do que cada rede é feita

Antes de comparar desempenho, vale perguntar com que *material* cada rede opera. Quando alguém diz "OSS", está falando de que tipo de hospital? A Figura 12 responde combinando as duas capacidades que mais separam um hospital de outro: ter UTI do SUS e fazer alta complexidade. As duas andam juntas na prática, porque a UTI é a retaguarda do procedimento complexo, e é a combinação, mais do que cada uma isolada, que descreve o hospital.

A resposta é que as redes não operam com o mesmo material. Nos Universitários, **96% dos hospitais-ano têm as duas coisas**; nas OSS são **78%**, contra 69% na administração Direta e **54% no Filantrópico**. E na outra ponta: mais de um quarto dos hospitais-ano filantrópicos (26%) não tem nem UTI nem alta complexidade, contra 6% nas OSS, 11% na Direta e nenhum hospital-ano universitário. Isso não desqualifica comparação nenhuma, mas explica por que ela precisa ser feita dentro de grupos de estrutura parecida, que é o que a Seção 3 faz.

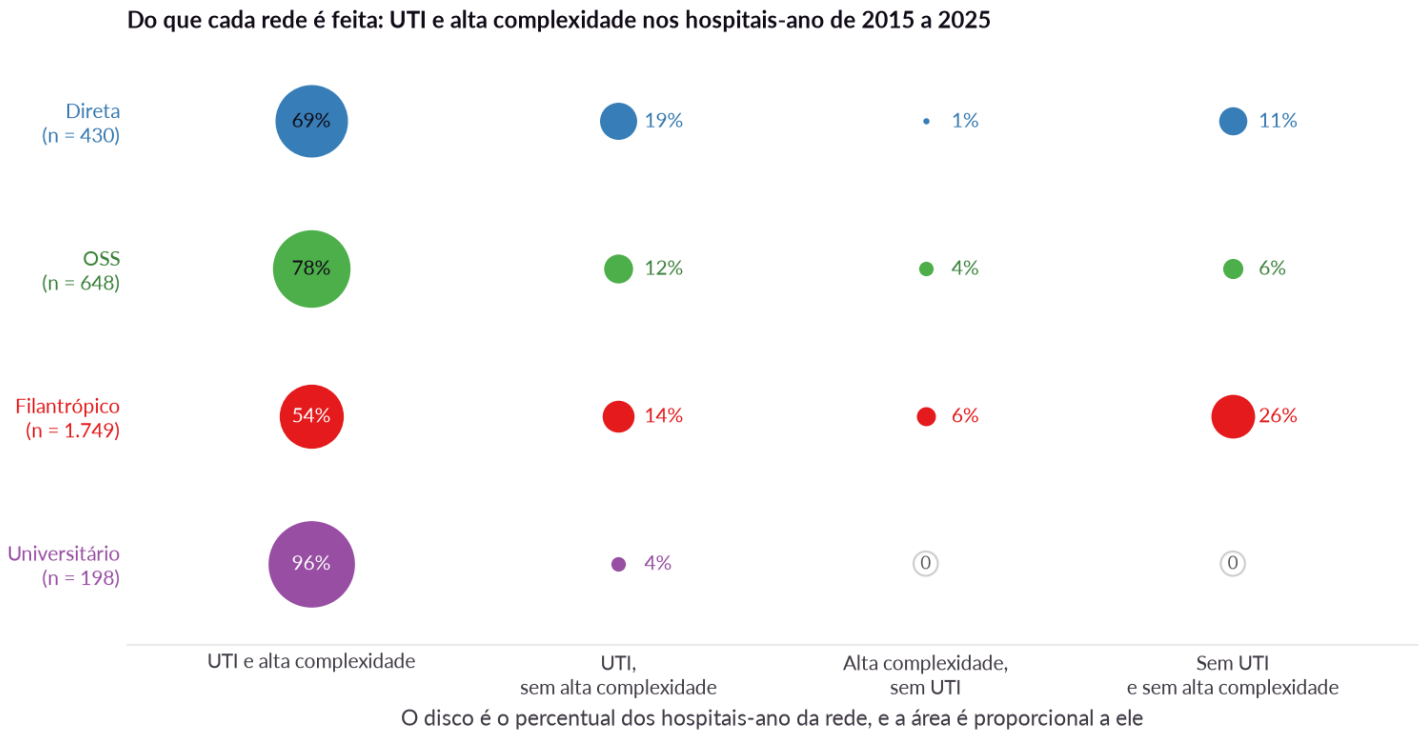
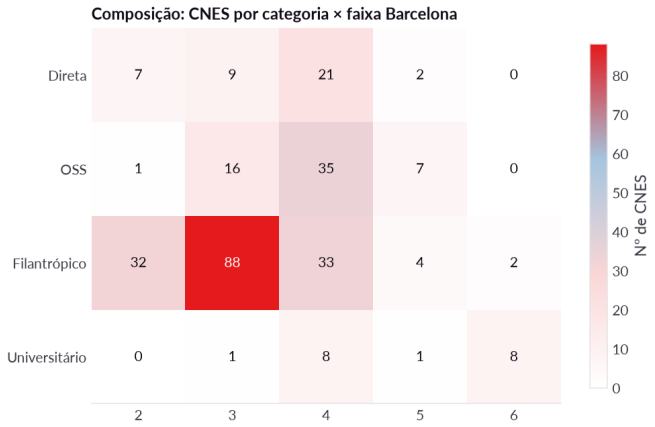
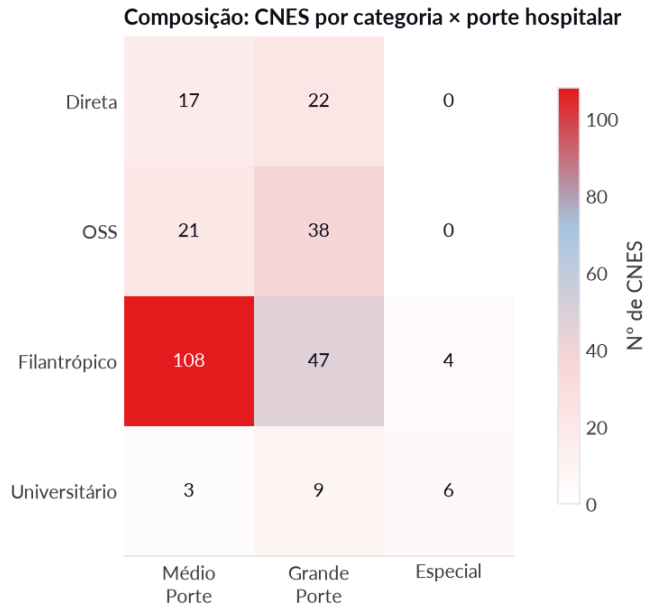


Figura 12: Composição estrutural de cada rede: o que os seus hospitais-ano oferecem, em UTI do SUS e em alta complexidade, de 2015 a 2025. O disco é o percentual dos hospitais-ano da rede, e a área é proporcional a ele. Cada linha é uma rede e cada coluna é uma combinação das duas capacidades. **O disco é o percentual dos hospitais-ano daquela rede**, e a área dele é proporcional ao percentual: disco grande é combinação frequente na rede. **As quatro colunas de uma linha somam 100%**. A cor é a da rede, e o círculo vazado com um zero marca a combinação que naquela rede não existe. A unidade é o **hospital-ano**: quem habilita UTI no meio do período conta nos dois grupos, cada ano no seu. "Tem UTI" é registrar ao menos um leito de UTI SUS no ano; "faz alta complexidade" é registrar ao menos uma internação de alta complexidade.

Uma pergunta indispensável antes de comparar categorias: **elas têm hospitais parecidos o bastante para a comparação ser justa?** A Figura 13 responde contando os hospitais de cada categoria em cada faixa de complexidade e porte. A sobreposição é boa nas faixas 3 e 4, onde estão 30 dos 39 hospitais da administração Direta e 51 dos 59 das OSS; mas **nem a Direta nem as OSS têm hospital na faixa 6**, e a faixa 2 é quase toda Filantrópica (32 dos 40 hospitais). No porte, nem as OSS nem a administração Direta têm hospital especial, e dos dez do painel **seis são Universitários e quatro Filantrópicos**. Em consequência, **comparações entre categorias são seguras nas faixas 3 e 4 e nos portes médio e grande**, onde todos os grupos públicos e filantrópicos estão presentes; fora dessa região faltam hospitais para comparar.



(a) Categoria por faixa de complexidade



(b) Categoria por porte

Figura 13: Quantos hospitais cada categoria tem em cada faixa de complexidade e em cada porte (contagem de CNES; roxo mais escuro indica mais hospitais). Aqui cada hospital conta uma única vez, na categoria em que passou a maior parte do período; por isso as células somam 275, e não a soma por período do texto. Cada célula é o número de hospitais daquela categoria naquela faixa ou porte. **Célula com zero é alerta**: sem hospital daquele perfil, não há o que comparar.

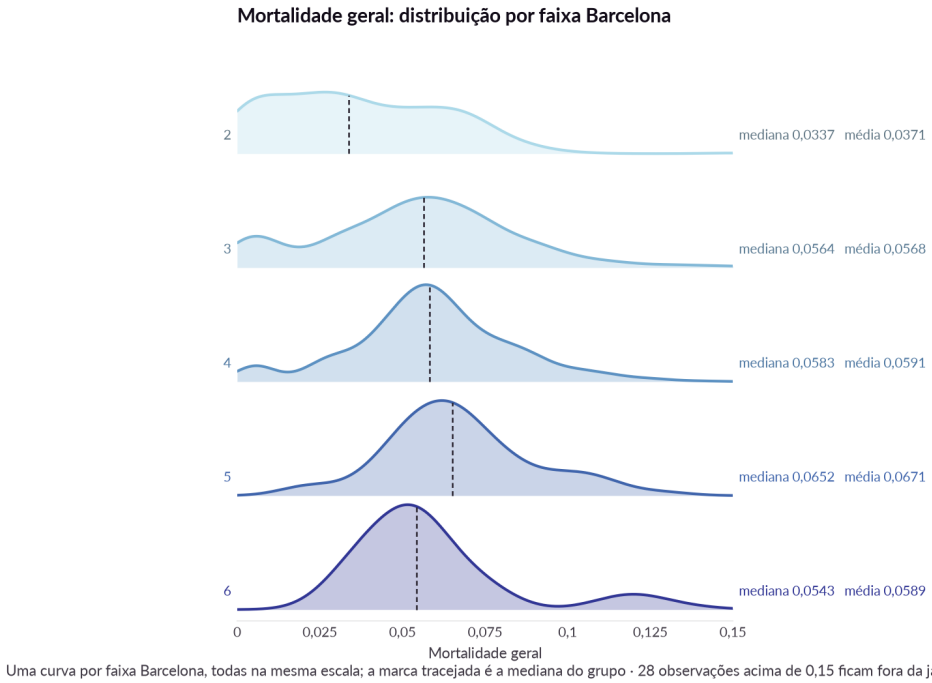
1.4 Complexidade e porte: os grandes divisores da rede

Antes de qualquer comparação entre modelos de gestão, é preciso reconhecer o quanto a complexidade e o porte, sozinhos, separam os hospitais. As Figuras 14 a 16 mostram a mediana e a média de cada indicador ao longo das faixas Barcelona de complexidade (da faixa 2, menor, à 6, maior), e as Figuras 17 a 21, ao longo dos portes. As duas medidas de centro aparecem juntas de propósito: em indicadores com muitos zeros, como a fração de alta complexidade, a mediana de um grupo pode ser zero enquanto boa parte dele é positiva, e a barra sozinha seria lida como "este grupo não faz".

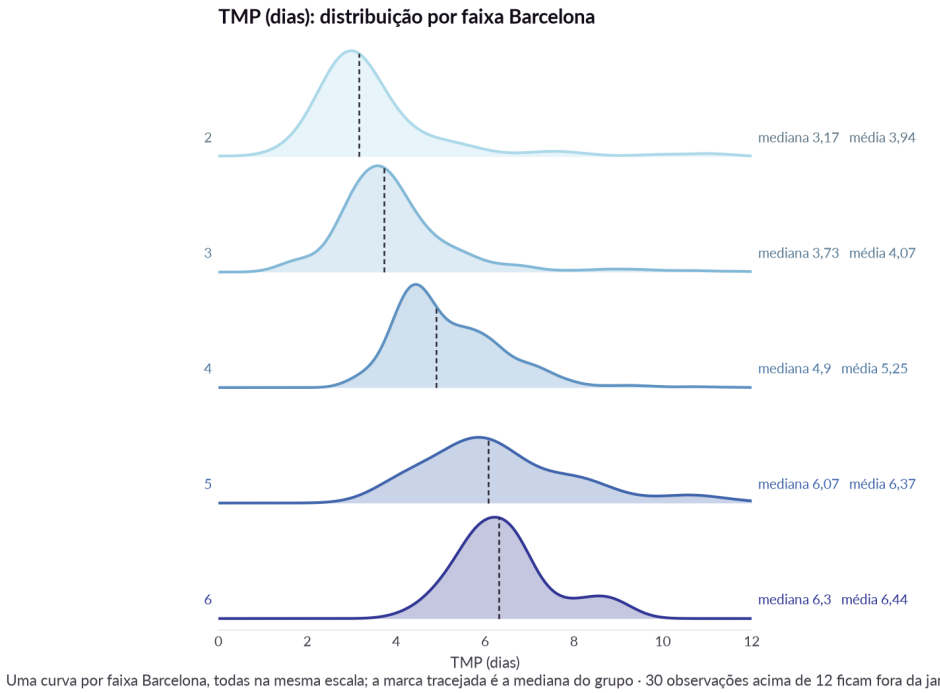
O padrão é de escada: o faturamento real mediano por saída (R$ de dez/2025) sobe de **R$ 631 na faixa 2 para R$ 3.780 na faixa 6** (quase seis vezes), o tempo de permanência vai de 3,16 para 6,30 dias, a fração *mediana* de alta complexidade sai de zero e chega a 22,5% (a média correspondente parte de 7,9%, e a diferença entre as duas é o assunto da Figura 19 e das que a acompanham), e a taxa de ocupação de internação sobe de 35,1% para a casa dos 90%. A mortalidade cresce com a complexidade até a faixa 5 (de 3,20% para 6,52%) e **recua na faixa 6 (5,43%)**, um sinal de que os hospitais de ponta convertem estrutura em resultado. Vale notar que **33 dos 40 hospitais da faixa 2 não têm UTI SUS** pela mediana dos onze anos (a mesma regra que define o estrato E1 na Subseção 1.9.2), e que 32 deles não registram nenhuma diária de UTI em todo o período; a diferença de dois hospitais é o piscar cadastral (ver Subseção 1.9.2). No porte, a mesma escada: faturamento real mediano de **R$ 1.035 nos médios, R$ 1.806 nos grandes e R$ 3.831 nos especiais**.

A conclusão para todo o restante do documento: **complexidade e porte precisam ser sempre levados em conta ao comparar categorias de gestão**, sob pena de atribuir ao modelo de gestão diferenças que são, na verdade, de perfil assistencial.

A Seção 1.5 confirma esse papel de grande divisor por outro caminho, medindo o que anda junto com o quê e de onde vem a variação de cada indicador.

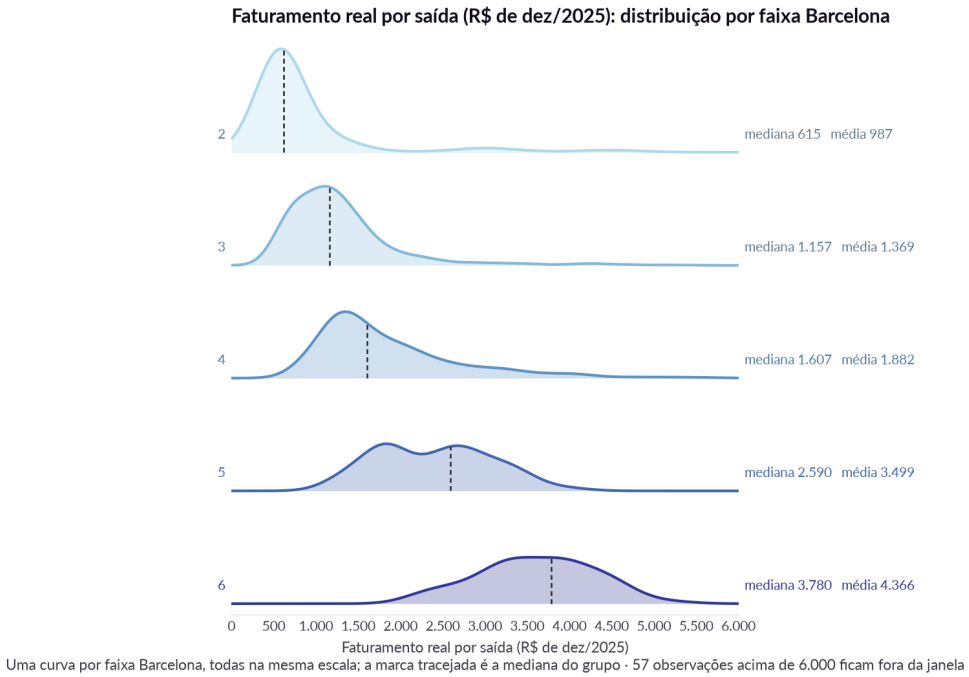


(a) Mortalidade geral

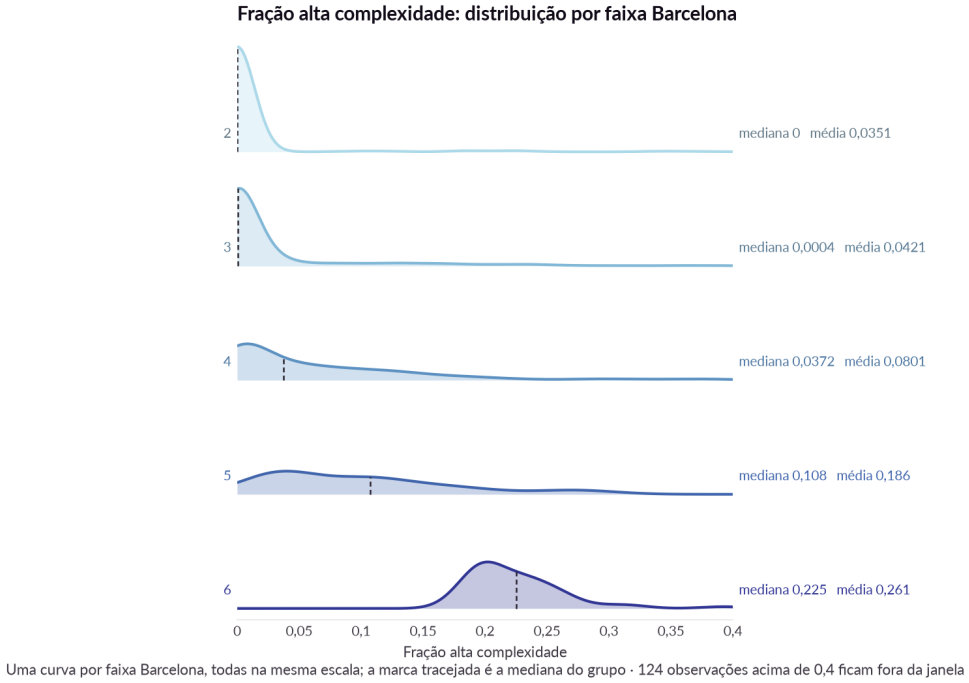


(b) TMP

Figura 14: Distribuição da mortalidade e do TMP por faixa Barcelona de complexidade (2 a 6), com o valor de cada uma. Uma curva por faixa, todas na mesma escala de x; a marca tracejada é a mediana do grupo, e os dois valores estão escritos à direita. Na mortalidade a mediana sobe até a faixa 5 e desce na 6; no TMP a escada é sempre ascendente.

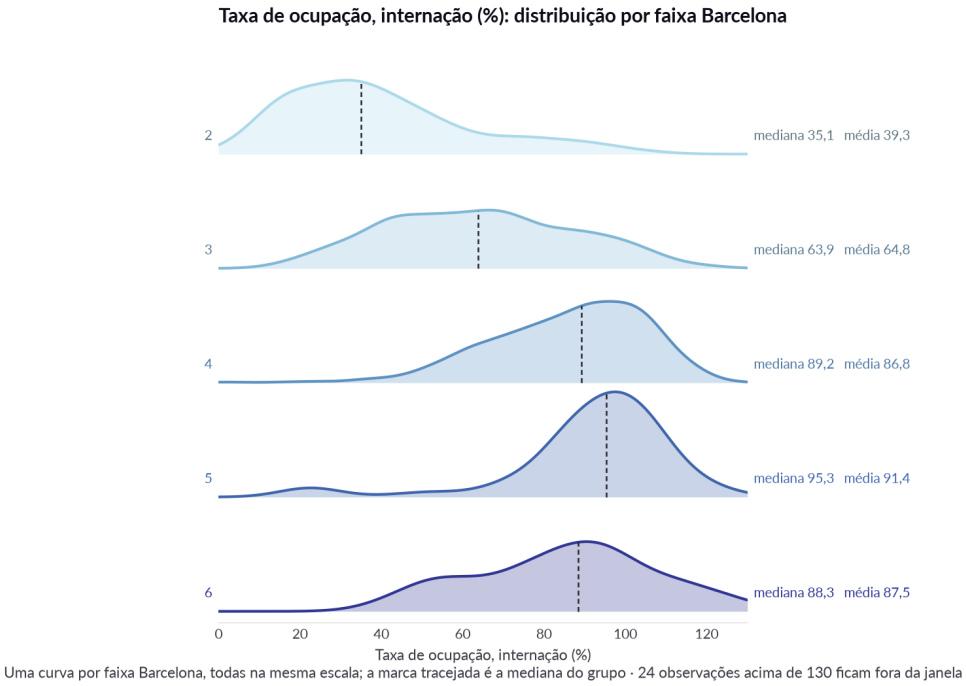


(a) Faturamento real por saída, R$ de dez/2025

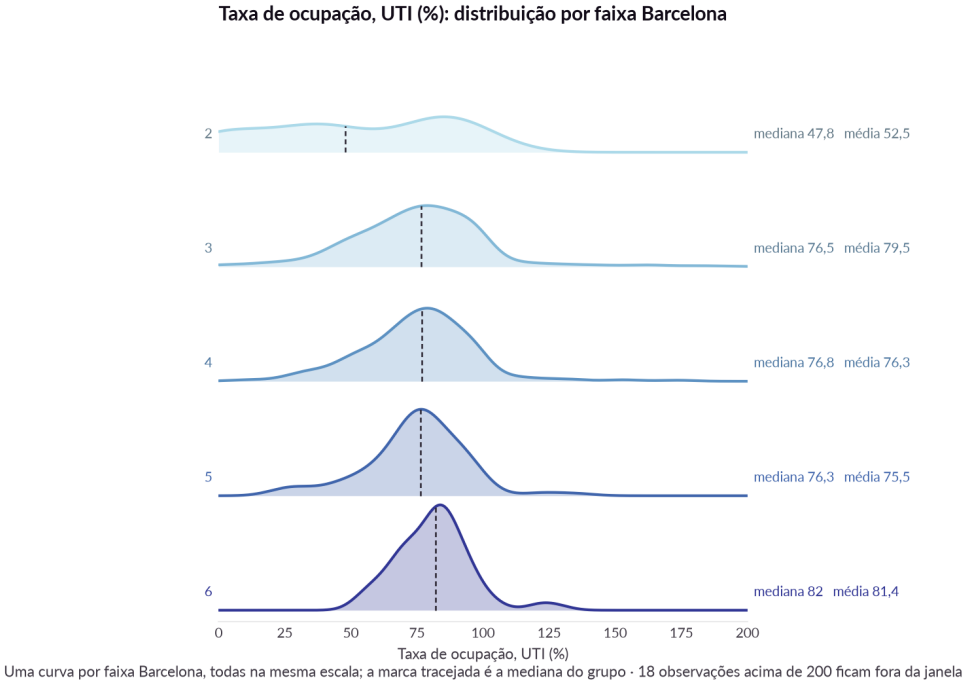


(b) Fração alta complexidade

Figura 15: Distribuição do faturamento real por saída (R$ de dez/2025) e da fração de alta complexidade por faixa Barcelona. A escada do faturamento é a mais íngreme do documento: da faixa 2 à 6 a mediana mais que quintuplica. Na alta complexidade a mediana parte de zero nas faixas baixas e **a média não**: 0,0787 na faixa 2 e 0,0427 na 3.

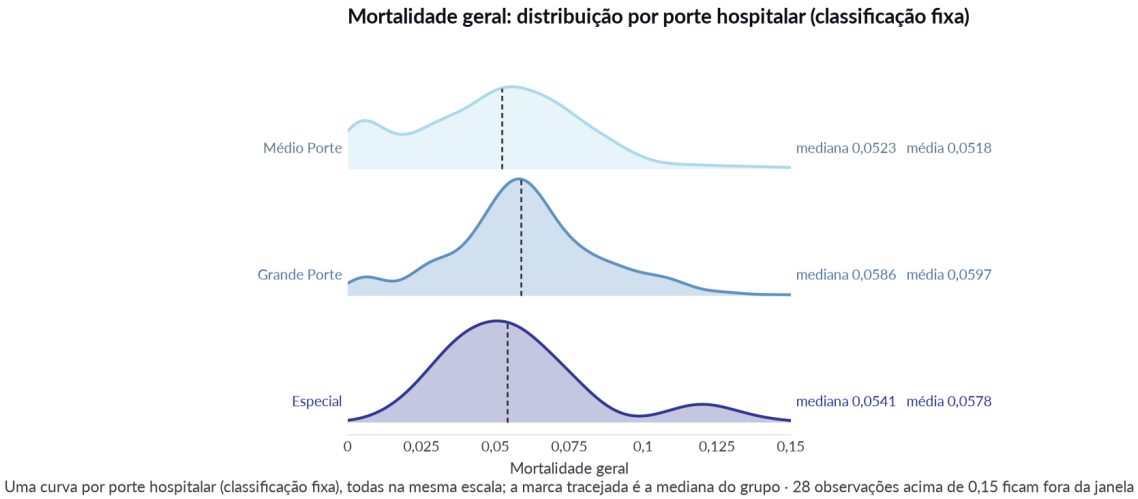


(a) Taxa de ocupação de internação

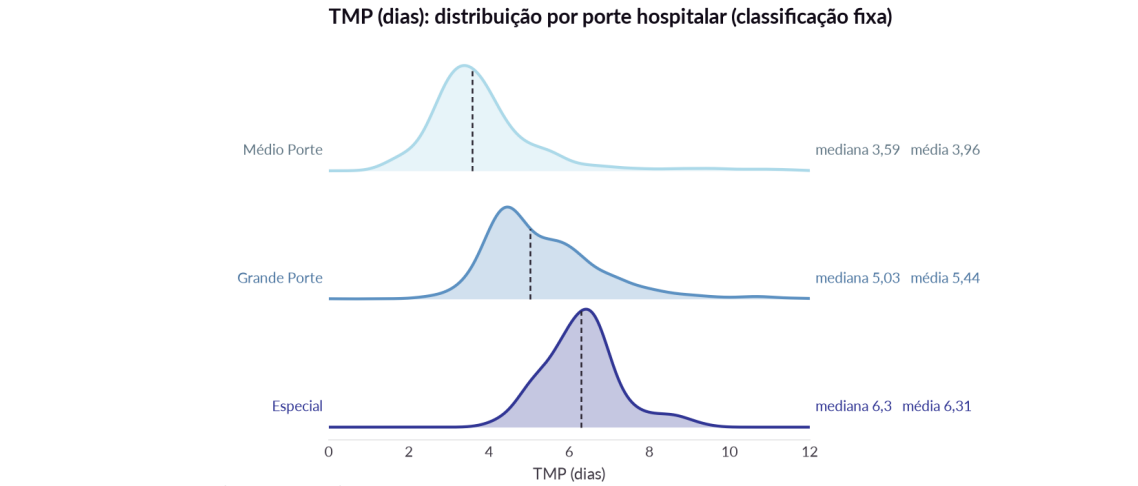


(b) Taxa de ocupação de UTI

Figura 16: Distribuição das taxas de ocupação de internação e de UTI por faixa Barcelona (na UTI, apenas hospitais com leito de UTI SUS cadastrado; ver Seção 1.3). Quanto mais complexo o hospital, mais cheio ele opera. A faixa 2 fica bem abaixo das demais na UTI (mediana de 37,3% contra a casa dos 76%), e ali **33 dos seus 40 hospitais não têm UTI SUS** e ficam fora da conta: a curva descreve os poucos que têm.

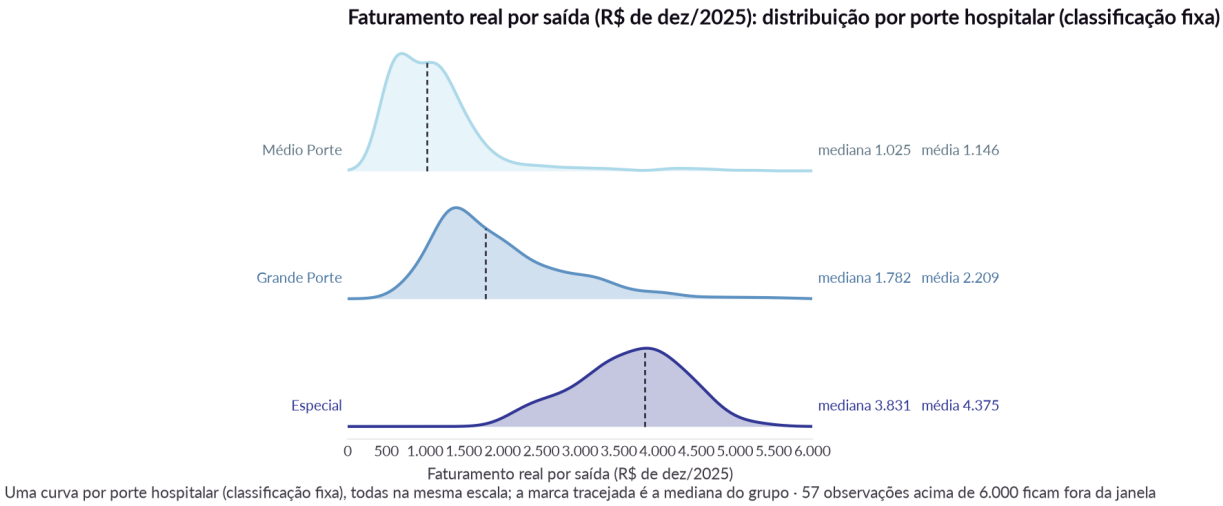


(a) Mortalidade geral

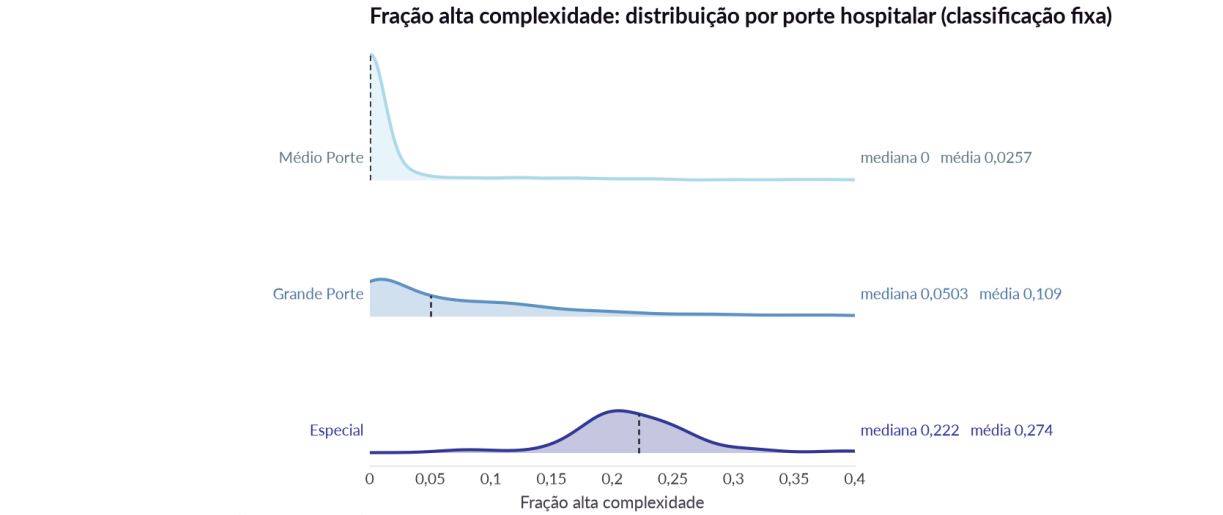


(b) TMP

Figura 17: Distribuição da mortalidade e do TMP por porte (classificação fixa pela mediana de leitos: 149 hospitais médios, 116 grandes e 10 especiais). Mesma leitura das figuras por faixa, agora por porte: hospital maior segura o paciente por mais tempo e tem mortalidade um pouco maior.



(a) Faturamento real por saída, R$ de dez/2025



(b) Fração alta complexidade

Figura 18: Distribuição do faturamento real por saída (R$ de dez/2025) e da fração de alta complexidade por porte, com a mediana e a média de cada porte ao lado da curva. Na alta complexidade do Médio Porte a mediana é 0 e a média é **0,0283**, e é essa distância que as duas figuras seguintes decompõem. O faturamento mediano do porte especial é mais de três vezes o do médio. **Cuidado com a mediana zero do Médio Porte na alta complexidade**: ela diz que o hospital médio *típico* não faz alta complexidade em metade dos anos, e não que hospitais médios não fazem. A média ao lado já mostra que o grupo não é zero.

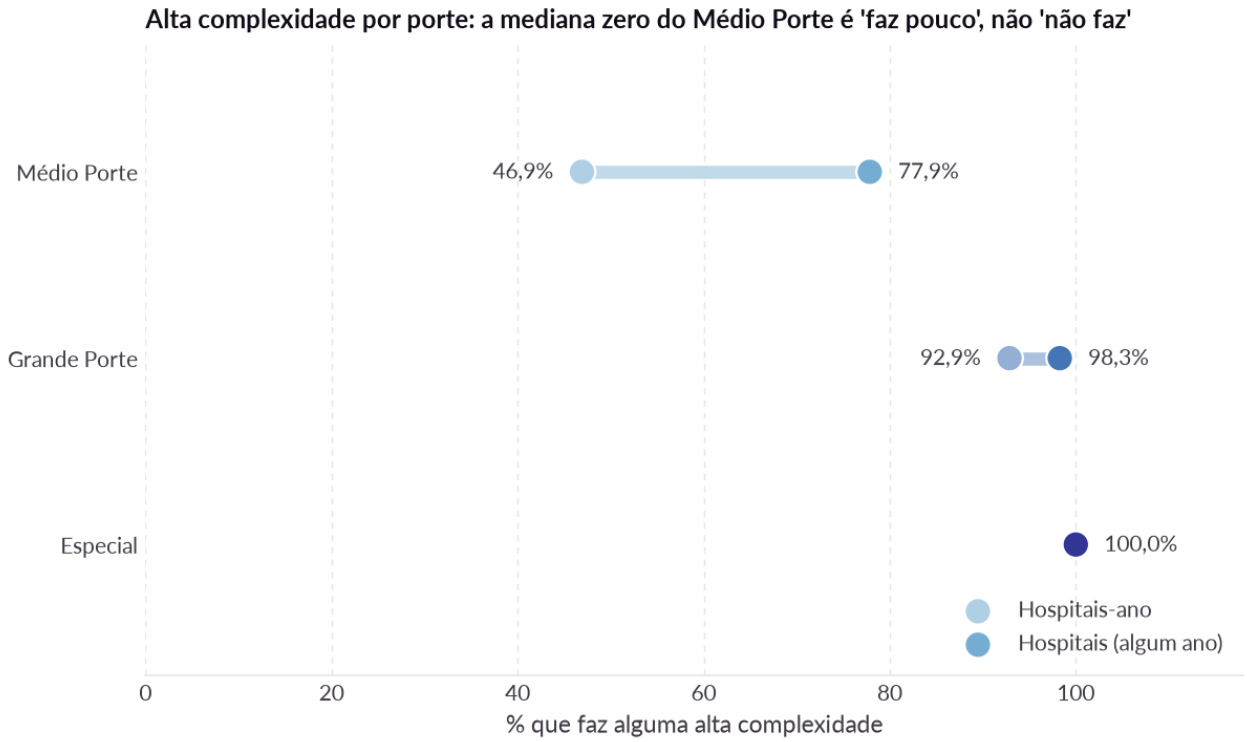


Figura 19: Quem faz alta complexidade, por porte. A mediana zero do Médio Porte esconde que **79,2% dos seus hospitais** fazem alta complexidade em algum ano. A mediana zero do Médio Porte é "faz pouco", não "não faz". A primeira figura conta *quantos* hospitais médios fazem alta complexidade em algum ano; a segunda, *quanto* isso soma. O elo está no Apêndice A.1: **quem faz, faz pouco**, 0,44% das internações no Médio Porte. A barra cheia é o percentual de hospitais (CNES) do porte com alta complexidade em ao menos um dos onze anos; a barra em tom mais claro é o percentual de hospitais-ano com fração positiva. A diferença entre as duas é a intermitência.

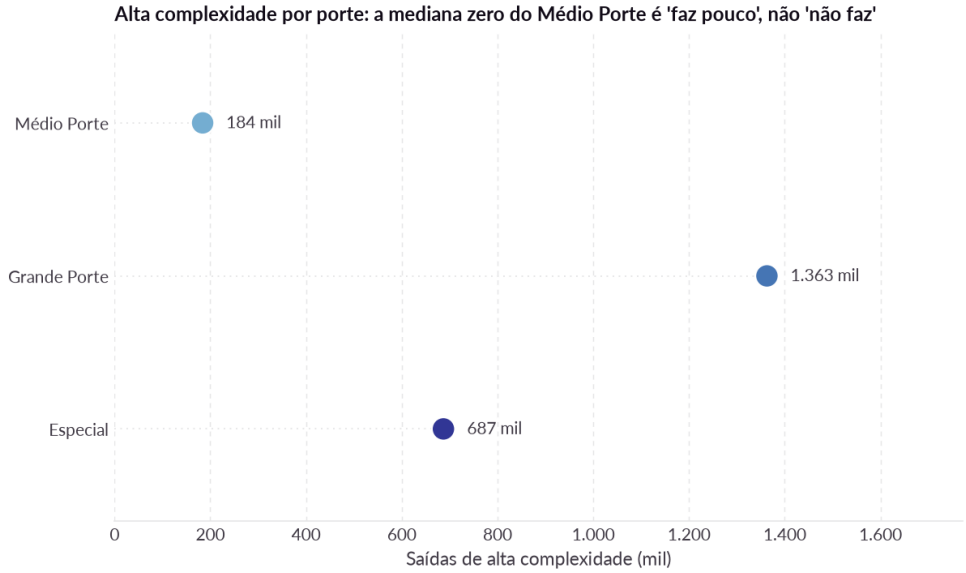
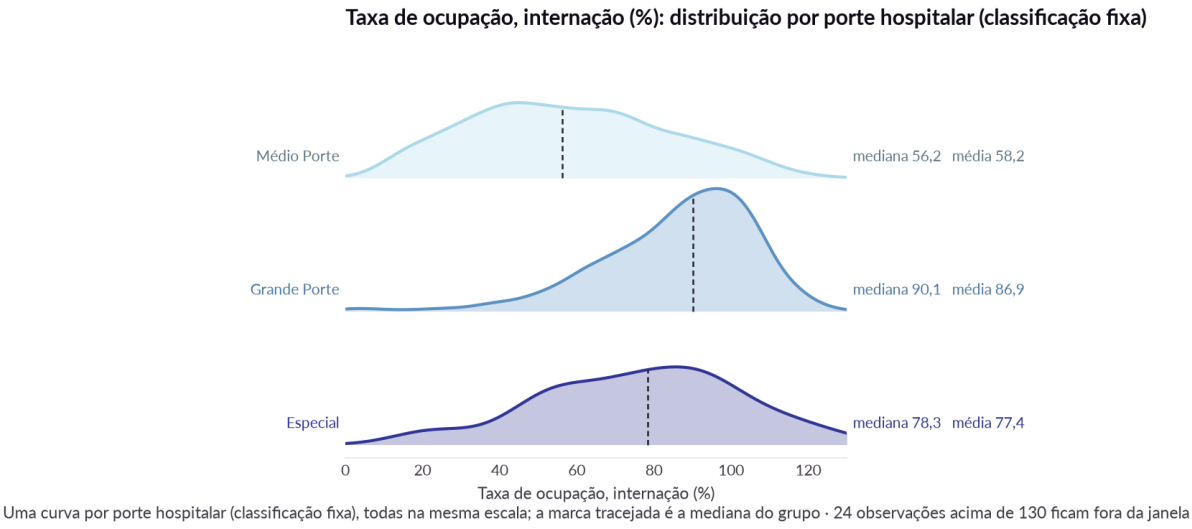
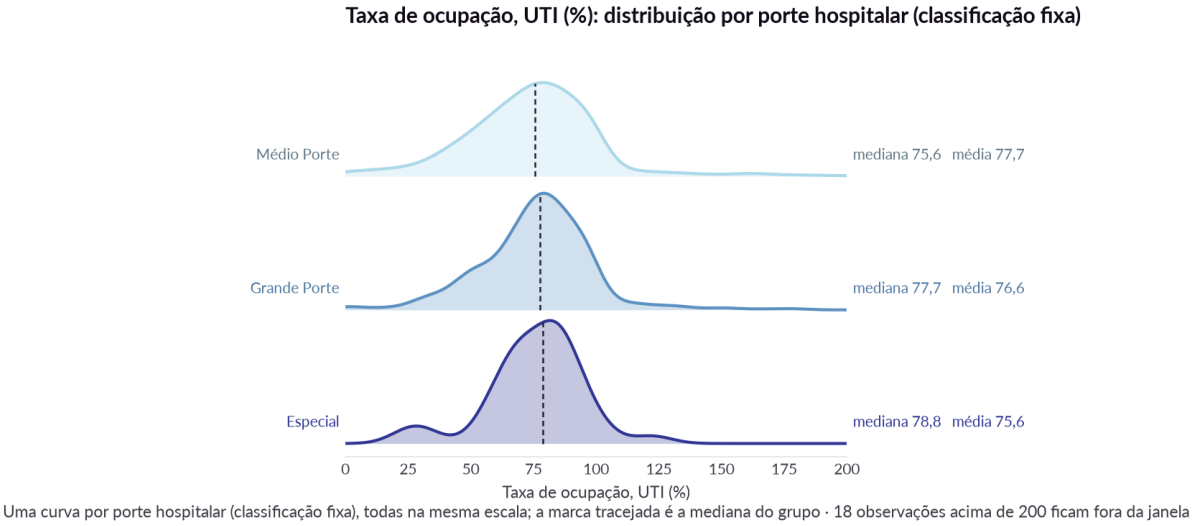


Figura 20: Volume de alta complexidade por porte, 2015 a 2025. O Médio Porte responde por **220 mil saídas** de alta complexidade no período: é o porte em que a mediana zero mais engana.



(a) Taxa de ocupação de internação



(b) Taxa de ocupação de UTI

Figura 21: Distribuição das taxas de ocupação de internação e de UTI por porte (na UTI, apenas hospitais com leito de UTI SUS cadastrado; ver Seção 1.3). Hospital maior opera mais cheio, na internação e na UTI.

A outra ponta: os 90% da produção que não são alta complexidade

As figuras anteriores descrevem em detalhe a alta complexidade, que é **9,9% das internações do painel**: uma **razão agregada**, e não a média das razões dos hospitais, que é 0,0759 na Tabela 1. Falta dizer o que é o resto, e o resto é grande: **21,0 milhões de internações**, ou 90,3% de tudo o que estes 275 hospitais produziram em onze anos. É o trabalho corrente da rede.

A figura espelho exata da alta complexidade seria inútil: **100% dos hospitais fazem produção de não alta complexidade, em todos os anos**, e a fração é simplesmente o complemento da outra. As três leituras que informam são outras, e estão no Apêndice A.1: o quanto cada porte *depende* dessa produção, quantos hospitais vivem *só* dela, e o volume que ela move. O que elas mostram, em uma linha: o Médio Porte é quase inteiramente produção de não alta complexidade (96,8%), e mesmo o porte Especial, que concentra a alta complexidade do estado, tem três quartos da sua produção nessa faixa. **Nenhum porte da rede paulista vive de alta complexidade.**

Os 35 hospitais que nunca fazem alta complexidade são uma sub-rede coerente, e não uma lista de exceções. Comparados com os outros 254, são menores, mais rápidos e mais baratos, e descrevê-los junto com o resto distorce as duas coisas.

Tabela 5: O perfil de quem nunca registra alta complexidade, contra o restante do painel. Todos os valores são medianas de hospital-ano, no período completo; o corte é por CNES, e o hospital entra na coluna da direita se a sua contagem de internações de alta complexidade for zero nos onze anos.

	Faz alta em algum ano	Nunca faz alta
Hospitais	250	**35**
Leitos SUS	100	52
Internações por ano	5.950	2.217
Tempo de permanência (dias)	4,40	3,29
Mortalidade	0,058	0,030
Faturamento real por saída (R$)	1.404	688
Taxa de ocupação de internação (%)	76,8	50,0

Eles têm **metade dos leitos**, produzem **pouco mais de um terço das internações por ano**, faturam **menos da metade por saída** e operam com **27 pontos a menos de ocupação**. A mortalidade menor (3,0% contra 5,8%) **não é qualidade superior**: é casuística de outra natureza, e lê-la como desempenho seria o erro que a Seção 1.3 adverte. Por rede, são **22 Filantrópicos, 7 da administração Direta e 6 sob gestão de OSS**; 21 dos 35 estão na faixa 2, a mais baixa, e juntos respondem por **4,6% da produção do painel**: pouco no agregado, mas são a porta de entrada do SUS em municípios onde não há outra.

Do lado das redes, a produção de não alta complexidade repete o ordenamento de intensidade do resto do documento. Em **internações de não alta complexidade por leito SUS** (razão distinta das saídas totais por leito da Subseção 1.7, e a ordem entre Filantrópico e Direta se inverte entre as duas), a mediana é de **62,6 nas OSS**, contra 52,9 no Filantrópico, 48,4 na Direta e 47,7 no hospital universitário: o regime mais intenso das OSS **não é um fenômeno da alta complexidade**, e aparece igual no trabalho corrente. Em fatia do volume total, o Filantrópico responde por 39,2%, as OSS por 33,1%, o hospital universitário por 14,3% e a Direta por 13,3%.

1.5 O que anda junto com o quê: correlações e origem da variação

A seção anterior mostrou o que separa os hospitais. Esta responde duas perguntas que decorrem dela e que governam tudo o que vem depois: quais indicadores andam juntos, e de onde vem a variação de cada um.

A Figura 22 resume, num único mapa, o quanto cada par de indicadores anda junto. A medida usada (correlação de Spearman) vai de 0, quando dois indicadores não têm relação, a 1, quando crescem sempre juntos.

Os pares mais fortes fazem sentido imediato para a gestão: **faturamento por saída e fração de alta complexidade (0,76)**, faturamento e tempo de permanência (0,53), e tempo de permanência e ocupação de internação (0,50). **As duas ocupações, ao contrário do que se poderia esperar, quase não andam juntas: 0,29.** Ter a enfermaria cheia diz pouco sobre ter a UTI cheia, e é coerente com o que a Seção 1.3 mostra sobre a UTI ser um recurso de perfil assistencial e não de volume. A **complexidade Barcelona conversa com quase tudo**: 0,60 com alta complexidade, 0,61 com taxa de ocupação de internação, 0,60 com faturamento, 0,59 com TMP e 0,23 com mortalidade; **a exceção é a ocupação de UTI, com 0,03**, o menor valor da matriz. É o retrato numérico do papel de grande divisor que a Seção 1.4 descreveu. Já a mortalidade se associa mais à ocupação de UTI (0,24) do que à de internação (0,21), na direção esperada: onde a casuística é mais grave, usa-se mais UTI e morre-se mais. A margem, porém, é estreita (0,03), e não sustenta muito peso: as duas associações são fracas e praticamente equivalentes. Este par é calculado sobre o domínio em que a ocupação de UTI é definida (Seção 1.3).

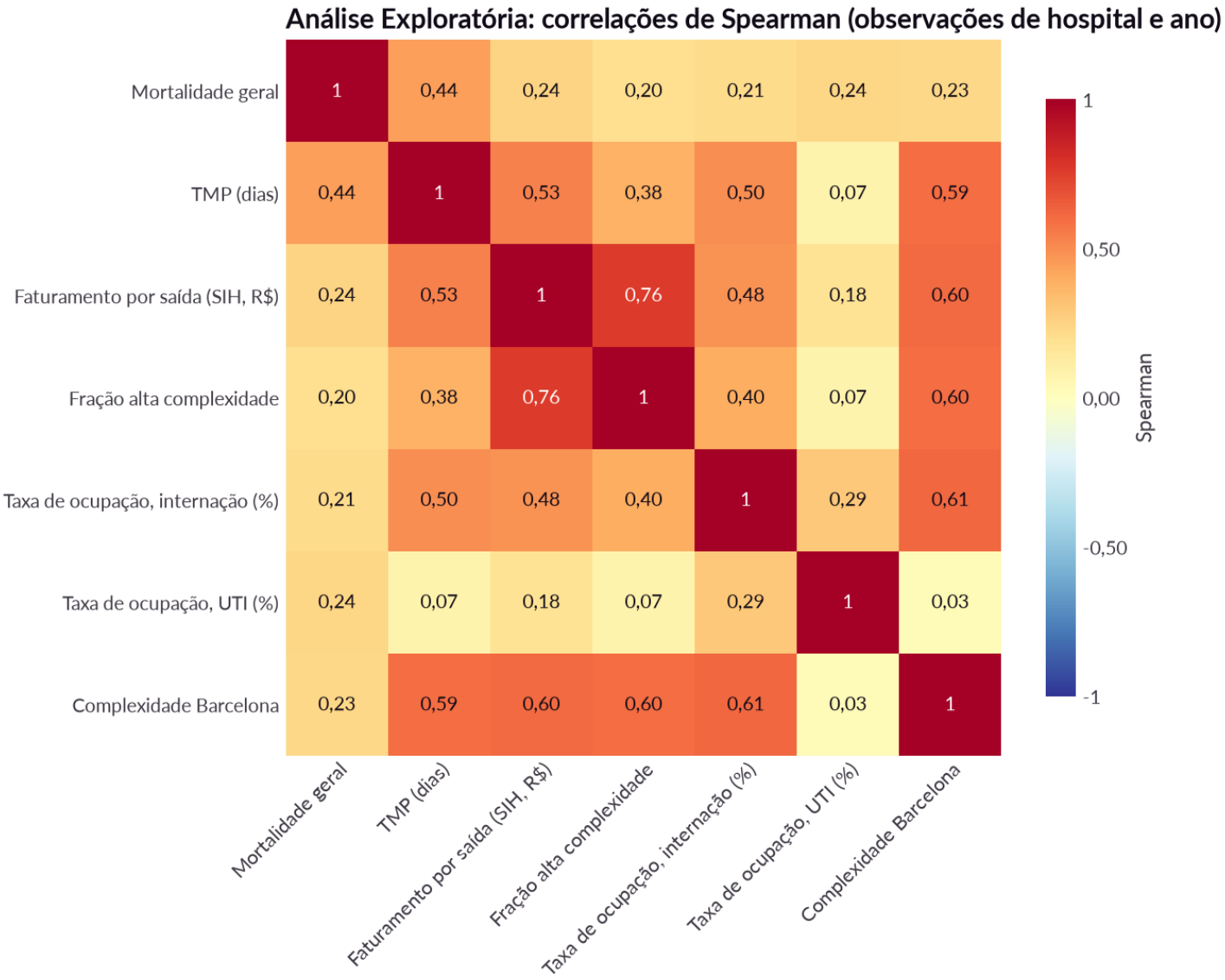


Figura 22: Mapa de correlações entre os indicadores, as ocupações e a complexidade Barcelona. Vermelho mais escuro indica relação mais forte; todos os valores estão impressos. A medida é a **correlação de Spearman**, escolhida por captar relações de ordem sem exigir forma linear. Percorra a linha de um indicador. **Vermelho é relação positiva e azul é negativa**; o tom claro do meio é a ausência de relação. O par das duas ocupações fica em 0,29: quase nenhuma relação entre enfermaria cheia e UTI cheia.

A Figura 23 e a Tabela 6 respondem a outra pergunta essencial: **quando um indicador varia, essa variação vem de comparar hospitais diferentes ou do mesmo hospital mudando ao longo dos anos?** A resposta se divide, e a divisão é nítida. Em **cinco dos seis indicadores** a variação vem quase toda das diferenças entre hospitais. Na fração de alta complexidade, **apenas 5,9% da variação total acontece dentro do mesmo hospital** ao longo da década; no faturamento são 9,5%, no tempo de permanência 12,0%, na mortalidade 15,9%, e na taxa de ocupação de internação 16,4%.

A ocupação de UTI é a exceção, e é uma exceção grande: 68,8% da sua variação acontece dentro do próprio hospital. Ela não fica um pouco acima dos demais: fica em outro regime. Enquanto os outros cinco se movem entre 6% e 16%, a ocupação de UTI passa de dois terços, e é o único indicador do painel em que o mesmo hospital difere mais de si mesmo ao longo do tempo do que difere dos vizinhos.

Em termos de gestão, portanto: **em quase tudo, cada hospital é muito parecido consigo mesmo, ano após ano, e muito diferente dos vizinhos, mas o uso da UTI não segue essa regra**. Os demais indicadores têm forte inércia institucional, e mudanças reais dentro de um hospital são eventos raros e valiosos de observar, o que dá ainda mais peso aos quatro casos de conversão da Subseção 3.7.

Tabela 6: De onde vem a variação de cada indicador: parcela que ocorre dentro do mesmo hospital ao longo dos anos e parcela que vem das diferenças entre hospitais.

Indicador	Dentro do hospital (%)	Entre hospitais (%)
Fração alta complex.	5,9	94,1
Faturamento por saída	9,5	90,5
TMP	12,0	88,0
Mortalidade geral	15,9	84,1
Taxa de ocupação, internação	16,4	83,6
Taxa de ocupação, UTI	68,8	31,2

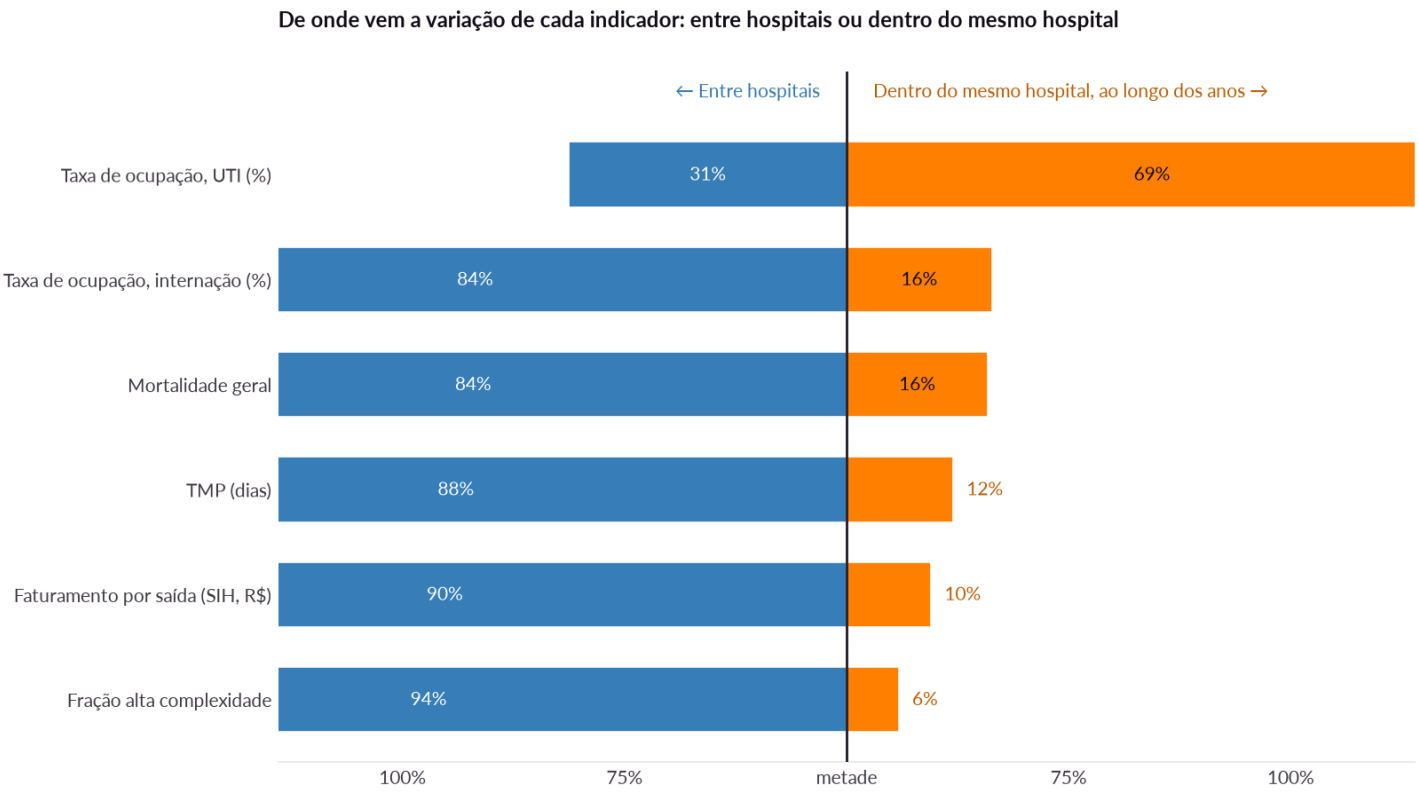


Figura 23: Parcela da variação de cada indicador que acontece dentro do mesmo hospital ao longo do tempo. Cada barra parte da **metade** para os dois lados: à esquerda, o que separa um hospital do outro; à direita, o que o mesmo hospital varia ao longo dos anos. A fração de alta complexidade tem 6% do lado direito e é quase uma impressão digital do hospital; a ocupação de UTI tem 69% e é a única que cruza a metade.

1.6 A evolução no tempo e a marca da pandemia

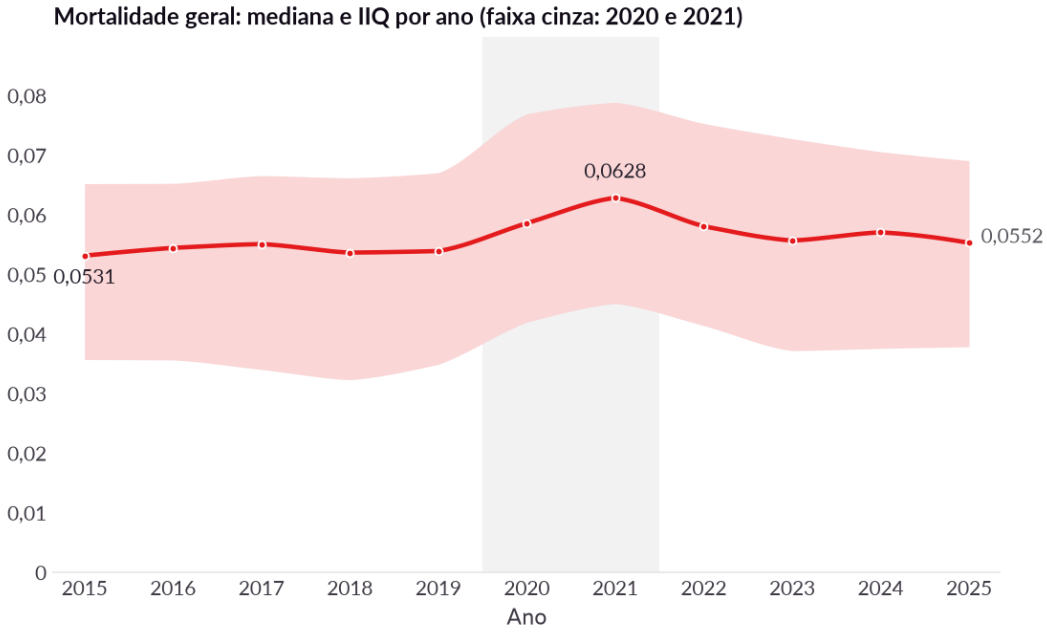
As Figuras 24 a 26 acompanham a mediana anual de cada indicador de 2015 a 2025, com a faixa cinza destacando o biênio 2020 e 2021. A pandemia deixou marca em quase tudo: a mortalidade (já sem as internações COVID) sobe de cerca de 5,3% para **5,85% em 2020 e 6,28% em 2021** e só retorna ao patamar histórico em 2025, sinal de que o biênio afetou também os pacientes não COVID. A taxa de ocupação de internação despenca para **64,5% em 2020** (leitos esvaziados por cancelamentos e medo) enquanto a de UTI dispara para **100,8% em 2021**, seu recorde na série: a mediana da rede passa acima da capacidade cadastrada, e não apenas a cauda, o que é a assinatura aritmética da superlotação já discutida na Seção 1.1. O tempo de permanência atravessa tudo estável, em torno de 4,3 dias.

O faturamento pede uma leitura em duas camadas. Em valores correntes (nominais), a mediana sobe de R$ 858 em 2015 para R$ 1.283 em 2025. Mas parte dessa alta é só inflação. Corrigindo tudo para o poder de compra de 2025 com o IPCA (Figura 27 e Tabela 7), a história muda de sinal: **em valores de 2025, o faturamento mediano caiu de R$ 1.415 para R$ 1.283, uma queda real de cerca de 10% na década**. Toda a alta aparente é inflação. Qualquer avaliação da evolução do faturamento deve, portanto, ser feita em valores reais ou com o nível de preços de cada ano devidamente considerado.

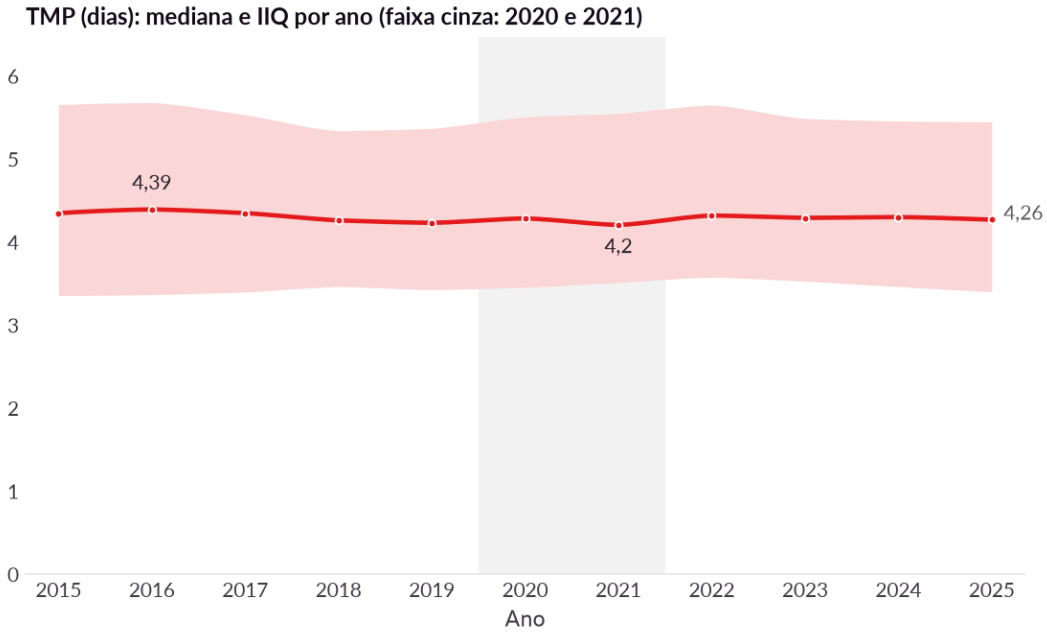
Por categoria (Figuras 28 a 30), o choque pandêmico é generalizado, mas a queda de ocupação de 2020 é mais funda na Direta e nos Filantrópicos; a fração de alta complexidade das OSS cresce de forma consistente na segunda metade do período; e, no faturamento em valores correntes, a Direta parte de nível parecido com as demais categorias e passa a liderar o faturamento mediano a partir de 2020.

Tabela 7: Faturamento por saída mediano por ano: em valores correntes e em valores de 2025 (corrigidos pelo IPCA, variação de dezembro a dezembro, IBGE). O fator indica por quanto o valor do ano é multiplicado para chegar a preços de 2025.

Ano	Nominal (R$)	Valores de 2025 (R$)	Fator IPCA
2015	858,42	1.414,56	1,6479
2016	875,96	1.358,05	1,5504
2017	880,26	1.325,62	1,5059
2018	898,32	1.303,92	1,4515
2019	933,31	1.298,72	1,3915
2020	1.019,99	1.357,97	1,3313
2021	1.048,25	1.268,03	1,2097
2022	1.168,18	1.335,76	1,1435
2023	1.191,90	1.302,70	1,0930
2024	1.261,90	1.315,66	1,0426
2025	1.283,46	1.283,46	1,0000

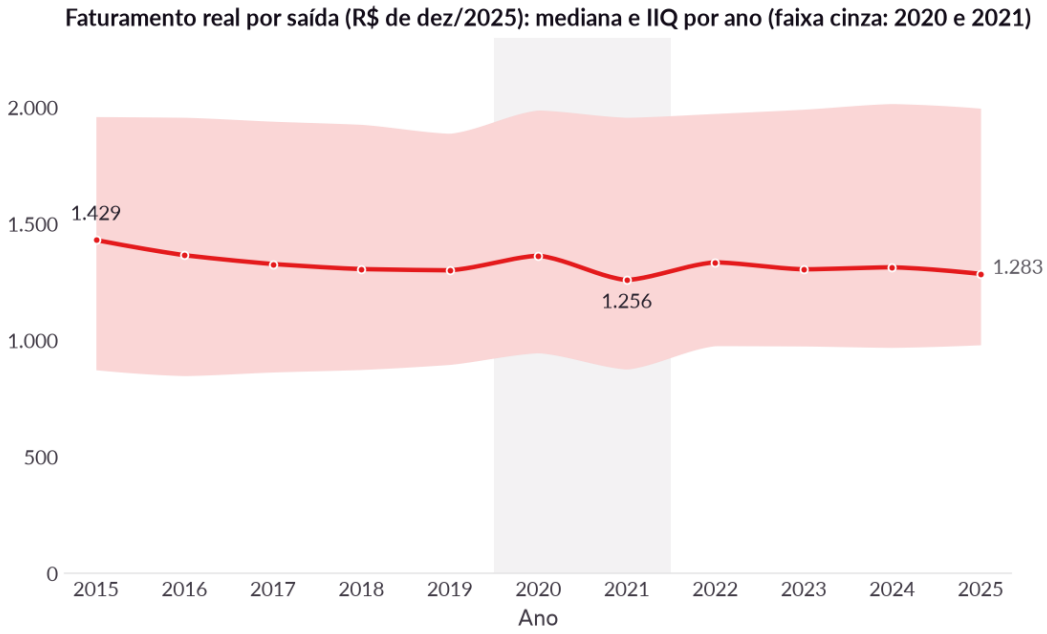


(a) Mortalidade geral

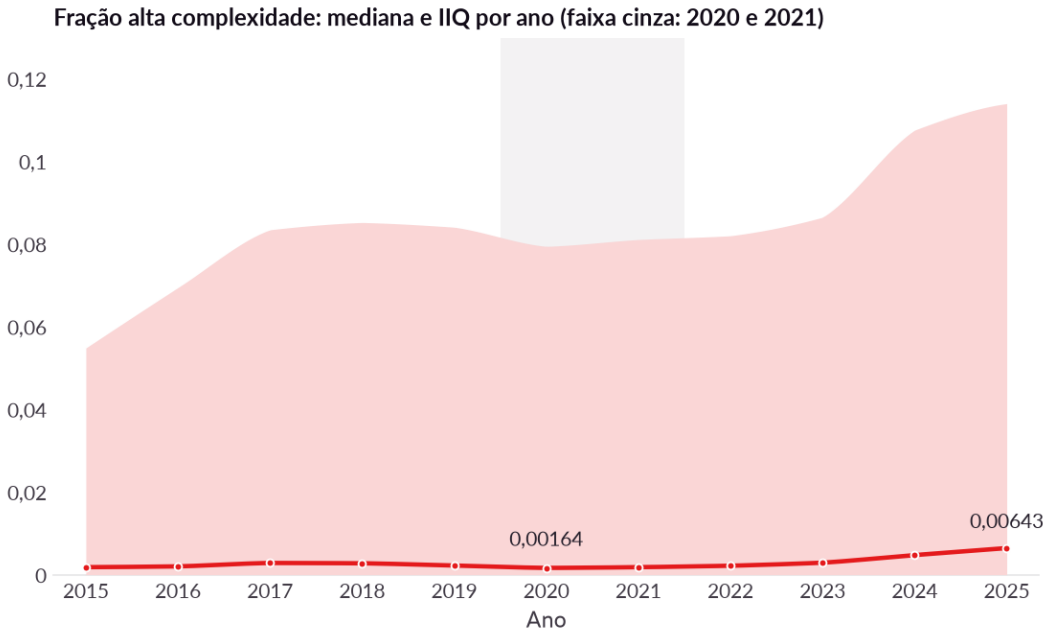


(b) TMP

Figura 24: Mediana anual da mortalidade e do TMP. A corcova da mortalidade é o biênio pandêmico; o TMP atravessa a década quase imóvel. A faixa em torno da linha é a metade central dos hospitais. **A curva liga os anos medidos e não inventa valor entre eles**: os pontos são as medições.

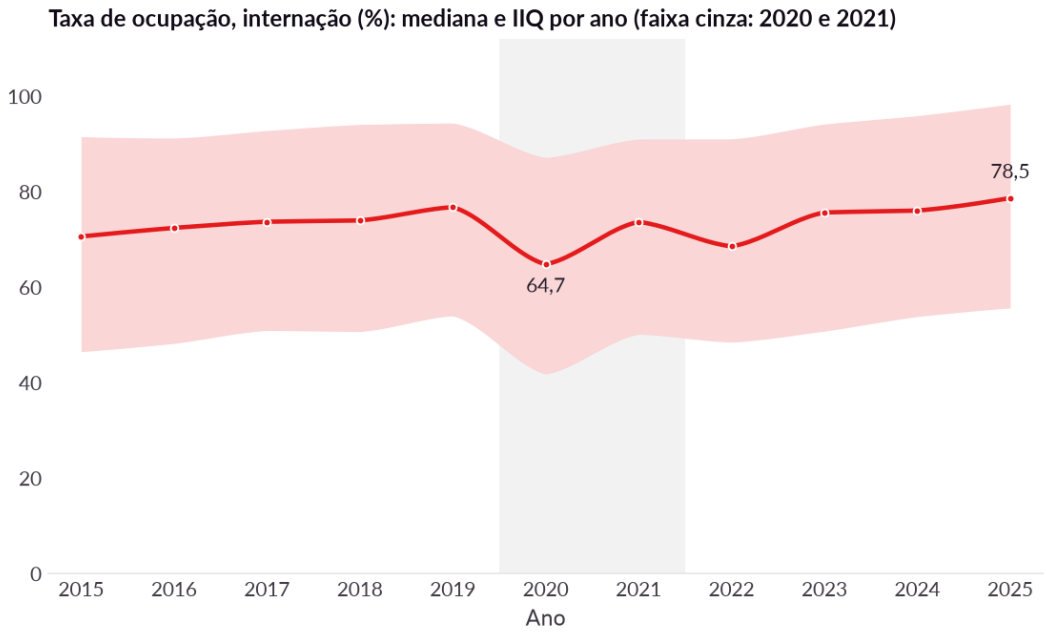


(a) Faturamento real por saída (R$ de dez/2025)

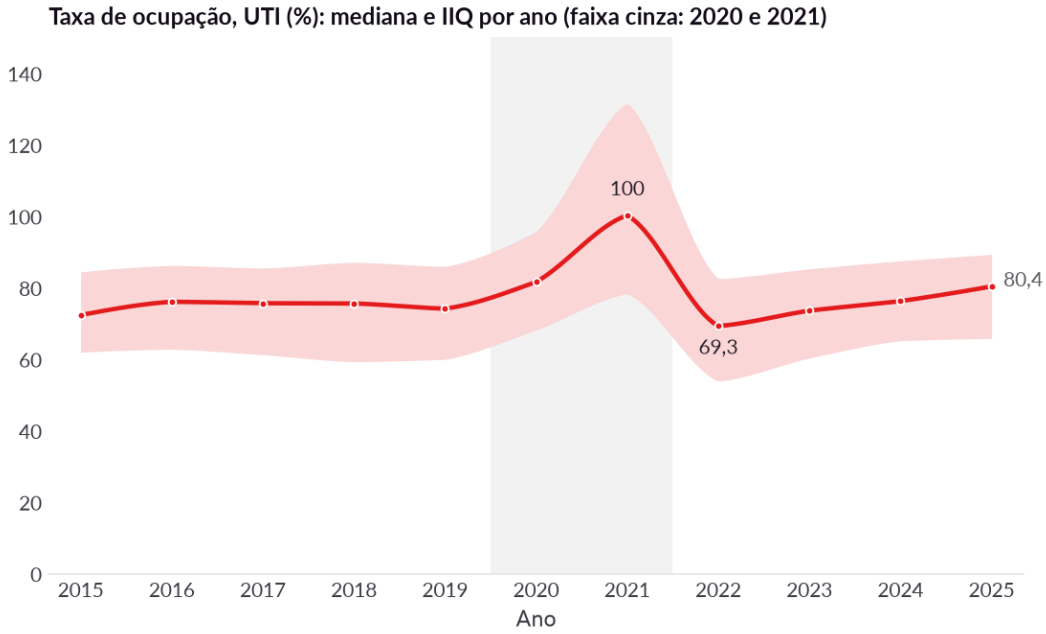


(b) Fração alta complexidade

Figura 25: Mediana anual do faturamento real por saída (R$ de dez/2025) e da fração de alta complexidade. Descontada a inflação, o valor pago por internação encerrada perde poder de compra ao longo da década. Em valor corrente a mesma série sobe.



(a) Taxa de ocupação de internação



(b) Taxa de ocupação de UTI

Figura 26: Mediana anual das taxas de ocupação. Os dois movimentos vão em sentidos opostos: a internação esvazia em 2020 (64,5%) e a UTI lota em 2021 (100,8%, recorde da série).

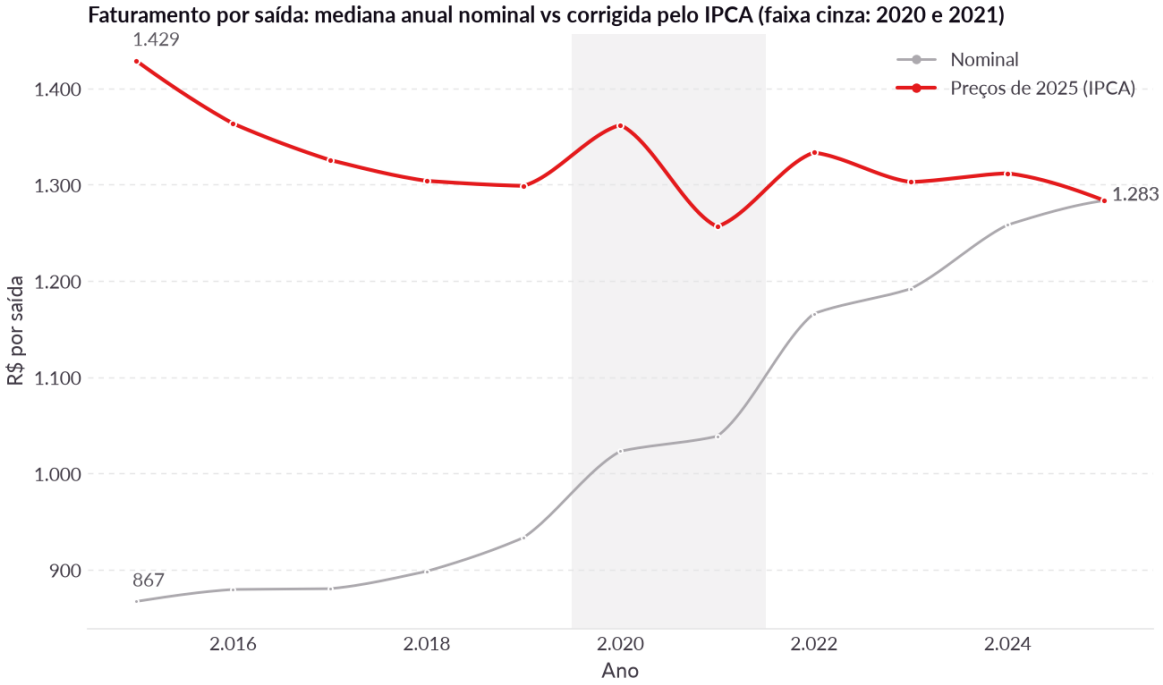
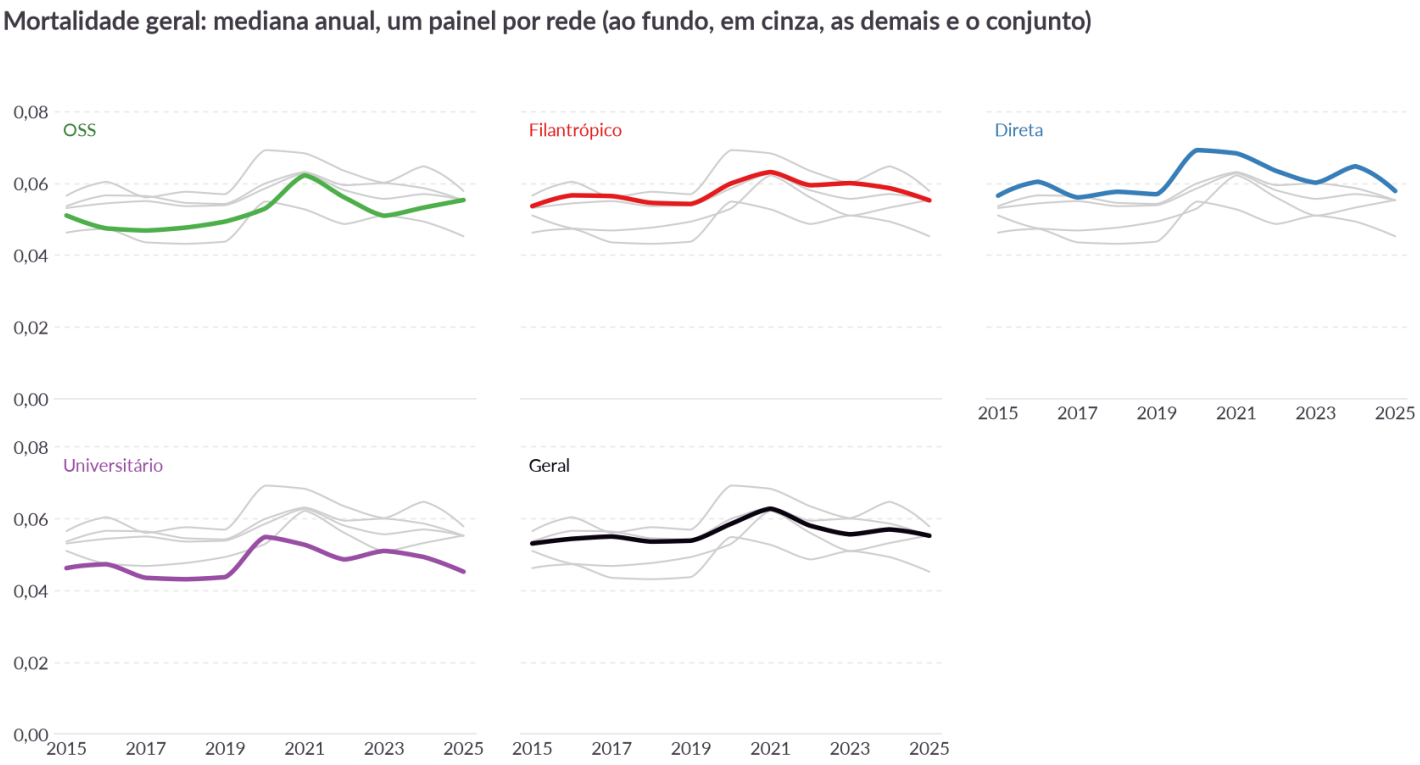
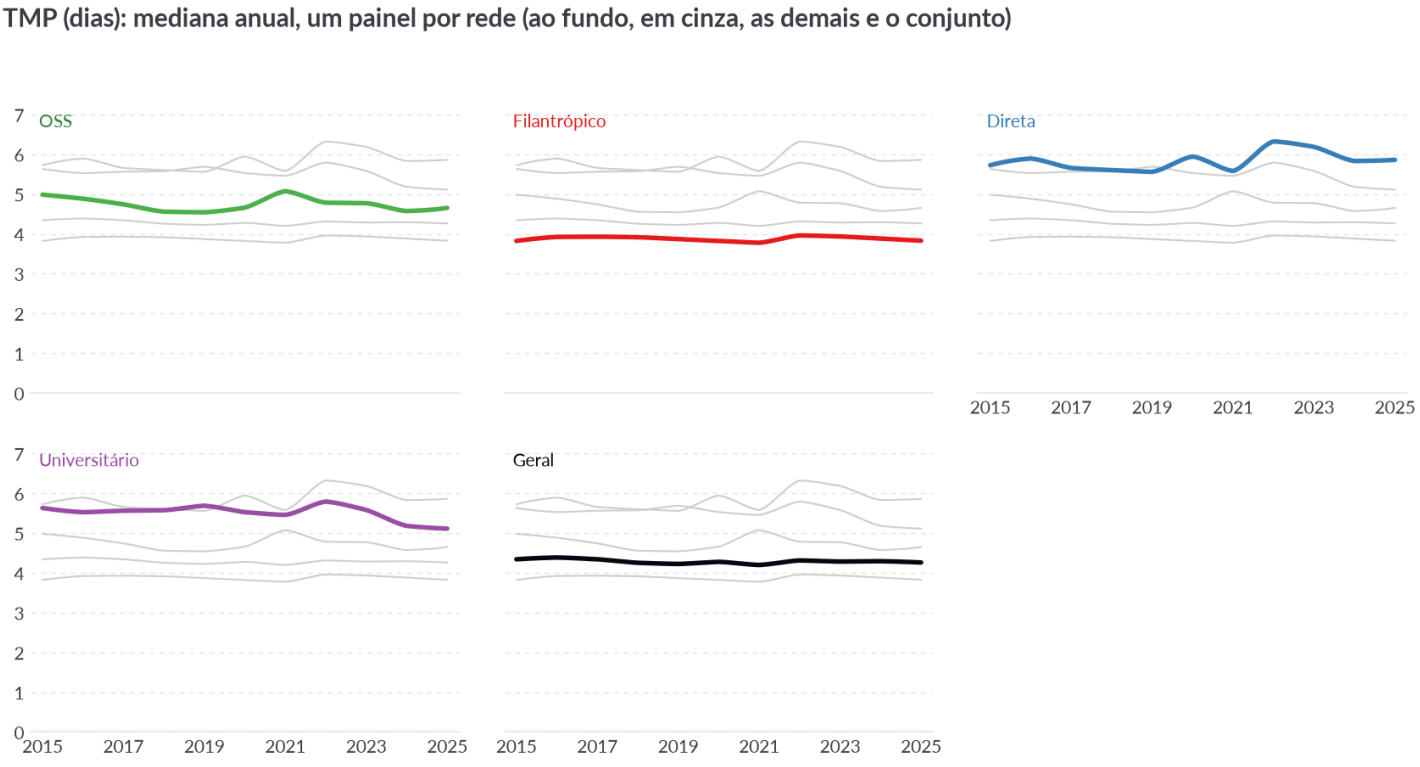


Figura 27: Faturamento por saída mediano: a linha clara tracejada é o valor corrente e a linha escura é o valor corrigido pelo IPCA para o poder de compra de 2025. A linha clara é o valor corrente e sobe; a escura é o valor de 2025 e cai, de R$ 1.415 para R$ 1.283 por internação. Em 2025 as duas coincidem por definição.

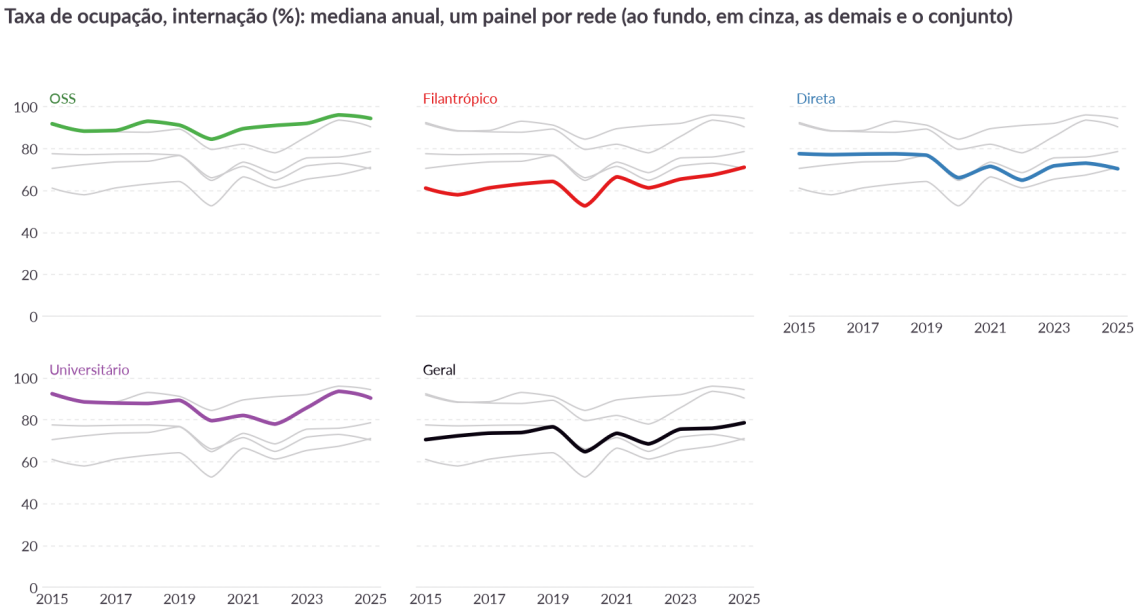


(a) Mortalidade geral

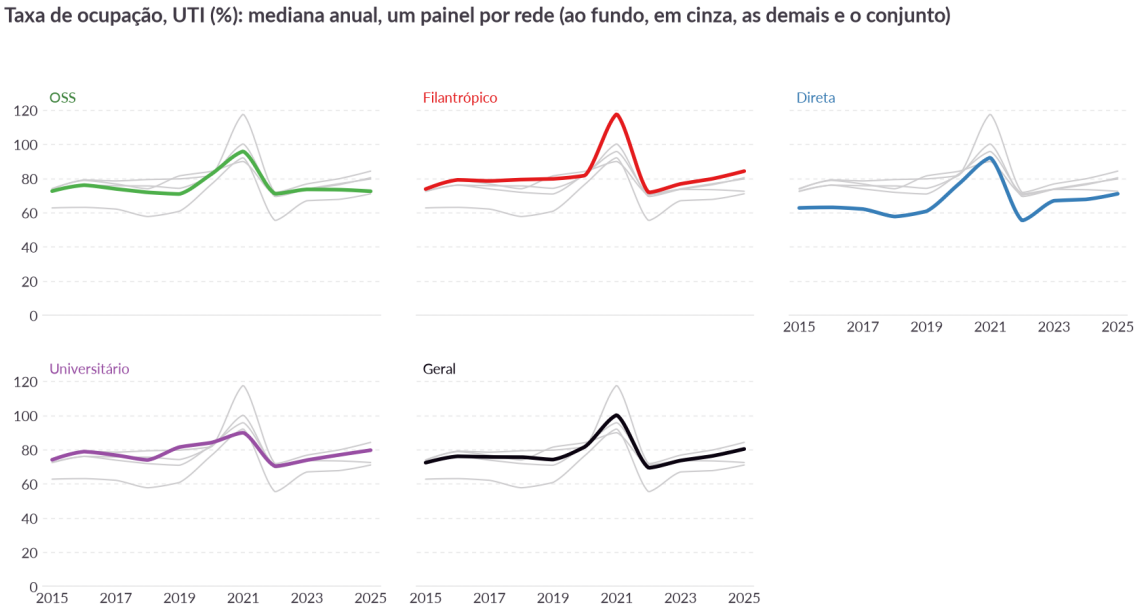


(b) TMP

Figura 28: Mediana anual da mortalidade e do TMP por categoria de gestão; cada categoria tem cor e marcador próprios. Mesma leitura, agora uma linha por rede. Na mortalidade todas fazem a corcova da pandemia; no TMP a linha da Direta corre acima das demais a década inteira.

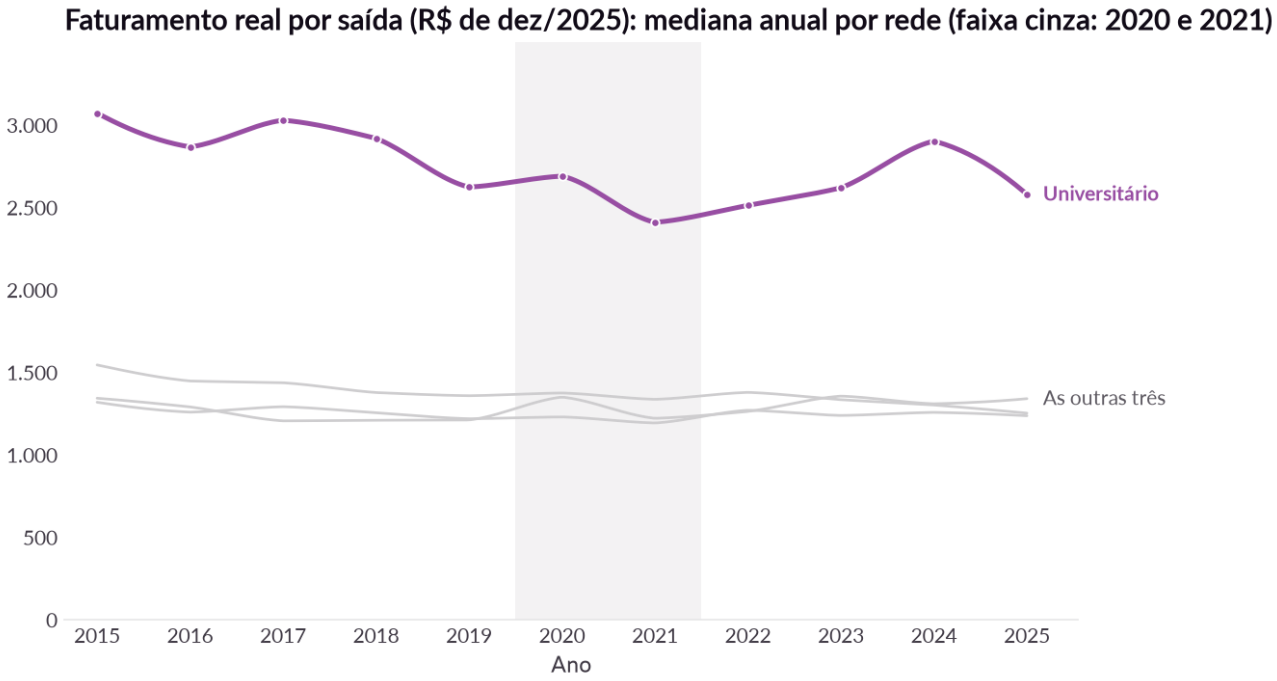


(a) Taxa de ocupação de internação

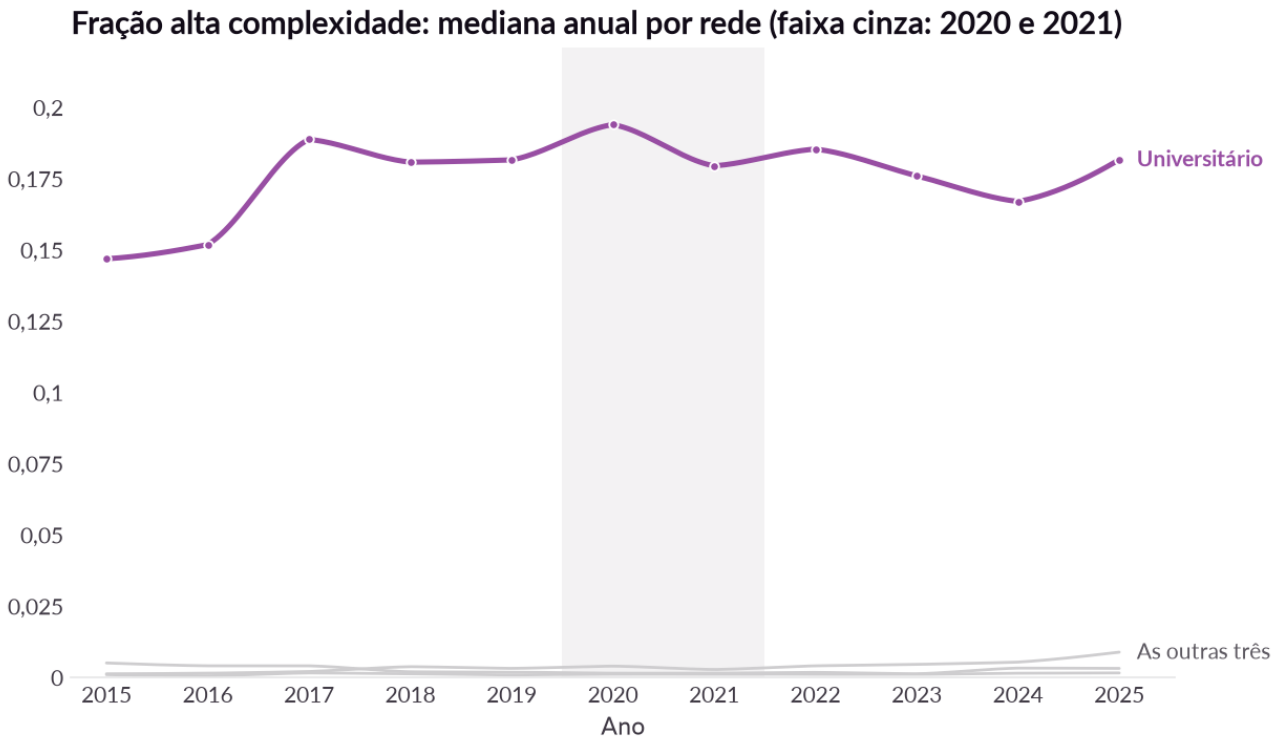


(b) Taxa de ocupação de UTI

Figura 29: Mediana anual das taxas de ocupação por categoria de gestão. Na ocupação de internação, OSS e universitário correm na casa dos 90% e dos 80% e Direta e Filantrópico na dos 70% e dos 60%, a década inteira. Na UTI, o pico de 2021 é a pandemia. **Aqui as quatro redes ficam cada uma na sua cor**: nestes dois indicadores nenhuma se separa das outras.



(a) Faturamento real por saída, R$ de dez/2025



(b) Fração alta complexidade

Figura 30: Mediana anual do faturamento real por saída (R$ de dez/2025) e da fração de alta complexidade por categoria de gestão. **O hospital universitário está na cor dele e as outras três redes ficam em cinza**, juntas e sem nome: é ele que se separa, e as outras não se separam entre si. No faturamento a linha dele corre o dobro acima; na alta complexidade, numa ordem de grandeza à parte. **Os dois eixos começam em zero.**.

1.7 A distância até a melhor prática na rede inteira

A segunda fase da estimação atacou a mesma pergunta com duas famílias de métodos ainda não usadas no documento: modelos **hierárquicos** (que tratam os 11 anos de cada hospital como parentes, não como observações soltas) e a análise envoltória de dados (**DEA**, que constrói uma fronteira de melhores práticas e mede a distância de cada hospital até ela). **A eficiência deste documento é medida por análise envoltória de dados.** Esta subseção traz os achados que mudam ou reforçam a leitura do documento.

Eficiência: o que o cálculo mede. O DEA mede eficiência produtiva: quanto produto (saídas, incluída a alta complexidade) cada hospital extrai dos seus insumos. A leitura que ele permite é comparativa, e a subseção inteira depende de uma pergunta anterior a qualquer ranking: se a ordem das redes se mantém quando se troca a medida.

Outra medida responde essa pergunta, e ela não diz o mesmo sobre todas as redes. É a **produção física por leito SUS**: são **56 saídas por leito nas OSS**, 51 no Filantrópico, 48 no hospital universitário e 43 na administração Direta.

Uma terceira foi estimada e fica de registro, não de resposta: o DEA reestimado só com leitos como insumo. Ela sai da comparação porque a nota que produz acompanha o tamanho do hospital muito mais do que a nota adotada, de modo que a rede com os hospitais maiores subiria por ser maior, e não por operar melhor.

As duas medidas não apontam para a mesma rede, e é isso que elas têm a dizer. Na produção física por leito as OSS ficam na frente; na que passa por fronteira, o hospital universitário fica. **A administração Direta é a última nas duas**, e essa é a única posição que se repete inteira. Não há, portanto, hierarquia de quatro posições a publicar: há **uma rede atrás nas duas medidas e três que trocam de lugar conforme o que se mede**. Nada disso desce ao hospital individual, pelo motivo que o parágrafo seguinte retoma.

Com a ressalva posta, o resultado: as notas medianas do período são **hospital universitário 0,708**, OSS 0,677, Filantrópico 0,612 e administração Direta 0,523. **A ordem das quatro é a mesma que a régua anterior dava**, e o que mudou foi a distância entre elas: a fila **mais que dobra de abertura**, de 88 para **185 milésimos** entre a primeira e a última. O maior degrau da fila é o último, da terceira rede para a administração Direta.

Descontando complexidade, porte e ano, **duas redes se separam da média das quatro**: a administração Direta fica atrás dela, e as OSS, à frente. O Filantrópico e o hospital universitário ficam onde a média está, e para os dois os dados admitem tanto cenários à frente quanto atrás. **E as duas continuam separadas em todos os descontos que se tentou**: a gravidade dos casos, medida pela intensidade com que cada hospital usa a UTI; a mortalidade; a fração de internações cirúrgicas; e as três ao mesmo tempo.

Essa firmeza mora numa cauda, e as duas coisas se leem juntas. Quase três quartos da distância que afasta a administração Direta da média vêm de **um único hospital**: retirado ele, a distância encolhe a uma fração do que era, e o mesmo vale para a vantagem das OSS. É uma razão para ler esta subseção como retrato da rede, e não como veredito: o veredito comparativo corre entre hospitais de estrutura parecida (Subseção 3.4), onde essa cauda não aparece.[2]

Ao contrário da mortalidade, **a eficiência maior das OSS é um traço da rede**, presente na comparação pura entre hospitais distintos. Vale relembrar aqui, porque a frase anterior é o tipo de afirmação que viaja sozinha, que essa conclusão é firme **no nível das categorias** e não desce ao hospital individual. A troca de régua mostra isso bem: entre a medida que este documento publicava, com o faturamento entre os insumos, e a que ele passa a publicar, sem ele, a correlação de ordem é de 0,77 por hospital, e ainda assim **123 dos 275 hospitais mudam de quartil**, 23 deles saltando dois ou mais. As redes ficam onde estavam e os hospitais se reordenam por dentro, de modo que a posição de um hospital específico deve ser lida na régua vigente e nunca herdada da anterior. **Notas de réguas diferentes não se somam nem se subtraem.** A fronteira publicada é a dos **275** hospitais do painel.

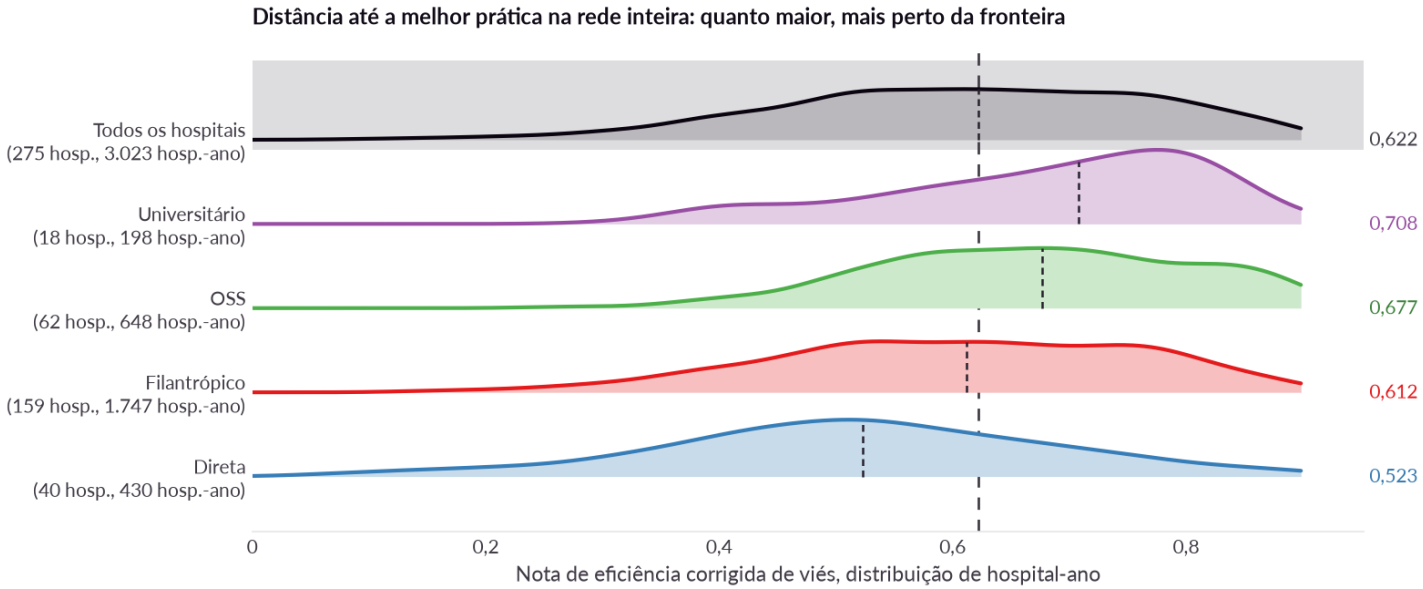


Figura 31: Distância até a melhor prática por rede de gestão, na rede inteira, medida por análise envoltória de dados e corrigida de viés. É o mesmo desenho das distribuições da Seção 1.3 e das do grupo E3, adiante. O universitário aparece na frente e as OSS logo atrás; o Filantrópico no meio; a administração Direta embaixo, e destacada das outras três por larga margem. A curva de cima, **em preto e sobre faixa cinza**, é a rede inteira, e a tracejada é a mediana dela. A **eficiência técnica** vai de 0 a 1: quanto mais perto de 1, mais perto da fronteira das melhores práticas observadas na própria amostra.

[2] As demais variantes desta segunda etapa (sem o biênio pandêmico e sem os hospitais convertidos) foram rodadas, mas não são citadas aqui como resultado corrente.

1.8 O contraste entre as redes, indicador a indicador

A Figura 32 resume o contraste central da pesquisa: quanto cada indicador difere entre a gestão por OSS e a administração Direta, já descontados complexidade, porte e ano, com as margens de erro agrupadas por hospital. **Estes contrastes são estimados sobre a rede inteira e reestimados adiante sob a restrição de comparabilidade da Seção 3**, que compara apenas hospitais de estrutura equivalente. Onde os dois conjuntos divergirem, **prevalece o segmentado**, pela regra de desempate da escada de evidência, na introdução.

Uma advertência precisa acompanhar todos os números desta subseção, e ela não está nas margens de erro. Os coeficientes estimados *dentro* do hospital (o tempo de permanência e o faturamento) são identificados por **quatro conversores**, e a Subseção 3.7 documenta que **nenhum dos quatro é um caso limpo**, enumerando os quatro defeitos que comprometem as conversões. **Três deles têm um único ano de acompanhamento depois da troca**, de modo que a evidência *dentro* do hospital repousa, na prática, sobre um caso. Os intervalos de confiança medem incerteza amostral e não sabem nada disso.

O quadro que emerge é o de uma **rede que trabalha em ritmo mais alto**: as OSS **atendem 32,9% mais pacientes**, com os leitos de internação **9,9% mais ocupados** e a UTI **11,1% mais usada** entre os hospitais que a possuem. **Só a produção tem folga suficiente para ser afirmada**: a margem dela vai de +16,8% a +51,1%, enquanto as das duas taxas de ocupação, de −3,6% a +25,3% e de −1,8% a +25,7%, comportam não haver diferença nenhuma. É uma diferença de regime entre redes com missões distintas, e não um efeito demonstrado da conversão de um hospital individual (ver a Subseção 3.7).

O **paciente fica 6,8% menos tempo internado** nas OSS quando se compara cada hospital consigo mesmo, e a direção fecha a conta do ritmo: **mais gente passa pelos mesmos leitos porque cada um fica menos tempo neles**. **A margem, porém, não sustenta a diferença**: ela vai de −17,0% a +4,5%, e comporta as duas direções. Com quatro hospitais convertidos, e um só com histórico posterior utilizável, o número é *direção sem precisão*, e não achado. O contraste **entre** redes, que não depende dos conversores, continua firme e é maior: −22,0% (adiante, na camada hierárquica desta mesma subseção).

O **faturamento real por saída** aparece 2,0% *maior*, e aqui a resposta honesta é que **os dados não decidem**: a margem vai de 10,6% de queda a 16,5% de alta, ou seja, comporta hospital mais barato e hospital mais caro. **O intervalo acomoda folgadamente as duas direções**, o que é a própria demonstração de que não há sinal a ler: com quatro conversões, não há como cravar se as OSS custam mais ou menos por paciente atendido. Os efeitos de ano do mesmo modelo confirmam, agora em ambiente controlado, a queda real do faturamento da década: 2025 fica 8,8% abaixo de 2015 em preços comparáveis.

Ressalva de leitura (regime de pagamento): *hospitais OSS são custeados por contrato de gestão com orçamento global, e não por reembolso de AIH. O valor registrado por saída é, para eles, produção sem consequência financeira direta, de modo que a diferença de faturamento pode refletir o próprio regime de pagamento, que é a variável cujo efeito se busca medir, e não uso de recursos ou qualidade assistencial. Esta ressalva vale para toda leitura de faturamento no documento e é retomada, em forma abreviada, onde o indicador reaparece.*

Na **mortalidade**, o modelo estima uma queda **de 5,6% para 5,0%** depois da conversão, medida dentro do mesmo hospital, num patamar que a margem de erro já não sustenta com folga. **Esse número não deve ser citado**: ele não sobrevive ao confronto com o hospital gêmeo da Subseção 3.7. Duas leituras acompanham o resultado e importam para a gestão. Primeiro, **as OSS não são hospitais de mortalidade estruturalmente baixa**: o modelo separa o que é diferença entre hospitais do que é mudança dentro do hospital, e a parcela entre hospitais não aponta vantagem alguma; toda a queda estimada vem da trajetória dos quatro conversores. Segundo, **nenhum hospital OSS ou universitário registra um ano sequer sem óbito** no painel, contra Filantrópicos que registram: são redes que recebem casos de outra natureza, e é mais uma razão para não ler mortalidade bruta como placar de gestão. Na **fração de alta complexidade** não há diferença entre OSS e Direta por método nenhum; quem determina essa fração é a complexidade instalada do hospital e o seu porte, como era de esperar.

A Tabela 8 traz os mesmos contrastes em número; quem quiser conferir os valores que sustentam cada afirmação desta subseção encontra-os aqui.

Tabela 8: O que muda quando o hospital é gerido por OSS em vez da administração Direta, já descontados complexidade, porte e ano. As linhas estão ordenadas pela **firmeza da evidência**, e não pelo tamanho do número: é a ordem em que um gestor deve confiar neles. A coluna **Diferença** é a única que precisa ser lida para decidir; as três últimas são o registro técnico que sustenta cada linha e estão explicadas logo abaixo da tabela. Cada linha é um dos sete modelos principais, de OSS contra administração Direta. **Diferença** traduz o resultado para a unidade do gestor: variação percentual nos indicadores de quantidade, e deslocamento da taxa na mortalidade, que vale **0,62 ponto percentual para baixo**. Na fração de alta complexidade a rotina não produz essa tradução, e a coluna traz a leitura. **Coef., EP e** z são o registro técnico: o coeficiente, a margem de erro agrupada por hospital, e o que separa diferença real de ruído. A ocupação de UTI já traz a reestimação do Apêndice E.

Indicador	Diferença	Evidência	Coef.	EP	z
Diferença firme, medida entre as redes					
Produção (saídas)	+32,9% de pacientes atendidos	firme	0,2841	0,0656	4,33
Sem diferença que os dados sustentem					
Taxa de ocupação, internação	+9,9% de leito ocupado	nenhuma	0,0944	0,0670	1,41
Ocupação de UTI	+11,1% de uso da UTI	nenhuma	0,1050	0,0630	1,67
Tempo de permanência	−6,8% de tempo internado	nenhuma	−0,0709	0,0589	−1,20
Mortalidade (geral)	−0,62 ponto percentual, não sustentada	frágil	−0,1197	0,1007	−1,19
Faturamento real por saída	+2,0% por paciente	nenhuma	0,0199	0,0676	0,29
Fração alta complexidade	sem deslocamento medido	nenhuma	−0,0528	0,1664	−0,32

Como ler a coluna Evidência. Os quatro rótulos (*firme*, *sugestiva*, *frágil* e *nenhuma*) estão definidos na escada de evidência, na introdução. Em uma linha: *firme* sobrevive a todos os métodos, *sugestiva* se apoia nos conversores, *frágil* não deve ser citada, e *nenhuma* quer dizer que a diferença é menor que a própria margem de erro. **Nesta tabela não há linha *sugestiva***: os dois indicadores identificados dentro do hospital têm margem cobrindo o zero, porque a identificação repousa em apenas quatro conversores.

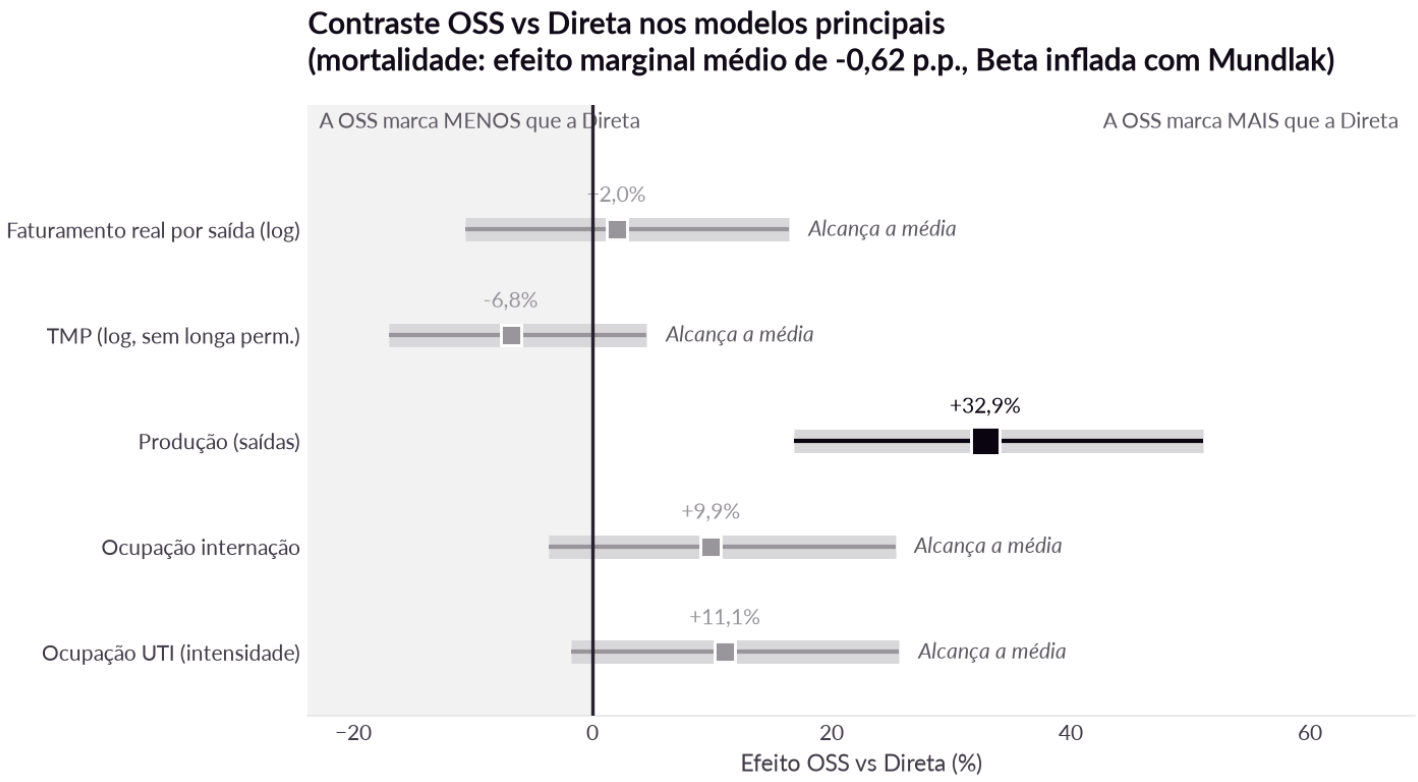


Figura 32: Contraste OSS vs Direta nos modelos principais, em efeito percentual com intervalo de 95%; a mortalidade, que tem escala própria, aparece anotada no título. Faturamento e TMP: identificação *within* (efeitos fixos, sustentada pelos quatro conversores); produção e ocupações: contraste predominantemente *between* entre as redes OSS e Direta, de natureza associativa. Na ocupação de UTI a barra desta figura traz **o mesmo valor da Tabela 8**, +11,1%. Cada linha é um indicador; o **quadrado escuro** é a melhor estimativa do efeito de ser OSS em vez de Direta, e a haste é a margem de erro. Haste que alcança a média não autoriza afirmar diferença; à direita do zero, OSS maior, à esquerda, OSS menor. Quem se separa sai no tom cheio; quem alcança a média, num tom recuado. A posição do quadrado é o **efeito de ser OSS em vez de Direta**, em variação percentual, já descontados complexidade, porte e ano; a haste é a margem de erro agrupada por hospital. A mortalidade, por ter escala própria, vai anotada no título.

A camada hierárquica separa duas perguntas que o resto do documento mistura, e é essa separação que ela acrescenta. Estimado com efeito próprio para cada hospital e com o termo que carrega a média de cada um, o modelo produz *dois* contrastes entre OSS e administração Direta, e eles respondem a coisas diferentes. Um mede o que acontece **dentro** do hospital que trocou de gestão; o outro mede a distância **entre** um hospital sempre OSS e um sempre Direta. Somados, dão o contraste entre redes; olhar só o primeiro é olhar os conversores.

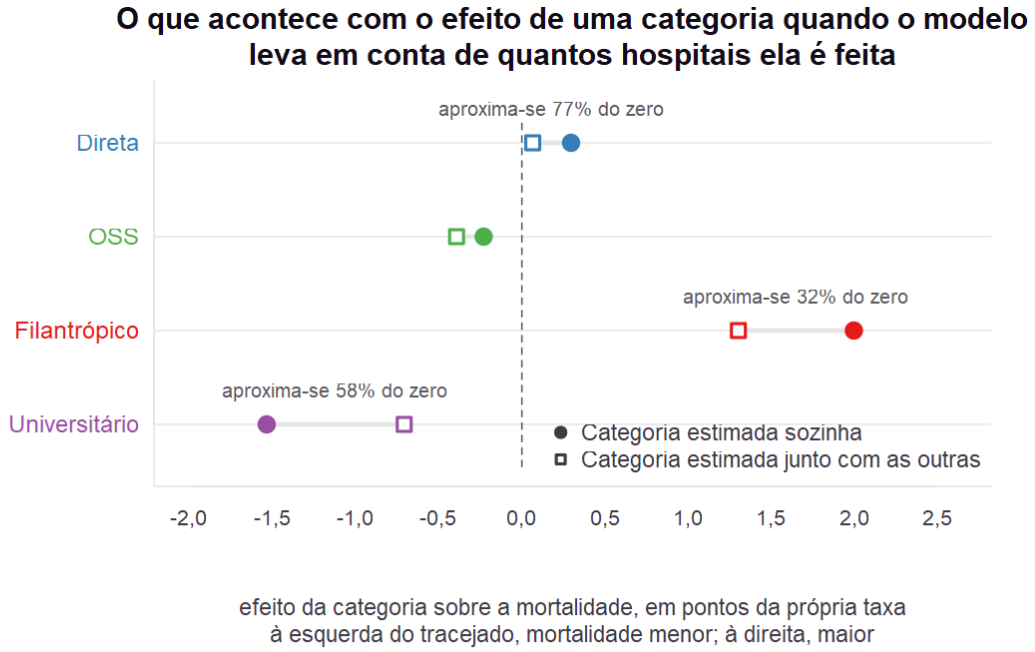
Entre redes, dois dos quatro traços do retrato se repetem com força, e dois deixam de se sustentar. A produção é **44,7% maior** nas OSS, com margem de +17,8% a +77,8%, e o tempo de permanência é **22,0% menor** (de −30,4% a −12,7%): as duas com folga suficiente para descartar o acaso. Já a taxa de ocupação de internação fica **10,1% maior** e a intensidade de uso da UTI **10,8% maior**, as duas com margem que comporta não haver diferença nenhuma. O faturamento real por saída não difere entre as redes nem aqui. **A produção fica mais alta nesta camada do que na anterior**, e a razão é de desenho (o intercepto aleatório por hospital, que o modelo daquela seção não tem), e não de dado.

Dentro do hospital, ao contrário, nenhum dos contrastes se separa do acaso. A mortalidade cairia de **5,6%** para **4,8%**, mas a margem vai de 4,0% a 5,6% e portanto comporta não mudar nada; o tempo de permanência fica em −6,8%, o faturamento em +2,0% e a produção em +8,3%, todos com a margem cobrindo o zero.[3] **Não é que a medida tenha mudado: é que a**

[3]O bootstrap paramétrico da mortalidade, com 100 réplicas válidas de 100, é o único que fecha do lado da queda: margem de 4,0% a 5,5%. A diferença entre ele e a margem acima é de método de cálculo do intervalo, e não de estimativa: o ponto central é o mesmo.

quantidade de evidência mudou. Este contraste é identificado *só* pelos hospitais que trocaram de gestão, e eles são **quatro**, dos quais um único com mais de um ano de acompanhamento posterior.

As duas leituras, lado a lado, dizem o que o resto do documento diz, e dizem com mais precisão. O regime operacional das OSS é um **traço de rede**, medido entre hospitais distintos e intacto. O que não se sustenta é vê-lo *aparecer* quando um hospital troca de modelo; e a mortalidade, medida entre redes, continua sem diferença: a taxa vai de 5,6% na administração Direta a 6,3% nas OSS, com margem de 4,7% a 8,3%, que comporta as duas direções. Some-se o que a Subseção 3.7 documenta sobre o único conversor com janela utilizável: a conversão de Sorocaba foi decidida em resposta a uma crise de gestão, o que deprime o período anterior e faz da reversão à média a explicação mais econômica para a melhora posterior.



O eixo está em pontos percentuais de mortalidade, contados a partir da média da administração Direta (5,6%). O percentual de aproximação de cada linha é medido na escala interna do modelo, onde o encolhimento do pooling é proporcional.

Figura 33: O efeito de cada categoria sobre a mortalidade, estimado das duas maneiras. **As duas que mais encolhem não são as menores**: são aquelas cujo efeito bruto já estava perto da média das redes. Cada linha compara duas estimativas do mesmo efeito, na cor da própria rede: o **círculo cheio** trata cada rede isoladamente; o **quadrado vazado** deixa as redes emprestarem informação umas às outras, e as duas saem do mesmo modelo. O recuo do quadrado em direção ao zero mede **quanta evidência própria** cada rede sustenta: **77,5%** na Direta, **57,6%** no universitário e **31,7%** no Filantrópico. **Nas OSS ele é negativo**: ali emprestar informação afasta a rede da média. **O eixo está em pontos percentuais**, contados da média da administração Direta (5,6%): o Filantrópico vai de **2,0** a **1,3 ponto** acima da média das quatro redes, e as OSS de **0,2** a **0,4 ponto** abaixo. **O percentual anotado em cada linha corre em escala interna ao modelo** e não corresponde à distância medida no eixo.

1.8.1 Três decisões por trás dos números de ocupação

Os números de ocupação desta fase dependem de três decisões, e vale declará-las: nas três havia alternativa razoável, e a escolha muda o que o número significa.

Quem entra na conta da UTI são os hospitais que têm leito de UTI habilitado, tenham ou não usado o leito no ano. A alternativa, contar só quem usou, escolheria a amostra pela própria coisa que se quer medir.

Onde a cauda alta é aparada é no percentil 99 desses mesmos hospitais, e não do painel inteiro. Calculado sobre o painel inteiro, o corte seria puxado pelos hospitais sem UTI, que não são ocupação baixa: são ausência de ocupação (Seção 1.3).

A taxa de ocupação de internação não é aparada acima de 100%, porque esse excesso não é ruído: é a própria superlotação descrita na Seção 3. Apará-lo apagaria o achado.

Definir a amostra pela capacidade mantém dentro dela os hospitais com UTI habilitada e nenhuma diária no ano. Esses zeros não cabem no mesmo molde que os demais valores, e por isso o modelo principal é feito **em duas partes**: primeiro se o hospital usou a UTI no ano, depois com que intensidade a usou entre os que usaram.

O resultado, e ele precisa ser lido na quantidade certa. Entre redes, comparando um hospital sempre OSS com um sempre Direta, as OSS operam a UTI **10,8% mais intensamente**, com intervalo de 95% entre −1,4% e +24,5%, que comporta não haver diferença. *Dentro* do hospital que trocou de gestão, o mesmo modelo dá −1,0%, com o intervalo cobrindo o zero de ponta a ponta: essa metade do contraste é sustentada apenas pelos conversores, e eles são quatro. A taxa de ocupação de internação repete o padrão, e agora nas duas pontas: +10,1% entre redes e −1,8% dentro do hospital, as duas margens cobrindo o zero.

Estes 10,8% não são os 11,1% da Tabela 8 medidos outra vez, e a diferença entre os dois é de desenho, não de dado. O número da tabela sai do modelo transversal, cuja amostra de UTI é definida pelo *uso* do leito; este sai do modelo em duas partes, que define a amostra pela *capacidade instalada* e trata a massa em zero num componente próprio, e é por isso a estimativa preferida para a intensidade. Os dois apontam na mesma direção, e os **três décimos de ponto** que os separam são menos que a largura de qualquer um dos dois intervalos. O valor que se compara com os demais indicadores é o da tabela.

E o número não depende de como a conta foi montada. A comparação dentro do hospital foi refeita **cinco vezes**, cada uma com um molde diferente para o modo como o uso da UTI se espalha entre os hospitais, e **as cinco caem no mesmo lugar**: entre −3,0% e −0,4%, uma faixa de 2,7 pontos, estreita perto da margem de erro de qualquer uma delas, e todas comportando não haver diferença. A que mais se afasta das outras é a que mede o hospital *típico* em vez da *média* entre hospitais: ela responde outra pergunta, e responde com menos precisão. Para a gestão, a leitura é direta: **a diferença pequena que a comparação dentro do hospital encontra não vem do jeito de calcular**.[4]

[4] **Entre as decisões de cálculo, a que mais mexe no resultado é a escolha do molde**, e o quanto ela mexe está medido: **seis décimos de ponto**. Mudar quem entra na conta mexe doze centésimos, e mudar onde a cauda alta é aparada, quatro centésimos. É por isso que as cinco são reportadas juntas.

1.9 Hospitais que não são comparáveis entre si: o recorte de comparabilidade

Antes de comparar hospital com hospital, é preciso responder uma pergunta anterior a qualquer modelo: **há hospitais no painel que não deveriam estar sendo comparados de jeito nenhum?** A resposta define um recorte de comparabilidade que vale para a leitura do documento inteiro, a começar pela descrição que vem a seguir, e cujo efeito sobre os contrastes entre redes a Seção 3 mede.

1.9.1 O caso que motivou a pergunta

O gatilho foi concreto, e a Seção 1.3 o desenvolve. A ocupação de UTI só é definida onde há leito de UTI, e medi-la sobre a rede inteira somaria hospitais **que não têm UTI** a hospitais de UTI vazia, que são coisas diferentes.

Ali o problema é de definição, mas ele expõe um problema mais geral. Um hospital de pequeno porte do interior, sem UTI e sem alta complexidade, e um hospital-escola de mil leitos com UTI e transplante não fazem a mesma coisa. Medi-los pelos mesmos seis indicadores e descontar a diferença com uma covariável de complexidade supõe que a diferença entre eles é de *grau*. Boa parte dela é de *gênero*: há indicadores que simplesmente não se aplicam a um dos dois.

A resposta natural seria cruzar duas dimensões, ter ou não UTI e fazer ou não alta complexidade, e obter quatro grupos. **Esse cruzamento degenera.** A célula "sem UTI, mas faz alta complexidade" é **vazia**: no painel de 275 hospitais não existe um único caso. Alta complexidade sem terapia intensiva não é uma combinação rara: é uma combinação que a organização assistencial não produz.

O que sobra, portanto, não são quatro grupos: é uma **escada de três degraus**, ordenada por capacidade instalada.

1.9.2 Os três estratos, e por que ficam fixos

- **E1, sem UTI SUS.** Mediana de leitos de UTI SUS igual a zero nos onze anos.
- **E2, com UTI, escore Barcelona abaixo de 4.** Mediana de UTI positiva e faixa Barcelona 2 ou 3.
- **E3, com UTI, escore Barcelona 4 ou mais.** Mediana de UTI positiva e faixa Barcelona de 4 a 6.

O corte separa hospitais por estrutura disponível, e só por isso. Ele é feito com a mediana de leitos de UTI SUS e com o escore Barcelona, que medem capacidade física e tecnológica instalada, e não com o que o hospital produz. A consequência precisa ser dita de saída, porque o nome dos degraus convida ao engano: **um hospital de E3 não é, por definição, um hospital que faz muita alta complexidade**. Ele tem capacidade instalada para fazer, o que é outra coisa. A fração mediana de internações de alta complexidade em E3 é de **0,054**, ou seja, cerca de 5% das internações (Tabela B.1). Quando o nome longo pesar, o texto usa **menor** e **maior capacidade instalada**.

A classificação é **fixa para todo o período**, e essa escolha precisa de justificativa porque um hospital pode, em princípio, mudar de degrau ao longo de onze anos. Duas verificações sustentam a fixação.

A primeira é direta: **a faixa Barcelona não varia dentro de nenhum CNES do painel**. Ela é atributo estrutural, e não há o que fixar: já é fixa.

A segunda é menos óbvia e mais interessante. O número de leitos de UTI *oscila* entre anos, e à primeira vista isso pediria classificação anual. Mas a oscilação não é obra física: é **suspensão e limpeza de cadastro**, tipicamente inativação temporária por falta de intensivista. A evidência é que existem 36 observações, em 25 hospitais, com **zero leito de UTI cadastrado e diárias de UTI registradas no mesmo ano**: a ala operando enquanto o registro está zerado. O controle equivalente na internação, leito zerado com diária registrada, dá **zero casos**, como se espera de um leito comum, que não é habilitação que se suspenda. Sendo o cadastro que pisca e não a capacidade que muda, **a mediana dos onze anos é o estimador certo** da capacidade subjacente: ela ignora os anos em que o registro caiu sem que a ala fechasse.

1.9.3 O funil da segmentação: como os 275 hospitais se repartem nos três estratos

Tabela 9: Distribuição dos 275 hospitais pelos três estratos estruturais, por categoria de gestão. Cada célula traz hospitais distintos (CNES), e **os quatro conversores são contados nas duas categorias que ocuparam**, pela mesma convenção declarada na Seção 1.3. Por isso a soma das células de uma coluna excede o total dela: em E2 por um hospital (Presidente Prudente) e em E3 por três (Sorocaba, Taipas e Vila Penteado). Os totais contam hospitais distintos, uma vez cada.

Categoria	E1 (sem UTI)	E2 (Barcelona <4)	E3 (Barcelona ≥4)	Total
Direta	5	11	24	40
OSS	6	13	43	62
Filantrópico	54	66	39	159
Universitário	0	1	17	18
Total	**65**	**90**	**120**	**275**

A tabela já entrega o principal achado estrutural da segmentação, e ele é sobre **quem pode ser comparado com quem**. Em **E1** a administração Direta tem 5 hospitais e as OSS têm 6, as duas abaixo dos dez que o documento exige de uma célula para lê-la, e por isso os resultados daquele estrato aparecem tarjados em todas as tabelas da Seção 3. Em **E2** as duas passam desse piso (11 e 13), e o que mantém o veredito fora dali não é o tamanho da célula: é a definição do estrato, que reúne hospitais de menor capacidade instalada.

É em **E3** que a comparação se sustenta, e ali o par é o maior dos três estratos: **43 hospitais OSS contra 24 da administração Direta**. E é também em E3 que estão três dos quatro hospitais que trocaram de rede no período.

Vale completar a composição do estrato, porque ela dimensiona o alcance dessa comparação. Ao lado do par, E3 reúne **39 hospitais filantrópicos** e **17 universitários** (Tabela 9). As OSS passaram a ser a maior categoria do estrato, à frente do filantrópico. E o par, descontados os três conversores que ocupam as duas colunas, reúne **64 hospitais distintos dos 120** de E3, mais da metade do estrato.

1.9.4 O hospital universitário, e a ressalva que acompanha a nota dele

A escada de três degraus separa os hospitais pela estrutura instalada. **O que ela não separa é um tipo que a estrutura não distingue: o universitário.** Ele tem UTI, tem escore Barcelona alto e cai em E3 junto com os demais de maior capacidade, e **participa da comparação como as outras redes**. O que esta subseção faz é mostrar por que a nota dele pede ressalva de leitura.

São **18 hospitais** no painel, **17 deles em E3**. A relação foi montada um a um pela equipe, porque a base de origem registra a natureza jurídica do prestador e não a atividade de ensino: entram os hospitais das clínicas das universidades públicas do estado, os institutos desses complexos, os universitários municipais e os de ensino das faculdades de medicina privadas.

Tabela 10: Como cada rede se parece, medianas de 2015 a 2025 sobre os 275 hospitais. O faturamento é o real, em reais de dezembro de 2025. **As duas últimas colunas sustentam a ressalva**: a fração de alta complexidade e o faturamento por saída separam o hospital universitário das outras três por margem que nenhum desconto de porte ou de complexidade fecha.

Rede	Mortalidade	TMP (dias)	Ocupação	Alta complex.	Faturamento/saída
Universitário	4,7%	5,49	87,0%	**17,4%**	**R$ 2.757**
OSS	5,2%	4,74	91,0%	0,3%	R$ 1.356
Direta	5,9%	5,77	72,6%	0,2%	R$ 1.270
Filantrópico	5,7%	3,87	63,2%	0,1%	R$ 1.243

A fração mediana de alta complexidade é de 17,4% no universitário e não passa de 0,3% nas outras três: 0,3% nas OSS, 0,2% na administração Direta e 0,1% nos filantrópicos. **O faturamento por saída acompanha**: R$ 2.757 contra a faixa de R$ 1.243 a R$ 1.356 que abriga as três juntas.

Dentro de E3 a distância encolhe, e é honesto dizê-lo, porque é ali que a comparação acontece: a alta complexidade é de 18,4% no universitário e 11,7% no filantrópico, com 2,7% nas OSS e 1,5% na Direta; o faturamento por saída é de R$ 2.926 e R$ 2.417 nos dois primeiros, contra R$ 1.520 e R$ 1.423 nos dois últimos. **A ordem se mantém e a margem diminui**: o estrato já seleciona, entre os filantrópicos, os grandes hospitais de referência regional.

Seguem daí duas ressalvas de leitura.

A primeira é sobre o que ele faz. Quase uma em cada cinco internações é de alta complexidade, a maior fração das quatro redes dentro de E3. A covariável de complexidade estrutural desconta a capacidade instalada, e não a seleção de pacientes que essa capacidade atrai.

A segunda é sobre como ele é financiado, e essa nenhum desconto fecha, porque não é diferença de caso: é de orçamento. O hospital universitário público é autarquia ou fundação vinculada a uma universidade, com dotação própria que não passa pelo faturamento das internações. O que o Sistema Único de Saúde paga por produção é, para ele, parte da receita; para as outras três é substancialmente a receita.

Nenhuma medida de eficiência deste documento tem o faturamento entre os recursos consumidos, e a razão é anterior a este hospital. A conta da internação enxerga apenas o que a tabela federal paga por produção: nela não aparecem a Tabela SUS Paulista, o Programa Mais Santas Casas, as emendas parlamentares nem o fomento a pesquisa. O que fica de fora tem o tamanho do que fica dentro, e cada um desses canais aponta para uma rede diferente: só a Tabela SUS Paulista repassou R$ 4,3 bilhões em 2024, contra R$ 4,45 bilhões que os 275 hospitais do painel faturaram em internações no mesmo ano. Medir eficiência com o faturamento seria, portanto, chamar de recurso consumido um número que mede desigualdade de repasse. **O que a medida conta são os leitos do SUS, os leitos de terapia intensiva e os dias de paciente**, e a ressalva de leitura fica sendo esta: o orçamento próprio do hospital universitário não aparece entre os recursos que a nota desconta.

Ele entra na comparação de eficiência, e as duas leituras acima acompanham a nota dele. Concorre pela mesma régua, com os mesmos insumos e o mesmo produto, sem filtro nem peso próprio. **São ressalvas de leitura, e não correções que o cálculo tenha aplicado**: descontar por dentro do modelo uma diferença de orçamentação que o dado não observa seria inventar uma correção.

O contraste de eficiência dentro de E3 corre nas quatro redes, e no grupo inteiro. São **120 hospitais**: 43 OSS, 39 filantrópicos, 17 universitários e 21 de administração direta, ou 24 quando os conversores são contados nas duas redes que ocuparam. **Um segundo universo é reportado no material de apoio**: 79 hospitais, restrito a quem tem rótulo de rede vindo inteiramente da base administrativa. **Ele é um recorte de três redes por construção**, porque o rótulo do universitário não vem daquela base, e por isso não substitui o universo desta seção. É o universo dos 120 que a Seção 3 usa.

1.10 A segmentação captura gradiente estrutural real

Os resultados que o corte torna possíveis, e que a Seção 3 apresenta, só valem se o corte significar alguma coisa. **Em cinco dos seis indicadores as medianas ordenam monotonicamente**, E1, depois E2, depois E3, sem inversões: em quatro a ordenação atravessa os três estratos, e no quinto, a ocupação de UTI, ela compara apenas E2 e E3.

Tabela 11: Mediana de cada indicador por estrato, todas as categorias reunidas. A ordenação é sempre pela mediana. Na última coluna, ● sim ● não, e ● inverte quando a ordem se inverte entre dois estratos.

Indicador	E1	E2	E3	Ordena?
Taxa de ocupação, internação (%)	40,8	67,8	89,9	● sim
Faturamento real por saída (R$)	654	1.296	1.816	● sim
TMP (dias)	3,19	3,86	5,23	● sim
Fração de alta complexidade	0,000	0,001	0,054	● sim
Taxa de ocupação, UTI (%)	n/a	76,6	77,2	● sim
Mortalidade geral	0,0435	0,0592	0,0584	● inverte

n/a: o E1 é, por definição, o grupo sem leito de UTI do SUS, e a taxa de ocupação de UTI não tem denominador ali.

A exceção é a mortalidade, e ela é informativa. Entre E2 e E3 as medianas são 0,0592 e 0,0584, isto é, a ordem **inverte**, por diferença menor do que a que separa qualquer outro par de estratos. Ela separa bem "sem UTI" de "com UTI" e não distingue os dois degraus de escore Barcelona entre si, o que é coerente: a terapia intensiva muda o perfil de gravidade; a faixa de complexidade, dentro de quem já tem UTI, muda mais o *tipo* de procedimento do que o risco de morte.

A célula vazia da ocupação de UTI em E1 não é bem uma célula vazia. E1 é definido pela *mediana* dos onze anos de leitos de UTI SUS igual a zero, e não por ausência de UTI em todos os anos. Dos 65 hospitais do estrato, **17 registram UTI SUS em algum ano**, num total de 67 hospitais-ano, e para eles a razão existe e vale 66,4% na mediana: é o *piscar cadastral* (Subseção 1.9.2). A célula fica fora da tabela porque 67 observações em 17 hospitais não descrevem o estrato, **e não porque a razão seja indefinida ali**.

As doze figuras que mostram a distribuição de cada indicador dentro de cada estrato, e as que as acompanham ano a ano, estão no Apêndice B.

1.11 O que os estratos separam, e o que eles não separam

A tabela anterior responde a uma pergunta binária: a mediana ordena ou não. Ela não diz *quanto* os estratos separam, nem em quais dimensões separam muito e em quais quase nada. Isso foi apurado cruzando os três estratos com **as 26 variáveis do painel que admitem leitura descritiva**, e não apenas com os seis indicadores do estudo. O levantamento inteiro, com a figura de η^2 variável a variável, a tabela das duas pontas e os três padrões que só aparecem com o painel largo, está no Apêndice B.

O achado que importa a quem decide cabe em um parágrafo, e é uma advertência sobre o próprio instrumento. A escada de complexidade **organiza fortemente a estrutura dos hospitais e quase não organiza o desfecho**. Saber em que degrau um hospital está explica de **23% a 43%** do que separa um hospital do outro em leitos, volume, faturamento e ocupação, e apenas **6% na mortalidade**, onde a escada nem sequer sobe: os degraus dois e três são estatisticamente indistinguíveis (p_{23} de 0,391). Traduzido: o degrau permite prever com folga o tamanho do hospital e o ritmo com que ele opera, e quase não permite prever quantos dos seus pacientes morrem. **Segmentar por capacidade instalada resolve o problema de comparar coisas incomparáveis; não deve ser lido como se o degrau explicasse a qualidade do que o hospital entrega.**

2 A Tabela SUS Paulista: o que uma mudança de financiamento move, e o que ela não move

Antes de avaliar: o que o bloco alcançado produziu, em número bruto

Esta abertura não avalia a Tabela SUS Paulista. Ela imprime o nível do bloco que a tabela alcança, ano a ano, e para por aí. Aqui **nada está sendo comparado**, nenhum número desta abertura entra na escada de evidência, e é justamente a distância entre o que estes números mostram e o que as subseções seguintes concluem que dá a esta seção o seu assunto.

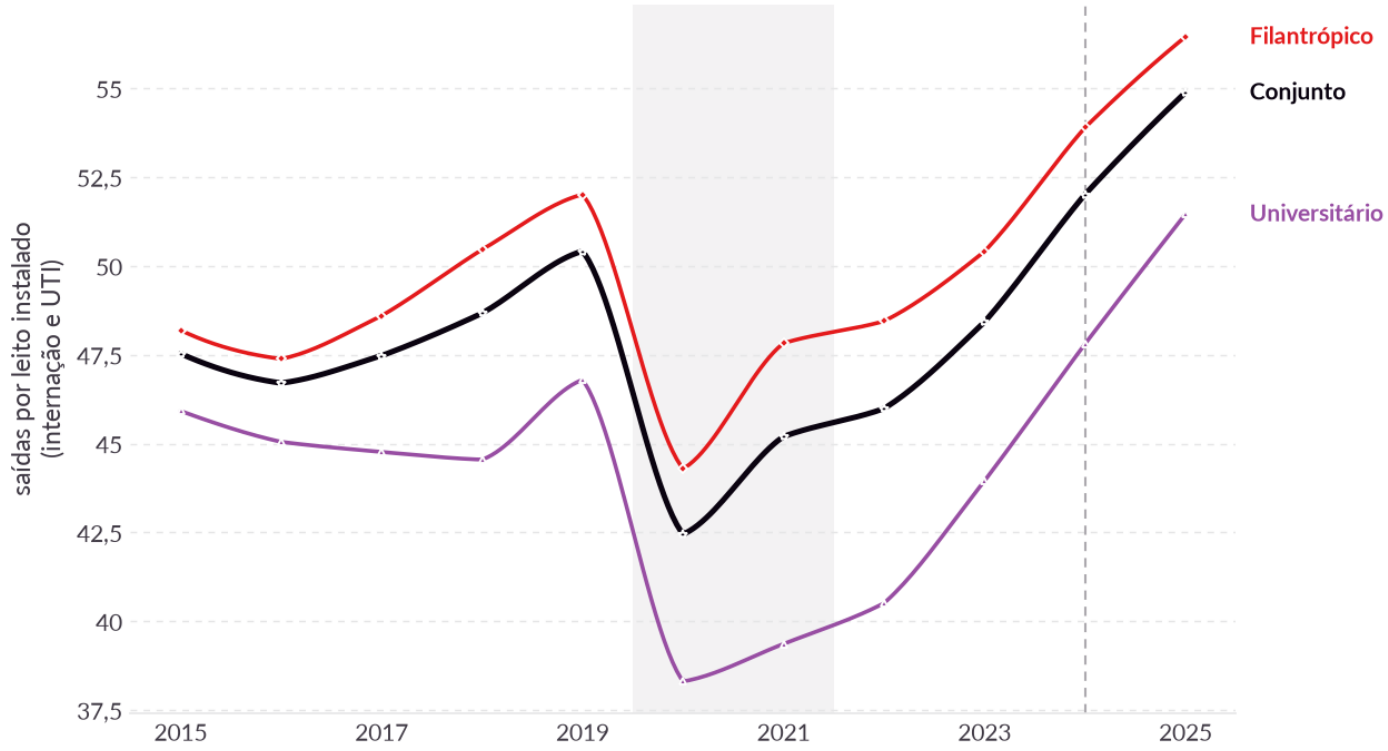
O universo são os 176 hospitais do recorte, os 159 filantrópicos mais 17 dos 18 universitários. É o mesmo recorte da Subseção 2.3, e ele se sobrepõe aos universos que abrem as Seções 1 e 3.

O bloco alcançado produziu mais depois do marco. Foram **1.330.592 saídas** em 2025, contra 1.164.123 em 2023, que é o último ano antes da tabela, e 1.166.855 em 2019. **O hospital mediano subiu junto**, de 4.314 saídas em 2019 para **4.854,5** em 2025.

E a alta complexidade subiu mais. Foram **213.906 saídas de alta complexidade** em 2025, contra 171.333 em 2023 e 159.904 em 2019; no hospital mediano são **29**, contra 10 em 2019. A taxa de ocupação do hospital mediano foi de 67,8% em 2019 a **75,5%** em 2025.

A Subseção 2.2 publica outra contagem de alta complexidade, e as duas não são comparáveis entre si: ela conta os **159 hospitais filantrópicos** que faturam produção pela tabela de procedimentos, a partir de **2023**, e chega a 128.015 saídas em 2025. Esta abertura conta os 176 do recorte a partir de 2019.

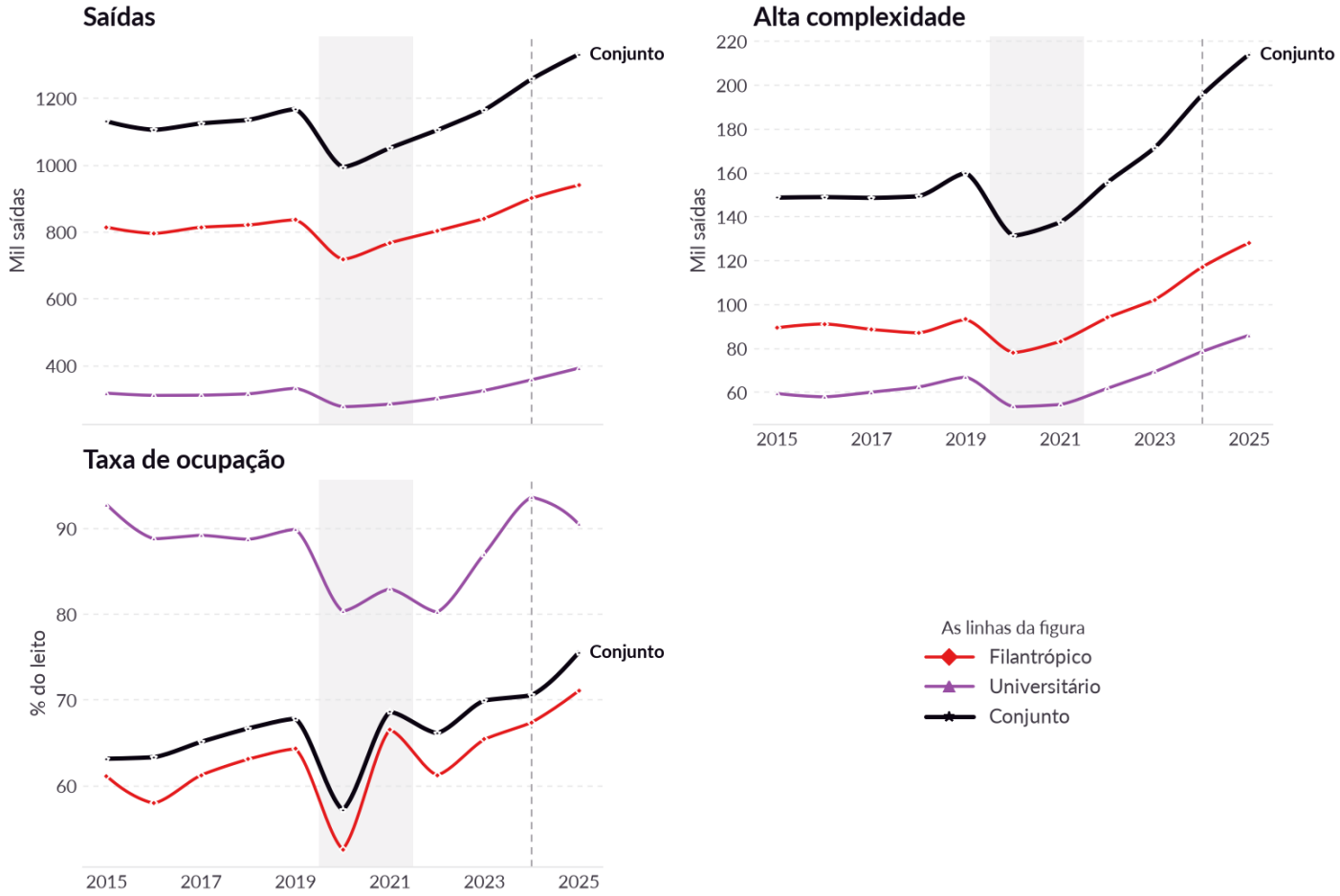
As quedas também são do mesmo bloco. A obstetrícia recuou **15,5%** entre 2019 e 2025, e **45 dos 176 hospitais fecharam 2025 com menos saídas do que registravam em 2019**.



Seção 2: o recorte da Tabela SUS Paulista. Contagem bruta; nada está sendo comparado.

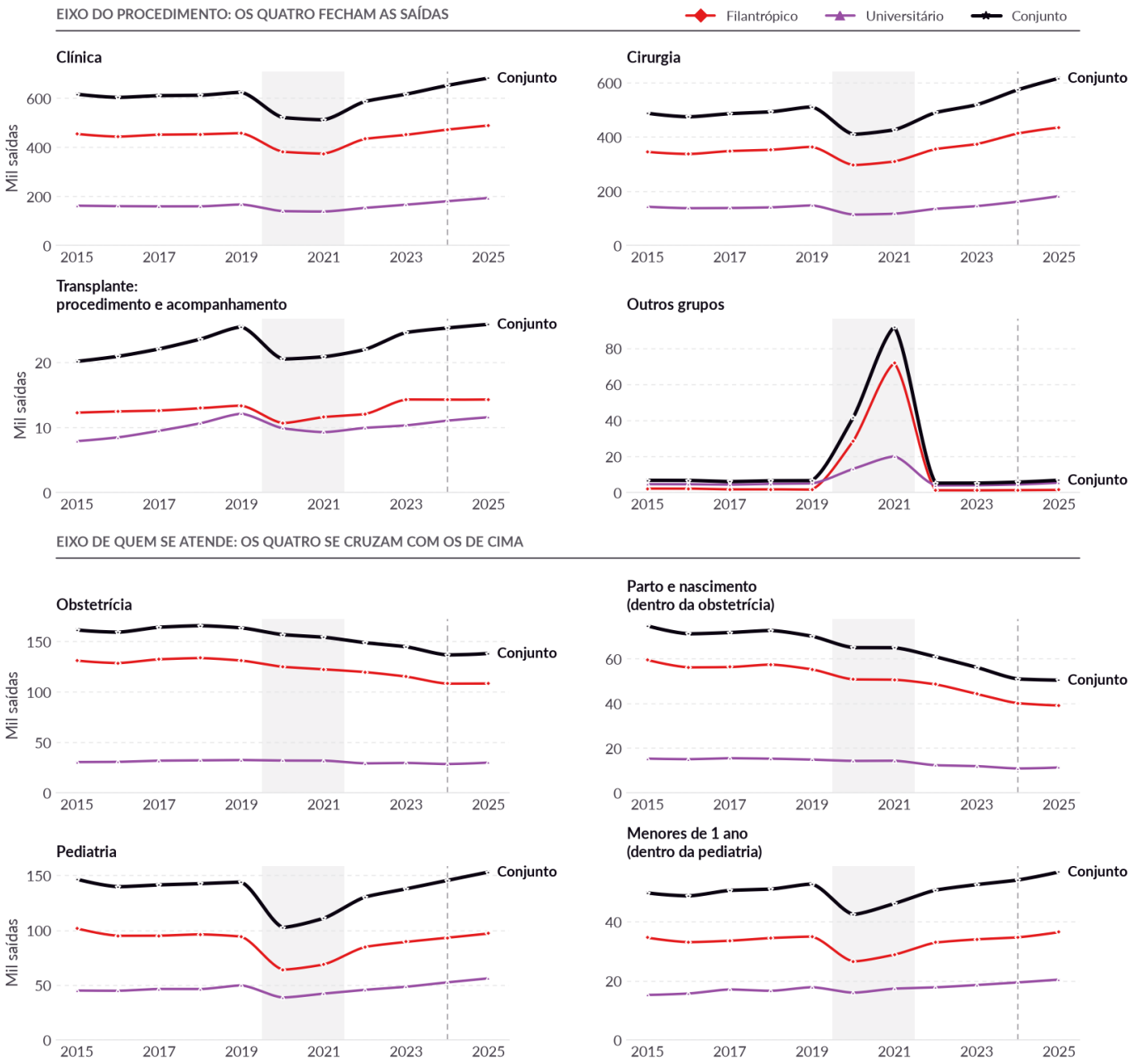
Figura 34: Saídas por leito instalado no recorte da Tabela SUS Paulista, por rede de gestão e no conjunto, ano a ano. A razão é as saídas do ano divididas pelos leitos SUS do ano, somados os dois no universo inteiro. **O denominador conta o leito de internação e o de terapia intensiva**, porque o numerador conta todas as saídas, inclusive as de terapia intensiva. Uma linha por rede de gestão, com o rótulo de rede fixado em 2023, e a linha escura do conjunto. A faixa cinza marca o biênio da pandemia. **A conta que mantém o leito parado no valor de 2023 não é desenhada aqui**: ela está no parágrafo seguinte, em número. A linha tracejada vertical marca 2024, o ano em que a Tabela SUS Paulista entrou em vigor.

A produção por leito subiu, e o leito não encolheu. A razão foi de **50,4** saídas por leito instalado em 2019 a **54,9** em 2025, com 48,4 em 2023. O leito cadastrado do recorte passou de 23.143 para 24.242 leitos SUS, e por isso a conta com o leito parado chega a 2025 em 55,4, um pouco acima da observada.



Seção 2: o recorte da Tabela SUS Paulista. Contagem bruta; nada está sendo comparado.

Figura 35: Saídas, saídas de alta complexidade e taxa de ocupação do recorte da Tabela SUS Paulista, ano a ano, **em contagem**. As duas primeiras séries são a soma de todos os hospitais do universo; a terceira é taxa, e por isso sai no hospital mediano, porque somar percentual de hospital não dá percentual de rede. O rótulo de rede é fixado em 2023 nas curvas por rede, para que a produção de um hospital que trocou de regime não mude de linha no meio da série; a linha do conjunto não é fixada, porque o total não se altera com reclassificação entre redes. A faixa cinza marca o biênio da pandemia. A linha tracejada vertical marca 2024, o ano em que a Tabela SUS Paulista entrou em vigor.



Seção 2: o recorte da Tabela SUS Paulista. Os dois grupos contam a MESMA internação por critérios diferentes e não se somam. Contagem bruta; nada está sendo comparado.

Figura 36: Perfil de caso do recorte da Tabela SUS Paulista, ano a ano, **em contagem** de internações, em dois grupos de quatro quadros. No grupo de cima, o **eixo do procedimento**, que é partição e fecha as saídas do ano; no de baixo, **quem se atende**, por especialidade e por idade, com cada total ao lado do seu recorte: o parto está dentro da obstetrícia e os menores de 1 ano dentro da pediatria. **Os dois grupos não se somam**: são **três eixos** do bruto de AIH, lidos de colunas diferentes, e por isso eles **se cruzam e não se somam**, já que uma cesárea em paciente de 30 anos entra na cirurgia, na obstetrícia e no parto ao mesmo tempo. **Outros grupos** reúne os procedimentos de finalidade diagnóstica, o **tratamento de COVID**, que existe em 2020 e 2021 e só neles, e as saídas que a fonte deixou sem grupo; ali o total do ano é pequeno e o movimento de um ano para o outro **não é leitura**. A escala é própria em cada quadro, e a âncora no zero impede que ela vire lupa. A linha tracejada vertical marca 2024, o ano em que a Tabela SUS Paulista entrou em vigor.

O que o recorte da Tabela SUS Paulista faz, por tipo de procedimento. Em 2025 foram **681.782 saídas clínicas**, **616.159 cirúrgicas**, **25.855 de transplante e acompanhamento** e **6.796 em outros grupos**. Os quatro somam exatamente as saídas do ano, de modo que eles podem ser lidos como partes de um todo. **O número do transplante não é o número de**

transplantes feitos: o grupo inclui o acompanhamento e as intercorrências do pré e do pós, e as ações de doação, que juntos são a maior parte dele.

E a cirurgia é a família que mais cresce. Ela passou de **510.706 saídas** em 2019 para as 616.159 de 2025, o que é um crescimento de **20,6%** no período. **Nada aqui diz por quê**: a figura não desconta complexidade, porte nem ano, e não há grupo de comparação. E a distância entre as redes nesta figura **é composição**: cada rede reúne hospitais de portes e perfis diferentes, de modo que quem ler modelo de gestão aqui estará lendo a carteira de casos de cada uma.

E quem o recorte da Tabela SUS Paulista atende. Em 2025 foram **138.152 saídas de obstetrícia**, das quais **50.394 de parto e nascimento**, e **152.940 de pediatria**, das quais **56.819 em menores de 1 ano**. Os dois pares são de contenção e não de soma, e nenhum deles se soma às quatro famílias de procedimento: a mesma internação é contada em mais de um eixo.

Agora a advertência que este bloco exige, e ela é o assunto das subseções seguintes. Tudo o que se acabou de ler é o bloco alcançado comparado com ele mesmo. **Um bloco que cresce depois de uma data não demonstra que cresceu por causa dela**: o país inteiro se recuperava da pandemia, e a rede paulista vinha de projetos próprios. A pergunta desta seção é se sobra crescimento depois de descontado o que já vinha acontecendo, e a resposta depende inteiramente de contra quem se compara. **A Subseção 2.3 mostra o preço de dispensar essa comparação**: tomado contra ele mesmo, este mesmo recorte acusa melhora em seis dos sete indicadores, inclusive no faturamento por saída, que é o campo por onde o complemento estadual comprovadamente não transita. Um desenho que encontra a tabela onde ela não passa está medindo o período.

2.1 O que fica desta avaliação

Em janeiro de 2024 passou a valer a Tabela SUS Paulista, que acrescenta remuneração estadual à tabela federal para procedimentos realizados em hospitais paulistas. Esta seção pergunta se a mudança aparece no que os hospitais fizeram. **O quadro abaixo é a resposta inteira**, e as páginas seguintes explicam cada linha dele.

Tabela 12: O que a avaliação encontrou em cada indicador do bloco alcançado, com a régua de comparação ao lado de cada número.

O que podia ter mudado	O que os números mostram, e contra quê
Número de internações	**10,0%** acima das redes de comparação em 2025, e a distância não se sustenta contra os hospitais municipais
Faturamento total	**13,3%** acima das redes de comparação em 2025, e quem o move é o número de internações, não o preço de cada uma
Valor de cada internação	R$ 1.236 em 2023 e R$ 1.234 em 2025: **o preço mudou fora do alcance desta base**, porque o complemento estadual corre por convênio
Cirurgias	**434.679** em 2025, contra 373.444 em 2023, que são **16,4%** a mais; as redes de comparação fizeram **3,8%** a mais, e a distância entre os dois é de **12,1%**
Casos de alta complexidade	**128.015** em 2025, contra 102.065 em 2023, que são **25,4%** a mais; as redes que a tabela não alcança cresceram **21,0%**, e **o que liga esse crescimento à tabela é o canal de financiamento**, e não a distância entre os dois números
Tempo de permanência	não se move em leitura nenhuma
Taxa de ocupação	**4,15 pontos** acima das redes de comparação em 2025, e já subia **0,70 ponto ao ano** antes da tabela
Saídas por leito de internação	**6,7%** acima das redes de comparação em 2025, e já subiam **1,68%** ao ano antes da tabela

A fronteira do achado do volume: ele se sustenta contra as redes de orçamento global e não se sustenta contra os hospitais municipais, que a regra do programa deixou de fora. **A cirurgia tem a mesma fronteira**: o resultado vale contra as redes de orçamento global. **O desenho de comparação que produz estes números**, com as verificações que o cercam, está no Apêndice G, junto com as ressalvas de método.

O volume de internações é o resultado mais firme desta seção. Os **159 hospitais filantrópicos**, que são a rede que fatura produção pela tabela de procedimentos, internaram em 2025 **10,0%** mais do que os hospitais geridos por organizações sociais e pela administração direta, tomando 2023 como partida. É o único resultado da seção que atravessa as três verificações que o desenho permite.

E ele tem uma fronteira. Os hospitais de titularidade municipal ficaram fora da tabela durante toda a janela deste painel, por regra escrita do programa, o que faz deles o grupo de comparação mais limpo que esta avaliação tem. **Medida contra eles, a diferença de 2025 é pequena demais para ser afirmada.** Os municipais também internaram mais sem receber pela tabela, e um crescimento que aparece nos dois lados não pode ser creditado ao que os separa.

O crescimento chega no segundo ano, e o segundo ano admite duas leituras. Em 2024 a diferença ainda é pequena demais para se separar do acaso, e em 2025 ela se separa. **A tabela, porém, não cobriu o mesmo conjunto nos dois anos**: nasceu alcançando pouco mais de uma centena de instituições e passou de setecentas no ano seguinte. Parte do que se lê como resposta tardia **pode ser cobertura que chegou depois**, e não decisão que demorou.

O preço de cada internação não se move, e essa é a limitação central desta avaliação. O complemento estadual é pago por convênio, por fora da tabela federal que o registro de internação traz: o valor que esta base enxerga não se move por mais que a receita do hospital mude. **O preço mudou fora do alcance da medição**, e isso não é o mesmo que não ter mudado.

O que se move e o que não se move, depois da resposta do volume. A cirurgia cresce, e o crescimento se sustenta; a produção de alta complexidade também cresce, e a Tabela SUS Paulista explica o movimento: é a verba estadual que financiou a ampliação da capacidade de atendimento de alta complexidade nos hospitais alcançados. O tempo de permanência não se move em leitura nenhuma. **A taxa de ocupação e a produtividade por leito sobem, e as duas já vinham subindo antes da tabela**, o que impede lê-las como resposta a ela.

Esses resultados não são o retrato de uma política sem efeito. São o retrato do que um painel anual de internações consegue enxergar de uma mudança de remuneração que não passa pelo campo que ele registra e que alcançou conjuntos diferentes em cada ano. A diferença entre as duas afirmações é grande, e a fase qualitativa existe para tratá-la.

2.2 Indicador a indicador: o volume, o faturamento, o perfil dos casos e a produtividade

O bloco alcançado são os 159 hospitais filantrópicos do painel, que são a rede que fatura produção pela tabela de procedimentos, e é por esse canal que uma tabela de pagamento alcança um hospital. Os conjuntos de comparação são as **redes de orçamento global**, custeadas por contrato e não por reembolso de internação, e os **hospitais de titularidade municipal**, que a regra do programa deixou de fora durante toda a janela deste painel. **A categoria universitária fica fora desta avaliação, dos dois lados**, e o recorte que fecha esta seção a inclui por outro critério, resolvendo *por nome* os dois hospitais que decidiram a questão.

O volume de internações do bloco alcançado cresce, e é o resultado mais firme desta seção. Tomando 2023 como partida, os hospitais filantrópicos internaram **7%** mais em 2024 e **12%** mais em 2025; as redes de orçamento global, **2%** e **3%** mais; e os hospitais de titularidade municipal, que a norma não alcançou, **4%** mais nos dois anos. **O que este desenho mede não é a subtração entre esses números**: ele compara cada hospital consigo mesmo ao longo do tempo e desconta o que foi comum a todos naquele ano. Feita essa conta, sobra uma diferença de **10,0%** em 2025 contra as redes de orçamento global, com folga para descartar o acaso.

E o resultado tem uma fronteira. A distância é menor contra o grupo que a norma excluiu do que contra as redes de orçamento global: trocando o conjunto de comparação, o número de 2025 encolhe até **deixar de se separar do acaso contra os hospitais municipais**, que são, pelo critério desta própria seção, o grupo de comparação mais limpo. **O crescimento do volume continua sendo o resultado mais firme desta seção; o que ele não é, é indiferente a quem serve de comparação.**

Nada disso vale para o preço, e a razão é que ele não passa por aqui. O faturamento por saída, em reais de dezembro de 2025, **não se move em bloco nenhum, em ano nenhum, contra conjunto de comparação nenhum**: fica em R$ 1.255 em 2024 e R$ 1.234 em 2025, contra R$ 1.236 em 2023, e a diferença é pequena demais para se separar do acaso. **A razão é documental, e não estatística**: o complemento estadual é pago por **convênio**, por fora da tabela federal que este painel observa, de modo que **nenhum resultado adiante pode ser lido como resposta a um preço que se possa medir aqui**.

A cirurgia cresce, e o crescimento sobrevive às verificações: é o segundo resultado mais firme desta seção. Os hospitais filantrópicos fizeram **373.444** cirurgias em 2023 e **434.679** em 2025, que são **16,4%** a mais; as redes de orçamento global fizeram **3,8%** a mais no mesmo período. Descontado o que foi comum a todos em cada ano, a distância em cirurgias é de **6,9%** em 2024 e **12,1%** em 2025, e as duas são grandes o bastante para serem afirmadas. **As trajetórias anteriores ao marco são paralelas**, e dar a cada hospital a reta que ele já vinha desenhando deixa a cirurgia em **14,4%** em 2025.

E ela tem a mesma fronteira que o volume tem. Medida contra os hospitais de titularidade municipal, a diferença de 2025 continua grande, mas ali **as trajetórias anteriores ao marco não são paralelas**, e o desenho não autoriza a leitura: **o que esta seção afirma da cirurgia vale contra as redes de orçamento global**.

A produção de alta complexidade também cresce, e a Tabela SUS Paulista explica o movimento. Os hospitais filantrópicos registraram **102.065** internações de alta complexidade em 2023, **116.937** em 2024 e **128.015** em 2025, que são **25,4%** a mais em dois anos. As redes de orçamento global, que não faturam produção pela tabela de procedimentos, também cresceram na alta complexidade nos mesmos dois anos, **21,0%**; descontado o que foi comum a todos, a distância na alta complexidade entre os dois blocos é de **1,5%** em 2024 e **3,7%** em 2025. **A atribuição à tabela vem do mecanismo de financiamento, e não desse desconto contra o grupo de comparação**: a verba estadual foi direcionada para os hospitais ampliarem a capacidade de

atendimento de alta complexidade, e é esse canal, e não a distância estatística contra as redes de orçamento global, que sustenta a leitura. E as diárias de terapia intensiva por saída não sobem.

São duas medidas do mesmo perfil, e esta seção usa a de produção: a fração, que é a medida da Seção 1 e da estimação, responde outra pergunta, e os dois números não são comparáveis entre si.

O padrão de internação não muda, e a produtividade aparente já vinha subindo. O tempo médio de permanência não se separa do acaso em nenhuma das especificações. **A taxa de ocupação de internação está 4,15 pontos acima** das redes de orçamento global em 2025, e é um movimento grande; **ele não se lê como resposta à tabela porque a ocupação do bloco já subia 0,70 ponto ao ano** em relação às redes de comparação desde antes do marco.

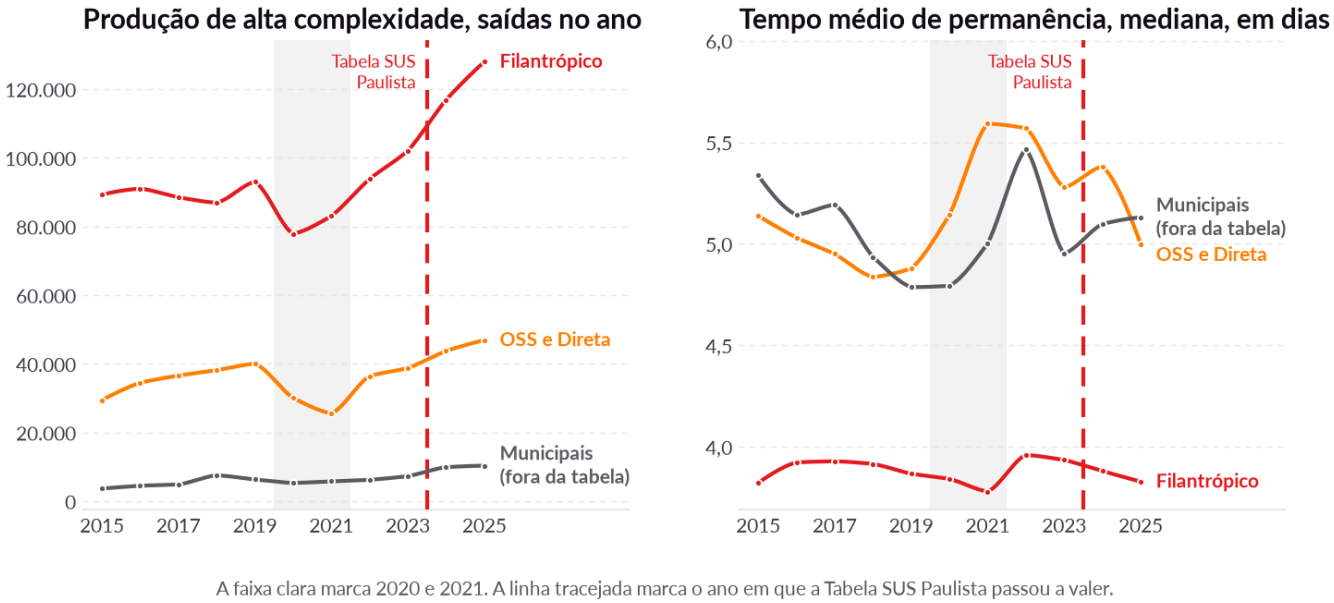


Figura 37: A produção de alta complexidade dos três grupos, em número de saídas no ano, e o tempo médio de permanência, em mediana de hospital. À esquerda, quantas saídas de alta complexidade cada grupo produziu no ano; à direita, o tempo médio de permanência. As três linhas são os grupos, a faixa clara marca 2020 e 2021, e a tracejada marca o ano em que a tabela passou a valer. **À esquerda o que se procura é se a distância entre as linhas se abre depois do tracejado**, e à direita, se alguma delas muda de nível.

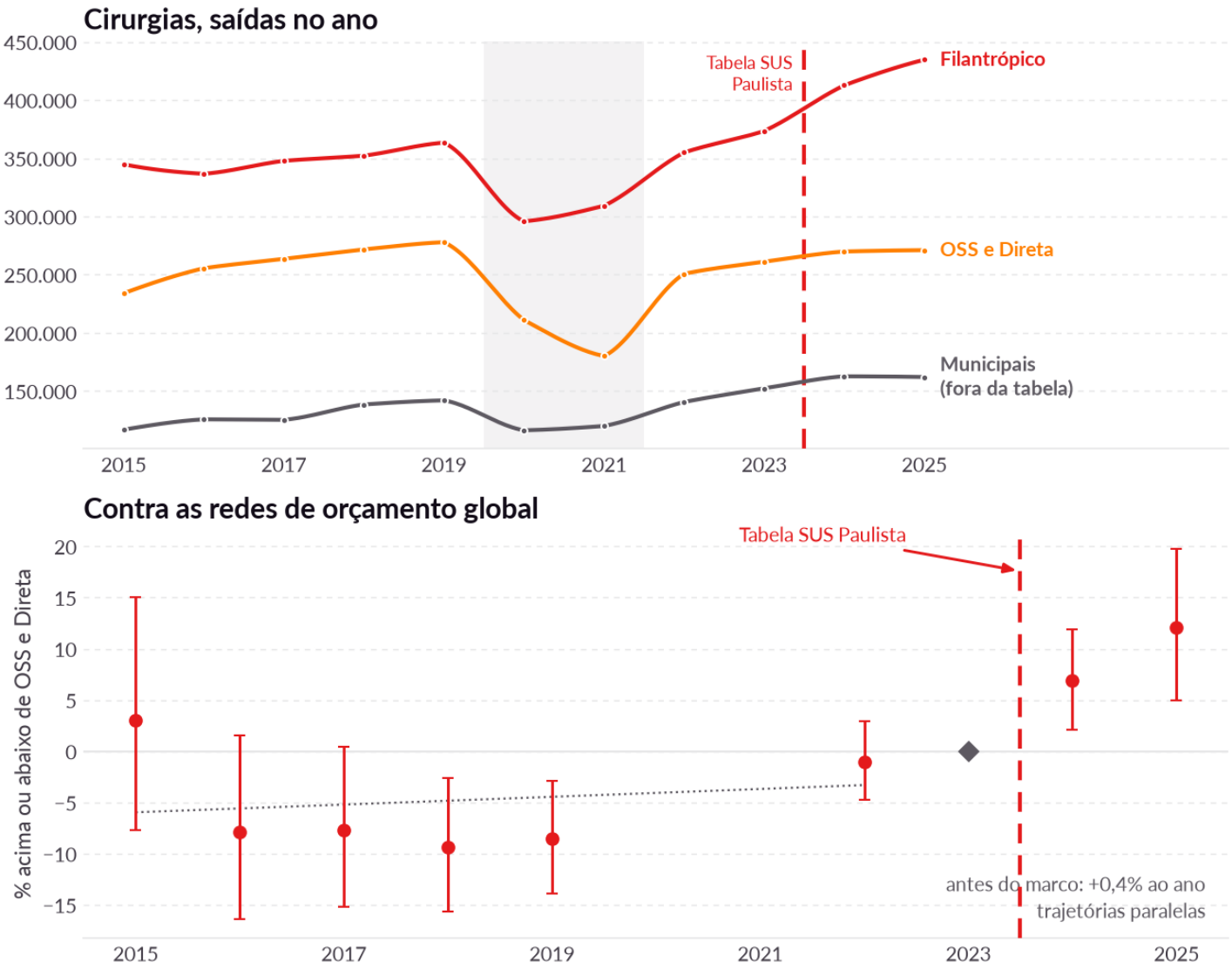


Figura 38: As cirurgias dos três grupos, em número de saídas no ano, e a distância entre os hospitais filantrópicos e as redes de orçamento global, tomando 2023 como ponto de partida, com a tendência anterior ao marco ajustada. Em cima, quantas cirurgias cada grupo produziu no ano. Embaixo, cada ponto mede a distância entre os hospitais filantrópicos e as redes de orçamento global naquele ano, com o losango de 2023 em zero por construção, e as barras dizem quanta imprecisão há em cada um. **A reta pontilhada é a tendência ajustada aos anos anteriores ao marco**: plana quer dizer que os grupos vinham paralelos, e o que aparece depois do tracejado é movimento novo. A contagem soma as cirurgias de todos os hospitais do grupo naquele ano. **A distância é estimada em Poisson**, e não em logaritmo, e a razão é que parte dos anos-hospital registra zero: em logaritmo essas observações sairiam da conta, e o hospital entraria e sairia da amostra conforme tivesse ou não tido um caso naquele ano.

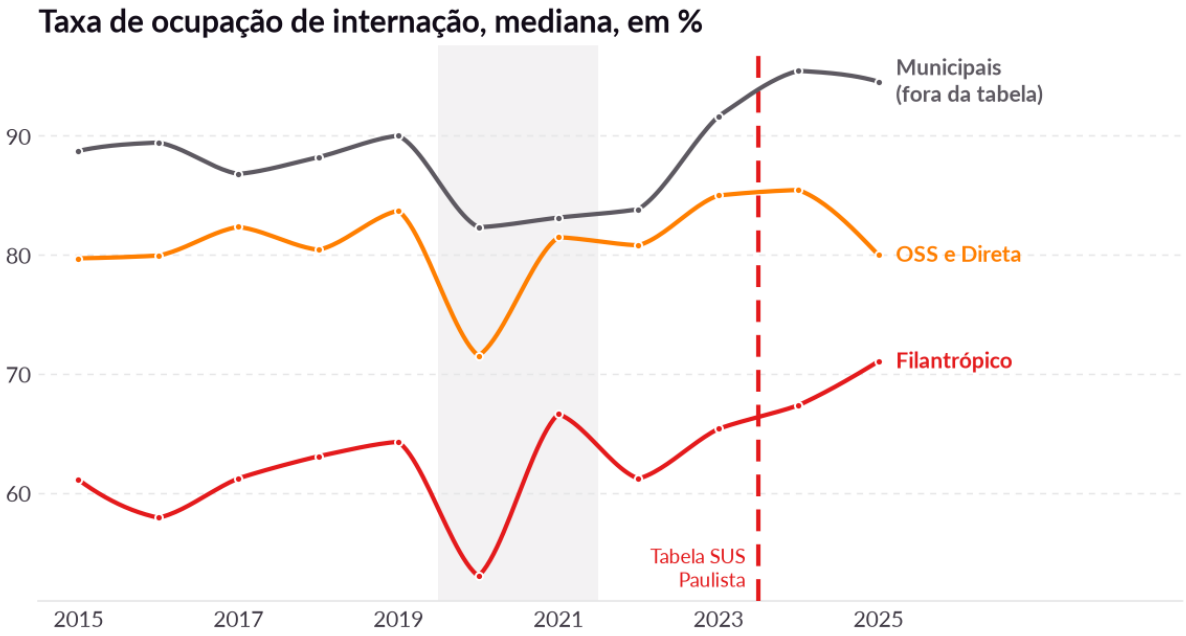


Figura 39: A taxa de ocupação de internação dos três grupos, ano a ano. A taxa de ocupação de internação, na mediana de cada grupo. **O que se procura é uma mudança de nível depois do tracejado**, e ela aparece só no grupo alcançado, e só em 2025.

A produtividade parecia ter subido, e o teste de marco falso mostrou que não. As **saídas por leito de internação** dos hospitais filantrópicos aparecem **1,6% abaixo** das redes de orçamento global em 2024 e **6,7% acima** em 2025, na mesma conta que mede o volume. Lido sozinho, o número de 2025 diria que a tabela tornou a rede mais produtiva. **Ele não se lê assim, porque a produção por leito do bloco já vinha subindo 1,68% ao ano** em relação às redes de comparação desde antes do marco.

São duas razões por leito nesta seção, e por isso dois nomes. Esta divide as saídas pelo leito SUS de internação; a que abre a seção em número bruto soma ao denominador o leito de terapia intensiva, e se chama saídas por leito instalado. Os dois números não são comparáveis entre si.

O volume de internações cresce nos três grupos, e cresce mais em quem a tabela alcança.

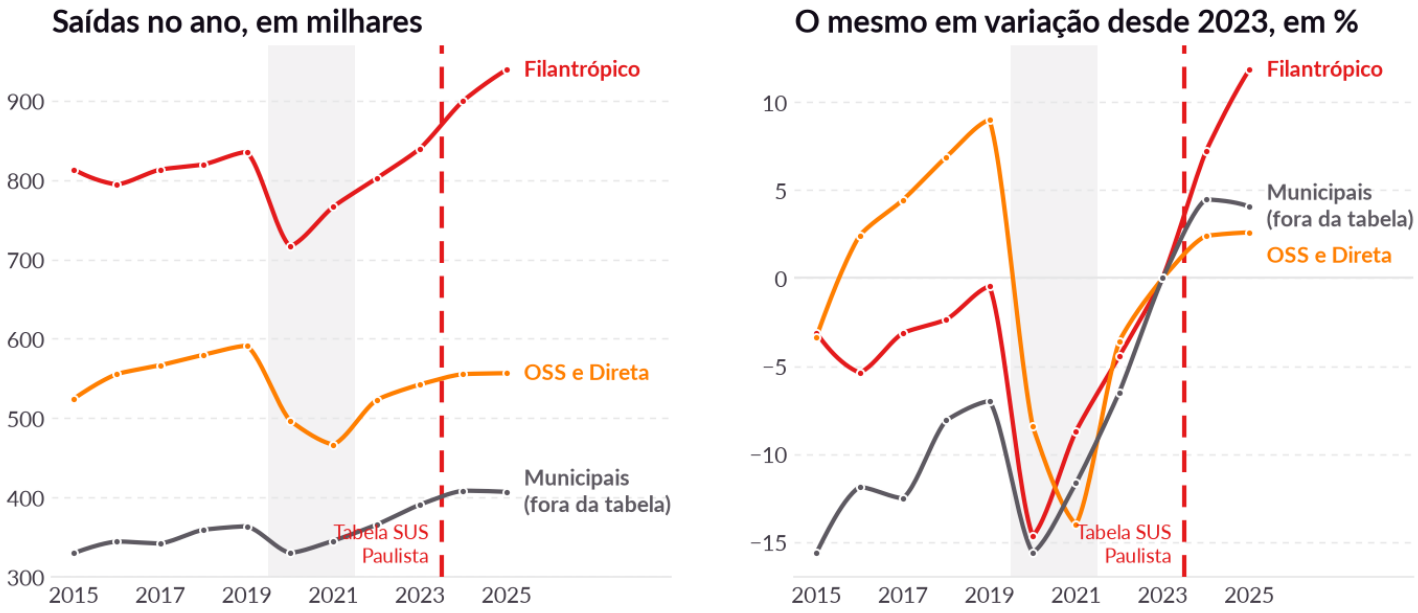


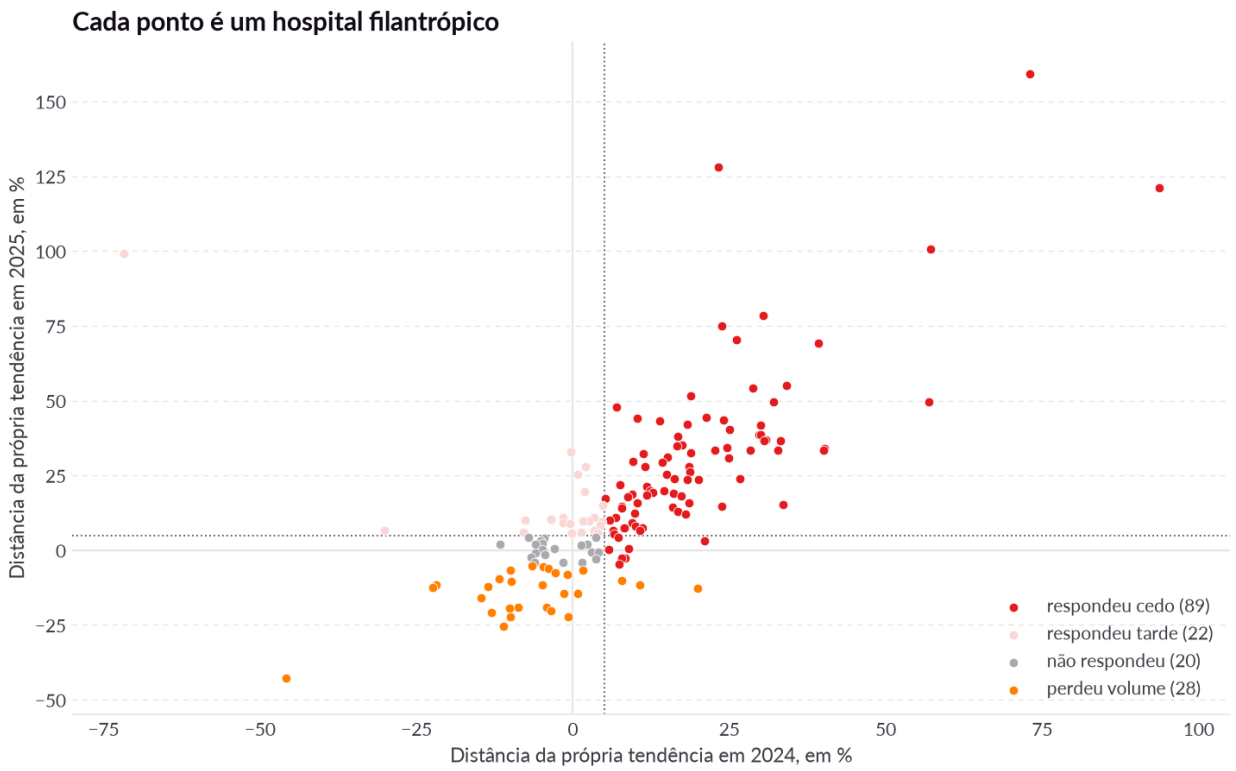
Figura 40: A produção bruta dos três grupos, ano a ano, de 2015 a 2025. À esquerda, em saídas; à direita, em variação desde 2023. Cada linha é um grupo. À esquerda, a produção bruta em milhares de saídas; à direita, a mesma série em variação desde 2023, de modo que a linha do zero é o nível daquele ano. **O que se lê é a distância entre as linhas depois do tracejado**, e não a altura de cada uma. Cada linha soma as saídas de todos os hospitais do grupo naquele ano. **O painel é balanceado**: cada hospital aparece nos onze anos, de modo que nenhuma subida vem de hospital entrando na conta. Os grupos são os 159 filantrópicos, os 55 sob organização social e administração direta que não são de titularidade municipal, e os 43 de titularidade municipal.

Os três crescem dentro de um Estado que também cresce, e essa é a régua que falta a qualquer um deles sozinho. Somadas as saídas de todos os hospitais paulistas presentes nos onze anos, o Estado internou **6%** mais em 2024 e **9%** mais em 2025 sobre a mesma partida. **O bloco alcançado cresce pouco acima do Estado e os dois conjuntos de comparação crescem bem abaixo dele**, de modo que a distância que esta seção mede é, em boa parte, comparação crescendo devagar, e não bloco alcançado disparando.

O crescimento do bloco alcançado chega no segundo ano, e não no ano em que a tabela passou a valer. Em 2024 a distância para as redes de comparação ainda é pequena demais para ser afirmada, e em 2025 ela se afirma. **A explicação não é que a rede inteira tenha esperado.**

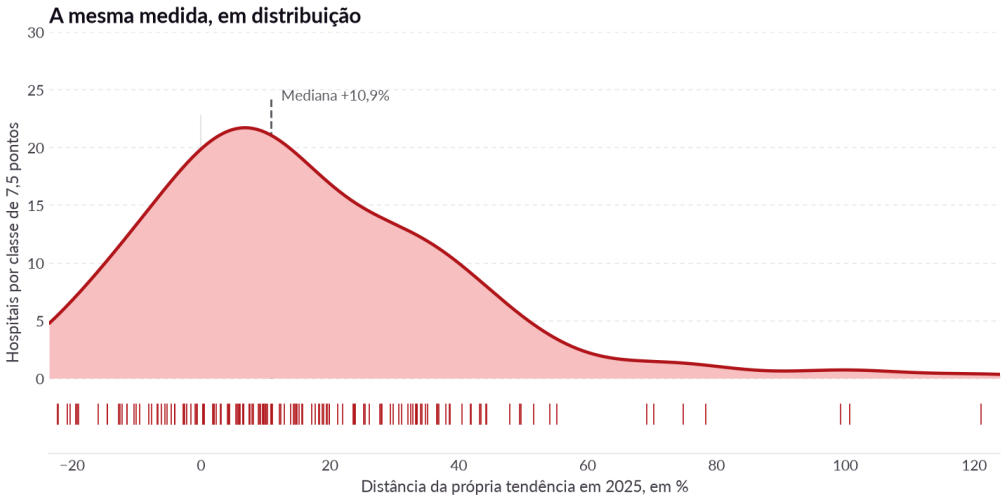
O atraso do bloco é de composição, e não de espera. Medido hospital a hospital, contra a reta que cada um vinha desenhando, **92 dos 159 hospitais filantrópicos já estão acima da própria tendência em 2024**. Separados em padrões, **89 sobem já em 2024 e seguem acima em 2025**, **22 sobem apenas em 2025**, **20 não se movem** e **28 perdem volume**; a mediana do bloco em 2025 fica **10,9% acima da própria tendência**. **A média do bloco chega tarde porque soma dois movimentos contrários.**

O que separa quem se moveu de quem não se moveu não está na estrutura. A mediana de leitos SUS vai de **62 a 76** entre os quatro padrões, a fração de internações cirúrgicas de **37,6% a 39,4%** e a fração de leitos que são SUS de **63,9% a 76,5%**, e **nenhuma das três separa os padrões**. A maior diferença é de localização, e vai de **nenhum** hospital na capital entre os que sobem apenas em 2025 a **14,3%** entre os que perdem volume.



A tendência de cada hospital é a reta ajustada ao log do seu volume nos anos anteriores ao marco, fora 2020 e 2021. O corte dos padrões é de cinco pontos percentuais.

Figura 41: A resposta ao marco, hospital a hospital, nos 159 filantrópicos: a distância da própria tendência em 2024 contra a de 2025. Cada ponto é um hospital, e a cor é o padrão de resposta. Na primeira figura, cada ponto é um hospital filantrópico, com a distância até a própria tendência em 2024 no eixo de baixo e a de 2025 no da esquerda; **a cor é o padrão de resposta** e as pontilhadas marcam o corte de cinco pontos que o define. A segunda traz a mesma distância de 2025 em distribuição. **O que se procura é se os pontos formam um grupo só**, e eles não formam.



Cada hospital entra uma vez, com a distância entre o volume de 2025 e a própria tendência anterior ao marco. A linha tracejada é a mediana. 4 hospitais ficam fora da janela do p1 ao p99.

Figura 42: A mesma medida de 2025, em distribuição. A linha tracejada marca a mediana dos 159 hospitais. A tendência de cada hospital é a reta ajustada ao logaritmo do seu volume nos anos anteriores ao marco, fora 2020 e 2021, e a resposta é a distância entre o que ele fez e o que a reta previa. **Ano de volume muito abaixo do que o hospital pratica fica fora do ajuste**: um ano de abertura inclinaria a reta.

Medida contra os hospitais de titularidade municipal, que a regra do programa manteve de fora durante toda a janela, a diferença de 2025 é pequena demais para ser afir-

mada. Os municipais também internaram mais sem receber pela tabela, e um crescimento que aparece nos dois lados não pode ser creditado ao que os separa. **Isso não é o mesmo que dizer que a tabela não teve efeito**: é o que uma série anual de internações consegue separar.

Onde o desenho identifica, o resultado é de volume e chega no segundo ano; onde ele não identifica, a leitura é descritiva, e o texto a apresenta assim.

2.3 Um recorte próprio: os filantrópicos e os universitários juntos

Esta subseção responde a uma pergunta diferente da anterior, e o recorte é a diferença. A Subseção 2.2 toma como alcançados os hospitais que faturam produção pela tabela de procedimentos, que são os filantrópicos. **Aqui o bloco alcançado inclui também os hospitais universitários**, pela razão econômica que a pesquisadora principal apontou: eles recebem a complementação da Tabela SUS Paulista **pelas fundações de apoio**, de modo que respondem ao mesmo mecanismo de receita, por outro canal.

O recorte tem 176 hospitais: os 159 filantrópicos e 17 dos 18 universitários. **O Hospital das Clínicas da Unicamp entra**, e a razão está publicada pela própria Secretaria de Estado da Saúde, que o traz em segundo lugar entre as dez instituições que mais aumentaram internações sob a tabela. **O Hospital Universitário da USP fica de fora**, porque não há fonte que estabeleça se o programa o alcança, e enquanto não houver nenhum argumento deste documento pode se apoiar nele, em direção nenhuma.

O resultado do recorte repete o da subseção anterior, com a mesma fragilidade. Contra as redes de orçamento global, o volume de internações fica **13,0% acima** e o faturamento total **12,6% acima**, os dois separando-se do acaso; a taxa de ocupação de internação sobe **5,1 pontos**. **Contra os hospitais de titularidade municipal, que a regra do programa deixou de fora até 2026, nada disso se separa**: o volume fica em −3,1% e o faturamento total em −3,6%. **Acrescentar os universitários ao bloco não muda a leitura**, e é essa a resposta à pergunta que motivou o recorte.

E o faturamento por saída continua parado, aqui como lá. Ele fica em −0,3% contra as redes de orçamento global e em −0,5% contra os municipais, sem se separar do acaso em nenhum dos dois. **Na descritiva do próprio recorte ele cai**, de R$ 3.010 para R$ 2.856 nos universitários e de R$ 1.258 para R$ 1.247 nos filantrópicos, entre os anos anteriores e os posteriores ao marco. **É o que a Subseção 2.2 já explica por documento**: o complemento estadual é pago por convênio, por fora da tabela federal que esta base registra, e por isso não teria como aparecer neste campo.

Uma leitura sem grupo de comparação diria outra coisa, e é por isso que ela não é a leitura desta subseção. Tomado o recorte contra ele mesmo, antes e depois do marco, com a trajetória anterior descontada, *seis dos sete indicadores* sobem, inclusive o faturamento por saída, com **5,7%**. **Um desenho que encontra a tabela no campo por onde ela comprovadamente não passa está medindo o período, e não a política**, e é por isso que o grupo de comparação não é dispensável.

O método desta seção e as suas ressalvas estão no Apêndice G: quem a tabela alcança e contra quem ela compara, o que sustenta cada número, e o que esta avaliação não consegue dizer.

3 Onde a comparação se sustenta: quatro modelos de gestão entre hospitais equivalentes

Esta seção é o veredito comparativo do documento. Toma o estrato em que os hospitais de fato fazem a mesma coisa, com terapia intensiva própria e alta complexidade, e pergunta se os modelos de gestão que operam ali diferem no ritmo de trabalho, no uso do leito, no desfecho clínico e na distância até a melhor prática observada. É comparação entre hospitais equivalentes, não entre médias de rede. O que ela não responde é a pergunta causal: diferença apurada aqui não autoriza dizer que trocar o modelo produziria o resultado do outro modelo, porque quem vai para qual regime não é sorteado.

O que vem nesta seção

3.1 O retrato do grupo E3, indicador a indicador 84
Como cada indicador se distribui dentro do E3, e quanto disso é a rede.

3.2 Os resultados em E3 92
Que diferenças sobrevivem entre hospitais equivalentes, e quais não sobrevivem.

3.3 A taxa de ocupação de internação eram duas perguntas, não uma 95
O que a taxa de ocupação somava sem se ver, e quem transborda quanto.

3.4 A distância até a melhor prática entre hospitais equivalentes 102
Quanto muda a eficiência quando a fronteira é a dos pares.

3.5 As quatro redes dentro do grupo E3, lado a lado 107
Como as quatro redes se parecem antes de qualquer desconto.

3.6 O que a segmentação acrescenta 113
Onde há evidência afinal, e que problema o corte não resolve.

3.7 As conversões de gestão: o que foram, e por que não sustentam leitura causal 114
O que a troca de gestão mostra, e por que não se lê como causa.

Antes do veredito: o que o estrato produziu, em número bruto

Esta abertura não é o veredito. Ela imprime o nível do estrato onde a comparação desta seção acontece, e nada mais. Tudo o que vem depois desconta complexidade, porte e ano, e compara rede com rede; aqui **nada está sendo comparado**, e nenhum número desta abertura entra na escada de evidência.

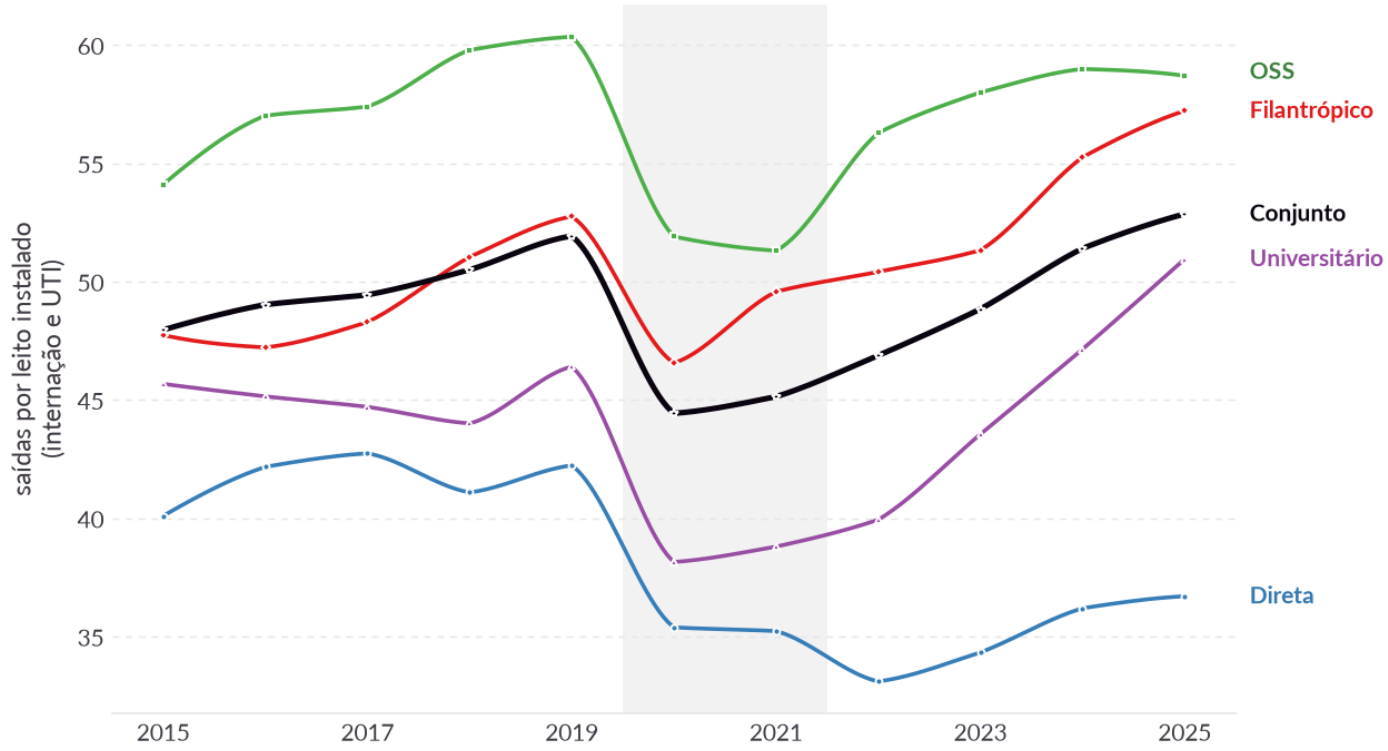
O universo são os 120 hospitais do estrato E3, os que têm terapia intensiva própria e capacidade instalada nas faixas mais altas da escala de Barcelona. **Capacidade instalada não é produção**: o estrato reúne quem tem estrutura para tratar caso complexo, e quanto cada um de fato trata é uma das coisas que esta seção mede. Ele se sobrepõe aos universos que abrem as Seções 1 e 2, e somar os três conta o mesmo hospital mais de uma vez.

O estrato concentra a produção da rede. Foram **1.675.674 saídas** em 2025, contra 1.532.219 em 2023 e 1.551.299 em 2019. São 120 hospitais dos 275, e eles respondem por quase três quartos das saídas da rede inteira. **O hospital mediano do estrato** passou de 10.648 saídas em 2019 para **12.186,5** em 2025, praticamente o dobro do hospital mediano da rede inteira.

E a diferença de perfil aparece inteira na alta complexidade. Foram **236.018 saídas de alta complexidade** em 2025, contra 188.256 em 2023 e 179.062 em 2019. **No hospital mediano do estrato são 791,5**, contra 605 em 2019, e são 42 no hospital mediano da rede inteira: a capacidade instalada que define o estrato tem correspondência no que ele produz.

E o leito do estrato opera perto do limite. A taxa de ocupação do hospital mediano foi de 90,8% em 2019 a **95,2%** em 2025, com 90,9% em 2023. O hospital mediano da rede inteira fecha 2025 quase dezessete pontos abaixo disso.

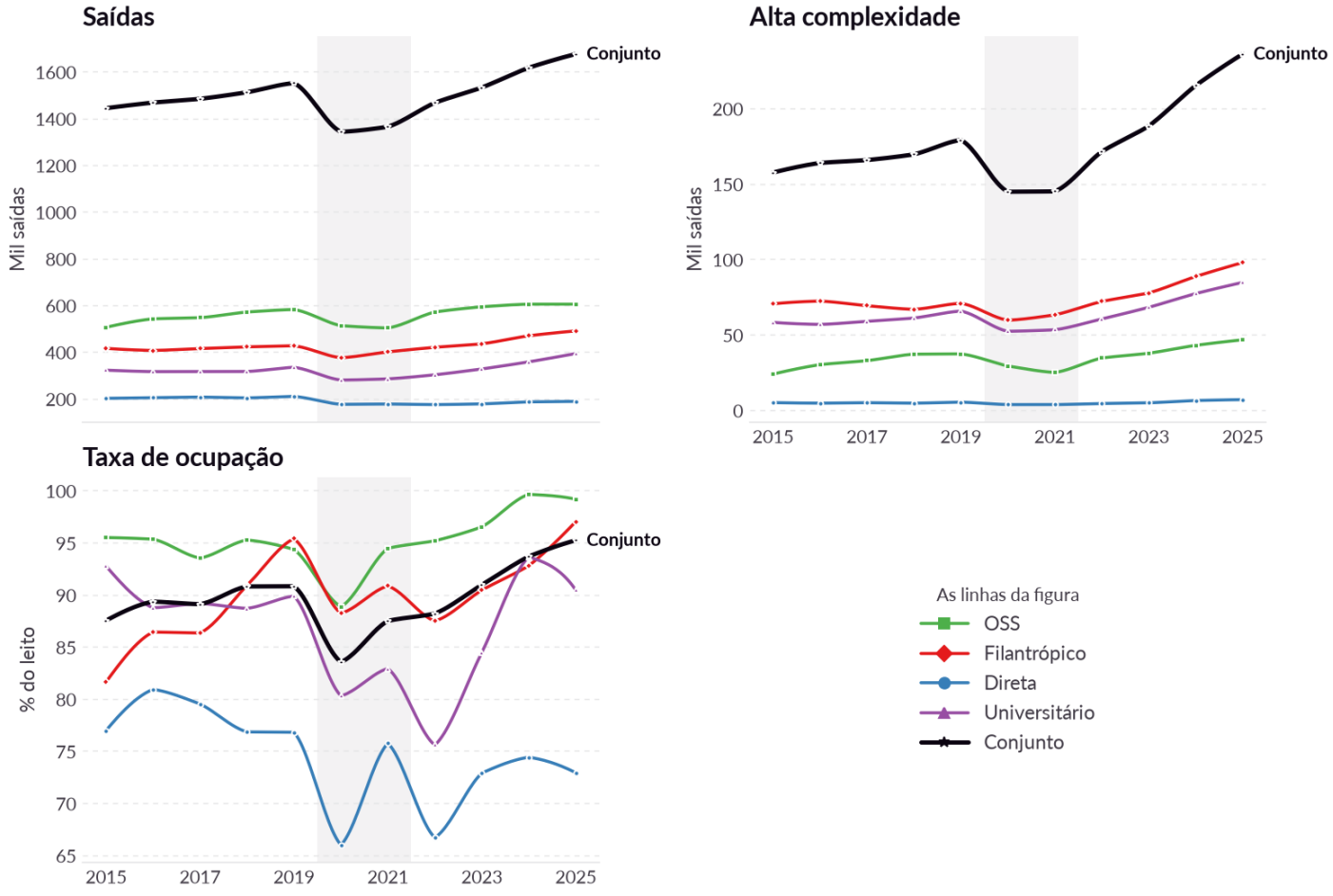
As quedas acompanham, e aqui são maiores. A obstetrícia recuou **20,9%** entre 2019 e 2025, mais do que na rede inteira, e **47 dos 120 hospitais fecharam 2025 com menos saídas do que registravam em 2019**.



Seção 3: o estrato E3. Contagem bruta; nada está sendo comparado.

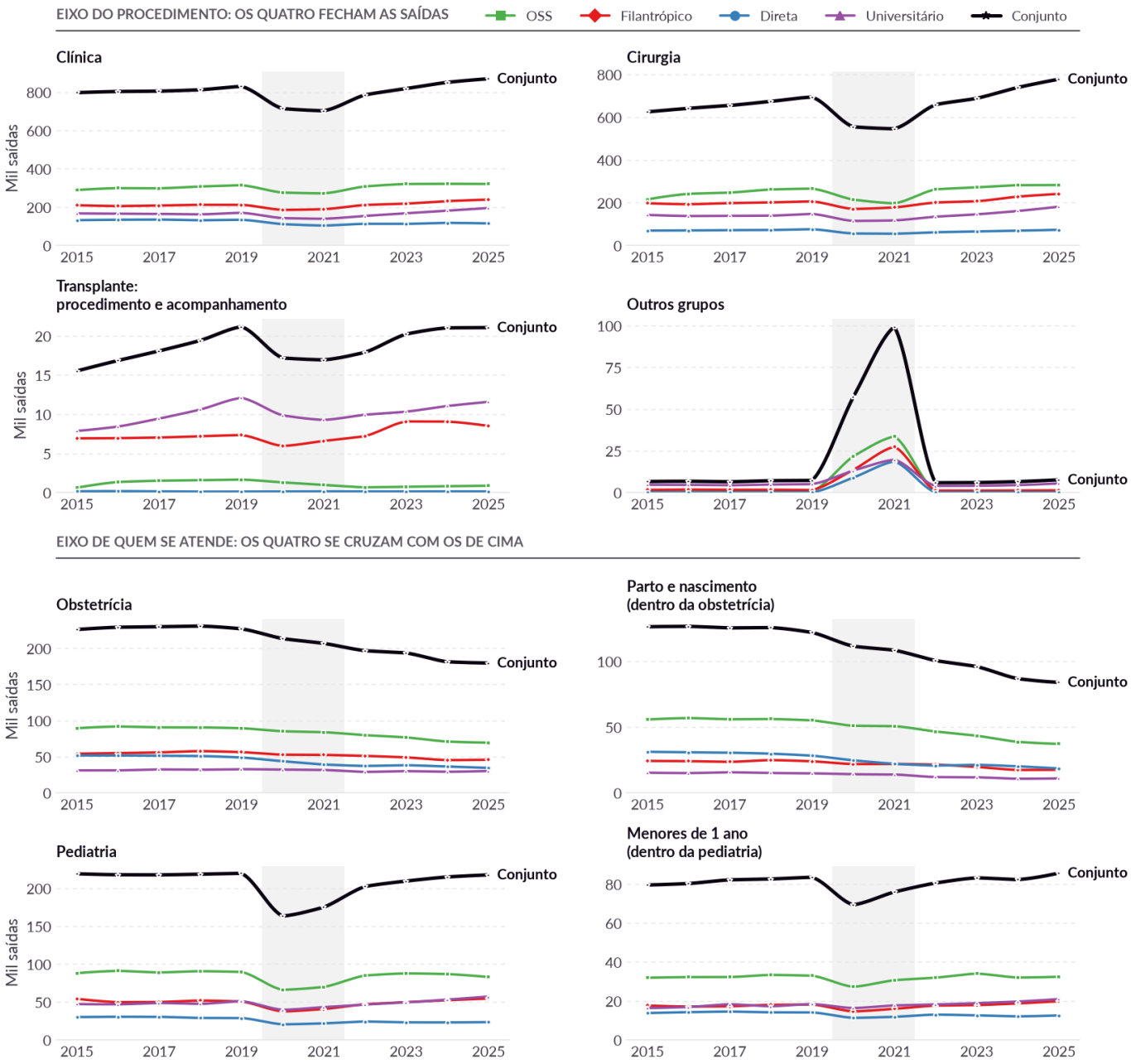
Figura 43: Saídas por leito instalado no estrato E3, por rede de gestão e no conjunto, ano a ano. A razão é as saídas do ano divididas pelos leitos SUS do ano, somados os dois no universo inteiro. **O denominador conta o leito de internação e o de terapia intensiva**, porque o numerador conta todas as saídas, inclusive as de terapia intensiva. Uma linha por rede de gestão, com o rótulo de rede fixado em 2023, e a linha escura do conjunto. A faixa cinza marca o biênio da pandemia. **A conta que mantém o leito parado no valor de 2023 não é desenhada aqui**: ela está no parágrafo seguinte, em número.

A produção por leito subiu, com mais leito e não com menos. A razão foi de **51,9** saídas por leito instalado em 2019 a **52,9** em 2025, com 48,8 em 2023. O leito cadastrado do estrato passou de 29.870 para 31.696 leitos SUS, e a conta com o leito parado em 2023 chega a 2025 em 53,4, acima da observada.



Seção 3: o estrato E3. Contagem bruta; nada está sendo comparado.

Figura 44: Saídas, saídas de alta complexidade e taxa de ocupação do estrato E3, ano a ano, **em contagem**. As duas primeiras séries são a soma de todos os hospitais do universo; a terceira é taxa, e por isso sai no hospital mediano, porque somar percentual de hospital não dá percentual de rede. O rótulo de rede é fixado em 2023 nas curvas por rede, para que a produção de um hospital que trocou de regime não mude de linha no meio da série; a linha do conjunto não é fixada, porque o total não se altera com reclassificação entre redes. A faixa cinza marca o biênio da pandemia.



Seção 3: o estrato E3. Os dois grupos contam a MESMA internação por critérios diferentes e não se somam. Contagem bruta; nada está sendo comparado.

Figura 45: Perfil de caso do estrato E3, ano a ano, **em contagem** de internações, em dois grupos de quatro quadros. No grupo de cima, o **eixo do procedimento**, que é partição e fecha as saídas do ano; no de baixo, **quem se atende**, por especialidade e por idade, com cada total ao lado do seu recorte: o parto está dentro da obstetrícia e os menores de 1 ano dentro da pediatria. **Os dois grupos não se somam**: são **três eixos** do bruto de AIH, lidos de colunas diferentes, e por isso eles **se cruzam e não se somam**, já que uma cesárea em paciente de 30 anos entra na cirurgia, na obstetrícia e no parto ao mesmo tempo. **Outros grupos** reúne os procedimentos de finalidade diagnóstica, o **tratamento de COVID**, que existe em 2020 e 2021 e só neles, e as saídas que a fonte deixou sem grupo; ali o total do ano é pequeno e o movimento de um ano para o outro **não é leitura**. A escala é própria em cada quadro, e a âncora no zero impede que ela vire lupa.

O que o estrato E3 faz, por tipo de procedimento. Em 2025 foram **869.601 saídas clínicas**, **777.464 cirúrgicas**, **21.048 de transplante e acompanhamento** e **7.561 em outros grupos**. Os quatro somam exatamente as saídas do ano, de modo que eles podem ser lidos como partes de um todo. **O número do transplante não é o número de transplantes feitos**: o

grupo inclui o acompanhamento e as intercorrências do pré e do pós, e as ações de doação, que juntos são a maior parte dele.

E a cirurgia é a família que mais cresce. Ela passou de **693.500 saídas** em 2019 para as 777.464 de 2025, o que é um crescimento de **12,1%** no período. **Nada aqui diz por quê**: a figura não desconta complexidade, porte nem ano, e não há grupo de comparação. E a distância entre as redes nesta figura **é composição**: cada rede reúne hospitais de portes e perfis diferentes, de modo que quem ler modelo de gestão aqui estará lendo a carteira de casos de cada uma.

E quem o estrato E3 atende. Em 2025 foram **179.532 saídas de obstetrícia**, das quais **83.943 de parto e nascimento**, e **217.536 de pediatria**, das quais **85.657 em menores de 1 ano**. Os dois pares são de contenção e não de soma, e nenhum deles se soma às quatro famílias de procedimento: a mesma internação é contada em mais de um eixo.

E é aqui que a leitura crua encontra o seu limite. As quatro redes chegam a 2025 em patamares diferentes de saídas por leito, e essa distância não autoriza conclusão nenhuma sobre modelo de gestão: ela mistura hospitais de portes e perfis distintos dentro do mesmo estrato. Separar o que é modelo do que é composição é o trabalho do resto desta seção.

3.1 O retrato do grupo E3, indicador a indicador

Antes de comparar as redes entre si, convém ver o grupo em que elas serão comparadas. Esta subseção abre a seção com o retrato do E3 inteiro: **como cada indicador se distribui dentro dele, rede por rede, e quanto dessa distribuição a rede de fato explica**. É a régua das subseções seguintes, que descontam complexidade, porte e ano e chegam a distâncias de poucos centésimos: sem saber a largura de cada distribuição, não há como julgar se um centésimo é muito ou pouco.

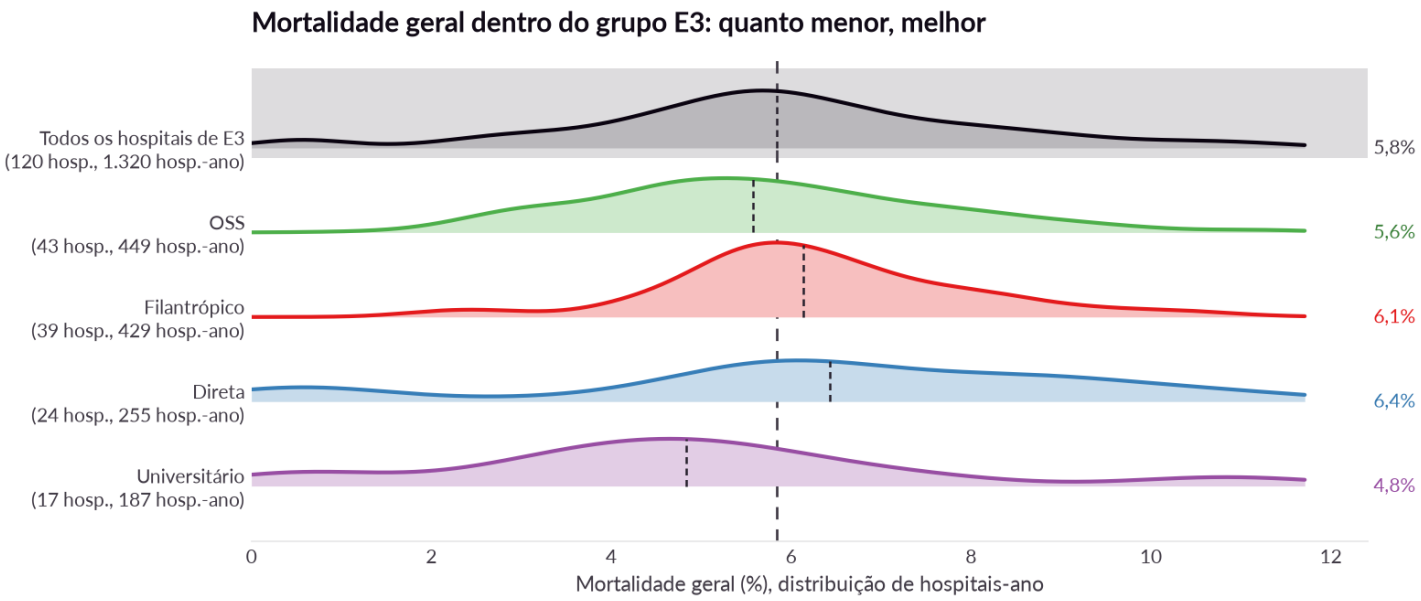
Ela não estima nada. Tudo aqui é **diferença bruta**: nenhum número foi descontado de nada. Serve para dar escala ao que vem depois, e não para sustentar conclusão sobre modelo de gestão.

Uma advertência de contagem, antes dos números. O grupo E3 tem **120 hospitais**, mas as quatro redes somam **123**, e as duas contagens estão certas. Três hospitais de E3 trocaram de regime dentro do período (são exatamente os três conversores que o grupo contém) e entregaram anos aos dois lados. Contados pelo regime de 2025 eles ficam num lado só e o grupo soma 120; contados pelo regime ao qual entregaram anos, que é a regra deste documento, eles entram nos dois e a soma dá 123. As tabelas e figuras abaixo desenham **hospital-ano**, e por isso usam a segunda contagem: é ela que diz de quantos hospitais vieram os pontos de cada boxplot.

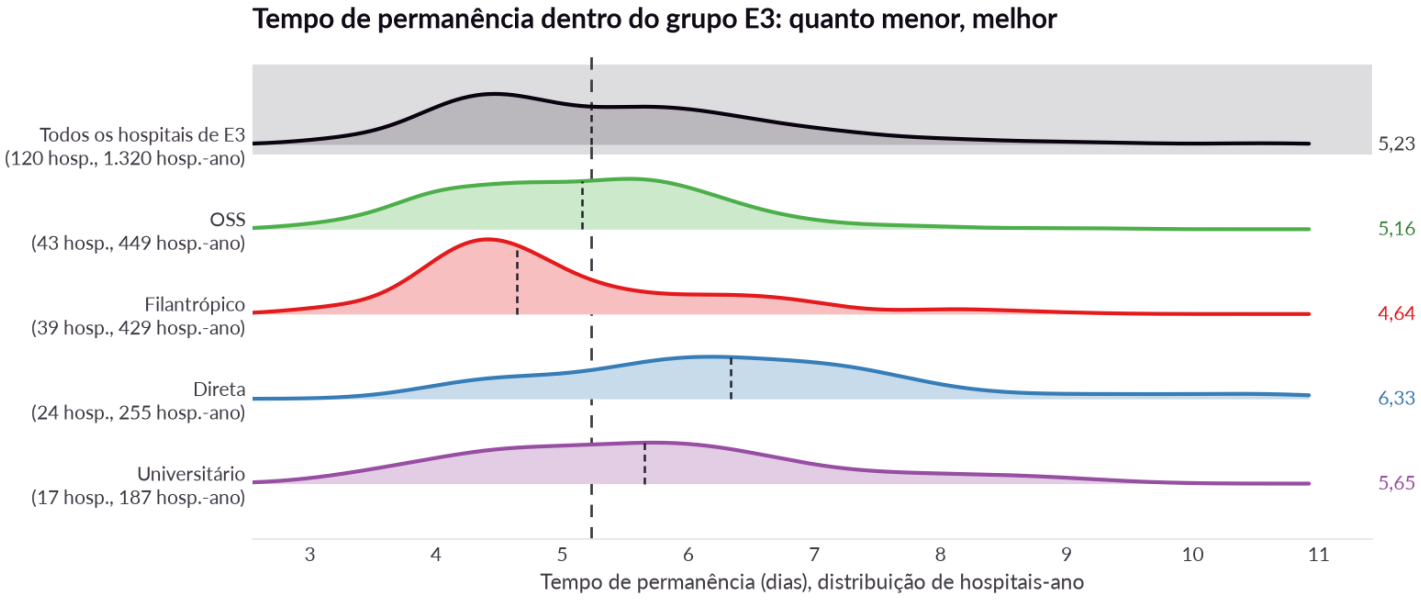
Tabela 13: Os seis indicadores dentro do grupo E3, por rede de gestão e no conjunto. Cada célula é a **mediana de hospital-ano** do período completo, e abaixo dela, em corpo menor, o primeiro e o terceiro quartis. A coluna **Todos** é o grupo inteiro e serve de régua para as outras quatro. **As quatro redes somam 123 hospitais e o grupo tem 120**: os três conversores entram nos dois regimes pelos quais passaram. Cada valor é a mediana de todos os anos de todos os hospitais da rede. O **faturamento real** está em reais de dezembro de 2025.

Indicador	Todos	OSS	Filantr.	Direta	Univ.
Hospitais	120	43	39	24	17
Observações de hospital-ano	1320	449	429	255	187
Mortalidade geral	**5,84%**	5,57%	6,13%	6,43%	4,83%
quartis	4,72%–7,24%	4,43%–6,89%	5,35%–7,20%	5,28%–8,71%	3,51%–6,43%
Tempo de permanência (dias)	**5,23**	5,16	4,64	6,33	5,65
quartis	4,43–6,21	4,40–5,83	4,23–5,52	5,56–7,31	4,67–6,49
Faturamento real por saída (R$)	**1.816**	1.520	2.417	1.423	2.926
quartis	1.343–2.685	1.230–1.941	1.765–3.267	1.183–1.762	1.847–3.855
Taxa de ocupação de internação	**89,9%**	95,3%	89,9%	75,3%	88,2%
quartis	74,8%–101,1%	83,4%–103,1%	77,3%–102,0%	60,7%–94,8%	75,8%–97,5%
Taxa de ocupação de UTI	**77,2%**	77,2%	82,7%	65,6%	76,5%
quartis	64,5%–88,1%	65,0%–87,5%	71,5%–92,7%	50,2%–78,9%	66,3%–86,6%
Fração de alta complexidade	**5,4%**	2,7%	11,7%	1,5%	18,4%
quartis	0,7%–14,8%	0,1%–7,9%	5,7%–19,4%	0,1%–4,7%	2,5%–22,8%

O que a tabela mostra são duas redes destacadas, uma em cada ponta, e as outras duas entre elas. A administração Direta tem a maior mortalidade mediana (6,43% contra 4,83% do hospital universitário), a permanência mais longa (6,33 dias contra 4,64 do Filantrópico) e, de longe, a menor taxa de ocupação de internação (75,3% contra 95,3% das OSS). O hospital universitário se separa por outro eixo: fatura **2.926 reais por saída** contra 1.423 da administração Direta, e faz **18,4% de alta complexidade** contra 1,5% dela. São perfis diferentes de hospital, e não posições numa mesma disputa.

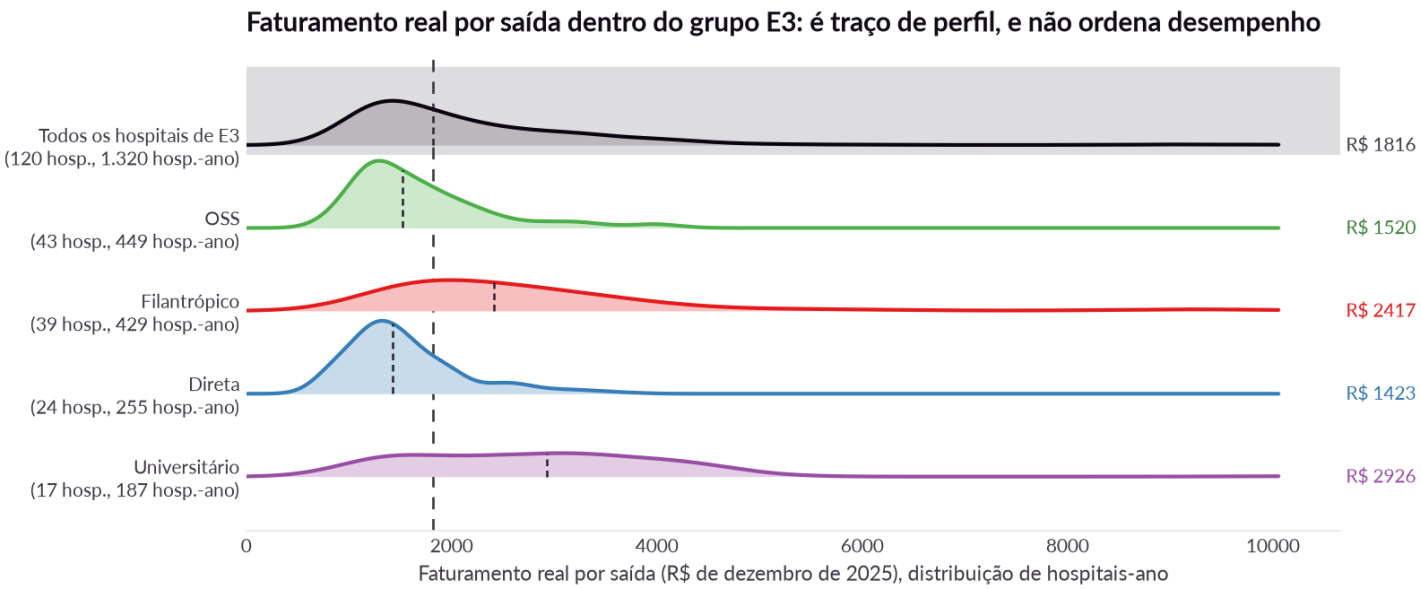


(a) Mortalidade geral

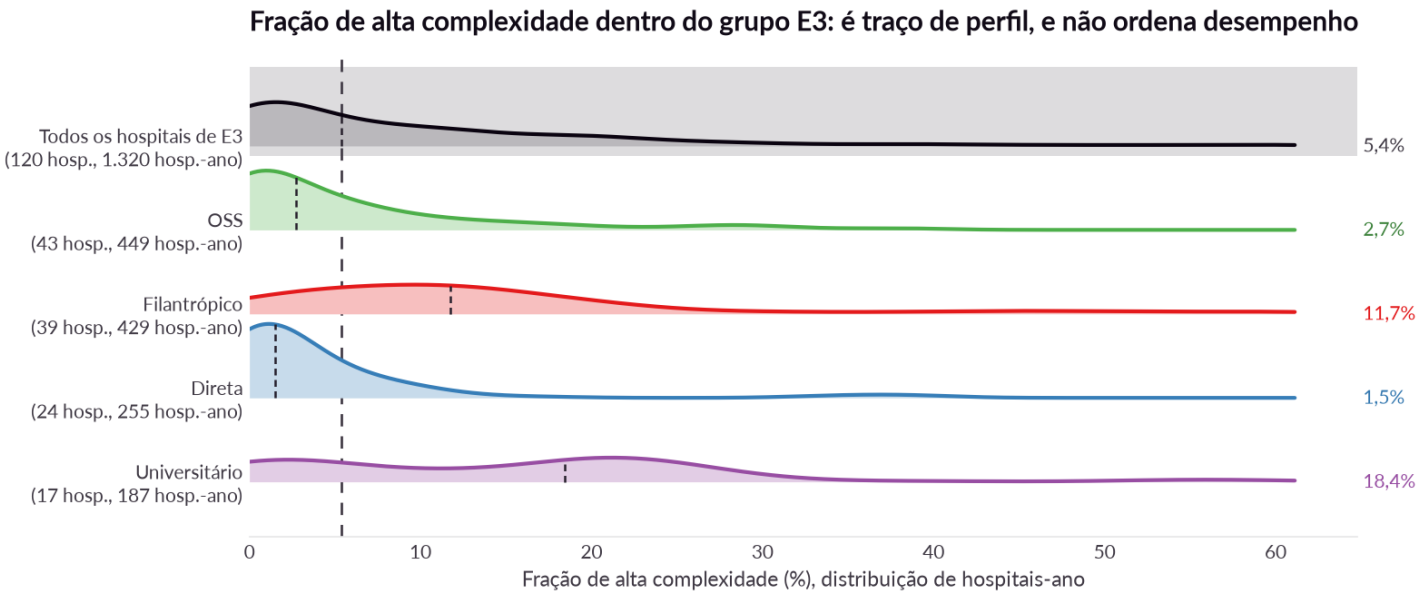


(b) Tempo de permanência

Figura 46: Mortalidade e tempo de permanência dentro do grupo E3, rede por rede e no conjunto. Nos dois indicadores, **menor é melhor**. Cinco curvas de distribuição empilhadas: a de cima, **em preto e sobre faixa cinza**, é o grupo E3 inteiro, e a tracejada que atravessa a figura é a mediana dele. **A altura da curva diz onde os hospitais se acumulam**, e a haste tracejada dentro de cada uma marca a mediana daquela rede, repetida em número à direita. **Nenhuma observação sai do cálculo**: a janela só decide até onde o quadro mostra.

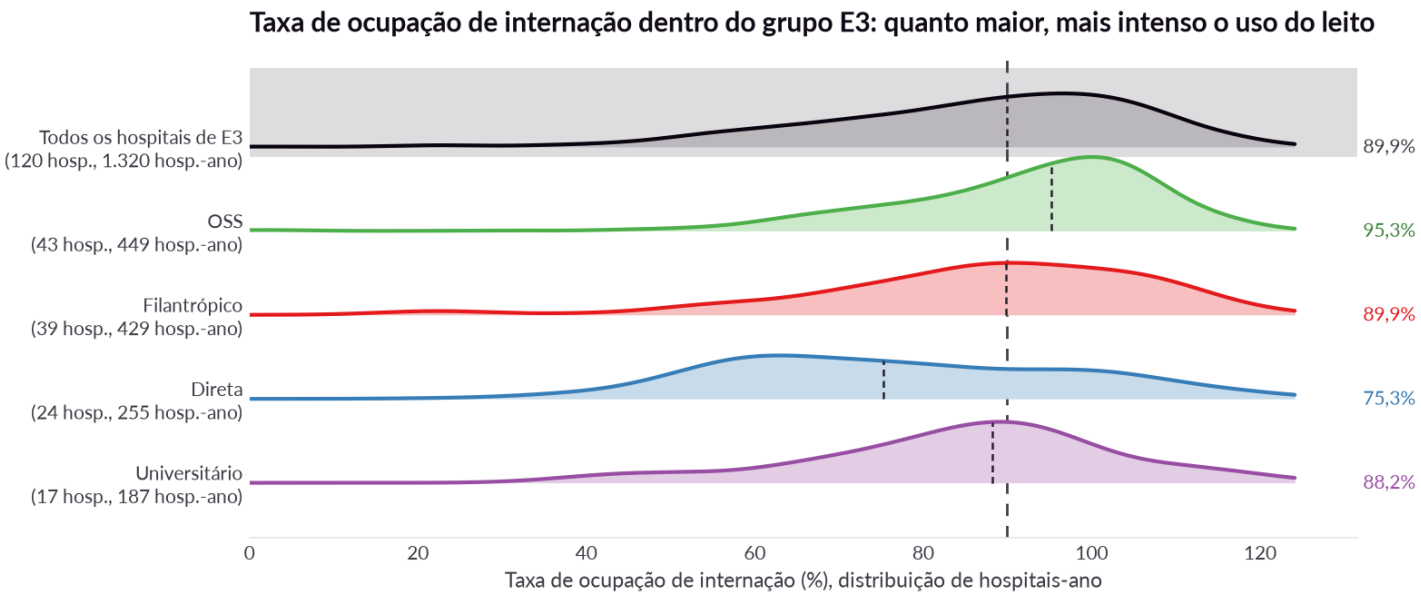


(a) Faturamento real por saída

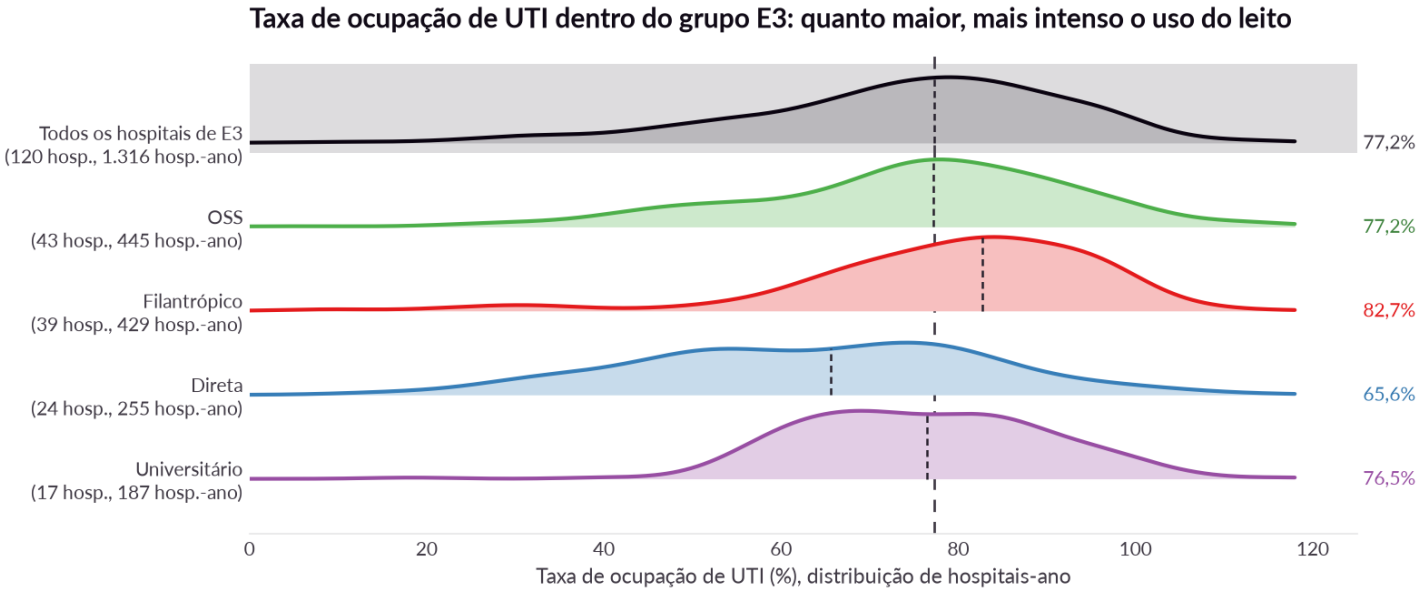


(b) Fração de alta complexidade

Figura 47: Faturamento real por saída e fração de alta complexidade dentro do grupo E3. Os dois são **traços de perfil**: descrevem que tipo de hospital é, e não ordenam desempenho.



(a) Taxa de ocupação de internação



(b) Taxa de ocupação de UTI

Figura 48: Taxas de ocupação de internação e de UTI dentro do grupo E3. Um ponto por hospital-ano. **Taxa de ocupação acima de 100% é operação acima da capacidade cadastrada**, e não desempenho melhor: o excesso mede leito ocupado além do que o hospital declara ter, e adiante nesta seção ele é separado em duas partes.

Quanto da variação a rede explica

Os boxplots se cobrem muito, e isso não é detalhe de desenho. Uma distância entre medianas pode ser real e ainda assim responder por quase nada da variação total, porque hospitais da mesma rede diferem muito entre si. A Tabela 14 reparte a variação de cada indicador em três parcelas que somam 100%: quanto vem de **estar numa rede ou em outra**, quanto sobra **entre hospitais da mesma rede**, e quanto ocorre **dentro do mesmo hospital** ao longo dos onze anos.

Tabela 14: De onde vem a variação de cada indicador dentro do grupo E3. As três parcelas somam 100%. A última coluna responde se as quatro redes de fato se separam naquele indicador, contando **cada hospital uma vez em cada regime** pelo qual passou, e não uma vez por ano. As três parcelas repartem a variação com o hospital-ano como unidade. A última coluna conta **cada hospital uma vez em cada regime**, porque onze anos do mesmo hospital não são onze evidências.

Indicador	De onde vem a variação			As quatro redes
	entre redes	entre hospitais	dentro do hospital	se separam neste indicador?
Mortalidade geral	3,3%	81,8%	15,0%	sim
Tempo de permanência	18,7%	69,0%	12,2%	sim, com folga
Faturamento real por saída	18,0%	77,8%	4,2%	sim, com folga
Taxa de ocupação de internação	6,4%	68,9%	24,7%	sim
Taxa de ocupação de UTI	4,0%	31,7%	64,3%	sim, com folga
Fração de alta complexidade	16,0%	80,8%	3,3%	sim, com folga
Nota de eficiência em E3	**4,1%**	**53,8%**	**42,1%**	**não**

Em todos os sete indicadores a rede explica pouco. As maiores parcelas são a do tempo de permanência (18,7%) e a do faturamento por saída (18,0%), com a fração de alta complexidade logo atrás (16,0%); nos demais fica entre 3,3% e 6,4%. Em todos, a parcela que sobra *entre hospitais da mesma rede* é a maior das três. Dito de outro modo: **saber que rede administra um hospital de E3 diz menos sobre ele do que saber qual hospital ele é**.

E a nota de eficiência é o caso à parte, agora pelo motivo oposto. A rede responde por **34,8%** da variação dela, que é a **maior parcela dos sete**, e é o indicador em que as quatro redes mais se separam. **Boa parte disso é contabilidade e não achado**: até a medida anterior deste documento, o faturamento entrava como recurso consumido, e a administração direta faturava abaixo do que o perfil de caso dela explica, de modo que a conta a favorecia e encurtava a fila. Retirado o faturamento, a distância que estava encoberta aparece. O que a parcela grande diz, portanto, é que a nota passou a enxergar uma diferença que a medida antiga escondia, e não que as redes tenham mudado de desempenho. A Subseção 3.4 chega perto disso pelo outro caminho, o do desconto de complexidade, porte e ano: ali, das quatro redes que entram na comparação, **três se separam da média delas**, a administração Direta atrás e o Filantrópico e as Organizações Sociais à frente, e só o hospital universitário fica no meio. **As distâncias de eficiência entre redes que este documento publica são reais, e deixaram de ser pequenas quando o faturamento saiu da conta**, e a régua para lê-las é esta.

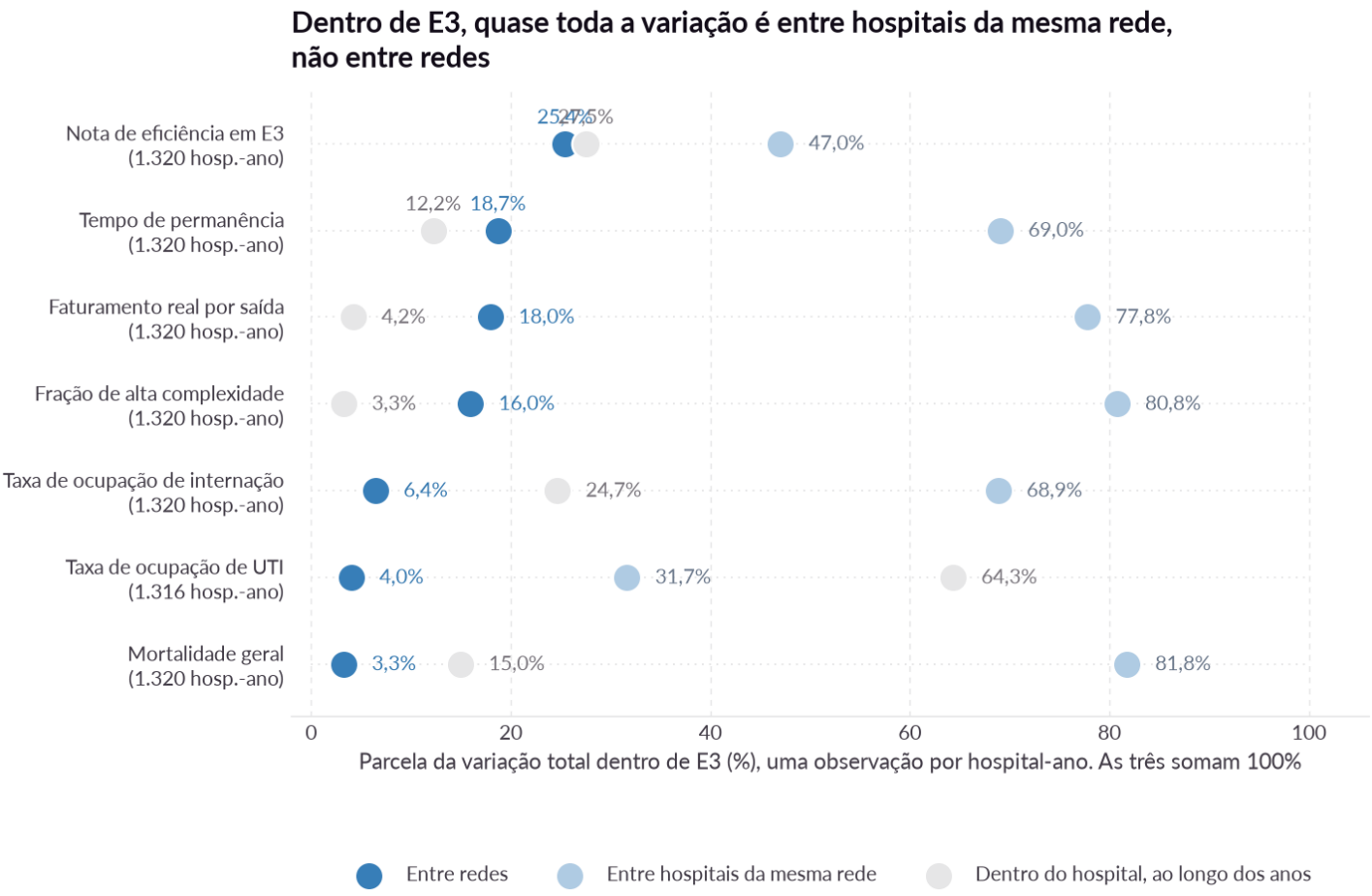


Figura 49: De onde vem a variação de cada indicador dentro do grupo E3, em três parcelas que somam 100%. Uma observação por hospital-ano. **As três parcelas de cada barra vêm escritas**, e o rótulo que não coube dentro da fatia aparece logo acima dela, ligado por um traço. Cada barra é um indicador. **A faixa azul, à esquerda, é a única que fala de rede de gestão**; tudo à direita dela é variação que a rede não explica.

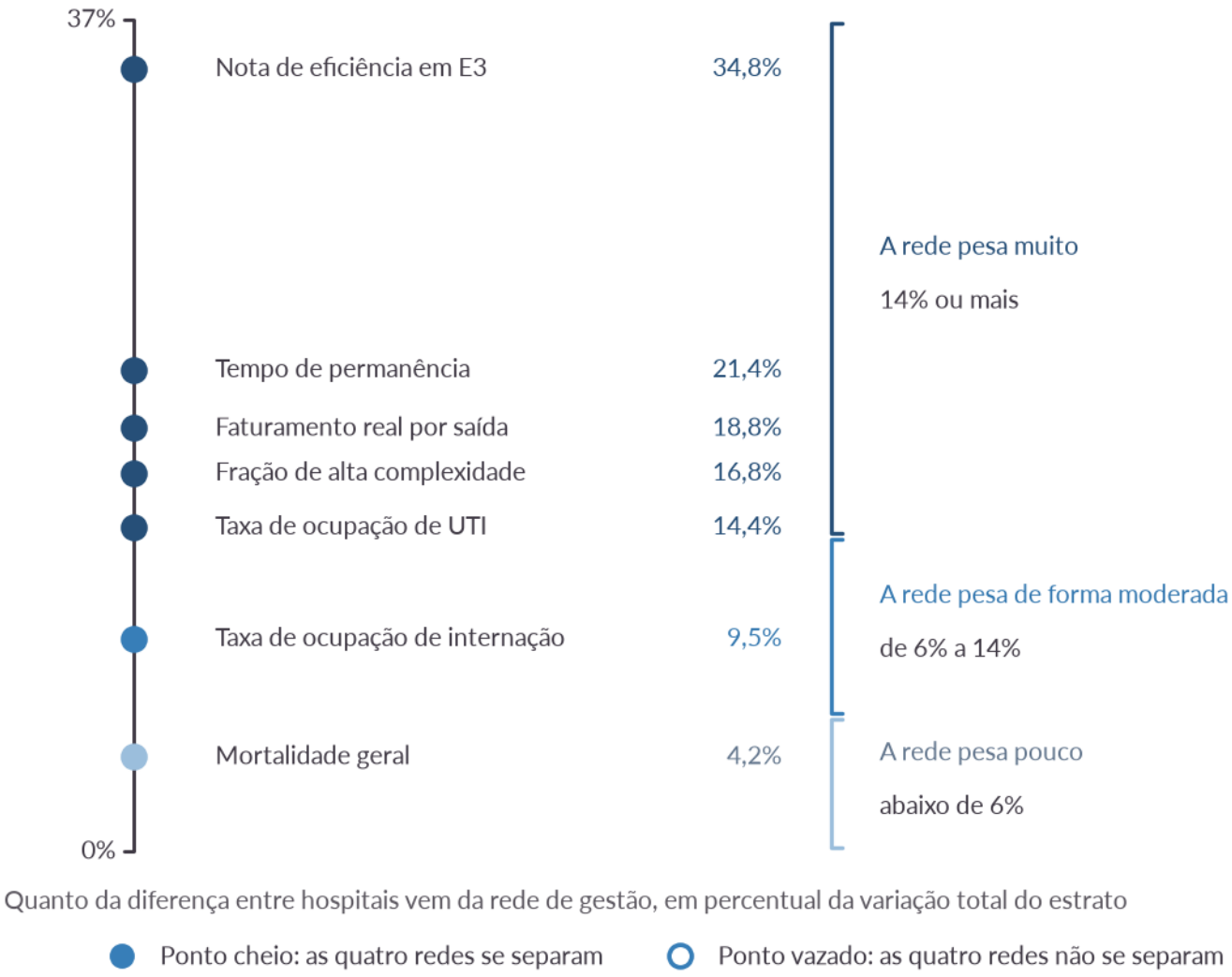


Figura 50: O que a rede de gestão explica em E3, indicador a indicador. Um ponto por hospital em cada regime. Cada ponto é um indicador, na altura de quanto a rede de gestão explica dele. As chaves à direita agrupam por faixa, com o intervalo escrito ao lado; **ponto cheio é rede que se separa, ponto vazado é rede que não se separa**. O padrão que fica: a rede diz bastante sobre o **perfil** do hospital (de 16,8% a 21,4%) e pouco sobre o quão **bem** ele atua, e a nota de eficiência é o único ponto vazado.

O que anda junto com o quê, dentro de E3

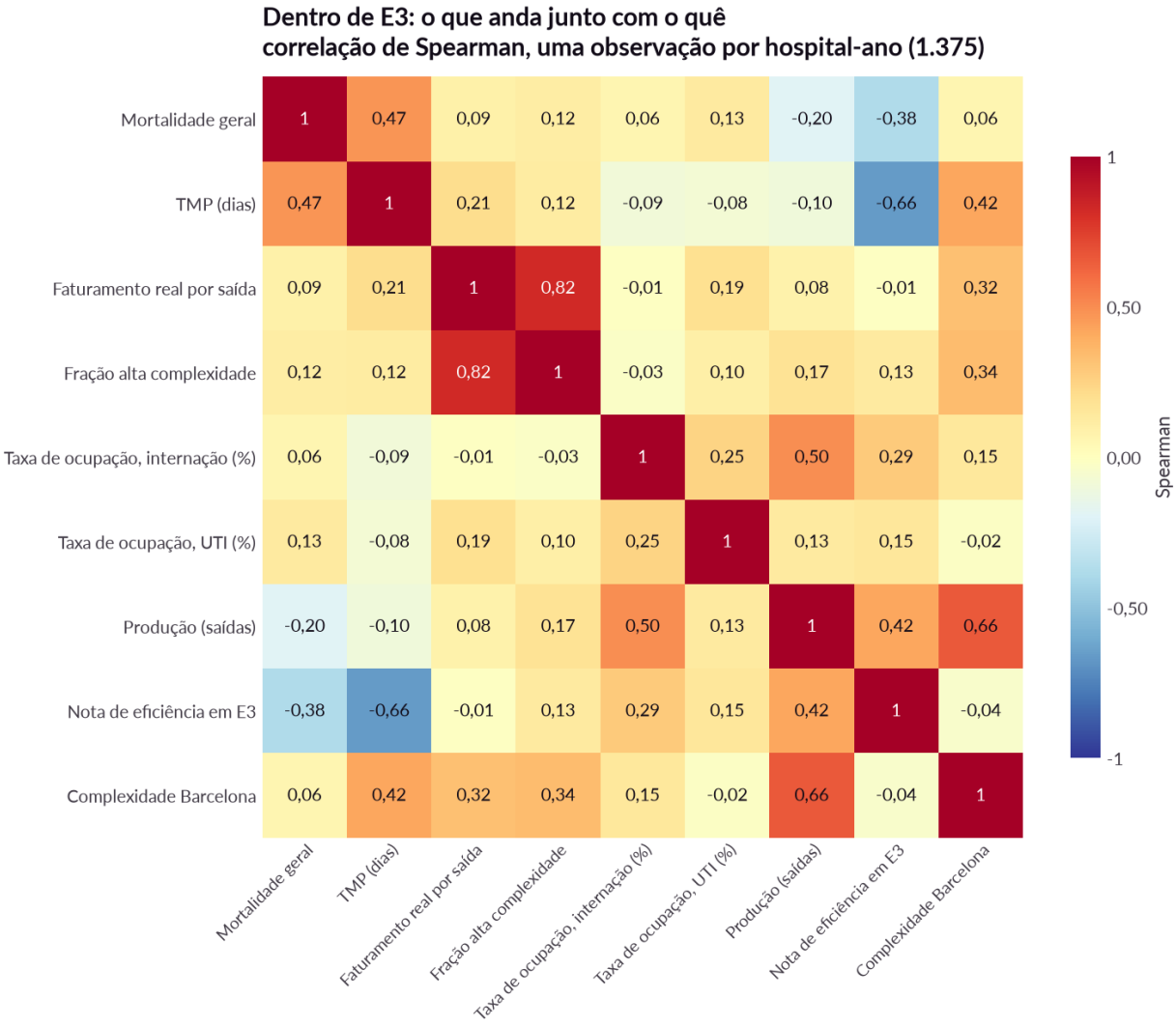


Figura 51: Correlações de Spearman entre os indicadores dentro do grupo E3. Uma observação por hospital-ano (1.320). Cada célula é a correlação de ordem entre dois indicadores, de −1 a +1. **Vermelho é positivo e azul é negativo**; o tom claro do meio é a ausência de relação. É a mesma escala do mapa da Seção 1. A diagonal vale 1 por construção. **Correlação aqui não é causa**, e nenhuma delas desconta porte, complexidade ou ano.

Três pares se destacam, e os três são de estrutura, não de gestão. O faturamento por saída anda quase junto com a fração de alta complexidade (+0,82): faturar mais por saída é, dentro de E3, sobretudo fazer procedimento mais caro. A produção acompanha a complexidade Barcelona (+0,66), que é o esperado num grupo em que o porte varia de 61 a 1.247 leitos do SUS. E a mortalidade anda com a permanência (+0,47), que é o par clássico: paciente mais grave fica mais tempo e morre mais.

A nota de eficiência tem a sua correlação mais forte com a permanência, e é negativa (−0,66): hospital que dá alta mais cedo fica mais perto da fronteira. Isso é aritmética do método antes de ser achado: a nota mede saída por leito, por leito de terapia intensiva e por dia de paciente, e girar o leito mais rápido produz mais saídas com menos dias de paciente. Vale como leitura do que a medida capta, e **não** como prova de que dar alta cedo seja melhor cuidado: a mortalidade não é produto do modelo, e a ressalva já registrada na Subseção 1.7 continua valendo aqui.

3.2 Os resultados em E3

Os resultados desta subseção não se movem quando o universo do grupo comparável é ampliado, e isso é informação sobre a solidez deles. Reestimados no universo comparável ampliado, os seis contrastes mudam pouco, e nenhum deles troca de lado: o que a tabela afirma sobre cada indicador continua valendo, e o maior deslocamento, que é o da mortalidade, não chega a mover a leitura de um décimo de ponto na escala do próprio indicador. **A leitura desta subseção, portanto, não depende da escolha de universo** que a subseção anterior discute: o que muda com aquela escolha é o contraste de eficiência, e não o regime operacional medido aqui.

Esta é a comparação que interessa a quem decide, porque é a única feita entre hospitais de fato parecidos: **120 hospitais de capacidade instalada equivalente**, sendo 43 geridos por OSS, 39 filantrópicos, 24 da administração Direta e 17 universitários. Tudo o que segue compara as redes dentro desse grupo, descontando complexidade, porte e ano.

A rede de referência é a OSS. É contra ela que a discussão pública compara as demais, e é ela que este documento mede como a mais próxima da fronteira dentro do E3. Cada bloco da tabela abre com o **valor observado nas OSS**, e as três linhas abaixo dizem **onde o modelo põe cada uma das outras redes** partindo dali.

O que a tabela mede, e o que ela não mede. Ela compara hospitais entre si, já descontados complexidade, porte e ano. Ela *não* mede o efeito de trocar de gestão: para isso é preciso ver o mesmo hospital antes e depois da troca, e é o que a Subseção 3.7 examina. Uma diferença demonstrada aqui quer dizer que **as duas redes operam em patamares distintos**; não quer dizer que passar um hospital de uma para a outra produziria esse patamar. Tudo o que separa as redes e não está no modelo (história, vocação, inserção na cidade) continua dentro do número.

O que é a margem, e o que se faz com ela. O valor de cada linha é a melhor estimativa que estes 120 hospitais sustentam, e não uma medição exata: com outro conjunto de hospitais igualmente parecidos, ele viria um pouco diferente. **A margem é o tamanho desse "um pouco"**, isto é, a faixa de valores que os dados ainda comportam além do número do meio. Os **95%** dizem quão exigente é a régua, e é a régua de sempre: a faixa é traçada larga o bastante para deixar o valor verdadeiro de fora em no máximo um caso a cada vinte.

Ela se lê de dois modos. O primeiro é o **tamanho**: margem estreita quer dizer número firme, em que se pode apoiar decisão; margem larga quer dizer que estes dados sabem pouco sobre aquela rede naquele indicador, e que o número do meio, sozinho, promete mais precisão do que existe. O segundo é **onde ela cai**: quando a margem alcança o valor das OSS, a diferença não está demonstrada, e é isso que a última coluna responde. **Não demonstrada não quer dizer igual**: quer dizer que estes dados não separam as duas redes ali, nem para mais nem para menos.

Duas linhas da mesma rede mostram os dois modos de ler. O tempo de permanência da administração Direta é de **5,650 dias**, e a margem vai de 5,160 a 6,186: são cerca de cinco décimos de dia para cada lado, e a faixa inteira fica acima dos 5,155 dias das OSS, ainda que o limite de baixo passe deles por **cinco milésimos de dia**, que é o quanto de folga esta linha tem. Já a superlotação da mesma administração Direta é de **43,2%** dos anos acima de 100% de ocupação, e a margem vai de 30,9% a 56,3%: cabem ali desde uma rede que passa da capacidade cadastrada em pouco menos de um ano em cada três até uma que passa em mais de um ano em cada dois, e os 35,0% das OSS ficam dentro dessa faixa. **É a mesma rede nos dois casos**: o que muda não é quem está sendo medido, é quanto o dado sabe. O primeiro número serve para decidir; o segundo, não.

Tabela 15: Onde cada rede opera, entre hospitais de capacidade equivalente (estrato E3). Cada bloco abre com o **valor observado nas OSS**, que são a rede de referência, e as duas linhas abaixo dizem onde o modelo põe as outras duas partindo dali, com complexidade, porte e ano descontados. **O hospital universitário não entra nesta tabela**, pela ressalva da Subseção 1.9.4: a orçamentação dele não passa pelo faturamento. A **margem** diz entre que valores o resultado pode estar: quando ela alcança o valor das OSS, a diferença não está demonstrada. Na última coluna, ● sim ● não. A linha da **taxa de ocupação até 100%** usa só a parte da taxa abaixo do teto, e por isso a margem dela para em 100%; a **ocupação de UTI** entra inteira, e o **faturamento real** está em reais de dezembro de 2025. O bloco do **tempo de permanência** vai com três casas decimais: com duas, o limite de baixo da administração Direta e o valor das OSS saem os dois em 5,16, e a tabela pareceria marcar como demonstrada uma diferença que ela mesma não separaria.

Indicador e rede	Nesta rede	Margem (95%)		Demonstrada?
Tempo de permanência nas OSS: **5,155 dias**				
na administração Direta	**5,650**	5,160	6,186	● sim
no Filantrópico	**4,188**	3,650	4,806	● sim
Mortalidade geral nas OSS: **5,6%**				
na administração Direta	**6,7%**	5,9%	7,6%	● sim
no Filantrópico	6,4%	5,0%	8,3%	● não
Taxa de ocupação até 100% nas OSS: **88,0%**				
na administração Direta	79,2%	66,0%	94,9%	● não
no Filantrópico	91,6%	74,0%	100,0%	● não
Taxa de ocupação de UTI nas OSS: **77,2%**				
na administração Direta	81,9%	77,2%	86,8%	● não
no Filantrópico	**102,8%**	90,7%	116,5%	● sim
Faturamento real por saída nas OSS: **R$ 1.520**				
na administração Direta	1.481	1.270	1.727	● não
no Filantrópico	**2.494**	1.995	3.117	● sim
Superlotação, % dos anos acima de 100% nas OSS: **35,0%**				
na administração Direta	43,2%	30,9%	56,3%	● não
no Filantrópico	**64,8%**	37,0%	85,3%	● sim

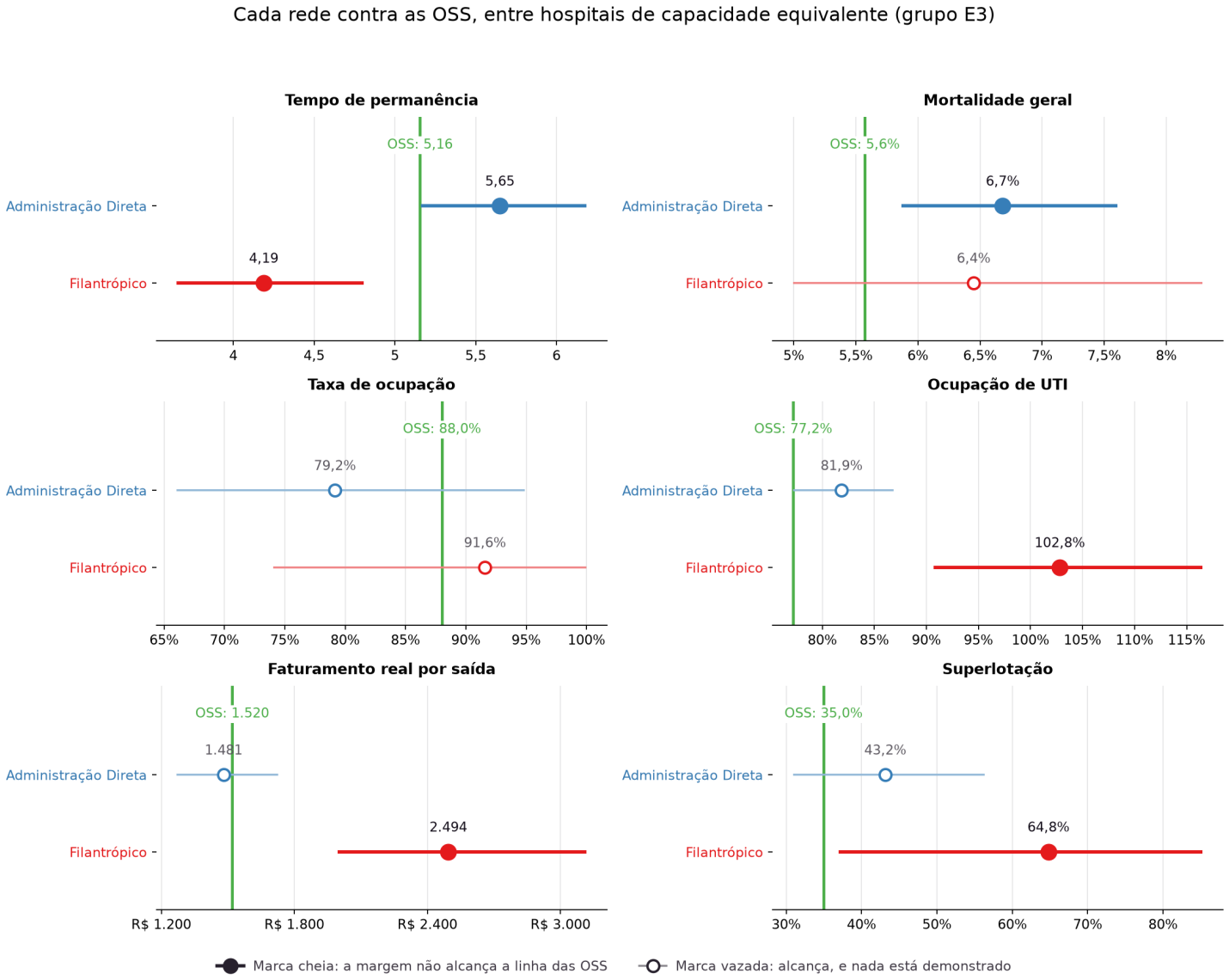


Figura 52: A Tabela 15 desenhada: onde cada rede opera em cada indicador, entre hospitais de capacidade equivalente, e quanta incerteza acompanha cada posição. A linha vertical de cada painel é a rede de referência, as OSS, e o número em cima dela é o valor delas. Cada linha traz outra rede: **a marca é o valor dela** e **a barra é a margem de 95%**. **Marca cheia é diferença demonstrada**; **marca vazada é margem que alcança a linha das OSS**, e ali nada está demonstrado. Cada painel tem escala própria: o comprimento das barras não se compara entre painéis.

Seis das doze comparações se sustentam, e elas contam uma história curta. A **administração Direta** interna por mais tempo (**5,650 dias** contra 5,155 das OSS) e tem mais mortalidade (**6,7%** contra 5,6%). O **Filantrópico** interna por menos tempo (**4,19 dias**), fatura bem mais por saída (**R$ 2.494** contra R$ 1.520), usa mais a UTI (**102,8%** contra 77,2%) e passa de 100% de ocupação em muito mais anos que as OSS: **64,8%** dos anos, contra 35,0%. Nas outras seis comparações a margem alcança o valor das OSS, e ali a tabela não autoriza afirmação em direção nenhuma: não diz que a rede é melhor, nem que é pior, nem que empata. Como estes números divergem dos da Subseção 1.8, vale a regra de desempate da escada de evidência: onde as duas medidas divergem, prevalece a feita aqui, entre hospitais de estrutura equivalente.

O tempo de internação é o único indicador em que duas redes se separam das OSS, e elas se separam em direções opostas. A Direta segura o paciente **quase meio dia a mais**; o Filantrópico dá alta **quase um dia mais cedo**. Girar o leito mais rápido é o que produz mais saídas com a mesma estrutura, e é por isso que este indicador volta, e no centro, quando a Subseção 3.5 olha produção por leito.

O faturamento por saída separa as OSS do Filantrópico, e de mais ninguém. A administração Direta fica onde as OSS estão, com folga. O Filantrópico fatura **R$ 974 a mais por saída**, e esse número é de **perfil, não de desempenho**: a mesma rede faz mais de quatro vezes mais alta complexidade que as OSS, como a Subseção 3.5 mostra. Faturar mais por uma internação mais complexa não é gastar mais pelo mesmo trabalho.

A superlotação é onde a distância entre as redes é maior, e ela é de leito antes de ser de gestão. Entre hospitais de mesma complexidade, mesmo porte e mesmo ano, o Filantrópico passa da capacidade cadastrada em quase dois terços dos anos, e as OSS em pouco mais de um terço deles. A leitura útil para quem planeja rede não é que essa rede administra pior: é que **ela tem leito de menos para a demanda que bate na porta**. Quantas vezes cada rede transborda é uma pergunta, e quanto ela transborda quando transborda é outra: a Subseção 3.3 separa as duas, e mostra que as respostas não coincidem.

Sobre a mortalidade, a ressalva precisa acompanhar o número. Os 6,7% da administração Direta valem **com a complexidade do hospital descontada**, e só assim. **A diferença bruta de mortalidade entre as redes dentro de E3 não é citável**, e por isso não aparece neste documento nem na Subseção 3.5: parte dela é diferença de casuística dentro do próprio grupo. Dos dez hospitais de faixa 6 do grupo, oito são universitários e dois filantrópicos; nem as OSS nem a administração Direta têm algum.

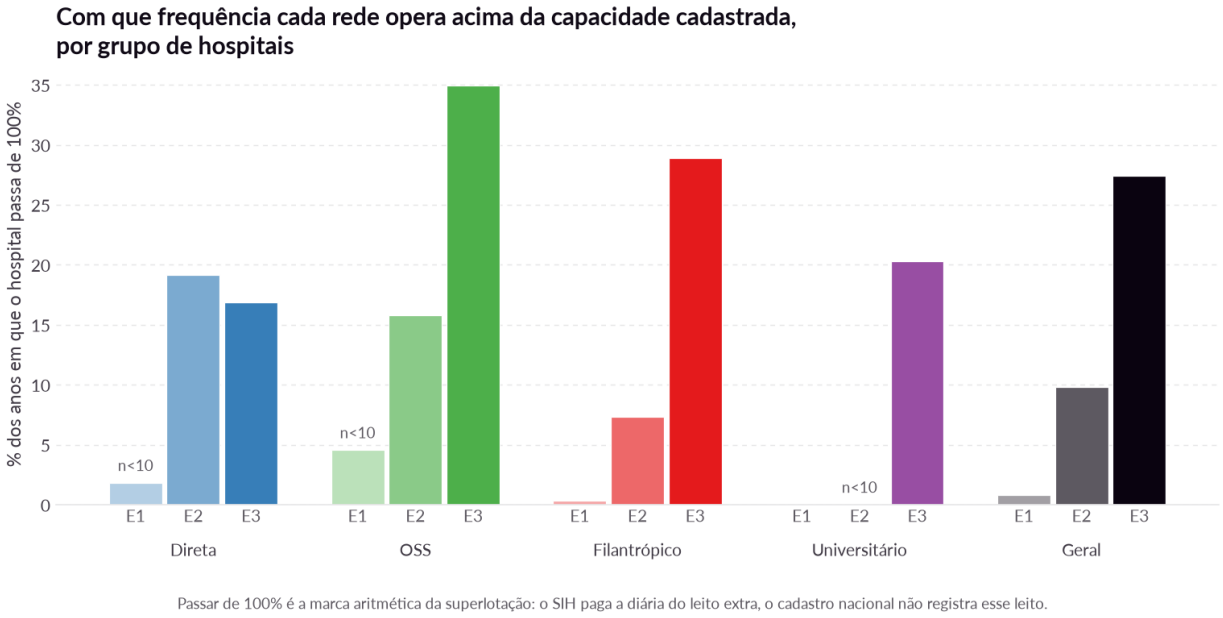


Figura 53: Com que frequência cada rede opera acima da capacidade cadastrada, dentro de cada estrato estrutural. Para cada estrato, a **proporção de hospitais-ano com ocupação de internação acima de 100%**, uma barra por rede. A unidade é o hospital-ano.

O retrato descritivo do mesmo grupo aparece adiante, e ele é de outra camada. A Subseção 3.5 põe as redes do estrato lado a lado dentro dele, *sem* descontar nada, e é lá que está a série de eficiência ano a ano. Aqui os descontos existem, e por isso é esta a camada que decide: onde as duas divergirem, prevalece a desta subseção, pela regra da escada de evidência.

3.3 A taxa de ocupação de internação eram duas perguntas, não uma

O que segue parte da distinção já estabelecida na guia de leitura dos gráficos, na introdução: o que o documento publica na internação é a **taxa de ocupação**, que pode passar de 100%, e ela se separa em **leito de fato ocupado** mais **transbordo**. Aqui a separação é aplicada à comparação entre as redes, dentro do único grupo em que ela é viável.

A separação, e como ela reparte a distância entre as redes

Sendo D_{it} as diárias de internação do hospital i no ano t e L_{it} os seus leitos SUS cadastrados, as três grandezas se definem assim:

$$\underbrace{\ell_{it} = \frac{D_{it}}{365\, L_{it}}}_{\text{taxa de ocupação}} \qquad \underbrace{\tau_{it} = \min(\ell_{it},\, 1)}_{\text{parte até 100\%}} \qquad \underbrace{e_{it} = \max(\ell_{it} - 1,\, 0)}_{\text{excesso}}$$

acompanhadas do indicador de superlotação $s_{it} = \mathbf{1}\{\ell_{it} > 1\}$, que vale um quando o hospital demanda mais leito-dia do que tem habilitado. As três se ligam por uma **identidade exata**, verificada no painel sem resíduo:

$$\ell_{it} \;=\; \tau_{it} \;+\; e_{it}. \tag{1}$$

A variável impressa como "taxa de ocupação de internação" é $100\,\ell_{it}$**, e não** $100\,\tau_{it}$**.** Quando $\ell \leq 1$ as duas coincidem e o excesso é zero; é só acima de 100% que se separam, e é ali que mora o achado desta subseção.

Isto explica por que a Subseção 1.8 modela a taxa de ocupação **em duas partes** e não como contínua aparada: aparar em 100% joga fora e_{it}, isto é, estima τ e o chama de ℓ. O modelo em duas partes estima s e τ separadamente.

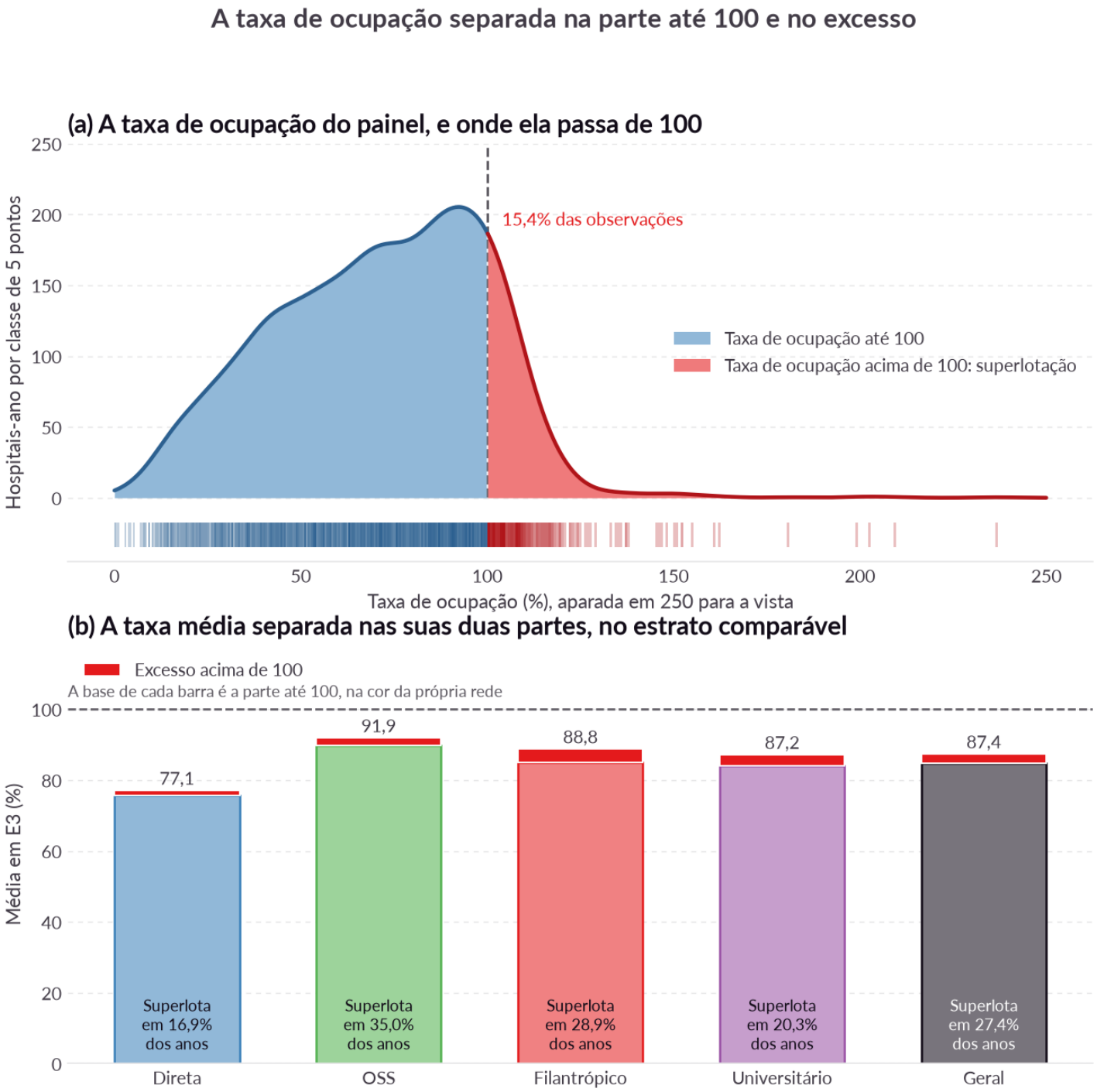


Figura 54: A taxa de ocupação do painel separada nas suas duas parcelas. **À esquerda**, a distribuição da taxa ℓ (em %) sobre os 3.025 hospitais-ano: a área **azul** é a parte abaixo de 100% e a **vermelha**, à direita da tracejada, é a superlotação, e a faixa de marcas por baixo do eixo muda de cor no mesmo ponto; o eixo é aparado em 250 apenas para a vista, e **nenhuma observação é descartada do cálculo**. **À direita**, a Equação 1 desenhada dentro do estrato E3, o único em que a comparação entre redes é viável: a altura da barra é a ocupação média da rede, a base é a média de τ na cor da rede e a faixa vermelha no alto é a média de e, e a soma das duas é o valor impresso acima da barra. **Compare a altura da faixa vermelha com a frequência escrita dentro da barra**: são coisas diferentes.

A média mistura duas coisas distintas: *com que frequência* o hospital entra em superlotação e *quão cheio* ele opera quando não está. O indicador foi separado nas duas.

Tabela 16: As duas perguntas da taxa de ocupação de internação em E3, por categoria. A última coluna é a mediana bruta, que mistura as duas.

Categoria em E3	% de anos em superlotação	Ocupação mediana quando ≤100	Mediana bruta (conflaciona)
Direta	16,9	69,1	75,3
Universitário	20,3	84,1	88,2
Filantrópico	28,9	83,5	89,9
OSS	35,0	88,0	95,3

A separação mostra que **as duas coisas andam juntas, mas não são a mesma**. A distância entre a mediana bruta e a mediana condicional é de 4,1 pontos no hospital universitário e de 7,2 pontos nas OSS: parte do que aparecia como "OSS opera mais cheio" era, na verdade, "OSS entra em superlotação com muito mais frequência". **A conflação existia, era real e explicava menos de um vinte avos da distância entre as duas redes: 4%, contra 96% que é leito de fato ocupado.**

A repartição se faz na média, e não na mediana, porque somar medianas não dá a mediana da soma. Entre os hospitais comparáveis, as OSS operam a **91,9%** da capacidade cadastrada contra **77,1%** da administração Direta: **14,8 pontos** de distância, repartidos assim:

$$\underbrace{14{,}8}_{\text{distância total}} = \underbrace{14{,}1}_{\text{leito de fato ocupado (96\%)}} + \underbrace{0{,}7}_{\text{transbordo (4\%)}}$$

O número corrige duas leituras erradas, e as duas circulam. A primeira é a ingênua, de que o indicador bruto media só o quanto o hospital opera cheio. Não media: sem a superlotação na conta, a distância entre as redes encolhe de 20,0 para 18,9 pontos na mediana, ou seja, **um vinte avos do que se via era frequência de transbordo, e não nível de ocupação**. **A régua aqui é outra**, e por isso o número não é exatamente o 4% do parágrafo anterior: ali a repartição é na média, a única que se soma; aqui a comparação é entre medianas. Os dois convivem e medem coisas diferentes. A segunda leitura errada é a oposta, a de que a vantagem das OSS *seria* superlotação disfarçada. Também não é: tirando todo o transbordo, as OSS continuam operando bem mais cheias que a Direta. **A diferença de ritmo sobrevive inteira; o que a separação corrige é o tamanho dela, não a sua existência.**

A mesma conta arruma as outras duas redes de um jeito que o número bruto escondia. O **Filantrópico** é o que mais transborda dos quatro (3,8 pontos na média) e, ainda assim, tem menos leito de fato ocupado que as OSS (85,0 contra 89,8). O **hospital universitário** vem logo atrás em transbordo (3,2 pontos) com 84,0 de leito ocupado. A regra que emerge: **quanto maior a parcela de transbordo, menos ela fala de hospital operando cheio, e mais de hospital com leito de menos para a demanda que bate na porta**.

Frequência e profundidade são coisas diferentes

Faltou separar duas perguntas que também vinham somadas: *com que frequência* o hospital passa da capacidade e *quanto* ele passa quando passa. A rede que mais faz uma não é a que mais faz a outra.

Primeiro, o tamanho típico do transbordo, que é menor do que a palavra "superlotação" sugere: nos anos em que um hospital passa de 100%, ele passa em geral para **107,0%**, e em nove de cada dez casos fica abaixo de 119%. Não é hospital operando ao dobro da capacidade; é hospital operando com alguns leitos a mais do que os cadastrados.

Segundo, e aqui a ordem das redes **se inverte**. As OSS são a rede que *mais vezes* transborda (35,0% dos anos) e, ao mesmo tempo, a que transborda *menos fundo*: 104,8% nos anos em que passa, contra 107,6% na administração Direta, 107,9% no Filantrópico, cujo pior caso chega a 236,6%, e 112,9% no hospital universitário.

Isso não contradiz o achado anterior; completa-o. A pressão sobre as OSS é *frequente e rasa*: passa da capacidade quase todo ano, e passa pouco. A do Filantrópico é *rara e profunda*. São dois problemas de gestão diferentes, que pedem respostas diferentes, e o indicador de ocupação sozinho somava os dois num número só.

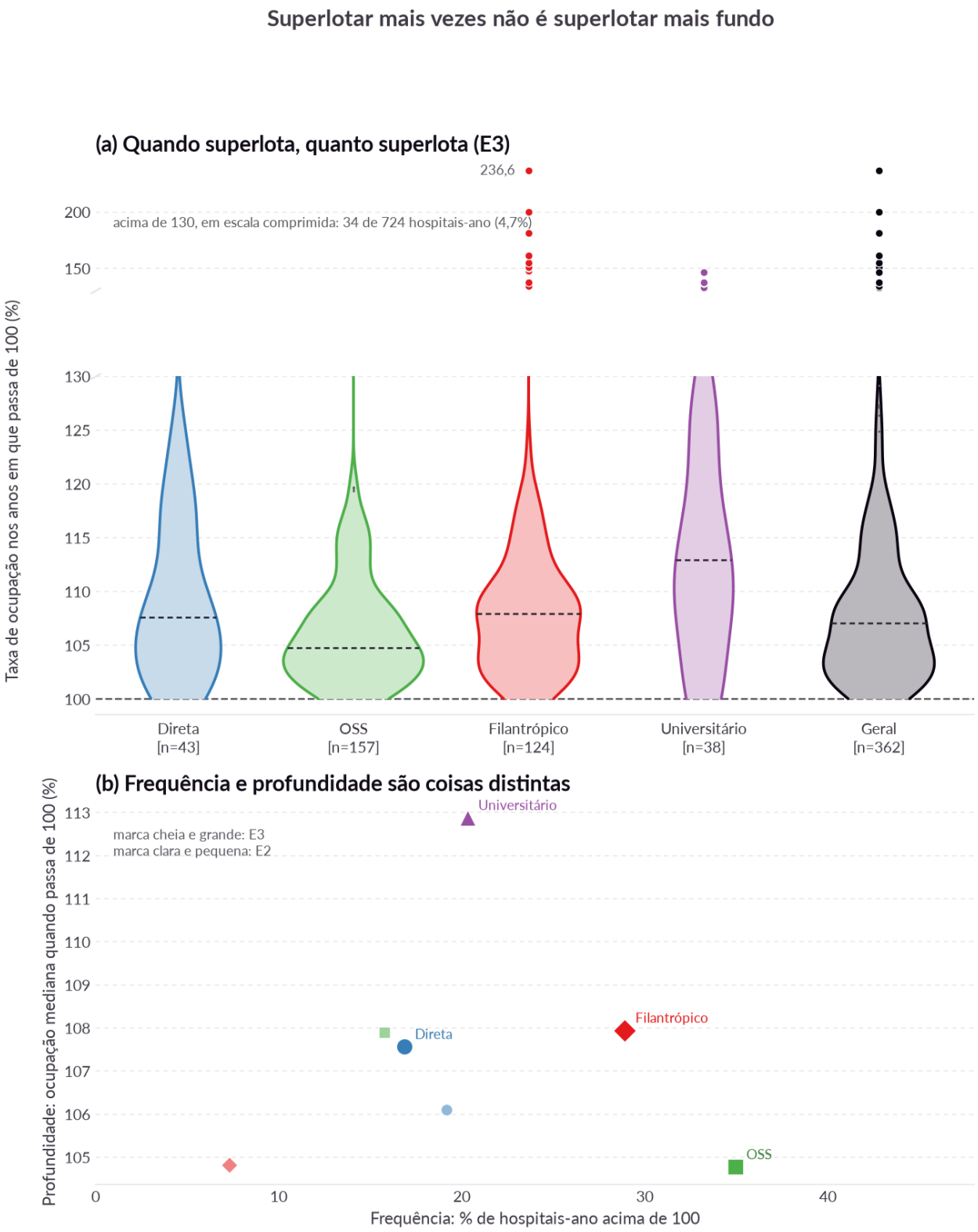


Figura 55: Frequência e profundidade da superlotação são independentes: as OSS superlotam mais vezes que o Filantrópico (35,0% dos anos contra 28,9%) e ainda assim transbordam três pontos menos fundo (104,8% contra 107,9%). **À esquerda**, a ocupação **restrita aos hospitais-ano acima de 100** em E3, uma curva por rede e o *n* no eixo: **nenhuma das quatro redes fica abaixo do piso de dez observações** (43 na Direta, 157 nas OSS, 124 no Filantrópico e 38 no universitário, 362 ao todo). A haste tracejada é a mediana, e a das OSS é a que menos sobe, apesar de ser a que mais passa da capacidade. **O eixo vertical é partido em 130**: acima da quebra, os 17 que passam dali (4,7% dos 362) saem **um a um**, comprimidos: uma curva de densidade esconderia essa cauda. **Nada foi descartado. À direita**, uma marca por rede e estrato: frequência na horizontal, profundidade na vertical, cheia em E3, clara em E2. Se as duas fossem a mesma coisa, os pontos formariam uma diagonal.

Uma terceira dimensão, e é a que mais importa para a leitura do excesso: quantos hospitais superlotam, e por quantos anos. No painel inteiro o padrão é **episódico**: dos 275 hospitais, 116 passam de 100% em ao menos um ano e **159 nunca passam**, e entre os 116 afetados a mediana é de **três anos** dos onze. Uma capacidade cronicamente sub-registrada produziria excesso permanente, e não é isso que se vê. **Mas o padrão geral não vale para todas as redes.** Nas OSS, **39 dos 59 hospitais (66,1%) superlotam alguma vez, e entre esses a mediana é de 4 dos onze anos**. Aqui cada hospital conta uma vez só, na categoria em que passou a maior parte do período. No hospital universitário o alcance é de metade da rede, com recorrência de dois anos, e no Filantrópico e na administração Direta a superlotação atinge de um terço a metade dos hospitais, por dois anos em ambos. **Nas OSS a superlotação não é episódica: é o modo normal de operar de boa parte da rede** (Figura B.17, no Apêndice B).

Vale registrar o que isso faz com um argumento anterior. O padrão episódico era uma das evidências de que o excesso mede sobrecarga real, e não sub-registro de leito; ele continua valendo **para o painel como um todo**, mas não para as OSS: um hospital acima de 100% em metade dos anos é compatível tanto com pressão assistencial persistente quanto com capacidade habilitada defasada da operada. **O que sustenta a leitura de sobrecarga é o mecanismo das definições do CNES e do SIH**, e não o padrão temporal, que apenas o acompanhava e para uma rede deixou de acompanhar.

Ano a ano, três coisas aparecem (Figura B.18, no Apêndice B). A distância entre a Direta e as demais redes **atravessa a década inteira** nas três leituras, e não é artefato de um ano nem do biênio pandêmico. **A pandemia esvaziou a Direta e não esvaziou as OSS**: em 2020 a taxa de ocupação média da Direta em E3 cai a 61,8%, o menor valor da série, enquanto a das OSS fica em 89,0%, praticamente no seu patamar habitual. E **a superlotação cresce no fim da série, não nela**: nas OSS a frequência vai de 37,5% em 2015 a 48,8% em 2024, e no Filantrópico de 20,5% a 35,9%. O aperto de leito da rede paulista, nestes dados, é mais um fenômeno de 2024 e 2025 do que de 2020 e 2021.

O que esta subseção estabelece, e o que ela não estabelece. Que a taxa de ocupação de internação somava duas coisas distintas, que a separação encolhe a distância entre as redes sem eliminá-la, e que frequência e profundidade de transbordo são dimensões independentes. Nada disso diz que a gestão *causa* a diferença de superlotação: é descrição entre hospitais equivalentes, e a pergunta causal é da Subseção 3.7.

3.4 A distância até a melhor prática entre hospitais equivalentes

A nota de eficiência da Subseção 1.7 compara cada hospital com a *mesma* régua, montada sobre a rede paulista inteira. Isso levanta uma objeção justa: um hospital pequeno pode aparecer longe da melhor prática simplesmente por ser pequeno, e não por operar mal.

A medida foi então refeita com uma mudança: **uma régua própria dentro de cada grupo de hospitais**. Cada hospital passa a ser comparado apenas com hospitais da sua própria escala, o pequeno com pequenos, o de referência com os de referência, e a melhor prática de cada ano passa a ser a melhor prática do grupo dele. Dentro do grupo de maior capacidade instalada isso reúne **120 hospitais** e as **quatro redes** de gestão do painel, e a pergunta deixa de ser "quão longe este hospital está do melhor do estado" e passa a ser "quão longe ele está do melhor hospital comparável com ele".

Nenhuma rede fica de fora deste conjunto de referência, e vale dizê-lo. As quatro entram tanto no contraste quanto na fronteira contra a qual todas são medidas, de modo que **o universo da comparação é o grupo inteiro**: são os mesmos 120 hospitais desta subseção e da seguinte, medidos contra a mesma régua. O que separa uma da outra é o que os títulos delas dizem: aqui a comparação desconta complexidade, porte e ano; lá as redes aparecem lado a lado sem desconto nenhum. **O hospital universitário entra como as demais**, e a ressalva de leitura que acompanha a nota dele está na Subseção 1.9.4 e é retomada adiante.

Comparadas só com hospitais do próprio grupo, as quatro redes ficam mais perto da melhor prática, e mais distantes entre si: a faixa entre a primeira e a última sobe de 198 para 230 milésimos

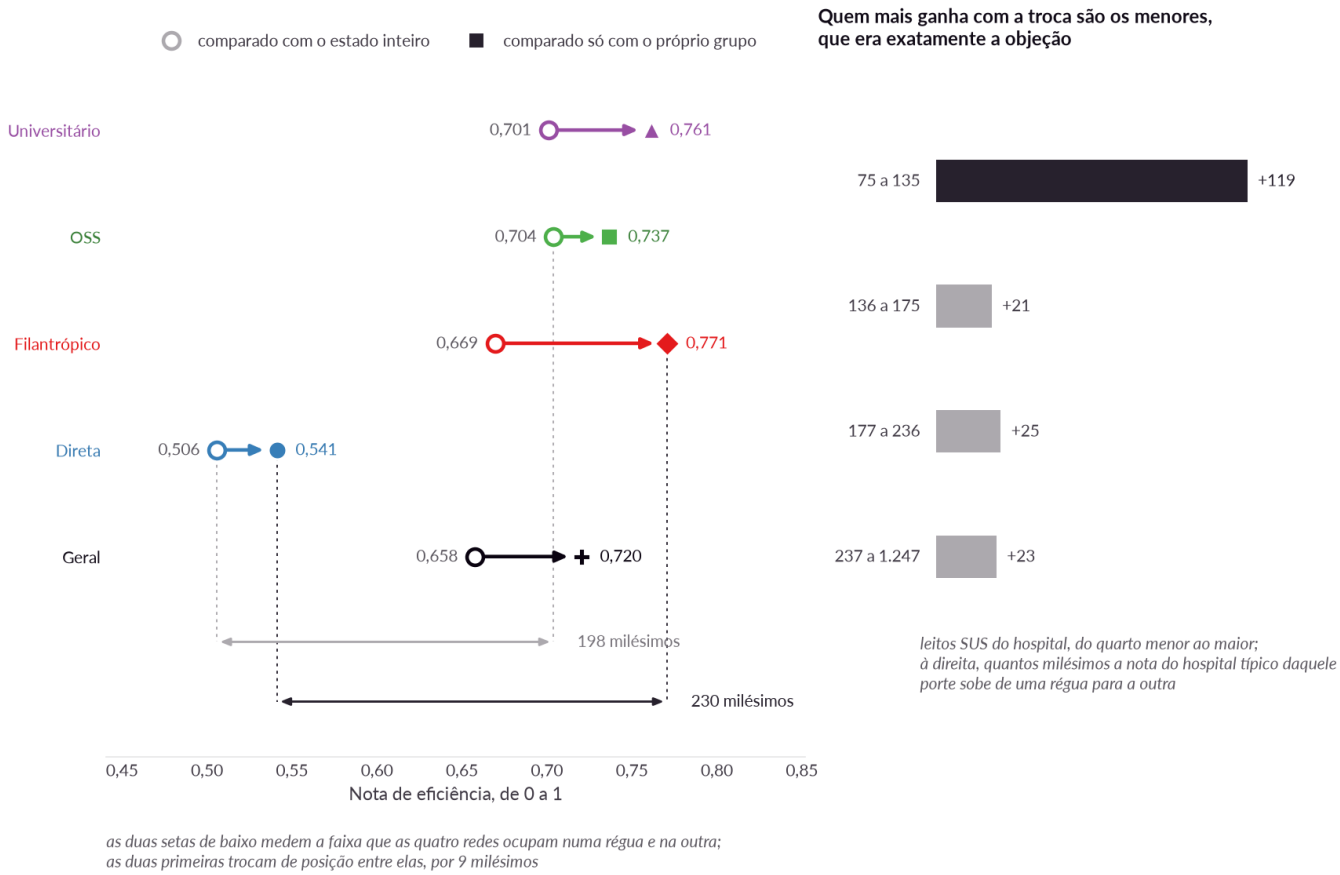


Figura 56: O que muda quando a régua deixa de ser o estado inteiro e passa a ser o próprio grupo de hospitais. Cada linha é uma rede, com dois pontos: o vazado é a nota dela comparada com o estado inteiro; o cheio, comparada só com o grupo de maior capacidade instalada, e a seta é o quanto a troca a move. **As duas setas de baixo medem a faixa que as redes ocupam numa régua e na outra**, e é a abertura dela que a figura mostra. No painel da direita, cada barra diz quantos milésimos a nota de uma faixa de porte sobe de uma régua para a outra. Os dois pontos de cada rede saem do mesmo cálculo, mudando apenas com quem cada hospital é comparado, e os dois são medianas dos onze anos. **Os valores da régua do estado não são os da Subseção 1.7**: lá cada rede é medida inteira, aqui só a parte dela neste grupo. As faixas de porte repartem os 120 hospitais em quatro partes iguais pelo número de leitos SUS.

A troca de régua ajuda quase todas as redes, e ajuda mais quem é menor. Dos 120 hospitais da comparação, **116 ficam mais perto da melhor prática** quando comparados só com os seus pares, e é o quarto de hospitais menores que mais ganha: **119 milésimos, contra pouco mais de vinte** em cada um dos três quartos maiores, que entre si empatam. A objeção do parágrafo anterior fica assim confirmada, e é ela que a régua nova corrige.

As quatro redes não ficam mais juntas dentro do grupo, e essa leitura mudou. Dentro do grupo as notas são **0,771** no Filantrópico, **0,761** no hospital universitário, **0,737** nas OSS e **0,541** na administração Direta: da primeira à última vão **230 milésimos** numa nota que vai de 0 a 1, contra **198** na régua do estado inteiro. Comparar cada hospital só com os seus pares aproxima quase todos eles da melhor prática, e não encurta a distância entre as redes: o que encurtava essa distância, na medida anterior, era o faturamento dentro da conta. E as duas primeiras ficam praticamente coladas: separa-as **nove milésimos**, o que é menos do que qualquer leitura desta subseção consegue distinguir. A Tabela 17 traz o quadro completo.

O primeiro lugar desta régua não é afirmável, e o texto não o afirma. O Filantrópico aparece à frente do hospital universitário por **nove milésimos**, que é distância menor do que a que separa duas leituras quaisquer do mesmo dado nesta subseção. **O que se pode dizer é que**

as duas não se separam uma da outra, e é assim que o resultado aparece daqui em diante: a nota crua não ordena as três primeiras redes. O desconto da próxima página ordena em parte, e é ele, e não a fila, que sustenta o que esta subseção afirma sobre cada rede.

Tabela 17: Nota de eficiência de cada categoria **dentro do seu próprio grupo**, na mediana dos onze anos. A nota vai de 0 a 1, e quanto mais perto de 1 mais próximo do melhor hospital do mesmo grupo. Entre parênteses, o número de hospitais. **As colunas não se comparam entre si**: cada uma mede distância até uma régua diferente. **É sobre a última coluna que esta subseção afirma alguma coisa**: as duas primeiras constam como registro, e o veredito comparativo é o do grupo de maior capacidade instalada.

Categoria	E1 (sem UTI)	E2 (Barcelona <4)	E3 (Barcelona ≥4)
Universitário	n/a	0,870† (1)	**0,761** (17)
OSS	0,741† (6)	0,674 (13)	**0,737** (43)
Filantrópico	0,699 (54)	0,561 (66)	**0,771** (39)
Direta	0,543† (5)	0,647 (11)	**0,541** (24)

† Menos de dez hospitais na célula: número registrado, mas que não sustenta comparação. **n/a**: a rede não tem hospital naquele estrato. **As três colunas usam agora a mesma medida**, com os leitos do SUS, os leitos de terapia intensiva e os dias de paciente como recursos; elas continuam sem se comparar entre si porque cada uma mede distância até a melhor prática do seu próprio grupo. **Uma ressalva vale para a coluna E1**: é o estrato dos hospitais sem terapia intensiva, e neles o recurso de UTI praticamente não varia, de modo que praticamente não distingue um hospital do outro. Na prática o E1 fica medido por leito de internação e dia de paciente.

Uma ressalva de leitura acompanha a nota do hospital universitário, e ela precisa vir antes do resultado. A rede tem **estrutura orçamentária e administrativa distinta das outras três**: o hospital universitário público é autarquia ou fundação vinculada a uma universidade, com dotação própria que não passa pelo faturamento das internações, e o que o Sistema Único de Saúde paga por produção é, para ele, parte da receita, e não substancialmente a receita. A composição do que ele atende também é outra: dentro deste grupo ele faz **18,4% de alta complexidade**, contra 1,5% da administração Direta, e fatura **R$ 2.926 por saída**, contra R$ 1.423 dela (Subseção 1.9.4).

Ele entra na comparação nos mesmos termos que as demais, e é por isso que a ressalva é de leitura. Nenhum filtro, nenhum peso e nenhum desconto próprio foram aplicados a ele: a nota dele sai da mesma conta, com os mesmos insumos e o mesmo produto, e ele concorre nas mesmas listas. O que a ressalva pede é que a posição dele seja lida sabendo que a estrutura de financiamento por trás dela é diferente, e não que ela seja descontada de alguma coisa que o dado não mede.

Descontando complexidade, porte e ano, três das quatro redes se separam da média do grupo. A **administração direta** aparece **mais distante** da melhor prática do que a média das redes comparadas, e continua mais distante mesmo no cenário menos favorável que os dados admitem. O **Filantrópico** aparece **mais perto**, e aparece mais perto em todas as leituras que esta seção testa. As **Organizações Sociais** também aparecem mais perto, mas não em todas as leituras: quando entra a gravidade dos casos elas voltam para junto da média. **Só o hospital universitário não se separa em leitura nenhuma**: para ele os dados admitem tanto cenários acima quanto abaixo. **Este é o resultado central da seção**, e o que vem a seguir existe para dizer com quanta folga ele se sustenta.

As três não se separam pelo mesmo tanto, e a que chega mais perto de se separar é a das Organizações Sociais. A faixa dela alcança a média por muito pouco; a do Filantrópico, por uma folga várias vezes maior; e a do hospital universitário fica com boa parte de si de cada lado da linha. **Nenhuma das três sustenta afirmação de posição**, e alcançar a média por pouco é alcançá-la: o desenho não distingue a mais próxima de se separar de uma rede que estivesse exatamente na média.

Descontar também a gravidade dos casos não desfaz esse resultado, e é essa a sensibilidade declarada da subseção. Acrescentada à conta a intensidade com que cada hospital usa a terapia intensiva por saída, a administração direta continua do mesmo lado e continua separada da média. **O que muda é o Filantrópico**, que sob esse desconto passa a aparecer mais perto da

melhor prática do que a média das quatro. **É assim que essa posição é reportada aqui**: como o que uma das duas leituras mostra, e não como posição da rede, porque na leitura sem o desconto ela não existe.

O desconto de gravidade aperta todas as faixas, e é por isso que ele muda o que se separa. A intensidade com que cada hospital usa a terapia intensiva por saída é a única dimensão de gravidade que esta base permite medir, e o termo dela fica inteiro de um lado onde quer que ele entre. Descontá-la deixa a faixa das Organizações Sociais com **menos da metade** da largura que ela tem sem o desconto, no mesmo universo. **Faixa mais estreita não é o mesmo que posição mais firme**: aqui ela aperta em torno da média, e o que se conclui é que quem trata caso mais grave aparece menos eficiente do que é quando a gravidade não é descontada.

Uma terceira leitura foi rodada e reportada, e o resultado dela é que ela não muda nada. Acrescentar à conta a fração de internações que vem de fora do município do hospital, que é a variável que mais separa as redes de tudo o que este trabalho mediu, deixa as quatro posições onde estavam e não põe nenhuma leitura do outro lado. **As três leituras estão numa tabela única** no Apêndice F, junto com o universo de comparabilidade estrita que a Subseção 1.9 descreve. Elas são reportadas porque a escolha entre elas foi fixada sem que o resultado de nenhuma fosse conhecido, o que é a salvaguarda que impede a escolha de especificação de andar atrás do sinal.

Descontando complexidade, porte e ano, três das quatro redes se separam da média do grupo: a administração Direta fica mais longe da melhor prática; o Filantrópico e as OSS ficam mais perto, e só o universitário não se distingue da média

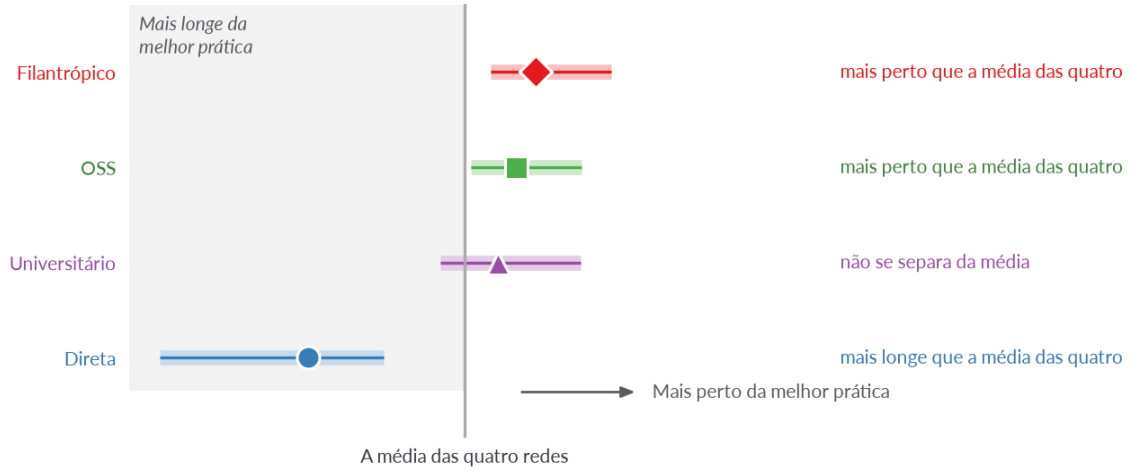


Figura 57: A posição de cada uma das quatro redes em relação à média delas, dentro do grupo de maior capacidade instalada, depois de descontar complexidade, porte e ano. Cada rede tem uma faixa, que cobre as posições que os dados admitem para ela, e o marcador é o valor central. **O que se lê é de que lado da linha vertical a faixa fica**: toda à direita, mais perto da melhor prática que a média; toda no lado cinza, mais longe; atravessando a linha, a rede não se separa da média. **Três das quatro ficam inteiras de um lado**, uma do lado cinza e duas do lado da vantagem. **O eixo não tem número de propósito**: esta escala não tem tradução em unidade de gestão. Descontar complexidade, porte e ano é comparar as redes como se todas atendessem a mesma mistura de casos, tivessem o mesmo tamanho e estivessem no mesmo ano. **Nenhuma das quatro serve de referência às outras**: a linha vertical é a média das quatro, cada rede contando uma vez.

O universo publicado é o mais preciso que este desenho já teve, e isso muda o que a ausência de separação significa. Com 120 hospitais em vez dos 79 do universo de comparabilidade estrita, a faixa de posições que os dados admitem para as Organizações Sociais fica **quase quatro vezes mais estreita**, na mesma especificação. **A faixa mais estreita é justamente a que alcança a média**, de modo que a ausência de separação não vem de imprecisão, e sim do contrário: com mais hospitais e uma medida mais determinada, o que se determina é uma rede que não se distingue da média.

Quatro advertências acompanham esses números. **A primeira é que as notas de grupos diferentes não se comparam entre si.** Cada uma mede distância até a melhor prática do próprio grupo, de modo que 0,90 num grupo significa "perto do melhor da minha categoria", e não "tão eficiente quanto" um 0,90 em outro.

A segunda é que a nota é a mediana dos onze anos, e ela reúne duas metades de década diferentes, em que a rede de melhor valor central não é a mesma. Nos anos de 2015 a 2019 é a do hospital universitário, com as Organizações Sociais coladas nela; de 2020 em diante é a filantrópica. O número do período vale como número do período, e não autoriza falar em posições estáveis ao longo da década.

A terceira é que a ordem das primeiras colocadas não é estável nem dentro da própria régua. O Filantrópico e o hospital universitário ficam separados por **nove milésimos** na nota crua, e qual dos dois aparece à frente é decidido por uma distância menor do que a que este desenho consegue resolver. O desconto de complexidade, porte e ano não resolve a ordem entre eles: o que ele diz é outra coisa, que um se separa da média das quatro e o outro não.

As duas instabilidades apontam para a mesma coisa, e ela não é ruído a ser escondido: é a medida da resolução deste desenho. Ele põe a administração direta atrás do resto em todas as leituras aplicadas, e a separa da média em quase todas elas. E **não distingue entre si a rede sob Organização Social, a filantrópica e a universitária em nenhuma**, de modo que qual das três aparece no topo depende do recorte de anos que se escolha olhar. **Ler essa alternância como classificação seria ler ruído como resultado.**

A quarta é que este resultado não conta como prova adicional. Ele usa os mesmos dados da Subseção 3.2; o que muda é a técnica, não a informação. Dois métodos concordando sobre os mesmos dados não valem por duas evidências, e **nenhuma das duas notas diz muito sozinha**.

3.5 As quatro redes dentro do grupo E3, lado a lado

A Subseção 3.2 comparou as redes com complexidade, porte e ano descontados. Esta as põe lado a lado **sem descontar nada**: são as medianas cruas de cada rede dentro do mesmo grupo, mais a nota de eficiência do grupo. Serve para ver o *perfil* de cada rede, e não para decidir entre elas.

Uma coisa muda em relação à Subseção 3.4, e não é o universo. São os mesmos 120 hospitais, as mesmas quatro redes e a mesma nota de eficiência, medida contra a mesma régua. **O que muda é que aqui nada é descontado**: lá as redes são comparadas como se todas atendessem a mesma mistura de casos e tivessem o mesmo tamanho, e aqui elas aparecem como são. É por isso que uma subseção sustenta veredito e a outra sustenta descrição.

A mortalidade fica de fora, e a razão é de dados: a composição por faixa de complexidade é muito desigual entre as quatro. Dos dez hospitais de faixa 6 do grupo, **oito são universitários e dois filantrópicos**; as outras duas redes não têm nenhum. A diferença bruta de mortalidade misturaria essa casuística com operação, e por isso o único número de mortalidade citável do grupo é o da Tabela 15, com a complexidade descontada.

Nas duas medidas de perfil, o hospital universitário está à parte

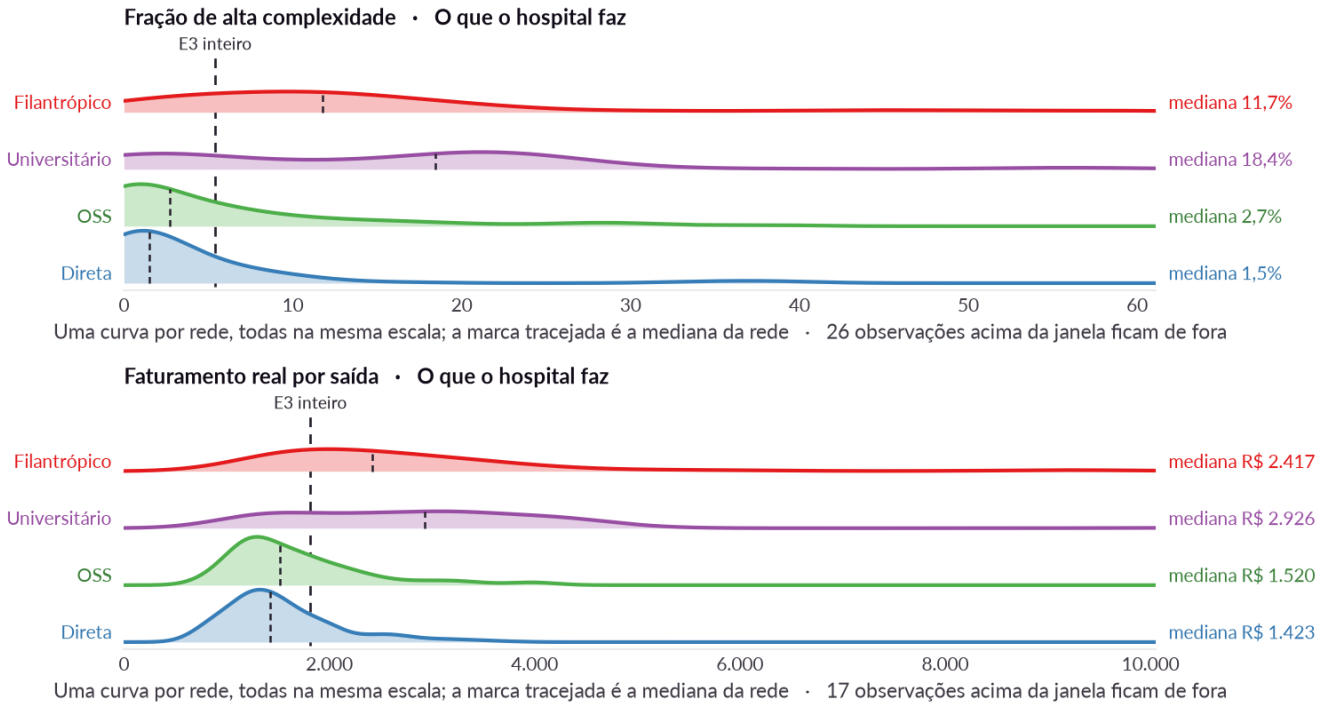


Figura 58: O perfil das quatro redes de E3, em distribuição: a fração de alta complexidade e o faturamento real por saída, uma curva por rede, sem desconto nenhum. Cada painel traz a **distribuição inteira** de cada rede, e não só a mediana: a curva é a forma, e a marca tracejada dentro dela é a mediana da rede, repetida em número à direita. A linha vertical é a mediana do E3 inteiro. **Este bloco descreve o perfil e não ordena desempenho**: faturar mais por saída e fazer mais alta complexidade são traços do que o hospital atende, e não posição numa disputa.

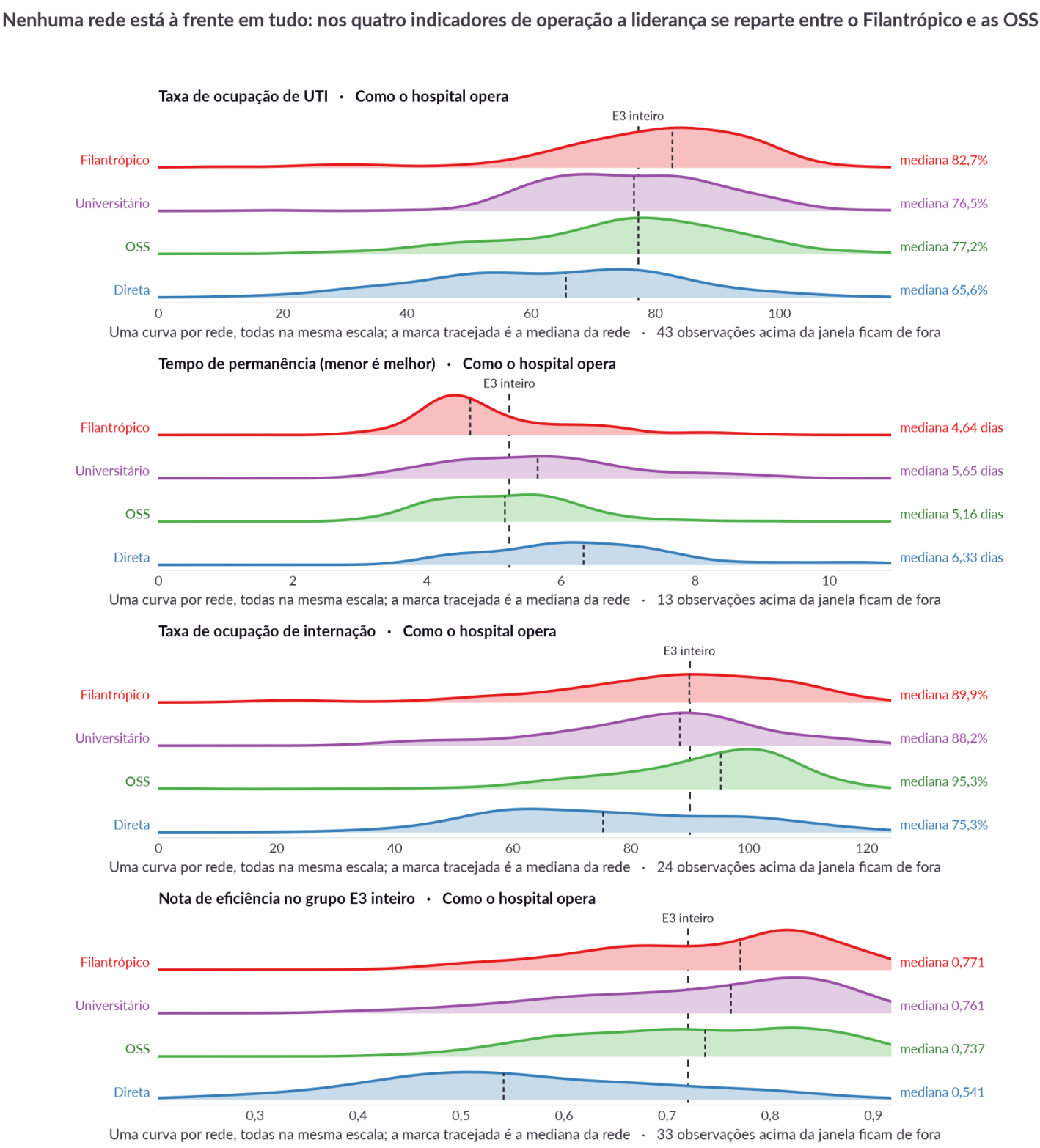


Figura 59: Como as quatro redes de E3 operam, em distribuição: as duas taxas de ocupação, o tempo de permanência e a nota de eficiência, uma curva por rede, sem desconto nenhum. Mesma leitura da figura anterior, agora nos quatro indicadores de **operação**. **A liderança se reparte entre duas redes**, e nenhuma está à frente em tudo. No tempo de permanência, curva mais à esquerda é melhor. **Cada painel tem a sua própria escala**: a comparação é entre as quatro curvas de um painel, e não entre painéis. Todos os valores são **medianas de hospital-ano** dentro do estrato E3, que tem 43 hospitais geridos por OSS, 39 filantrópicos, 24 da administração Direta e 17 universitários, contando os **três** que trocaram de regime nas duas redes que ocuparam. O **faturamento real** está em reais de dezembro de 2025.

Nenhuma rede está à frente em tudo. Nos quatro indicadores de operação a liderança se reparte entre duas redes: o **Filantrópico** mantém a UTI mais cheia (82,7% contra 65,6% da Direta) e dá alta mais cedo (4,64 dias contra 6,33); e as **OSS** operam a enfermaria mais cheia (95,3% de ocupação). **A nota de eficiência não separa as duas primeiras**: o Filantrópico marca 0,771 e o hospital universitário, 0,761. A administração Direta é a última nos quatro indicadores de operação e também na nota.

A administração Direta tem um perfil próprio, e ele é extremo do outro lado. A rede faz **1,5% de alta complexidade**, contra 2,7% nas OSS, 11,7% no Filantrópico e 18,4% no hospital universitário, e é a que menos fatura por saída (R$ 1.423). Não é uma rede que faz o mesmo pior: é uma rede que faz outra coisa. Ler a nota de eficiência dela sem esse dado ao lado seria comparar hospitais que não fazem o mesmo trabalho.

As quatro ocupam uma faixa de 230 milésimos na nota de eficiência, e as nuvens das três primeiras se cobrem quase inteiras. De 0,541 na administração Direta a 0,771 no Filantrópico, a distância entre a primeira e a última é **maior** do que a largura de qualquer uma das quatro distribuições, o que não acontecia enquanto o faturamento estava na conta. Medindo pela mediana do grupo inteiro, que é 0,720: **61,5% dos hospitais-ano do Filantrópico ficam acima dela, 60,4% dos do hospital universitário, 54,3% dos das OSS e 15,3% dos da administração Direta**. Entre as três primeiras a diferença é de quanta massa fica de cada lado, e não de conjuntos separados; **a administração Direta é a exceção**, e nela a massa está quase toda de um lado só. **E as três primeiras deixaram de trocar de ordem conforme a conta**: pela mediana e pela massa acima da mediana do grupo elas saem na mesma ordem.

E a nota do hospital universitário é composição, não gestão. Ele aparece em segundo na nota crua do grupo, com **0,761** contra 0,771 do Filantrópico, e nove milésimos não separam duas redes. Descontando complexidade, porte e ano, ele **não se separa da média das quatro redes**: os dados admitem para ele tanto cenários acima dela quanto abaixo. O que a nota crua mede, nele, é o perfil que a Subseção 1.9.4 descreve, com 18,4% de alta complexidade e R$ 2.926 de faturamento por saída, e não uma forma de administrar que as outras pudessem imitar.

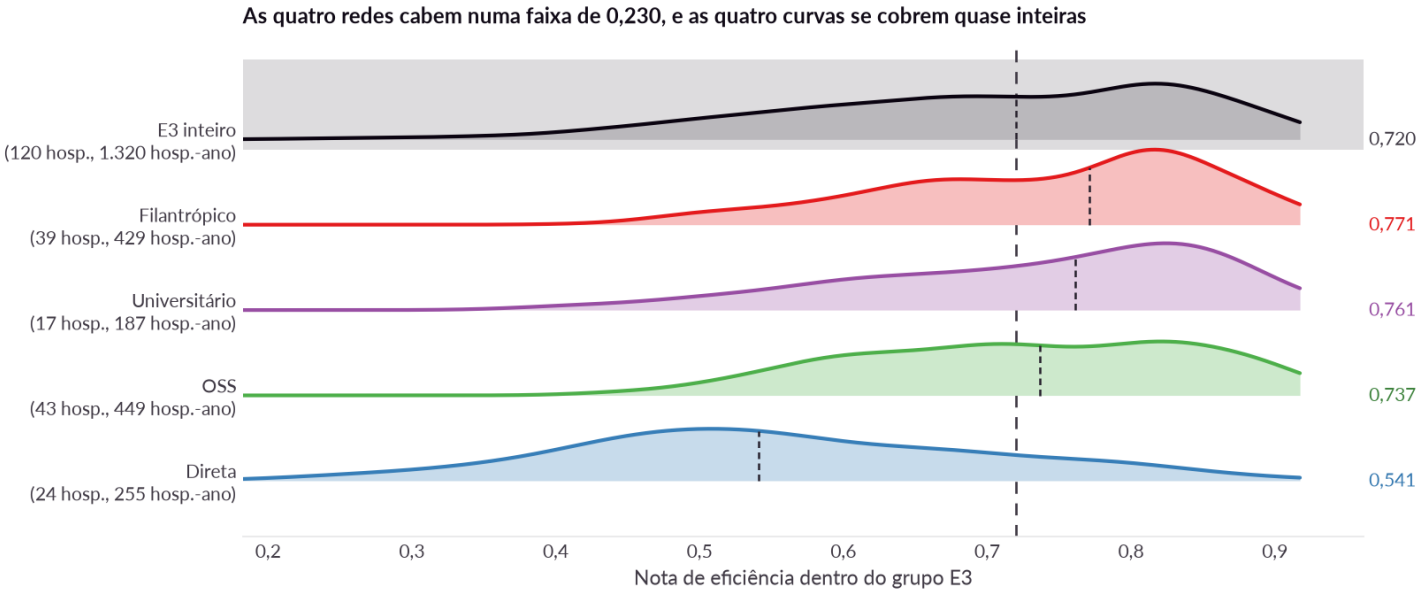


Figura 60: A distribuição inteira da nota de eficiência dentro do grupo E3, rede por rede, e não apenas a mediana de cada uma, nas quatro redes do estrato. As quatro redes estão empilhadas da mediana mais alta para a mais baixa, abaixo da curva do **grupo inteiro**, que serve de régua e vem **em preto sobre faixa cinza**. **A altura da curva diz onde os hospitais se acumulam**, e a haste tracejada dentro de cada uma marca a mediana daquela rede, repetida em número à direita. O rótulo traz **quantos hospitais e quantos hospitais-ano**: o do Filantrópico resume 39 hospitais e o da Direta, 24.

E a mediana do período inteiro esconde duas metades de década diferentes. Refeita ano a ano, a comparação mostra que **a liderança roda**: o hospital universitário lidera 2015, 2017

e 2019; as OSS, 2016 e 2018; e o Filantrópico, todos os seis anos de 2020 a 2025. **Três das quatro redes lideram algum ano do período, e a administração Direta não lidera nenhum.**

A troca é limpa demais para ser oscilação, e ela cai sobre a pandemia. Nos cinco anos até 2019 o hospital universitário marca **0,782** e as OSS **0,776**, com o Filantrópico em 0,704 e a administração Direta em 0,699, que é o último lugar. De 2020 em diante o Filantrópico sobe para **0,793** e passa a primeiro, as OSS ficam em 0,749, o universitário em 0,745 e a administração Direta cai para **0,653** e continua em último. Em variação entre os dois períodos: **o Filantrópico ganha 0,089, enquanto o universitário perde 0,037, as OSS perdem 0,027 e a Direta perde 0,046**. Por que isso aconteceu, este documento não diz; o que ele registra é que **a ordem das quatro redes neste grupo é um traço de cada metade do período, e não da década**.

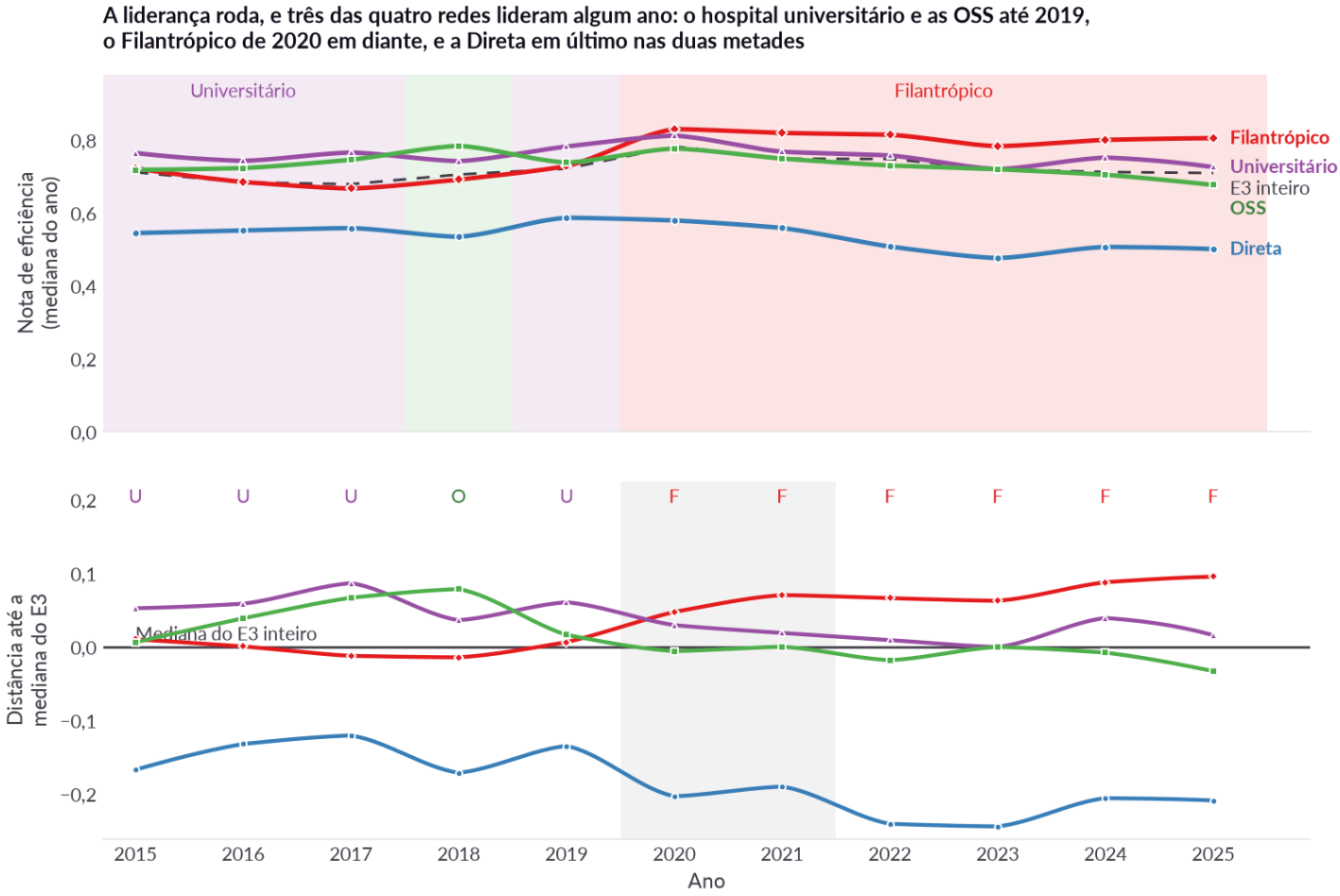


Figura 61: A eficiência das quatro redes dentro do grupo E3, ano a ano. Em cima, a mediana de cada rede e a do grupo inteiro em tracejado; embaixo, a **distância de cada rede até essa mediana**, com a linha do zero marcada e, no alto, a **inicial da rede que lidera cada ano** na cor dela, com a tarja de fundo na mesma cor. **Leia o painel de cima só dentro de cada ano**: a fronteira é redesenhada a cada ano, e uma linha que sobe não quer dizer que a rede produziu mais, e sim que ela ficou mais perto da fronteira daquele ano. Cada ponto é a **mediana dos hospitais-ano** daquela rede naquele ano, e **a curva liga os anos medidos e não inventa valor entre eles**. A fronteira é estimada **por estrato e por ano**, e nenhum modelo foi reestimado. **Uma ressalva de composição**: a Direta vai de 24 hospitais em 2015 para 21 em 2025, porque os que converteram passaram para as OSS.

O perfil de caso puxa a nota, e não puxa igual nas quatro. O cálculo de eficiência usa a alta complexidade como **produto**, de modo que fazer mais alta complexidade empurra a nota para cima. É o que acontece no hospital universitário, que faz **18,4% de alta complexidade contra 1,5%** da administração Direta; e acontece, em grau menor, no Filantrópico.

A produção física reordena as redes, e é ela que separa a Direta das outras. Medida a produção por leito SUS, duas redes ficam **próximas**: **58,8 saídas por leito no Filantrópico**

e 55,8 nas OSS. O hospital universitário fica em **47,0** e a administração Direta em **38,3**, isto é, 19% abaixo da terceira colocada. **É o segundo indicador desta subseção em que uma rede se separa das demais**, e aponta para a mesma rede que a nota de eficiência aponta.

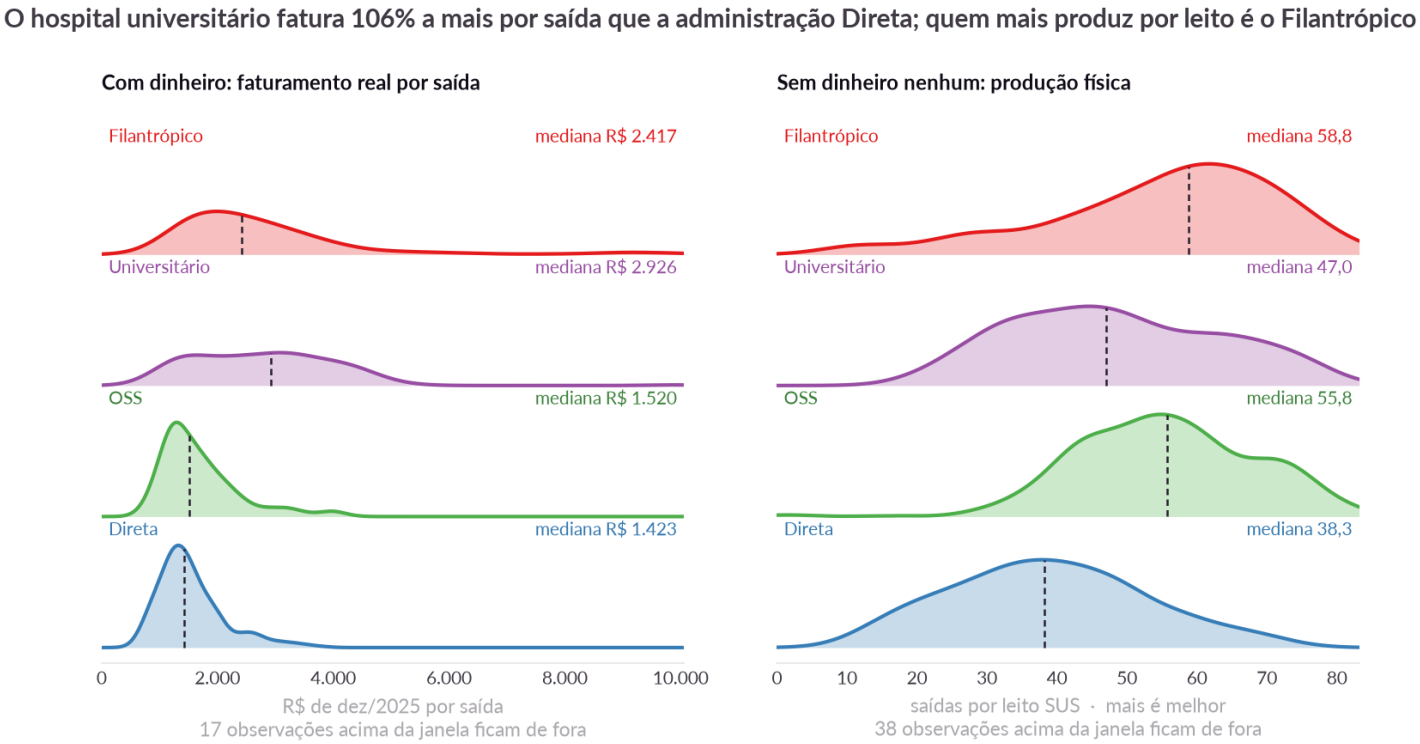


Figura 62: Perfil e produção nas quatro redes, em dois painéis: o faturamento real por saída e a produção física por leito SUS. Os dois painéis dizem coisas diferentes. À esquerda, o faturamento real por saída; à direita, a produção física por leito. **O painel da esquerda não diz quem está à frente**: faturar mais por saída é traço de perfil, não posição numa disputa.

Uma honestidade final: o E3 torna a comparação mais justa, não justa. Mesmo dentro do grupo, as redes não são gêmeas, e as assimetrias maiores são do hospital universitário e do Filantrópico. Os hospitais das quatro só se cobrem entre **102 e 318 leitos SUS**, e nessa faixa comum ficam os 24 hospitais da administração Direta e 39 dos 43 das OSS, mas apenas **29 dos 39 filantrópicos e 10 dos 17 universitários**: as duas redes vão de 75 a 972 e de 102 a 1.247 leitos, enquanto as outras duas não passam de 394. A composição por complexidade é igualmente desigual: **a faixa 6 existe no hospital universitário (8 hospitais) e no Filantrópico (2), e não existe nas outras duas**. Parte do que esta subseção mostra pode ser essa assimetria que sobrou, e não diferença de operação. É mais uma razão para tratar o que está aqui como descrição, e não como veredito.

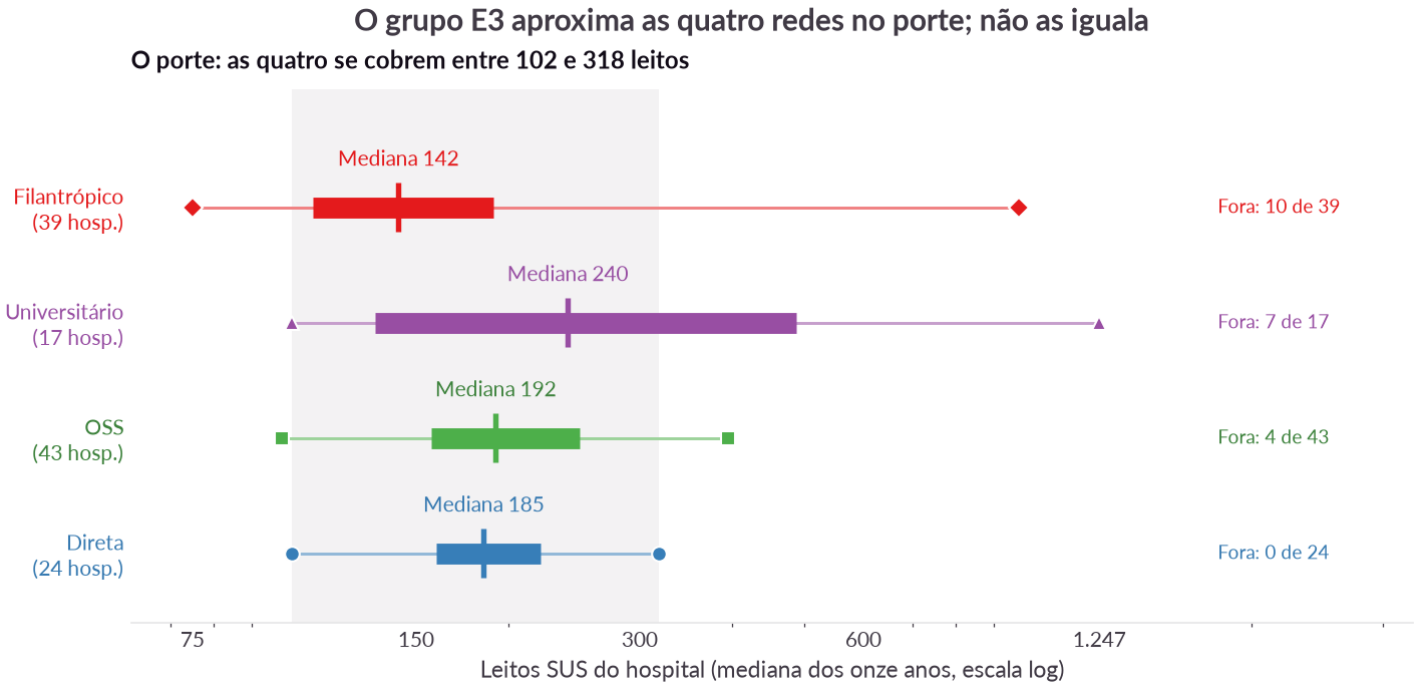


Figura 63: Primeira metade: a amplitude de porte. A linha fina vai do menor ao maior hospital da rede, a faixa grossa é a metade do meio, e o traço vertical é a mediana. A faixa cinza é o intervalo de leitos em que as quatro redes se cobrem. Na primeira figura o eixo é o porte do hospital, em escala logarítmica, porque em escala comum o hospital de 1.247 leitos empurraria todos os outros para o canto. A linha fina vai do menor ao maior hospital da rede, a barra grossa do primeiro ao terceiro quartil, o traço vertical é a mediana, e a **faixa cinza é onde as quatro de fato se cobrem**. Na segunda, cada barra é uma rede e soma 100% dos seus hospitais, repartida pelas faixas de complexidade da 4 à 6, em tom cada vez mais escuro. **O pedaço mais escuro existe em duas redes e não existe nas outras duas.**

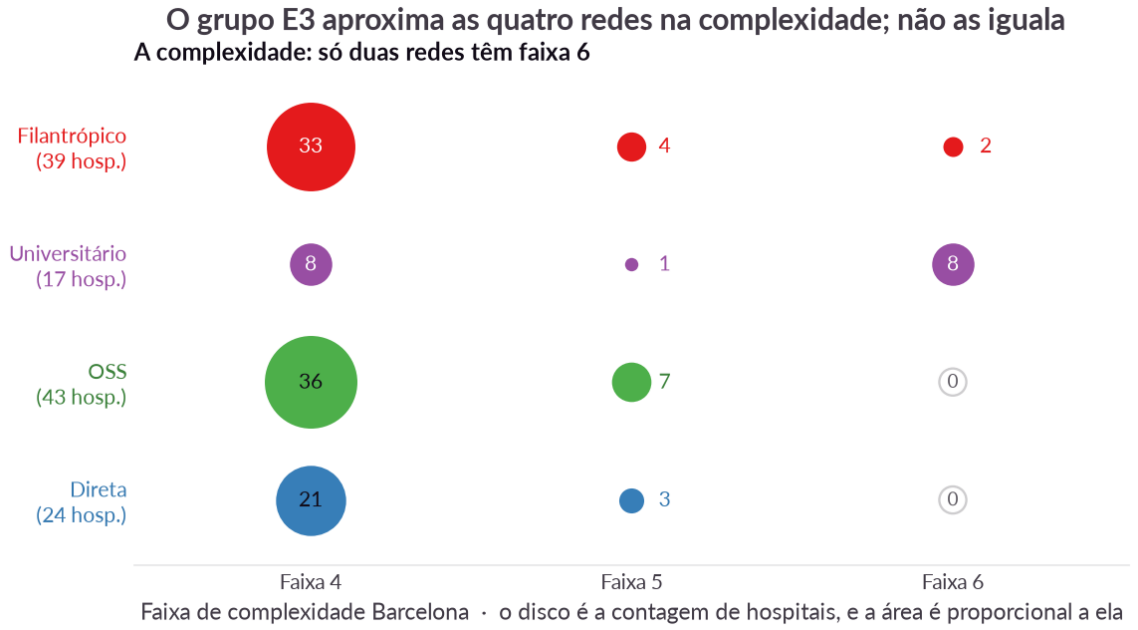


Figura 64: Segunda metade: a composição por faixa de complexidade. Cada barra é a rede inteira, repartida entre as faixas, e o número à direita é quantos hospitais dela estão na faixa 6.

Por que isso acontece, este documento não diz. O contraste é entre **categorias administrativas médias**, que é o que a classificação de gestão do painel registra, e não um efeito de modelo de gestão isolado de tudo o mais. Além disso, tudo o que está nesta subseção é **di-**

ferença bruta: nada foi descontado. Complexidade, porte, perfil da demanda local e regime de financiamento continuam dentro dos números. Contrato de metas, regime de financiamento, infraestrutura e perfil da demanda local são **hipóteses a investigar na fase qualitativa** desta pesquisa. Nenhuma delas está testada aqui, e a tabela acima não decide entre elas.

3.6 O que a segmentação acrescenta

Duas coisas, em ordem de importância.

Primeira: ela delimita onde há evidência. Dos três estratos, **apenas um** sustenta comparação entre redes. Isso não é limitação introduzida pela segmentação: é limitação que já existia e que a análise agregada escondia, ao somar num único contraste hospitais que não têm correspondente na rede oposta.

Segunda: ela confirma que a partição é real. O gradiente monotônico em cinco dos seis indicadores mostra que os três degraus capturam diferença estrutural de fato, e não um recorte arbitrário.

O que a segmentação *não* faz é resolver o problema de desenho. Em E3, como no painel inteiro, a identificação causal continua repousando sobre poucos hospitais convertidos, com confundidores documentados e um único tipo de operador.

3.7 As conversões de gestão: o que foram, e por que não sustentam leitura causal

A comparação desta seção mede **patamares**: hospitais equivalentes, redes distintas, diferenças descontadas de complexidade, porte e ano. Ela não mede o que acontece quando um hospital *troca* de modelo. Para isso seria preciso ver o mesmo hospital antes e depois, e o painel oferece poucos casos: poucos demais para sustentar leitura causal, como esta subseção mostra. É por essa razão que a conversão de gestão aparece aqui como nota, e não como capítulo próprio.

Quatro hospitais trocaram a administração Direta pela gestão por OSS dentro do período. São o **Conjunto Hospitalar de Sorocaba** (CNES 2081695), convertido em 2019, e três convertidos em 2025: o **Hospital Kátia de Souza Rodrigues, de Taipas** (CNES 2082225), o **Hospital Geral de Vila Penteado** (CNES 2091755) e o **Hospital Estadual de Presidente Prudente** (CNES 2750511). Os anos são de vigência no painel, isto é, o primeiro ano rotulado como OSS pela regra da maioria dos meses; as datas de contrato são anteriores.[5] Três deles (Sorocaba, Taipas e Vila Penteado) estão no estrato E3, que é o desta seção; Presidente Prudente está em E2. Nenhum hospital entrou ou saiu do Filantrópico nem do hospital universitário em todo o período.

Os chamamentos preservaram o orçamento da administração direta. Os hospitais remanescentes foram chamados com o mesmo orçamento que já tinham sob gestão pública: o que mudou foi o **modelo de gestão**, não o volume de recurso. O ponto é favorável à leitura de gestão (uma diferença encontrada não pode ser atribuída a mais dinheiro) e não resolve nenhum dos limites de desenho enumerados a seguir.

Restaram quatro casos, e apenas um é avaliável. Sorocaba tem **sete anos** de observação depois da conversão; os três de 2025 têm **um único ano**, que mostra o ponto de partida e não a trajetória. Na prática, toda a evidência *dentro* do hospital deste documento repousa sobre um hospital.

E nenhuma das quatro conversões é um caso limpo. Quatro fatos mudam o que se pode ler delas, e eles apontam todos na mesma direção: o desenho é mais frágil do que a aritmética sugere.

Primeiro: nenhuma conversão começou em janeiro, e o painel é anual. As OSS assumiram no meio do ano: Sorocaba com dois meses de OSS em 2018, Taipas e Vila Penteado com cerca de quatro em 2024. A regra adotada atribui o ano à categoria em que o hospital passou a maior parte dos meses, o que classifica esses anos de transição como Direta. A consequência é favorável à cautela: cada ano de transição carrega alguns meses já sob a nova gestão dentro do período rotulado como Direta, o que **atenua** o contraste medido. Se há erro nessa direção, ele empurra os efeitos estimados para baixo, não para cima.

Segundo: a conversão de Sorocaba foi resposta a uma falha de gestão documentada. Em março de 2018 vieram a público denúncias de fraude no controle de ponto no complexo hospitalar, e a decisão de transferir a administração para uma OSS foi anunciada na sequência. A implicação é direta e incômoda: o período *anterior* à conversão não retrata o hospital em funcionamento normal, e sim um hospital em crise, exatamente a crise que motivou a mudança. Quando se seleciona um caso pelo seu pior momento e se observa o que vem depois, a simples **reversão à média** produz melhora aparente ainda que a nova gestão não tenha efeito nenhum. E este é o caso do único conversor avaliável.

Terceiro: esse único conversor avaliável foi para uma organização específica. Sorocaba foi para o Seconci-SP. O que o desenho identifica é, a rigor, o efeito de **uma organização**, num único hospital, e não da categoria OSS como arranjo institucional. Nada garante que outra OSS, com outra cultura gerencial e outro contrato, produziria o mesmo resultado.

[5] Sorocaba passou à gestão do Seconci-SP em 1º de novembro de 2018, conforme material institucional do Seconci-SP e cobertura da imprensa local de Sorocaba, agosto de 2018. As datas de Taipas e Vila Penteado são **aproximadas**, inferidas de reportagem de outubro de 2024 que noticiava os primeiros trinta dias de contrato da IRSSL, do Sírio-Libanês. Para Presidente Prudente o **mês não foi identificado**: o ano de 2025 vem da classificação assistencial registrada na base do SIH, e não de fonte documental.

Quarto: o rótulo "Direta" do período anterior não descrevia gestão pública integral. Taipas e Vila Penteado já operavam com pronto-socorro, UTI e anestesia terceirizados por convênio antes da conversão de 2025.[6] Parte da operação assistencial já estava fora da administração direta antes da mudança formal, o que **reduz o contraste de tratamento**: a comparação não é entre gestão pública integral e gestão por OSS, mas entre dois arranjos mistos com proporções diferentes.

O que se vê em Sorocaba, e o que os testes fazem com isso. Comparando as medianas antes e depois da conversão, o hospital registra mortalidade **14,8% menor** (de 9,34% para 7,95%) e permanência **14,0% menor** (de 8,29 para 7,13 dias). O teste que decide se isso pode ser lido como efeito é o das tendências anteriores (se o hospital já vinha melhorando antes de trocar de gestão, parte da melhora posterior não é da OSS), e ele é **rejeitado nos cinco indicadores**: em todos os cinco, o hospital já vinha em trajetória própria antes da troca, o que impede creditar à conversão o que veio depois. **As três verificações adicionais não recuperam o que ele derruba.** Sorteando quatro conversores falsos entre os hospitais que nunca mudaram, 1.999 vezes, a queda de permanência aparece com a mesma frequência entre os falsos e entre os verdadeiros; a segunda verificação, que reamostra hospitais inteiros, chega ao mesmo lugar. E o gêmeo sintético de Sorocaba, montado para reproduzir o período anterior, **não descola do hospital real na mortalidade** e **chega a inverter de sinal** conforme quem é aceito no pool de doadores, o que é fragilidade e não efeito.

Nenhum achado da conversão sobrevive, e o mais próximo era o tempo de permanência. O que resta dele é **direção**: o efeito *within* é de 6,8% de queda, e a diferença é pequena demais para se separar do acaso. E a queda de mortalidade tem a demonstração mais direta contra si: medida **entre redes**, sem nenhuma contribuição dos hospitais que trocaram de gestão, a taxa vai de 5,6% na administração Direta a 6,3% nas OSS, com margem de 4,7% a 8,3%; ou seja, a mortalidade menor é fenômeno da trajetória dos convertidos, e não tem contraparte na comparação entre as redes.

O que isso decide sobre os números desta seção. Separar o que muda quando um hospital troca de regime do que apenas difere entre hospitais exige hospitais que tenham trocado, e dentro do E3 **três trocaram, todos da Direta para OSS**. Os números do Filantrópico são, portanto, comparação entre grupos distintos de hospitais, e carregam tudo o que separa uma rede da outra e não está no modelo. Isso inverte uma leitura tentadora: **margem estreita numa rede que não trocou é sinal de que há muita diferença entre hospitais, e não de que a diferença foi causada pelo modelo de gestão**. E uma estimativa que não separa nada sobre três hospitais não é evidência de que não há efeito: é evidência de que estes dados não têm potência para detectá-lo.

A margem de erro não sabe nada disso. Ela mede a incerteza que vem do tamanho da amostra, não a que vem de o experimento não ter sido desenhado. **Não é um desenho limpo; é o desenho disponível**, e os números desta seção devem circular com essa frase colada.

[6] Declaração do secretário estadual de saúde reproduzida em material de entidades do setor.

4 Fase qualitativa: as perguntas que o dado não fecha, e a quem fazê-las

Esta seção converte o que o dado deixou em aberto em roteiro de campo. Cada achado quantitativo que não se explica sozinho vira pergunta, e cada pergunta ganha um interlocutor: hospitais escolhidos pela posição que ocupam nas distribuições do painel, não por conveniência de acesso. A seção declara o critério de escolha e o que se pretende ouvir de cada grupo. O que ela não faz é decidir a fase. A seleção é sugestão construída por critério estatístico, e a palavra final sobre quais hospitais importam e quais perguntas fazer cabe ao julgamento de campo da pesquisadora principal.

O que vem nesta seção

4.1 Por que entrevistar, e o que a entrevista responde 117
Por que entrevistar, e o que a conversa alcança que o registro não alcança.

4.2 Apresentação e método 117
O que as entrevistas vêm explicar, e como os hospitais foram escolhidos.

4.3 Os quatro blocos da seleção 119
Quem entra na lista de entrevistas, e o que cada bloco responde.

Uma nota sobre o estatuto desta seção. O que se segue é uma **sugestão**, construída por critérios puramente estatísticos: os hospitais foram escolhidos pela sua posição nas distribuições de eficiência, permanência e produção do painel, e as perguntas foram derivadas dos achados quantitativos da fase de estimação. Nada disso substitui o julgamento de campo. A decisão sobre **quais hospitais de fato importam e quais perguntas fazer** cabe à experiência e ao conhecimento institucional da pesquisadora principal, Priscilla Reinisch Perdicaris, cuja leitura da rede hospitalar paulista é o fator decisivo desta fase. As listas e os roteiros abaixo são apenas um ponto de partida informado pelos dados, a ser confirmado, reordenado, enxugado ou ampliado conforme esse julgamento.

4.1 Por que entrevistar, e o que a entrevista responde

Este enquadramento é rascunho. Ele fixa o que a fase qualitativa vai perguntar e por quê; o que de fato se pergunta, e a quem, segue sujeito ao julgamento de campo da pesquisadora principal, como o resto desta seção.

O painel mede resultado, e não mede como o resultado é produzido. Onze anos de internações registradas dizem quanto cada hospital produziu, quanto tempo o paciente ficou internado, quanto se faturou por saída e a que distância da melhor prática do seu grupo cada um operou. O que eles não dizem é o caminho entre a regra institucional e esses números. Dois hospitais com o mesmo modelo de gestão e a mesma posição na distribuição podem ter chegado ali por rotinas opostas, e o registro administrativo sai igual nos dois casos. É essa distância entre o que se mede e o que a explica que a entrevista existe para cobrir.

São quatro as coisas que a conversa com quem administra alcança e o registro não alcança.

1. **O mecanismo.** O documento mostra que hospitais sob modelos diferentes operam em patamares diferentes de produção e de permanência. Não mostra por meio de quê: se a diferença passa pela escala de pessoal, pela regulação da vaga, pela relação com a rede de origem do paciente ou pela gestão do bloco cirúrgico. A pergunta de campo é qual dessas engrenagens o gestor identifica como a que move o número.

2. **As práticas de gestão.** Metas internas, rotina de acompanhamento, quem decide o desligamento de um serviço deficitário, como se resolve o gargalo de exame e como se mede o desempenho da equipe. Nada disso aparece em base administrativa, e é a camada em que dois hospitais formalmente iguais deixam de ser iguais.

3. **Os termos do contrato.** O instrumento que rege a unidade fixa metas, penalidades, periodicidade de repasse e margem de renegociação. Duas unidades com o mesmo rótulo de modelo institucional podem operar sob contratos que exigem coisas distintas, e o rótulo não distingue as duas. A entrevista pergunta o que o contrato cobra, com que frequência ele é revisto e o que acontece quando a meta não é cumprida.

4. **A autonomia efetiva.** A diferença entre a autonomia que a norma concede e a que a unidade exerce na prática: contratar e desligar pessoal, comprar, remanejar recurso entre rubricas, abrir e fechar leito. É a variável que a literatura trata como o coração da diferença entre modelos, e é a que o dado administrativo não observa em nenhuma coluna.

A entrevista não vem confirmar o que o painel achou, e é importante que não venha. O papel dela é explicar por dentro os achados que a fase quantitativa deixou de pé e, com igual interesse, os que ela deixou sem separação: onde o dado não distingue duas redes, a pergunta passa a ser se elas de fato operam parecido ou se operam diferente por caminhos que se cancelam na média. As duas respostas são informativas, e só a conversa as separa.

4.2 Apresentação e método

Esta seção operacionaliza a fase qualitativa da pesquisa sobre o efeito do modelo institucional de gestão no desempenho dos hospitais SUS de São Paulo, sobre o mesmo painel balanceado de **275**

hospitais de 2015 a 2025. A fase de estimação deixou quatro achados que as entrevistas devem explicar por dentro, e cada um deles é retomado, com a sua força de evidência, na pergunta que o testa: o regime operacional mais intenso e a eficiência técnica maior das OSS **na rede inteira** (Subseção 1.7), que **entre hospitais de estrutura equivalente passa a ser a do Filantrópico** (Subseção 3.4); o tempo de permanência menor (Subseção 1.8), a mortalidade menor que não sobrevive ao controle sintético (Subseção 3.7) e o faturamento real por saída que não difere entre categorias (Subseção 1.8). *Vale para este último a ressalva de regime de pagamento enunciada por extenso na Subseção 1.8, p. 56: para as OSS o valor por saída pode refletir o próprio regime de pagamento, e não uso de recursos.* Toda referência a complexidade nesta fase usa o escore estrutural, como no restante do documento, pela definição da introdução.

A seleção está organizada em quatro blocos, e três deles têm a mesma forma. Os blocos 1, 2 e 3 trazem os hospitais de nota alta, os de nota baixa e os pares casados de contraste. **A cota deixou de ser a mesma nos dois blocos de desvio.** No bloco 1 (notas altas) ela é de **onze** hospitais nas OSS, **dez** no Filantrópico, **sete** no hospital universitário e **cinco** na administração Direta, que só tem onze hospitais elegíveis no universo de seleção; no bloco 2 (notas baixas) ela é de **dez** nas OSS e no Filantrópico, **seis** na administração Direta e **cinco** no hospital universitário. Como os blocos se sobrepõem de propósito (as âncoras do bloco 3 são exatamente hospitais de nota alta do bloco 1, e parte dos contrapontos também são notas baixas do bloco 2), as **97 linhas** da lista correspondem a **65 hospitais distintos**.

A cota maior, e agora diferente entre os dois blocos de desvio, tem três consequências, e as três são de leitura da própria lista.

A primeira é que a persistência deixou de ser a regra e passou a ser a exceção. O critério pede o hospital que esteve no quarto de cima (ou de baixo) da nota em pelo menos seis dos onze anos, e não há dez ou onze hospitais assim em rede nenhuma. Onde falta candidato persistente a vaga é completada **pela ordem da nota**, sem exigir persistência, e **33 das 64 linhas dos dois blocos de desvio entraram assim** (a sexagésima quarta linha, do Hospital Regional de Assis, é um caso à parte e está descrita no bloco 2, adiante). No bloco de notas altas são 17: cinco na administração Direta, cinco no Filantrópico, quatro nas OSS e três no universitário; no de notas baixas são 16: oito no Filantrópico, cinco nas OSS e três no universitário – a administração Direta fecha as cinco vagas padrão inteiras pela persistência. **Cada linha da lista diz se é persistente ou se foi completada pela ordem**, e a diferença importa: um hospital de nota alta num ano só não sustenta a mesma conversa que um hospital de nota alta em sete.

A segunda é que a administração Direta não tem dez piores depois de tirados os dez melhores, e por isso a cota dela no bloco 2 não é a das outras três. A rede tem **18 hospitais gerais em E3**, e doze deles são elegíveis; dez e dez pediria vinte assentos, mais do que a rede tem. A cota da Direta no bloco 2 é, por isso, de **seis**, o que a rede efetivamente comporta com os doze elegíveis, **sem assento vazio**. Os dois blocos de desvio continuam **disjuntos por construção**: nenhum hospital pode ser desviante positivo e negativo da mesma rede, e é essa restrição, não a cota em si, que a tabela `tabE3_vagas_nao_preenchidas` continuaria registrando se alguma vaga faltasse.

A terceira é que o bloco 1 deixou de espelhar o bloco 2. Nas OSS e no hospital universitário sobrava candidato de nota alta além da cota padrão, e o bloco 1 passou a pedir **onze** e **sete** assentos nessas duas redes, contra dez e cinco no bloco 2. Na administração Direta o movimento foi o oposto: a sexta vaga de nota alta vinha sendo completada pela ordem, sem persistência, e o sexto lugar trocava de hospital de uma rodada para outra – pedir um assento a menos evita levar a campo um "melhor"que mal se separa do resto. A cota da Direta no bloco 1 é, por isso, de **cinco**, uma a menos que no bloco 2. **As quatro redes continuam fechando os dois blocos**, sem assento vazio em nenhum deles.

A seleção corre nas quatro redes, e o hospital universitário entra nela pelos mesmos critérios das outras três: posição na distribuição da nota, persistência ao longo dos onze anos e pareamento por porte e faixa de complexidade.

A entrevista com os hospitais universitários é optativa. Ela é a única parte da seleção que tem esse estatuto, e a razão é de conteúdo: o hospital universitário difere das outras três

redes no **modelo de gestão** e no **regime orçamentário**. Parte da receita dele não passa pelo faturamento das internações, e a estrutura de decisão responde também à universidade a que ele se vincula (Subseção 1.9.4). **As perguntas do roteiro sobre contrato, meta e autonomia podem ter outro sentido ali**, e é julgamento de campo decidir se elas se aplicam, se pedem adaptação ou se o bloco inteiro sai.

A entrada dos doze na lista continua sendo **sugestão construída pelo mesmo critério estatístico** das demais redes, e os nomes ficam publicados nos três blocos: o que muda não é o critério, é o que se espera de quem for a campo. **Cabe à pesquisadora principal decidir se entrevista ou não esses hospitais**, e a lista não deixa de fechar se ela decidir que não. **As outras três redes não são optativas**, e a comparação que este documento sustenta se apoia nelas.

Toda a seleção está **dentro do estrato E3 e restrita a hospitais registrados como gerais**. As entrevistas são semiestruturadas, e o instrumento de campo (roteiro-base comum aos blocos de gestão e módulos específicos por perfil) está no Apêndice C. Cada pergunta traz, em itálico, o achado quantitativo que ela testa; o entrevistador deve conhecer esses achados, mas não deve revelá-los ao entrevistado antes da resposta.

4.3 Os quatro blocos da seleção

O universo da escolha encolhe duas vezes. O primeiro corte é o **grupo E3**, que é o conjunto de hospitais em que a comparação entre modelos de gestão se sustenta, e sobre o qual o veredito deste documento se apoia: entrevistar fora dele é ouvir sobre hospitais que a análise não compara. O segundo é o **tipo de hospital**: dos 120 hospitais do grupo, **110 são registrados como hospital geral** e 10 como especializado. A entrevista pergunta como se administra um hospital geral, e um instituto de especialidade responde outra pergunta. **Sete outros são registrados como geral e operam como instituto de especialidade**, e saem pelo mesmo motivo. Sobram **103 hospitais**, e as quatro redes têm **41 geridos por OSS, 33 filantrópicos, 16 da administração Direta e 13 universitários** pelo regime de 2025.

O filtro de perfil é o registro do CNES, e não o que o hospital opera. O corte por tipo alcança quem o cadastro declara especializado, e não alcança o hospital que consta como geral e opera como instituto de especialidade. **Um hospital da lista estava nessa situação e foi retirado das entrevistas**, porque um instituto de especialidade responde outra pergunta e a resposta dele não se compara com as demais; ele permanece em todas as análises deste documento, como qualquer outro hospital do painel. **A lista publica o que o critério escolhe**, e quem vai a campo confirma, reordena ou troca.

O que cada coluna destas tabelas quer dizer. A **nota** diz o quanto o hospital produz em relação ao que os parecidos com ele conseguem produzir com a mesma estrutura: vai de 0 a 1, e é a mediana dos onze anos, como os **leitos SUS**. **Rede** é o regime de 2025. Pondo os **103** hospitais em fila pela nota, o **quarto de cima** começa em **0,819** e o **quarto de baixo** termina em **0,622**. **Persistente** é aparecer no seu quarto da fila em **pelo menos seis dos onze anos**. **A nota compara cada hospital só com hospitais da sua própria escala** (Subseção 1.9.2): um 0,80 de um grupo não quer dizer o mesmo que um 0,80 de outro, e por isso todos os nomes desta seção saem do mesmo grupo, o E3.

4.3.1 Bloco 0: os conversores da Direta para OSS (prioritários)

CNES	Hospital	Município	Leitos SUS	Nota
OSS				
2082225	Hospital Kátia de Souza Rodrigues (Taipas)	São Paulo	242	0,665
2081695	Conjunto Hospitalar de Sorocaba	Sorocaba	369	0,577
2091755	Hospital Geral de Vila Penteado	São Paulo	204	0,564

Estes três entram por serem conversores, e não pela nota. São os únicos hospitais que se observam *antes e depois* da troca de gestão, e é isso que os torna o material mais valioso da

pesquisa: nenhum outro bloco mostra o que eles mostram. O que a trajetória de cada um sustenta, e o que ela não sustenta, está na Subseção 3.7; por isso não se repete aqui.

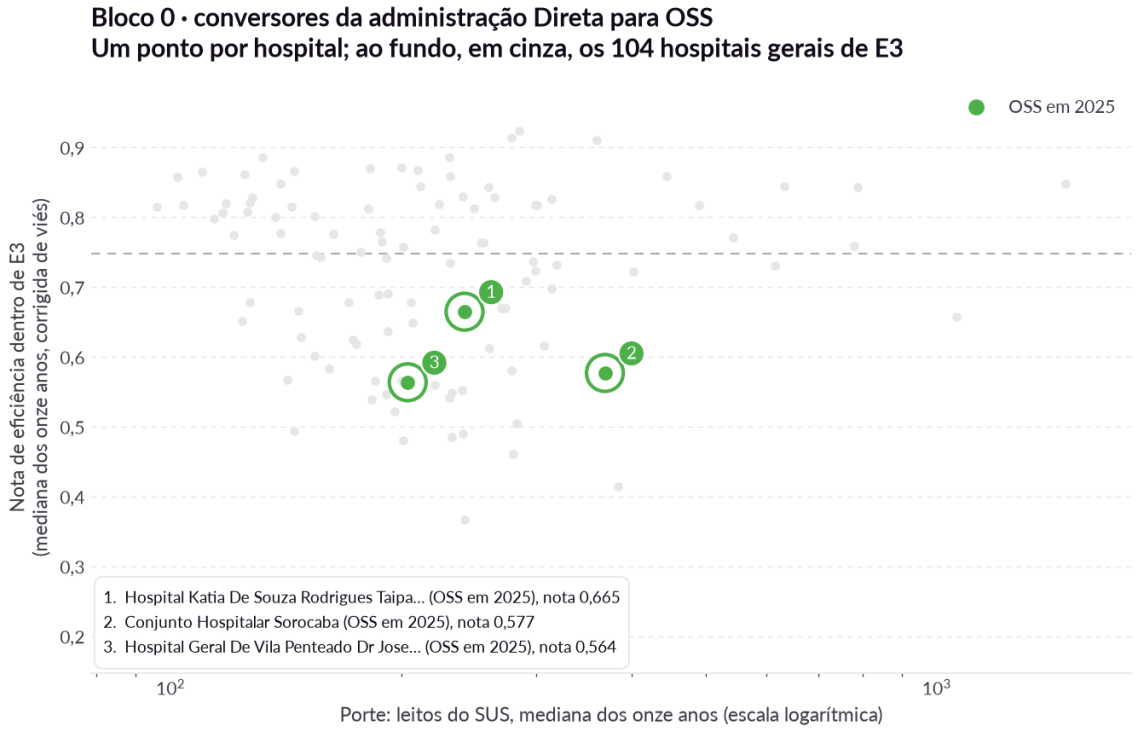


Figura 65: Bloco 0: os três conversores da administração Direta para OSS, dentro do universo dos 103 hospitais da seleção. Cada ponto é um hospital; ao fundo, em cinza, os 103 do universo da escolha, e os selecionados saem **circulados e numerados**. O eixo de baixo é o porte em leitos do SUS e o da esquerda é a nota. **Todas as figuras de bloco têm os mesmos limites de eixo**, para que a escala não mude de uma rede para a outra.

4.3.2 Bloco 1: as notas altas (quartil superior persistente)

CNES	Hospital	Município	Leitos SUS	Nota
OSS				
5718368	Hospital Municipal M'Boi Mirim	São Paulo	279	0,914
9628	Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	S. J. dos Campos	360	0,911
2792176	Hospital Geral de Itapecerica da Serra	Itapecerica da Serra	200	0,871
2792141	Hospital Regional de Cotia	Cotia	145	0,867
2077426	Hospital Geral Henrique Altimeyer De Vila Alpina	São Paulo	212	0,845
2078104	Hospital Geral De Itapevi	Itapevi	260	0,843
2792168	Hospital Geral De Carapicuiba	Carapicuiba	241	0,829
2080680	Hospital Das Clinicas Luzia De Pinho Melo Mogi Das Cruzes	Mogi das Cruzes	314	0,826
2079828	Hospital Geral Pirajussara	Taboao Da Serra	299	0,818
6095666	Hospital Municipal De Barueri Dr Francisco Moran	Barueri	301	0,818
2091585	Hospital Estadual De Sapopemba Sao Paulo	São Paulo	181	0,813
Filantrópico				
2080664	Santa Casa De Tupa	Tupa	132	0,886
2798298	Santa Casa de São José do Rio Preto	S. J. do Rio Preto	182	0,870
2786435	Hospital São Vicente de Paulo	Jundiaí	232	0,859
2082888	Santa Casa de Rio Claro	Rio Claro	102	0,858
2705982	Santa Casa de Franca	Franca	265	0,828
2089327	Hospital Padre Albino Catanduva	Catanduva	139	0,848
2082527	Santa Casa De Araraquara	Araraquara	128	0,828
2083116	Santa Casa de Marília	Marília	96	0,815
2087057	Hospital Dos Fornecedores De Cana De Piracicaba	Piracicaba	144	0,815
2081253	Hospital São Luiz de Araras	Araras	117	0,807
Direta				
2786680	Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha	São Paulo	256	0,763
2082829	Hospital Municipal Alípio Corrêa Netto	São Paulo	274	0,670
2080583	Hosp Mun Tide Setubal	São Paulo	173	0,624
2079240	Hospital Geral de Guaianases	São Paulo	240	0,553
2080079	Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho	Ferraz de Vasconcelos	233	0,549
Universitário (entrevista optativa)				
2082128	Hospital e Maternidade Celso Pierro	Campinas	210	0,868
2078015	Hospital das Clínicas da FMUSP	São Paulo	1472	0,848
2077396	Hospital de Base de S. J. do Rio Preto	S. J. do Rio Preto	632	0,844
2082187	Hospital das Clínicas (FAEPA)	Ribeirão Preto	789	0,843
2748223	Hospital das Clínicas de Botucatu	Botucatu	490	0,818
5860490	Hospital Universitário de Marília	Marília	154	0,802
2077485	Hospital Sao Paulo Hospital De Ensino Da Unifesp Sao Paulo	São Paulo	780	0,758

Os hospitais de nota mais alta de cada rede – **onze** nas OSS, **dez** no Filantrópico, **sete** no hospital universitário e **cinco** na administração Direta –, escolhidos, quando o quarto de cima da rede tem candidato suficiente, por manterem a nota ali *ao longo dos onze anos*, e não em um ou dois deles. A pergunta que eles respondem é quais práticas concretas sustentam esse giro alto de forma persistente. As notas do bloco vão de **0,549 a 0,914**.

Nenhuma rede fecha mais a cota inteira só com hospitais que cumprem a persistência. A que mais perto chega é a OSS, com sete persistentes e **quatro** das onze vagas completadas **pela ordem da nota**; seguem **cinco** de dez no Filantrópico e **três** de sete no hospital universitário. **Na administração Direta as cinco vagas são completadas pela ordem**: nenhum dos cinco hospitais chega aos seis anos no quarto de cima que a persistência exige. A coluna *motivo* da tabela diz, linha a linha, qual hospital entrou por qual caminho. **A leitura que isso impõe é assimétrica**: nas vagas completadas pela ordem, o que a conta afirma é a posição do hospital *dentro da sua rede*, e não que ele seja alto no conjunto nem que tenha ficado alto ao longo do tempo. **O efeito é maior nas redes menores**: a administração Direta tem **16** hospitais no universo de seleção e o hospital universitário, **13**, contra **41** das OSS. As notas do bloco vão de **0,549 a 0,914**.

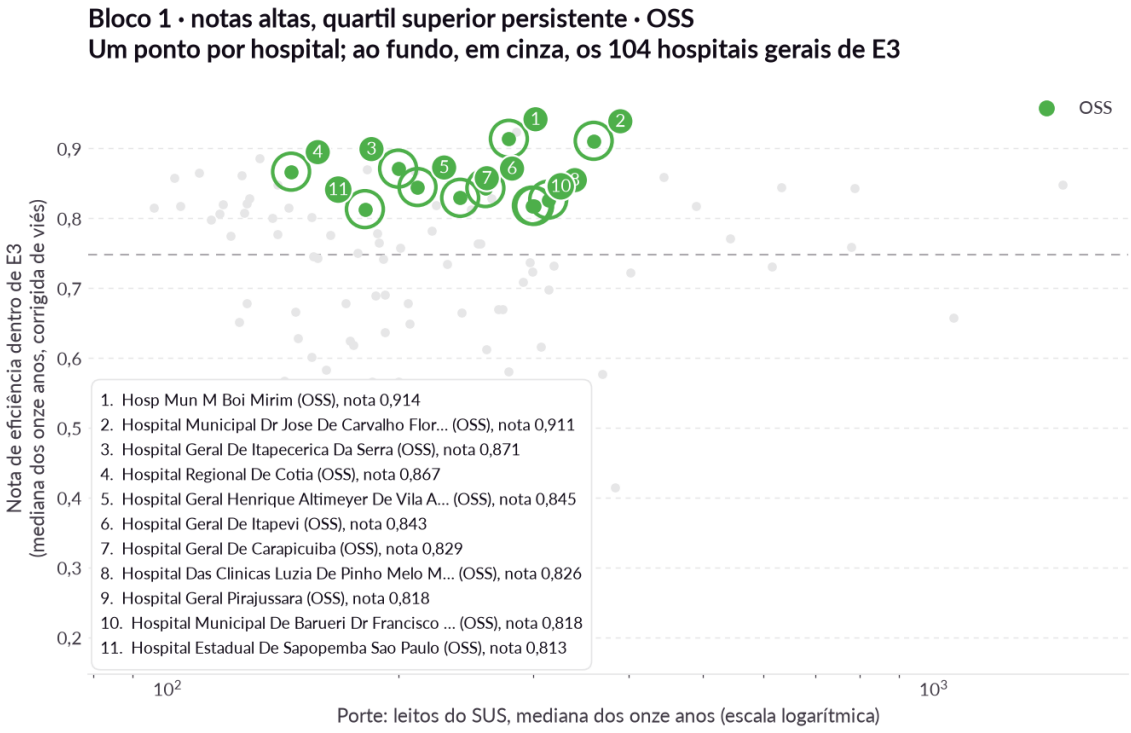


Figura 66: Bloco 1, OSS: as onze notas altas da rede.

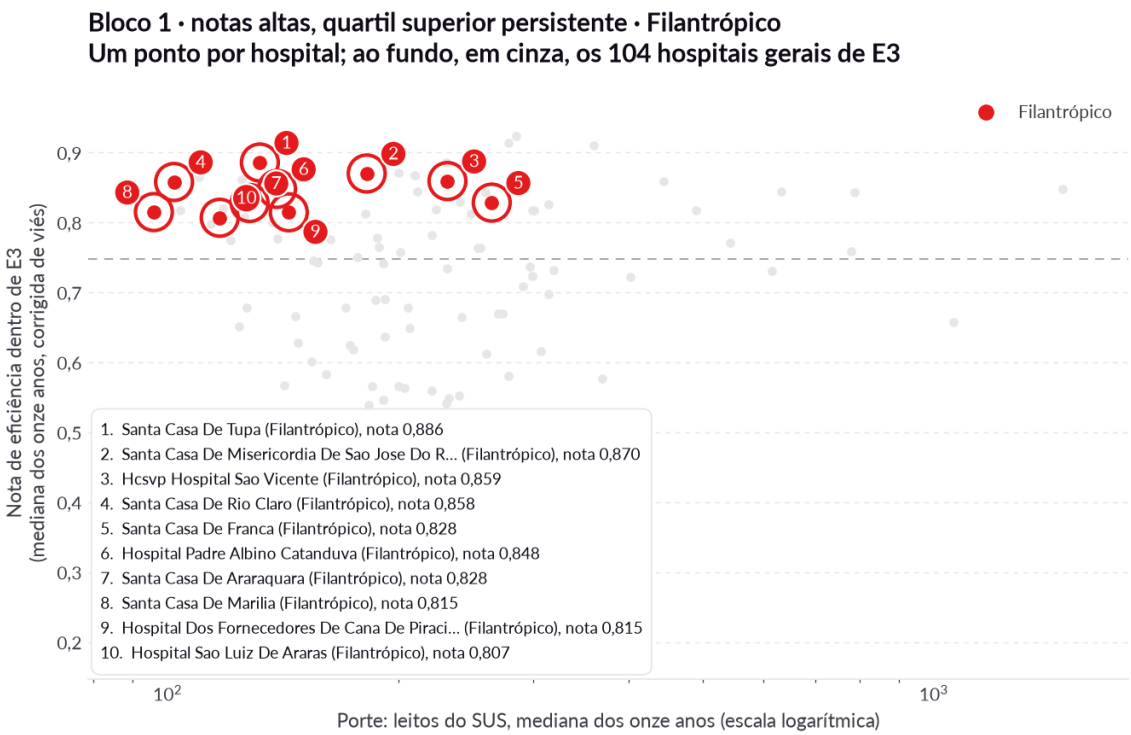


Figura 67: Bloco 1, Filantrópico: as dez notas altas da rede.

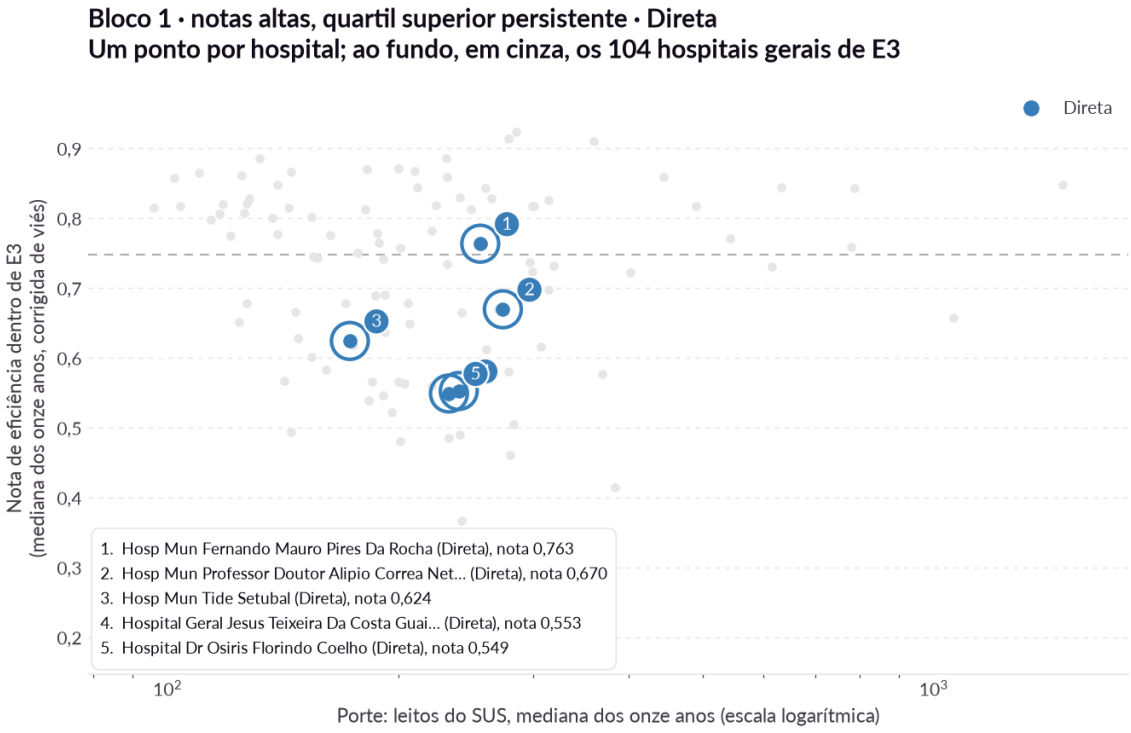


Figura 68: Bloco 1, administração Direta: as cinco notas altas da rede.

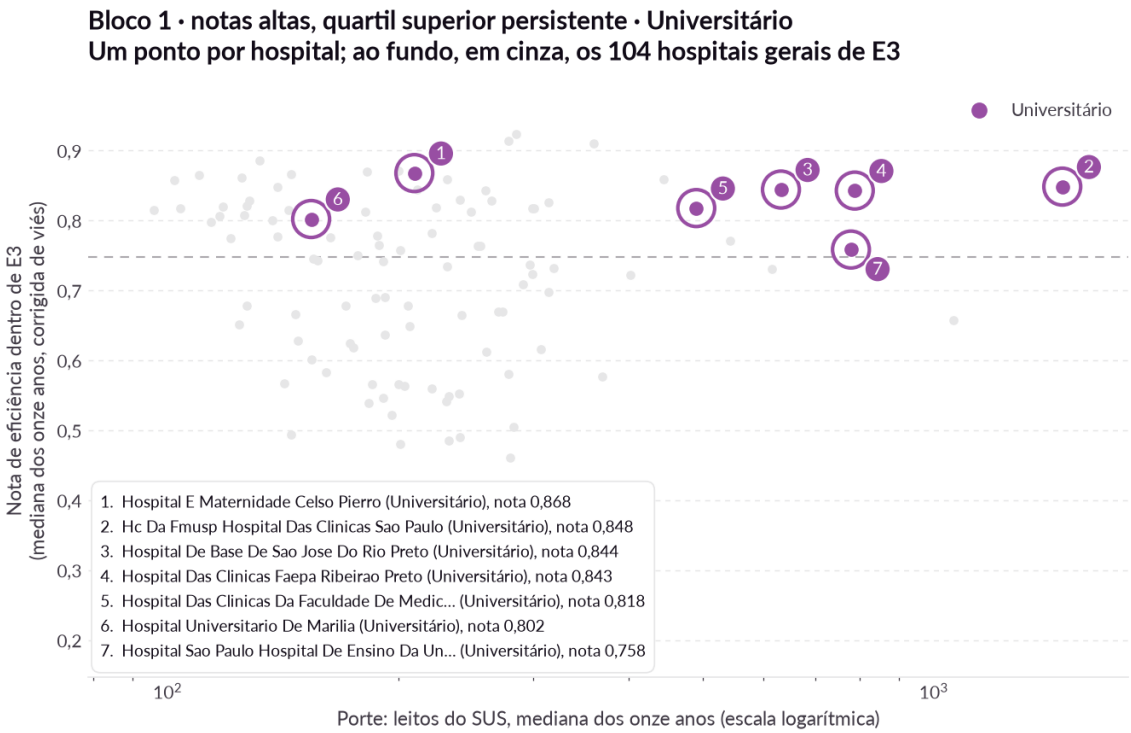


Figura 69: Bloco 1, hospital universitário: as sete notas altas da rede. A entrevista com esta rede é **optativa** (ver a Apresentação e método).

4.3.3 Bloco 2: as notas baixas (quartil inferior persistente)

CNES	Hospital	Município	Leitos SUS	Nota
OSS				
2716097	Complexo Hospitalar Irmã Dulce	Praia Grande	231	0,541
2091755	Hospital Geral de Vila Penteado	São Paulo	204	0,564
2081695	Conjunto Hospitalar de Sorocaba	Sorocaba	369	0,577
6878687	Hospital Estadual Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho	Franco da Rocha	161	0,583
2082594	Complexo Hospitalar Municipal	São Caetano do Sul	154	0,602
2082225	Hospital Kátia de Souza Rodrigues (Taipas)	São Paulo	242	0,665
5200105	Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso Manuel De Paiva	Guarulhos	147	0,666
8028	Hospital Municipal Antonio Giglio	Osasco	171	0,679
7711980	Hosp Mun Gilson De Cassia Marques De Carvalho	São Paulo	192	0,690
2080273	Hospital Estadual Mário Covas	Santo André	314	0,698
Filantrópico				
2025752	Santa Casa de Santos	Santos	283	0,505
2092611	Santa Casa de Barretos	Barretos	185	0,566
2078775	Santa Casa de Araçatuba	Araçatuba	261	0,612
2755092	Santa Casa De Pindamonhangaba	Pindamonhangaba	148	0,628
2754843	Hospital Santo Amaro	Guarujá	192	0,636
2688689	Santa Casa De Sao Paulo Hospital Central Sao Paulo	São Paulo	1062	0,658
2096463	Santa Casa de Mogi Guaçu	Mogi Guaçu	127	0,679
2791722	Santa Casa De Jau	Jau	187	0,689
2708779	Santa Casa de Sorocaba	Sorocaba	232	0,734
2772310	Santa Casa De Piracicaba	Piracicaba	191	0,742
Direta				
8052	Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões	Osasco	242	0,367
2080346	Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio	São Paulo	384	0,415
2091313	Hospital Regional Sul	São Paulo	201	0,480
2079720	Hospital Guilherme Álvaro	Santos	233	0,485
2077493	Hospital Geral De Sao Mateus Sao Paulo	São Paulo	241	0,490
2083094	Hospital Regional de Assis	Assis	124	nan
Universitário (entrevista optativa)				
2749319	Hospital Municipal Universitário de Taubaté	Taubaté	191	0,546
2089335	Hospital Escola Emílio Carlos	Catanduva	142	0,567
2076926	Hospital Universitário da USP	São Paulo	206	0,679
2079798	Hospital Das Clinicas Da Unicamp De Campinas	Campinas	615	0,731
2704900	Hospital Universitario Sao Francisco Na Prov De Deus	Braganca Paulista	155	0,746

O espelho do bloco anterior: dez hospitais por rede no quarto de baixo da fila nas OSS e no Filantrópico, seis na administração Direta e cinco no universitário, para ouvir quais restrições impedem o giro, na visão de quem opera, antes de confrontá-las com os dados do painel. As notas vão de **0,367 a 0,746**.

As quatro redes fecham a cota. Nas OSS, no Filantrópico e no universitário ela se completa em parte com hospitais persistentes no quarto de baixo e em parte pela ordem da nota: são **cinco** vagas completadas assim nas OSS, **oito** no Filantrópico e **três** no universitário.

A administração Direta fecha cinco das seis vagas com hospitais persistentes, e a sexta é um caso à parte. A rede tem **18 hospitais gerais em E3**, doze deles elegíveis; a cota é de cinco no bloco de notas altas e seis neste, e as duas juntas cobrem **onze** dos doze elegíveis. **Os cinco primeiros nomes cumprem a persistência**, no quarto de baixo em todos os onze anos: o Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, o Hospital Regional Sul, o Hospital Guilherme Álvaro, o Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões e o Hospital Geral de São Mateus. **O sexto nome, o Hospital Regional de Assis, entra com a nota de um instrumento anterior ao que dá a fronteira N3 usada no resto desta lista**, e essa nota **não foi recalculada sob a N3 e não se compara à dos outros cinco**: por isso ele entra sem nota impressa aqui, fora tanto da persistência quanto da ordem que decidem os demais assentos. Nenhum outro assento fica vazio.

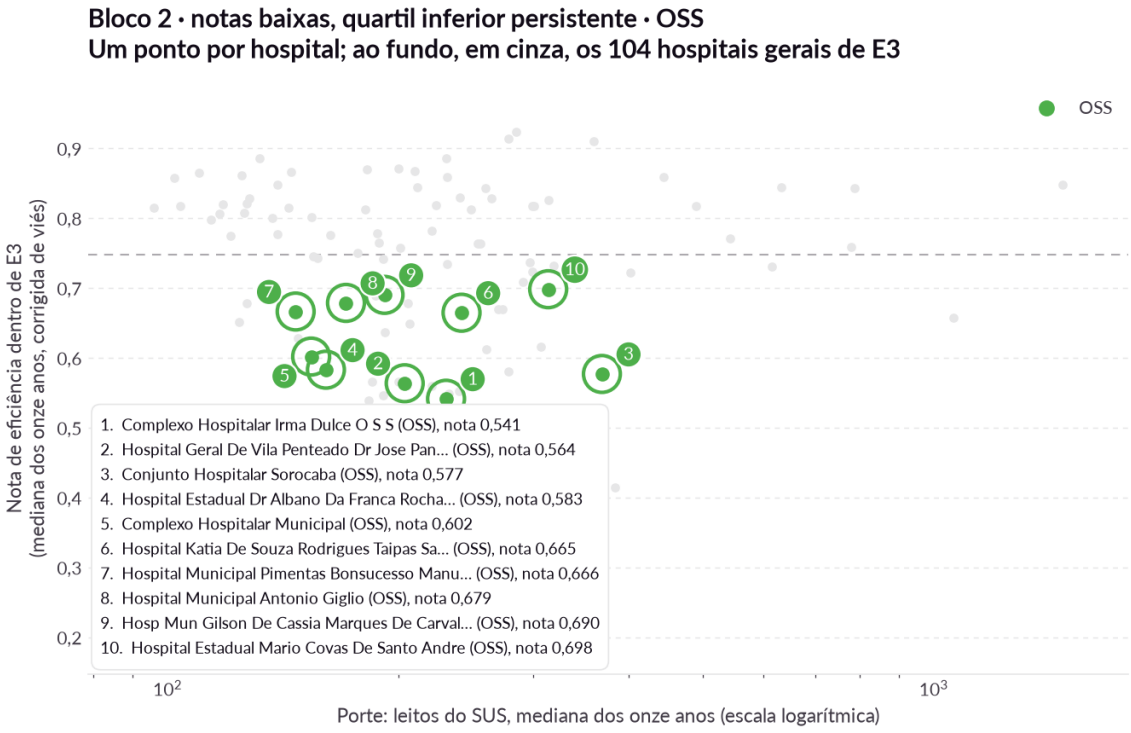


Figura 70: Bloco 2, OSS: as dez notas baixas da rede.

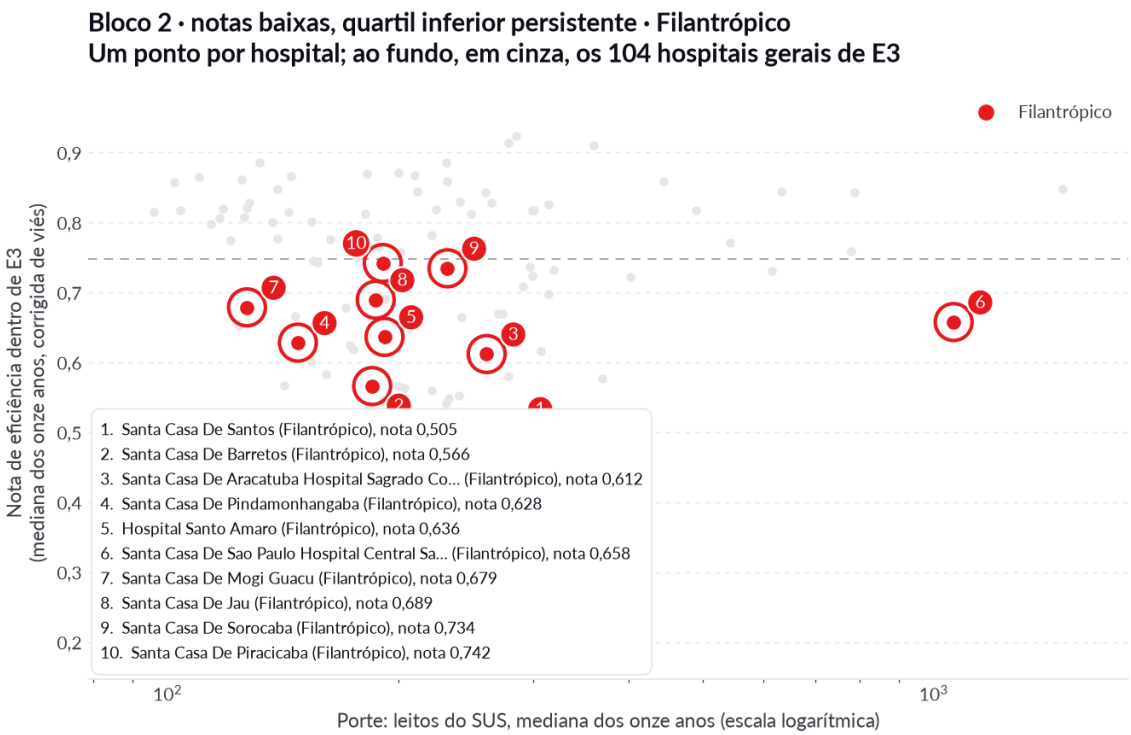


Figura 71: Bloco 2, Filantrópico: as dez notas baixas da rede.

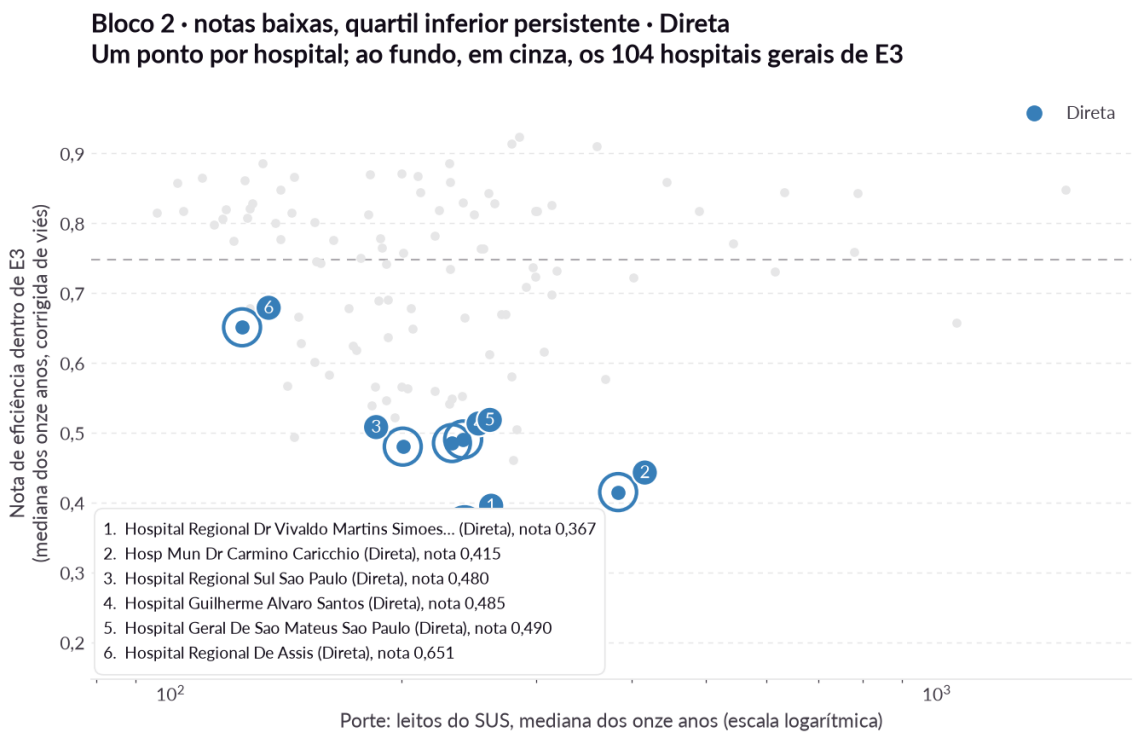


Figura 72: Bloco 2, administração Direta: as seis notas baixas da rede, cinco persistentes e uma (o Hospital Regional de Assis) reintroduzida com a nota do instrumento anterior à N3. A rede tem dezoito hospitais gerais em E3, doze elegíveis, e a cota (cinco no bloco 1, seis neste) cobre onze deles.

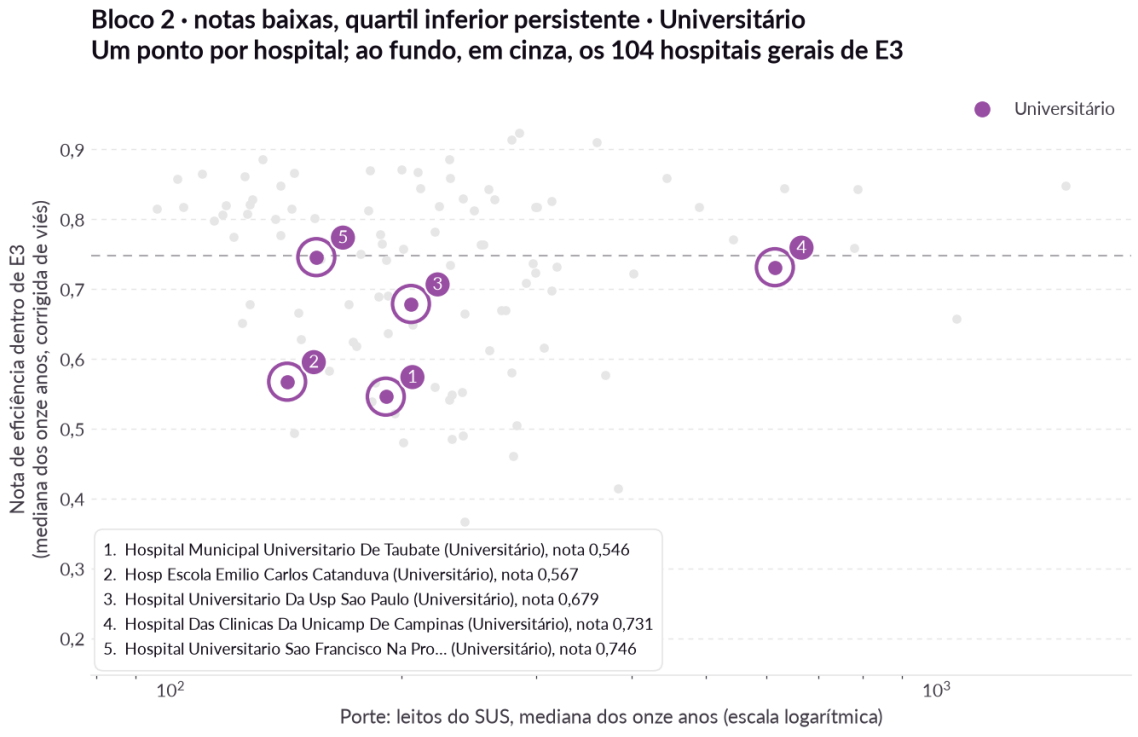


Figura 73: Bloco 2, hospital universitário: as cinco notas baixas da rede, três delas completadas pela ordem da nota. A entrevista com esta rede é **optativa** (ver a Apresentação e método).

4.3.4 Bloco 3: os pares casados dentro da mesma rede

Par	Papel	Hospital	Município	Leitos	Nota
OSS					
1	âncora	Hospital Municipal M'Boi Mirim	São Paulo	279	0,914
1	contra.	Hospital Geral Santa Marcelina de Itaim Paulista	São Paulo	297	0,737
2	âncora	Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	S. J. dos Campos	360	0,911
2	contra.	Conjunto Hospitalar de Sorocaba	Sorocaba	369	0,577
3	âncora	Hospital Geral de Itapecerica da Serra	Itapecerica da Serra	200	0,871
3	contra.	Hospital Geral de Vila Penteado	São Paulo	204	0,564
4	âncora	Hospital Regional de Cotia	Cotia	145	0,867
4	contra.	Complexo Hospitalar Municipal	São Caetano do Sul	154	0,602
5	âncora	Hospital Geral Henrique Altimeyer De Vila Alpina	São Paulo	212	0,845
5	contra.	Complexo Hospitalar Irmã Dulce	Praia Grande	231	0,541
Filantrópico					
1	âncora	Santa Casa De Tupa	Tupa	132	0,886
1	contra.	Santa Casa de Mogi Guaçu	Mogi Guaçu	127	0,679
2	âncora	Santa Casa de São José do Rio Preto	S. J. do Rio Preto	182	0,870
2	contra.	Santa Casa de Barretos	Barretos	185	0,566
3	âncora	Hospital São Vicente de Paulo	Jundiaí	232	0,859
3	contra.	Hospital Santo Amaro	Guarujá	192	0,636
4	âncora	Santa Casa de Rio Claro	Rio Claro	102	0,858
4	contra.	Santa Casa De Pindamonhangaba	Pindamonhangaba	148	0,628
5	âncora	Santa Casa de Franca	Franca	265	0,828
5	contra.	Santa Casa de Araçatuba	Araçatuba	261	0,612
Direta					
1	âncora	Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha	São Paulo	256	0,763
1	contra.	Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio	São Paulo	384	0,415
2	âncora	Hospital Municipal Alípio Corrêa Netto	São Paulo	274	0,670
2	contra.	Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões	Osasco	242	0,367
Universitário (entrevista optativa)					
1	âncora	Hospital e Maternidade Celso Pierro	Campinas	210	0,868
1	contra.	Hospital Universitário da USP	São Paulo	206	0,679
2	âncora	Hospital das Clínicas da FMUSP	São Paulo	1472	0,848
2	contra.	Hospital Municipal Universitário de Taubaté	Taubaté	191	0,546
3	âncora	Hospital de Base de S. J. do Rio Preto	S. J. do Rio Preto	632	0,844
3	contra.	Hospital Escola Emílio Carlos	Catanduva	142	0,567

Cada par é dois hospitais da mesma rede com notas distantes. Os dois têm o mesmo regime, o mesmo tipo de contrato e a mesma fonte de recurso, e por isso o que sobra para explicar o vão entre eles é **como se administra**. É a pergunta que a fase qualitativa pode responder e a quantitativa não.

Como o par é montado. A âncora é cada um dos **cinco primeiros** hospitais de nota alta da rede, e o bloco pede cinco pares em cada uma das quatro redes. O contraponto é o hospital da mesma rede que esteja ao menos **0,15 abaixo** na nota e que seja o mais próximo em leitos SUS, preferindo-se quem tenha o mesmo porte *e* a mesma faixa de complexidade. São **quinze pares**: as cinco âncoras acharam contraponto nas OSS e no Filantrópico, três no hospital universitário e duas na administração Direta. **Treze dos quinze fecham no nível mais exigente**, com o mesmo porte e a mesma faixa de complexidade dos dois lados, e dois fecham sem nenhuma das duas restrições. A diferença mediana de porte dentro do par é de **18 leitos SUS** (mínimo 3, máximo 1.281), e os vãos de nota vão de 0,177 a 0,348.

As cinco âncoras sem par são um achado e não uma falha do desenho: três na administração Direta e duas no hospital universitário. Para elas não existe, dentro da própria rede, hospital que fique 0,15 abaixo na nota. **Na administração Direta isso acontece porque a rede inteira desceu** quando o faturamento saiu da conta, de modo que as notas dela se juntaram embaixo e o vão exigido deixou de caber.

Os pares frouxos se concentram no hospital universitário, e a razão é o tamanho da rede. Dois dos três pares dele fecham sem restrição de porte nem de faixa de complexidade: a âncora é um hospital de porte Especial e faixa 6, e o contraponto que está 0,15 abaixo dela é de

grande porte e faixa 4. **Num dos dois a diferença de porte chega a 1.281 leitos SUS**, e no outro fica em 490. Com treze hospitais no universo, a rede não tem com quem casar melhor, e isso não é defeito de execução: é o que treze hospitais permitem. **Nesses pares, parte do vão pode ser de estrutura**, e a entrevista tem de perguntar isso antes de perguntar sobre operação. **A administração Direta entra com dois pares**, os dois no nível mais exigente, com o mesmo porte e a mesma faixa de complexidade dos dois lados. **Três das cinco âncoras da rede não acham contraponto**, e o motivo é o achado da própria medida: sem o faturamento na conta, as notas da administração direta se juntaram na parte de baixo da escala, e não há, dentro da rede, hospital que fique 0,15 abaixo da âncora. **O bloco de pares da Direta ficou menor, e isso é informação e não falha**: uma rede cujos hospitais se parecem tanto entre si não oferece contraste interno para casar.

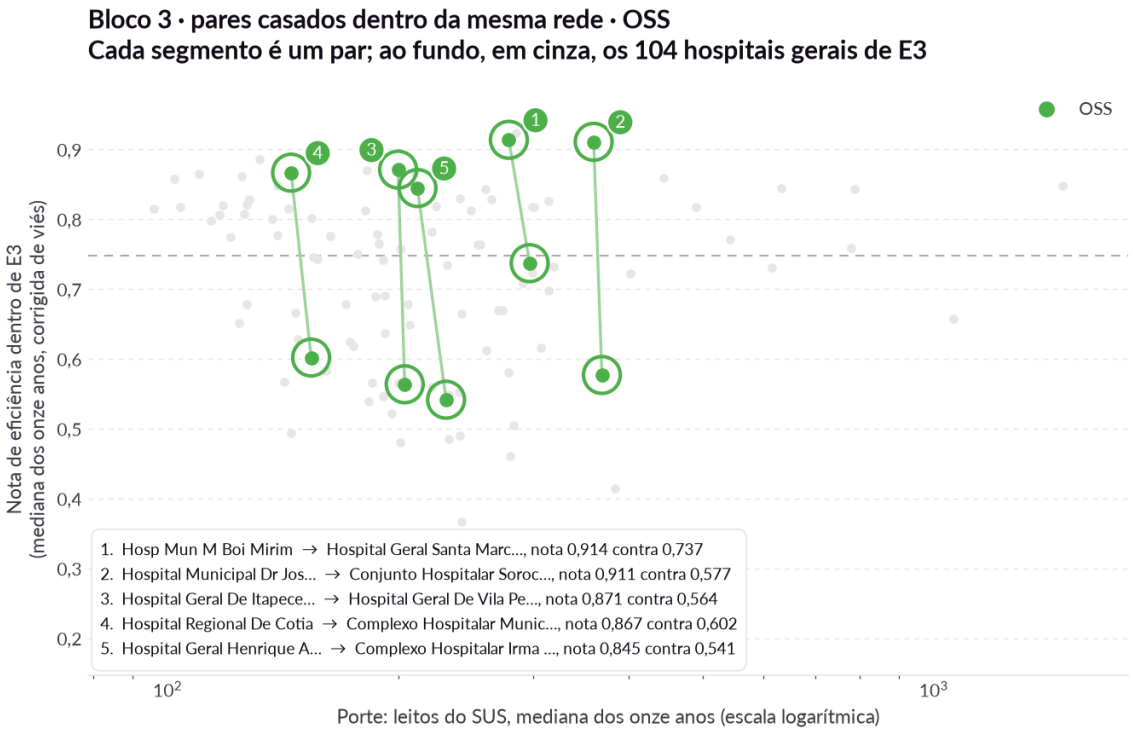


Figura 74: Bloco 3, OSS: os cinco pares casados. Cada segmento liga a âncora ao seu contraponto, e o número fica na âncora.

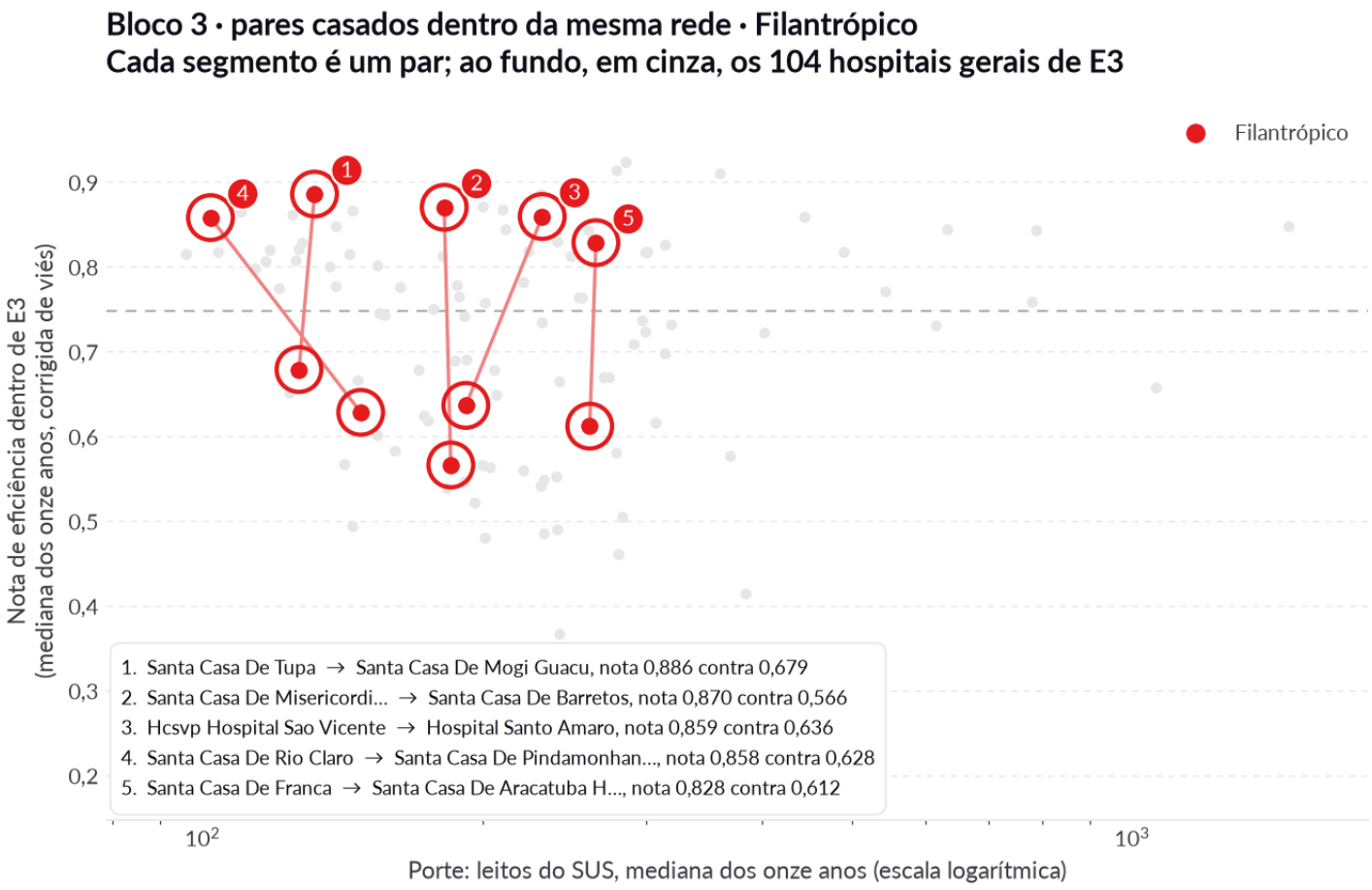


Figura 75: Bloco 3, Filantrópico: os cinco pares casados.

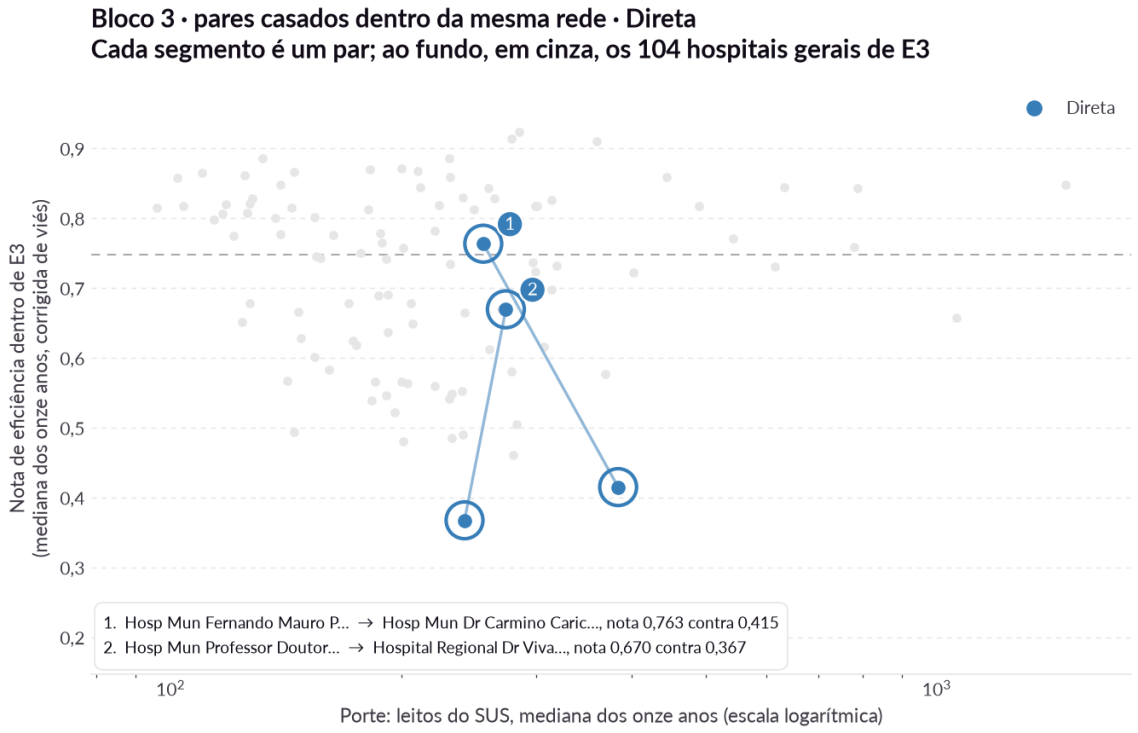


Figura 76: Bloco 3, administração Direta: os dois pares casados, um deles no nível mais exigente (mesmo porte e mesma faixa de complexidade). As outras três âncoras não acham contraponto na própria rede.

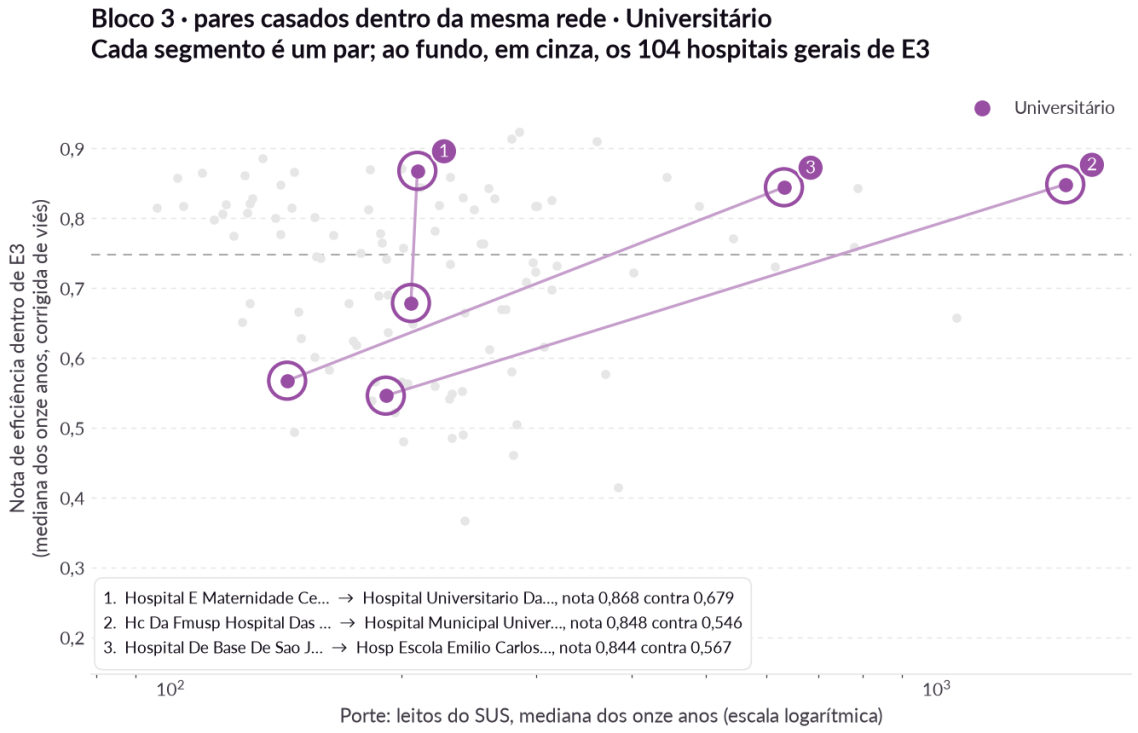


Figura 77: Bloco 3, hospital universitário: os três pares casados, dois deles sem o mesmo porte nem a mesma faixa de complexidade. A entrevista com esta rede é **optativa** (ver a Apresentação e método).

O que o par casado pergunta é o que sobra quando a estrutura é controlada por construção: dois hospitais do mesmo grupo, da mesma rede e, nos doze pares que fecham no nível mais exigente, da mesma faixa de porte, com notas separadas por mais de 0,15. Se a diferença não é de material nem de modelo de gestão, é de operação, de financiamento ou de demanda local, e é isso que a entrevista vai atrás. O módulo de roteiro correspondente (D) está no Apêndice C, com os demais.

5 Síntese e Conclusão geral

Esta seção reúne o que o documento sustenta e separa isso do que ele apenas sugere. Recolhe os achados das seções anteriores, ordena cada um pela firmeza da evidência que o apoia e diz, para cada um, que decisão de gestão ele autoriza e qual não autoriza. Registra também o que ficou fora do alcance dos dados disponíveis. O que ela não faz é introduzir resultado novo: tudo o que aparece aqui foi estimado, testado e discutido antes, e esta não é a seção onde uma estimativa entra sem ter passado pelo crivo das anteriores.

Este documento perseguiu uma única pergunta ao longo de todas as suas seções: entre os quatro arranjos institucionais que administram os hospitais do SUS no estado de São Paulo (**Filantrópico, OSS, Administração Direta e Universitário**), algum entrega desempenho sistematicamente melhor nos cinco indicadores oficiais do estudo, com a taxa de ocupação desdobrada em internação e UTI, como explica a introdução? A resposta foi construída sobre o painel definitivo ali descrito: **275 hospitais acompanhados ano a ano de 2015 a 2025, 3.025 observações balanceadas**, destilado por um funil auditável a partir de 830 estabelecimentos da base bruta do SIH/SUS. A conclusão honesta é que a resposta depende radicalmente de qual pergunta se faz, se quem opera mais intensamente, quem é mais eficiente ou quem *causa* melhor desfecho ao mudar de gestão, e que a evidência é forte para umas e frágil para outras. Esta seção amarra o que as anteriores estabeleceram: o retrato da rede inteira (Seção 1), a comparação entre hospitais equivalentes (Seção 3) e o que as conversões mostram, e o que não mostram (Subseção 3.7).

O que a fase descritiva estabeleceu. A metade exploratória do documento mapeou o terreno antes de qualquer modelo. Fixou os moldes estatísticos de cada indicador (Seção 1.2.2), retratou o perfil bruto de cada categoria de gestão em medianas e boxplots (Seção 1.3) e mostrou que as redes diferem tanto em desempenho quanto naquilo que as torna comparáveis, a complexidade e o porte (Seção 1.4). Duas ressalvas atravessam toda essa leitura e valem para o documento inteiro. A primeira é que a categoria de gestão de cada hospital segue a classificação assistencial do SIH adotada operacionalmente pela equipe, e **não um cruzamento institucional depurado** caso a caso: é uma definição de trabalho, não um cadastro jurídico. A segunda é que todo contraste descritivo entre categorias reflete o **desempenho médio de quem está em cada rede**, e não o efeito causal limpo do modelo de gestão, pois hospitais não são sorteados para uma administração ou outra, e as redes diferem de partida em porte, complexidade e vocação assistencial. Os números descritivos situam; não julgam.

Uma terceira ressalva vale para a ocupação de UTI (apenas hospitais com leito de UTI SUS cadastrado; ver Seção 1.3). A consequência que alcança a conclusão é esta: o Filantrópico tem a UTI mais cheia da rede entre os hospitais que têm UTI, e ao mesmo tempo a maior proporção de hospitais sem UTI nenhuma (Seção 1.3). São dois fatos distintos, e somá-los num indicador único confundiria não usar bem a UTI com não ter UTI.

O que a fase inferencial sustenta. O placar por indicador, com a firmeza de cada achado, está no sumário executivo. O que esta seção acrescenta é o registro de *quanto* cada resultado foi submetido a teste, que é o que autoriza a leitura acima.

Os dois traços firmes das OSS foram medidos entre hospitais distintos, e não em conversão. O regime assistencial mais intenso reaparece em todos os métodos, e sobretudo naquele que o separa dos conversores: o contraste entre redes, medido só entre hospitais distintos, é de **44,7%** a mais de produção e **22,0%** a menos de permanência de internação, os dois com folga suficiente para descartar o acaso. A maior eficiência produtiva é da mesma natureza: na rede inteira, descontados complexidade, porte e ano, as Organizações Sociais ficam **mais perto da fronteira do que a média das quatro redes**, e a administração Direta, mais longe; o Filantrópico e o hospital universitário ficam onde a média está. **A posição das OSS não atravessa o desconto de gravidade**: posta no modelo a intensidade com que cada hospital usa a UTI, só a da administração Direta continua separada.[7]

Esse número é da rede inteira, e ele não sobrevive ao recorte que torna os hospitais comparáveis. No grupo de maior capacidade instalada, que é onde o veredito deste documento

[7] A variante desta segunda etapa *sem os conversores* foi rodada, mas não é citada aqui como resultado corrente.

se forma e que reúne 120 hospitais nas quatro redes, a distância das Organizações Sociais até a média das redes comparadas deixa de se separar do acaso, e o que resta afirmável é a desvantagem da administração direta. A diferença entre os dois resultados não é de método: é de quem está sendo comparado com quem. **Sobre a taxa de ocupação, uma ressalva acompanha o traço**: no painel como um todo a operação acima da capacidade cadastrada é episódica, e nas OSS não, onde atinge 66,1% dos hospitais por uma mediana de 4 dos onze anos. Isso é compatível tanto com pressão assistencial persistente quanto com capacidade habilitada defasada da operada, e os dados não decidem entre as duas (Seção 3).

Limitações do projeto como um todo. Para além das ressalvas técnicas discutidas seção a seção, quatro limitações operam no nível do projeto e condicionam toda leitura dos resultados. A primeira, e a mais importante, é que **toda a identificação causal repousa em apenas quatro conversores**, três deles com um único ano de dados após a mudança de gestão, uma base estreita para qualquer afirmação de efeito, por mais cuidadosa que seja a metodologia. A segunda é que o painel, por construção, retém apenas hospitais com mediana de leitos superior a 50, o que **limita a generalização para hospitais menores**, ausentes do estudo. A terceira é a **janela temporal ainda curta** para os hospitais convertidos em 2025, cujo pós-tratamento se resume a um único ano e não permite ver a trajetória se estabilizar. A estas soma-se uma quarta, de natureza diferente: **as quatro conversões não são casos limpos**, e os quatro defeitos que as comprometem estão enumerados um a um na Subseção 3.7. O desenho mede menos o efeito do modelo de gestão em abstrato do que o que aconteceu nestes quatro hospitais específicos.

Contribuição. Com essas fronteiras claras, o que o projeto entrega é, ao que se sabe, o **primeiro comparativo institucional abrangente do estado de São Paulo**, e não apenas da Região Metropolitana, a reunir, sobre o mesmo painel, três camadas metodológicas que raramente convivem: a **estimação causal** (efeitos aleatórios correlacionados de Mundlak, estudo de eventos, o estimador de Callaway e Sant'Anna e controle sintético), a **análise de eficiência** (DEA com correção de viés) e a **validação por modelos hierárquicos**, que tratam os onze anos de cada hospital como parentes e estimam um efeito próprio para cada um. Mais do que o arsenal, a contribuição está no cuidado metodológico explícito de **não confundir efeito de gestão com efeito de trajetória de conversão**, distinção que, aplicada à mortalidade, inverteu a leitura ingênua dos dados brutos e é provavelmente o achado mais consequente do trabalho.

Onde há evidência, e onde não há. Separando os hospitais em três estratos por capacidade instalada (sem UTI, com UTI e escore Barcelona abaixo de 4, com UTI e escore Barcelona 4 ou mais), **apenas um dos três sustenta comparação entre redes** (Seção 3). Nos outros dois, a administração Direta tem 5 e 11 hospitais contra 6 e 13 das OSS: em E1 as duas ficam abaixo do piso de dez hospitais que este documento exige de uma célula para lê-la, e em E2, que já passa do piso, o que mantém o veredito fora dali é a definição do estrato, que reúne hospitais de menor capacidade instalada. No estrato comparável, os achados centrais se mantêm: o tempo de permanência é **menor nas OSS** (5,155 dias contra 5,650 na administração Direta) e a mortalidade, **1,1 ponto menor**, de 6,7% na administração Direta para 5,6% nas OSS, com margem de 0,3 a 2,0 pontos. **Nos dois a separação é estreita**: no tempo de permanência a faixa da administração Direta passa do valor das OSS por cinco milésimos de dia, e na mortalidade, por três décimos de ponto (Tabela 15). O faturamento segue sem diferença. **A linha da mortalidade ali não contradiz o parágrafo acima, e precisa ser lida com a mesma ressalva**: o coeficiente é do modelo que controla a complexidade Barcelona, é identificado pelos mesmos três conversores presentes no estrato, e a diferença bruta de mortalidade entre as redes dentro dele **não é citável**, por estar em parte comprada por composição de casuística (Seção 3). A segmentação mostra onde há comparação viável; ela não converte o achado de mortalidade em efeito de rede.

O achado mais forte foi medido duas vezes, e as duas medidas concordam. A intensidade de uso da UTI foi apurada por dois caminhos diferentes, com recortes distintos de quais hospitais entram na conta: **11,1% acima da administração Direta** na comparação da Subseção 1.8, citada mais acima, e **10,8%** no contraste entre redes da segunda fase, com margem de −1,4% a +24,5%. **As duas concordam até a casa das unidades, e as duas comportam não haver diferença**; as decisões de cálculo por trás delas estão declaradas na Subseção 1.8.1.

Direções futuras. Três frentes dão continuidade natural à pesquisa. A primeira é a **fase qualitativa de entrevistas**, cuja seleção de entrevistados e roteiro completo já constam da Seção 4, com o roteiro-base e os módulos no Apêndice C: as entrevistas semiestruturadas ali desenhadas são dirigidas a investigar o mecanismo por trás do efeito no tempo de permanência, pois, se ele é real, algo na gestão por OSS encurta a internação, e entender o quê é o passo que os dados administrativos não alcançam. A segunda é o acúmulo de **novos anos de dados**, sobretudo para os três hospitais convertidos em 2025, o único caminho para transformar a evidência dentro do hospital, hoje sugestiva, em conclusão. A terceira é o **ajuste de gravidade**: o escore estrutural de complexidade é um substituto de estrutura para uma variável clínica, e qualquer avanço na direção de uma medida de gravidade do caso (por classificação de procedimentos, por diagnóstico principal ou por dado externo ao SIH) melhoraria diretamente a comparabilidade entre hospitais em todas as análises de mortalidade.

Uma palavra final de cautela. Dois pontos exigem alerta expresso. Primeiro, **nada aqui autoriza a afirmação de que a gestão por OSS reduz a mortalidade**: o controle sintético não encontra descolamento significativo no único conversor testável, a comparação entre redes sem os conversores é nula, e citar a queda bruta seria trair o próprio achado central do trabalho. Segundo, toda a identificação causal apoia-se em **quatro hospitais convertidos**, uma base estatística frágil por natureza. Por isso, os achados deste documento **não devem ser usados isoladamente por gestores públicos para justificar decisões de modelo de gestão** sem o contexto metodológico que os cerca.

E fica dito o que este documento não separou. O crescimento que as três aberturas imprimem em número bruto é real e está medido. Separar dele a parte que uma política explica é outra pergunta, que exige comparação com quem a política **não alcançou**, e é isso que a Seção 2 faz.

O que fica para a leitura do documento. A segunda fase não altera nenhuma conclusão; ela redistribui os pesos, e a linha por onde ela os redistribui tem nome: **o que é medido *entre* hospitais distintos ficou onde estava; o que é medido *dentro* do hospital que trocou de gestão perdeu precisão.**

Entre redes, dos três traços de regime operacional só um mantém a folga. A produção é 44,7% maior nas OSS (margem de +17,8% a +77,8%); já a taxa de ocupação de internação fica 10,1% maior (de −6,3% a +29,3%) e a intensidade de uso da UTI 10,8% maior (de −1,4% a +24,5%), as duas com margem que comporta não haver diferença. O tempo de permanência entra no lugar delas: 22,0% menor, de −30,4% a −12,7%. A eficiência produtiva acompanha: na segunda etapa da rede inteira as OSS ficam **mais perto da fronteira do que a média das quatro redes**, descontados complexidade, porte e ano, e essa posição se desfaz quando a gravidade dos casos entra no modelo. **São esses quatro números que autorizam chamar o regime operacional das OSS de traço firme da rede**, e não a repetição do achado em várias amostras.[8]

Dentro do hospital, nenhum dos sete contrastes se separa do acaso. O **TMP menor** reaparece com o mesmo tamanho neste segundo modelo (−6,8%, exatamente como no principal), o que confirma que o resultado não depende da forma do modelo; o que ele não tem é margem que sustente a diferença, e os três testes mais exigentes seguem sem confirmá-lo, porque com quatro conversores, e um só com histórico posterior utilizável, eles não têm força para confirmar nem para desmentir. O **faturamento** segue sem diferença em qualquer método (+2,0%, margem de −10,6% a +16,5%). E a **mortalidade menor** concentra-se inteiramente na trajetória dos quatro conversores: medida entre redes a taxa vai de 5,6% na administração Direta a 6,3% nas OSS, com

[8] O quadro completo de variantes por amostra (sem o biênio pandêmico, sem os conversores e no suporte comum) foi rodado, mas não é citado aqui como resultado corrente.

margem de 4,7% a 8,3%, o que a aproxima das ressalvas causais da Subseção 3.7 e a afasta de uma leitura de superioridade da rede OSS nesse desfecho.

6 Material de apoio

A Os hospitais por trás de dois números da Seção 1.2

A Seção 1.2 publica dois percentuais que descrevem *ausência de serviço*: **31,8%** das observações de hospital e ano não registram nenhuma internação de alta complexidade, e **22,1%** são de hospital sem leito de UTI do SUS cadastrado. Percentual, porém, não diz *quem*, e quem lê este documento dentro da rede quer saber de quem se está falando. Este apêndice nomeia os dois grupos.

O critério das duas listas é o mesmo, e é o mais exigente possível: entra o hospital cuja contagem é **zero nos onze anos**, de 2015 a 2025, sem uma única exceção. Quem zera em alguns anos e não em outros fica *fora* das listas, porque zerar num ano é outro fenômeno: na alta complexidade, um ano sem procedimento; na UTI, um cadastro que se suspende sem que a ala feche. Os que oscilam estão contados no texto de cada subseção, e não escondidos.

Nas duas tabelas, o nome é o do cadastro (nome fantasia do CNES), o município é o da última competência e os leitos SUS são a mediana dos onze anos.

A.1 Os 35 hospitais que nunca registram alta complexidade

Dos 275 hospitais do painel, **129 têm ao menos um ano sem nenhuma internação de alta complexidade**, e é essa intermitência que produz os 31,8% de observações em zero. Mas **35 deles nunca registram uma única internação de alta complexidade em onze anos**: aqui não é ano fraco, é perfil assistencial. Por rede são **22 Filantrópicos, 7 da administração Direta e 6 sob gestão de OSS**, e 21 dos 35 estão na faixa 2 de complexidade, a mais baixa.

A Seção 1.4 descreve o grupo em detalhe e o resultado é coerente de ponta a ponta: comparados com os outros 240 hospitais, eles têm metade dos leitos, produzem pouco mais de um terço das internações por ano e faturam menos da metade por saída. Juntos respondem por 4,6% da produção do painel. É pouco no agregado, e é tudo o que existe em boa parte dos municípios da lista abaixo.

Tabela A.1: Os 35 hospitais sem nenhuma internação de alta complexidade registrada entre 2015 e 2025. Leitos SUS é a mediana dos onze anos.

Hospital	Município	Rede	Leitos SUS
Hospital Amparo Maternal	Sao Paulo	Filantrópico	94
Hospital Angatuba	Angatuba	Filantrópico	54
Hospital da Mulher Maria Jose dos Santos Stein	Santo Andre	OSS	92
Hospital de Clinicas Campo Limpo Paulista	Campo Limpo Paulista	OSS	56
Hospital de Misericordia Nossa Senhora Aparecida	Presidente Bernardes	Filantrópico	40
Hospital de Piraju	Piraju	Filantrópico	51
Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros Sao Paulo	Sao Paulo	Direta	147
Hospital e Maternidade Municipal de Sao Vicente	Sao Vicente	Direta	36
Hospital Estadual de Caieiras	Caieiras	Direta	46
Hospital Estadual Dr Odilo Antunes de Siqueira P Prudente	Presidente Prudente	OSS	47
Hospital Estadual Porto Primavera Rosana	Rosana	OSS	72
Hospital Maternidade Amador Aguiar	Osasco	Direta	155
Hospital Maternidade Interlagos	Sao Paulo	Direta	75
Hospital Municipal de Emergencias Albert Sabin	Sao Caetano Do Sul	OSS	48
Hospital Municipal de Ibiuna Ibiuna Sp	Ibiuna	OSS	63
Hospital Regional de Teodoro Sampaio	Teodoro Sampaio	Filantrópico	52

continua na página seguinte

Hospital	Município	Rede	Leitos SUS
Hospital Sao Francisco de Americana	Americana	Filantrópico	8
Hospital Sao Joao Registro	Registro	Filantrópico	68
Hospital Sao Luiz	Boituva	Filantrópico	36
Hospital Sao Miguel Arcanjo	Sao Miguel Arcanjo	Filantrópico	54
Instituto Lauro de Souza Lima Bauru	Bauru	Direta	63
Santa Casa de Caconde	Caconde	Filantrópico	62
Santa Casa de Guariba	Guariba	Filantrópico	59
Santa Casa de Jose Bonifacio	Jose Bonifacio	Filantrópico	28
Santa Casa de Junqueiropolis	Junqueiropolis	Filantrópico	25
Santa Casa de Misericordia de Pedregulho	Pedregulho	Filantrópico	55
Santa Casa de Misericordia de Tiete	Tiete	Filantrópico	33
Santa Casa de Monte Aprazivel	Monte Aprazivel	Filantrópico	30
Santa Casa de Nova Granada	Nova Granada	Filantrópico	19
Santa Casa de Pederneiras	Pederneiras	Filantrópico	52
Santa Casa de Presidente Epitacio	Presidente Epitacio	Filantrópico	68
Santa Casa de Santo Anastacio	Santo Anastacio	Filantrópico	37
Santa Casa de Tanabi	Tanabi	Filantrópico	30
Santa Casa Piedade	Piedade	Filantrópico	59
Unidade Mista de Saude de Taboao da Serra	Taboao Da Serra	Direta	57

A.2 A alta complexidade e o seu complemento, por porte

As quatro figuras a seguir detalham, por porte, o que a Seção 1.4 resume: quanto de alta complexidade faz quem faz, e o que é a produção de não alta complexidade, que responde por 90,1% de tudo o que estes 275 hospitais produziram em onze anos.

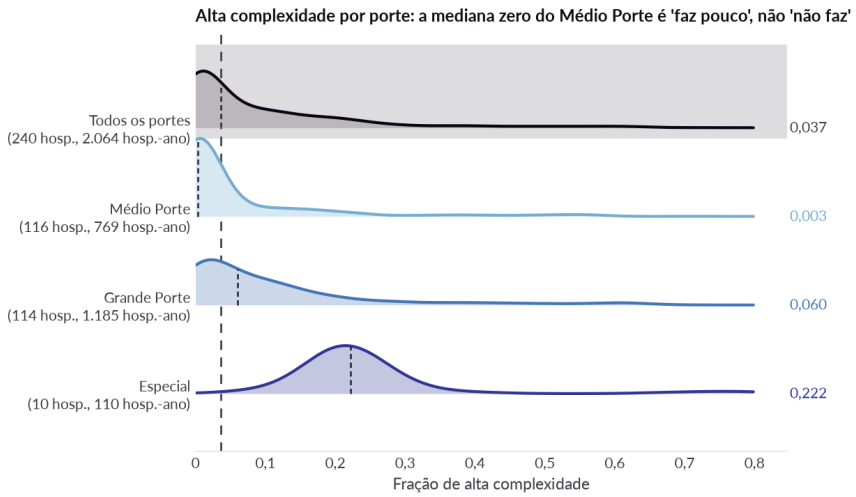


Figura A.1: Quanto de alta complexidade faz quem faz, por porte. Entre os hospitais-ano médios que fazem, a fração típica é de **0,44%** das internações, contra 6,2% no Grande Porte e 22,2% no Especial: pouco, e por isso a mediana do porte inteiro cai a zero. As curvas são **restritas aos hospitais-ano com fração de alta complexidade positiva**, para que os zeros não as puxem para baixo.

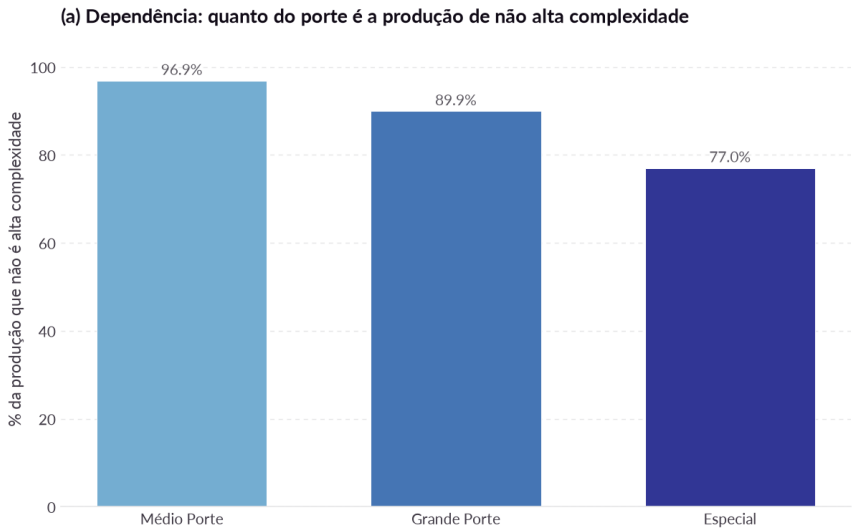


Figura A.2: Quanto da produção de cada porte não é alta complexidade. Mesmo no porte Especial, que é onde a alta complexidade se concentra, **77% das internações são de outra natureza**. O Médio Porte é quase inteiramente produção de não alta complexidade (96,8%), e mesmo o porte Especial tem três quartos da produção nessa faixa. É uma **razão agregada**, e não a média das razões: soma-se o numerador e o denominador do porte inteiro, de modo que cada hospital pesa pelo que produz.

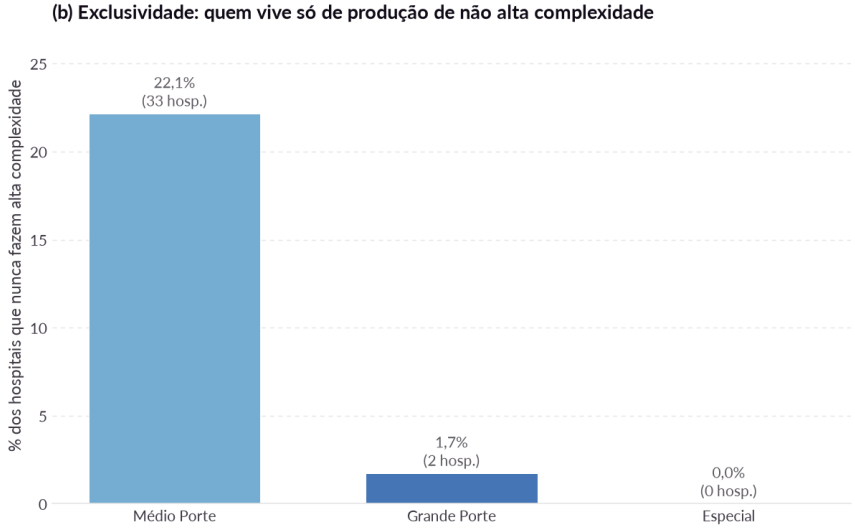


Figura A.3: Quantos hospitais de cada porte vivem exclusivamente de produção de não alta complexidade. São **35 hospitais no painel**, nomeados um a um no Apêndice A.1, e eles formam uma sub-rede com perfil próprio, descrito abaixo. Um em cada cinco hospitais de médio porte nunca registrou uma internação de alta complexidade em onze anos. No Grande Porte são dois, e no Especial, nenhum. O corte é o hospital (CNES) com zero internações de alta complexidade em **todos** os onze anos. A Figura 19 mede o oposto pela mesma régua: lá, quem faz em algum ano; aqui, quem nunca fez.

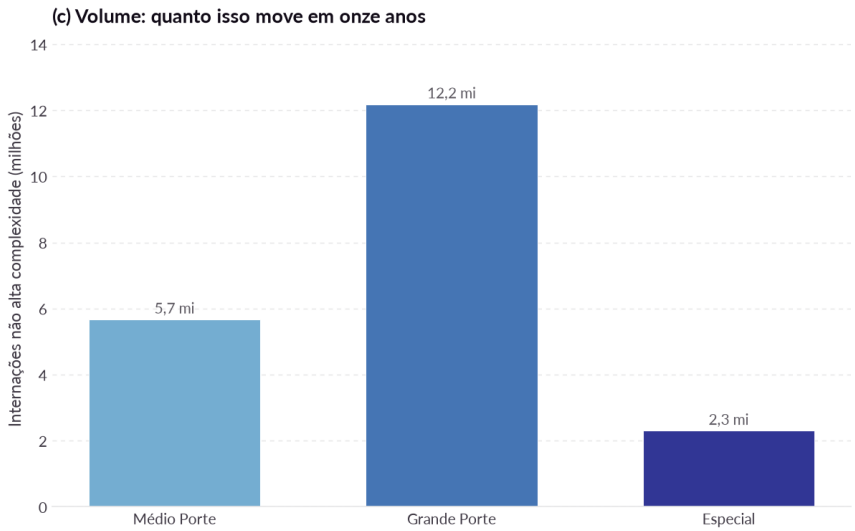


Figura A.4: Volume de internações de não alta complexidade por porte, 2015 a 2025. O Grande Porte move **12,4 milhões** delas, quase o dobro do Médio e cinco vezes o Especial.

A.3 Os 48 hospitais que nunca tiveram leito de UTI do SUS

Aqui a divisão é bem mais nítida do que na alta complexidade. Dos 275 hospitais do painel, **200 têm leito de UTI do SUS cadastrado nos onze anos** e **48 não têm em nenhum deles**. Apenas **27** oscilam entre ter e não ter, e essa oscilação, como mostra a Seção 3, costuma ser cadastro que se suspende (em geral por falta de intensivista), e não ala que fecha.

Isso responde a uma pergunta que o percentual sozinho deixava em aberto. As **668 observações sem UTI** da Seção 1.2 se repartem assim: **528 vêm dos 48 hospitais que nunca tiveram UTI** e as outras **140 vêm dos 27 que oscilam**. Ou seja, quase quatro quintos da ausência de UTI no painel é **estrutural, e não intermitente**: são hospitais que simplesmente não oferecem terapia intensiva ao SUS, em nenhum ano. É exatamente por isso que lançar zero para eles seria erro de leitura, e não arredondamento: zero significa UTI ociosa, e o que existe aqui é ausência de UTI.

Por rede são **42 Filantrópicos, 4 da administração Direta e 2 sob gestão de OSS**. Essa concentração no Filantrópico é o que sustenta a advertência da Seção 1.3: tratar ausência de UTI como ocupação zero penalizaria cada rede na proporção dos hospitais sem UTI que ela carrega, e nenhuma rede carrega tantos quanto a filantrópica. Dois recortes fecham o retrato. **Seis dos 48** mantêm leito de UTI *não* SUS em algum ano, isto é, operam terapia intensiva que não está disponível ao SUS. E **23 dos 48 aparecem também na lista anterior**: são hospitais sem UTI e sem alta complexidade ao mesmo tempo, o núcleo do estrato E1 da Seção 3, dentro do qual, aliás, os 48 estão todos contidos.

Tabela A.2: Os 48 hospitais sem nenhum leito de UTI do SUS cadastrado entre 2015 e 2025. Leitos SUS é a mediana dos onze anos e se refere ao leito de internação, não à UTI.

Hospital	Município	Rede	Leitos SUS
Casa de Caridade Sao Vicente de Paulo Cajuru	Cajuru	Filantrópico	55
Conderg Hospital Regional de Divinolandia	Divinolandia	Filantrópico	186
Hospital Angatuba	Angatuba	Filantrópico	54
Hospital Beneficente Santo Antonio Orlandia	Orlandia	Filantrópico	60
Hospital de Agudos	Agudos	Filantrópico	38
Hospital de Misericordia Nossa Senhora Aparecida	Presidente Bernardes	Filantrópico	40

continua na página seguinte

Hospital	Município	Rede	Leitos SUS
Hospital de Piraju	Piraju	Filantrópico	51
Hospital Dr Adhemar de Barros Apiai	Apiai	Filantrópico	45
Hospital e Maternidade Municipal de Sao Vicente	Sao Vicente	Direta	36
Hospital e Maternidade Sao Jose Barra Bonita	Barra Bonita	Filantrópico	59
Hospital Estadual Porto Primavera Rosana	Rosana	OSS	72
Hospital Municipal de Ibiuna Ibiuna Sp	Ibiuna	OSS	63
Hospital Municipal Dr Acilio Carreon Garcia	Nova Odessa	Direta	53
Hospital Regional de Teodoro Sampaio	Teodoro Sampaio	Filantrópico	52
Hospital Santa Luzia Duartina	Duartina	Filantrópico	77
Hospital Sao Jose de Herculandia	Herculandia	Filantrópico	58
Hospital Sao Luiz	Boituva	Filantrópico	36
Hospital Sao Luiz Gonzaga	Sao Paulo	Filantrópico	157
Hospital Sao Miguel Arcanjo	Sao Miguel Arcanjo	Filantrópico	54
Instituto Lauro de Souza Lima Bauru	Bauru	Direta	63
Santa Casa de Bariri	Bariri	Filantrópico	49
Santa Casa de Caconde	Caconde	Filantrópico	62
Santa Casa de Dois Corregos	Dois Corregos	Filantrópico	47
Santa Casa de Guararapes	Guararapes	Filantrópico	48
Santa Casa de Guariba	Guariba	Filantrópico	59
Santa Casa de Jose Bonifacio	Jose Bonifacio	Filantrópico	28
Santa Casa de Junqueiropolis	Junqueiropolis	Filantrópico	25
Santa Casa de Miguelopolis	Miguelopolis	Filantrópico	47
Santa Casa de Misericordia de Francisco Morato	Francisco Morato	Filantrópico	85
Santa Casa de Misericordia de Itarare	Itarare	Filantrópico	53
Santa Casa de Misericordia de Osvaldo Cruz	Osvaldo Cruz	Filantrópico	58
Santa Casa de Misericordia de Palmital	Palmital	Filantrópico	36
Santa Casa de Misericordia de Pedregulho	Pedregulho	Filantrópico	55
Santa Casa de Misericordia de Pereira Barreto	Pereira Barreto	Filantrópico	48
Santa Casa de Misericordia de Serrana	Serrana	Filantrópico	42
Santa Casa de Misericordia de Tiete	Tiete	Filantrópico	33
Santa Casa de Misericordia de Ubatuba	Ubatuba	Filantrópico	84
Santa Casa de Monte Aprazivel	Monte Aprazivel	Filantrópico	30
Santa Casa de Nova Granada	Nova Granada	Filantrópico	19
Santa Casa de Porto Feliz	Porto Feliz	Filantrópico	39
Santa Casa de Presidente Epitacio	Presidente Epitacio	Filantrópico	68
Santa Casa de Santo Anastacio	Santo Anastacio	Filantrópico	37
Santa Casa de Tanabi	Tanabi	Filantrópico	30
Santa Casa de Valparaiso	Valparaiso	Filantrópico	31
Santa Casa de Vinhedo	Vinhedo	Filantrópico	62
Santa Casa Piedade	Piedade	Filantrópico	59
Santa Casa Santa Rita do Passa Quatro	Santa Rita Do Passa Quatro	Filantrópico	36
Unidade Mista de Saude de Taboao da Serra	Taboao Da Serra	Direta	57

B Material de apoio da segmentação estrutural

Este apêndice reúne o material que sustenta a Seção 3 sem precisar interrompê-la: as figuras que mostram os três estratos lado a lado, o levantamento das 26 variáveis do painel e as duas leituras de superlotação que a seção cita em forma condensada. Nada aqui contradiz o corpo do texto; é o detalhe que o sustenta.

Os três estratos, indicador a indicador

As seis figuras a seguir mostram a distribuição completa de cada indicador dentro de cada estrato e categoria de gestão. Elas sustentam a afirmação da Seção 3 de que **em cinco dos seis indicadores as medianas ordenam monotonicamente**, E1, depois E2, depois E3.

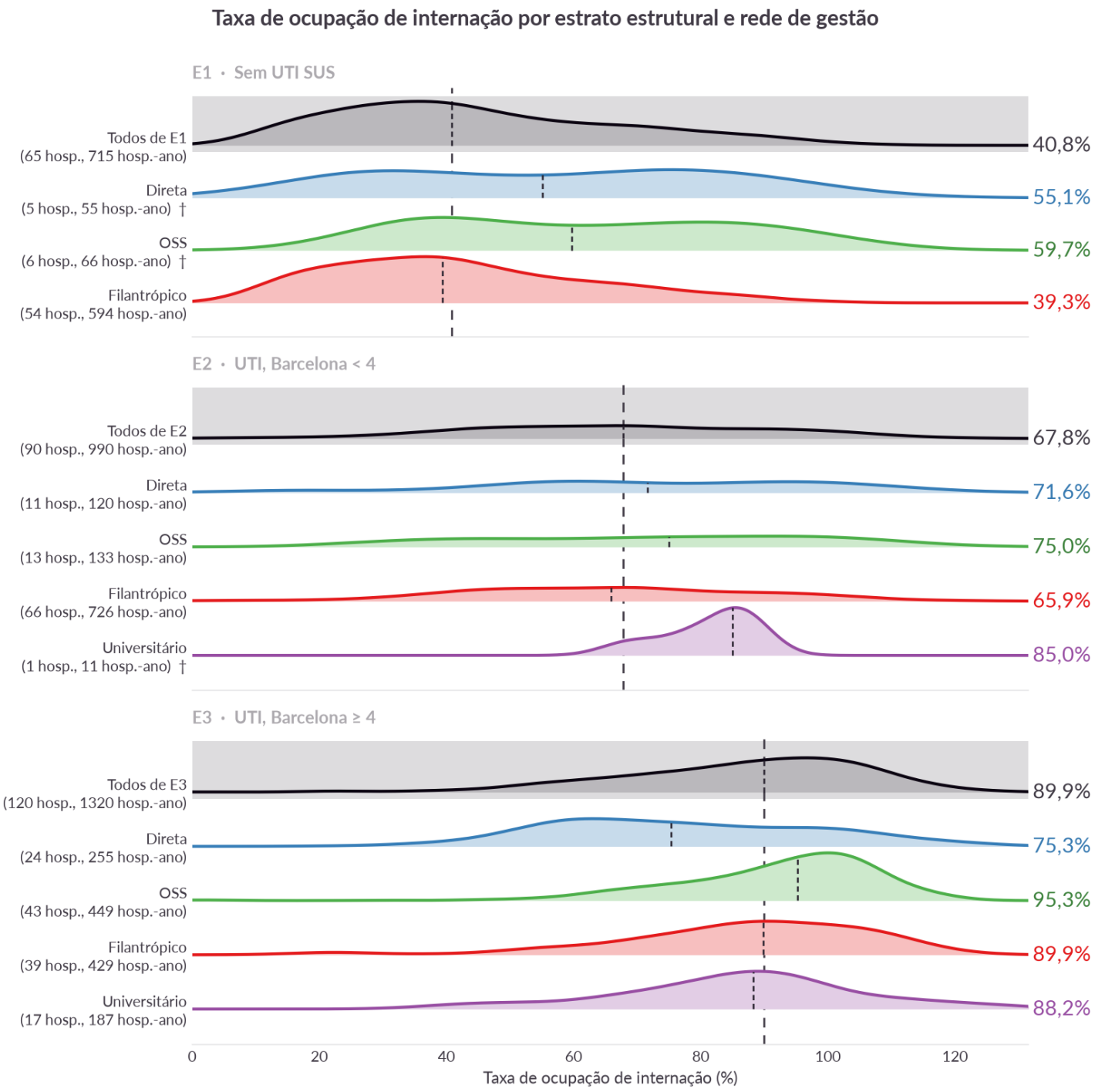


Figura B.1: Taxa de ocupação de internação por estrato estrutural e categoria de gestão. É a figura em que a distância entre as redes mais aparece: dentro do E3, o único com hospitais dos dois lados em número suficiente, a curva das OSS está inteira à direita da administração Direta. **As seis figuras deste grupo se leem do mesmo jeito**: três painéis empilhados, um por estrato, dividindo o mesmo eixo; no alto de cada um, **em preto e sobre faixa cinza**, a curva do **estrato inteiro**, com a tracejada na mediana dele, e abaixo as redes daquele estrato. Para ver se o indicador **ordena**, siga só as três curvas pretas: elas devem avançar para a direita de E1 a E3 sem se sobrepor, e na mortalidade E2 e E3 caem quase no mesmo ponto. Os três painéis são estimados na **mesma janela**; entre parênteses, **quantos hospitais e quantos hospitais-ano** cada curva resume, e o **punhal** (†) marca a célula com menos de dez hospitais, que não sustenta leitura. **Nenhuma observação sai do cálculo**: a janela só decide até onde o quadro mostra. No faturamento a escala é logarítmica, e por isso esse eixo não começa em zero.

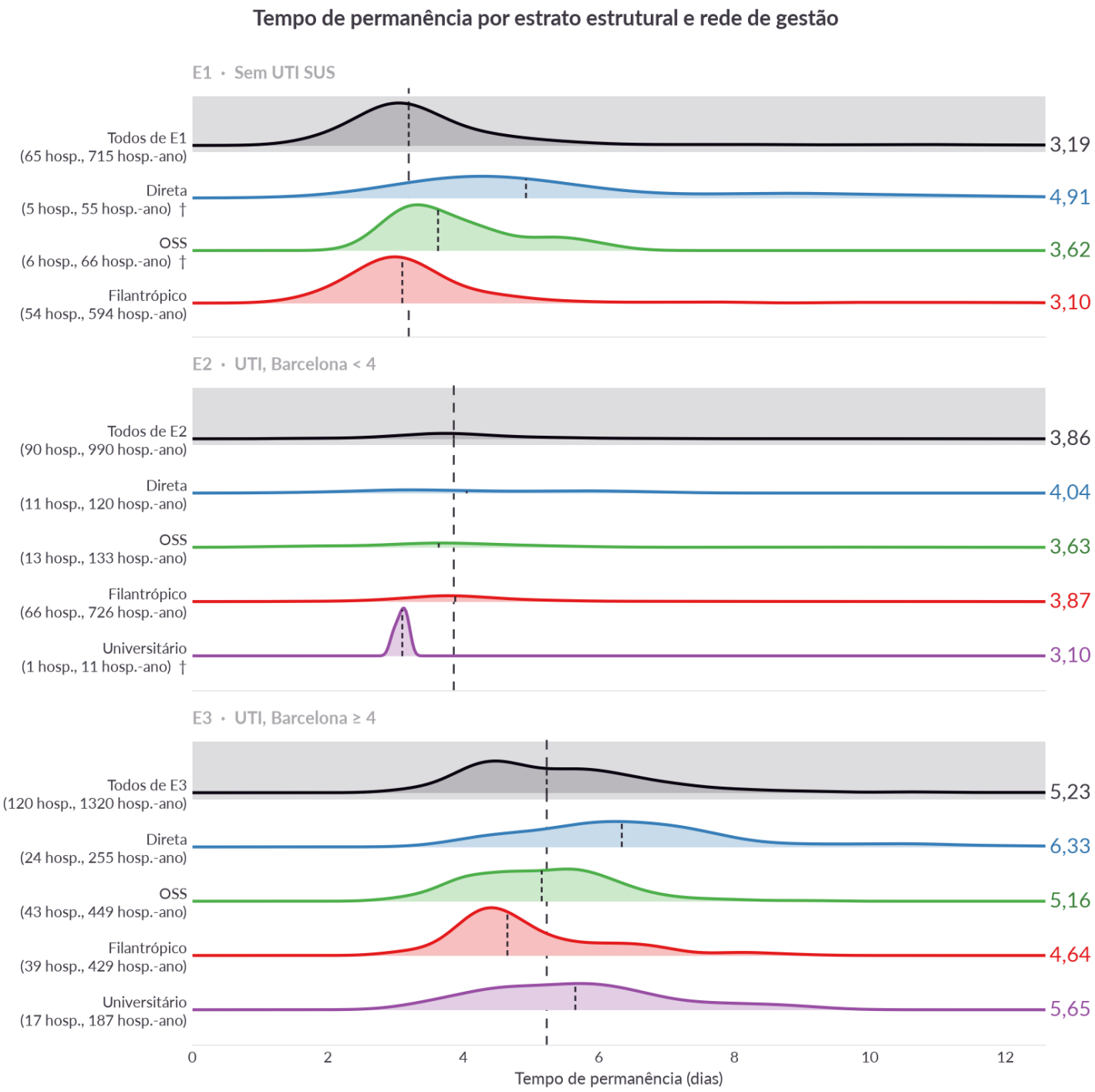


Figura B.2: Tempo médio de permanência por estrato estrutural e categoria de gestão.

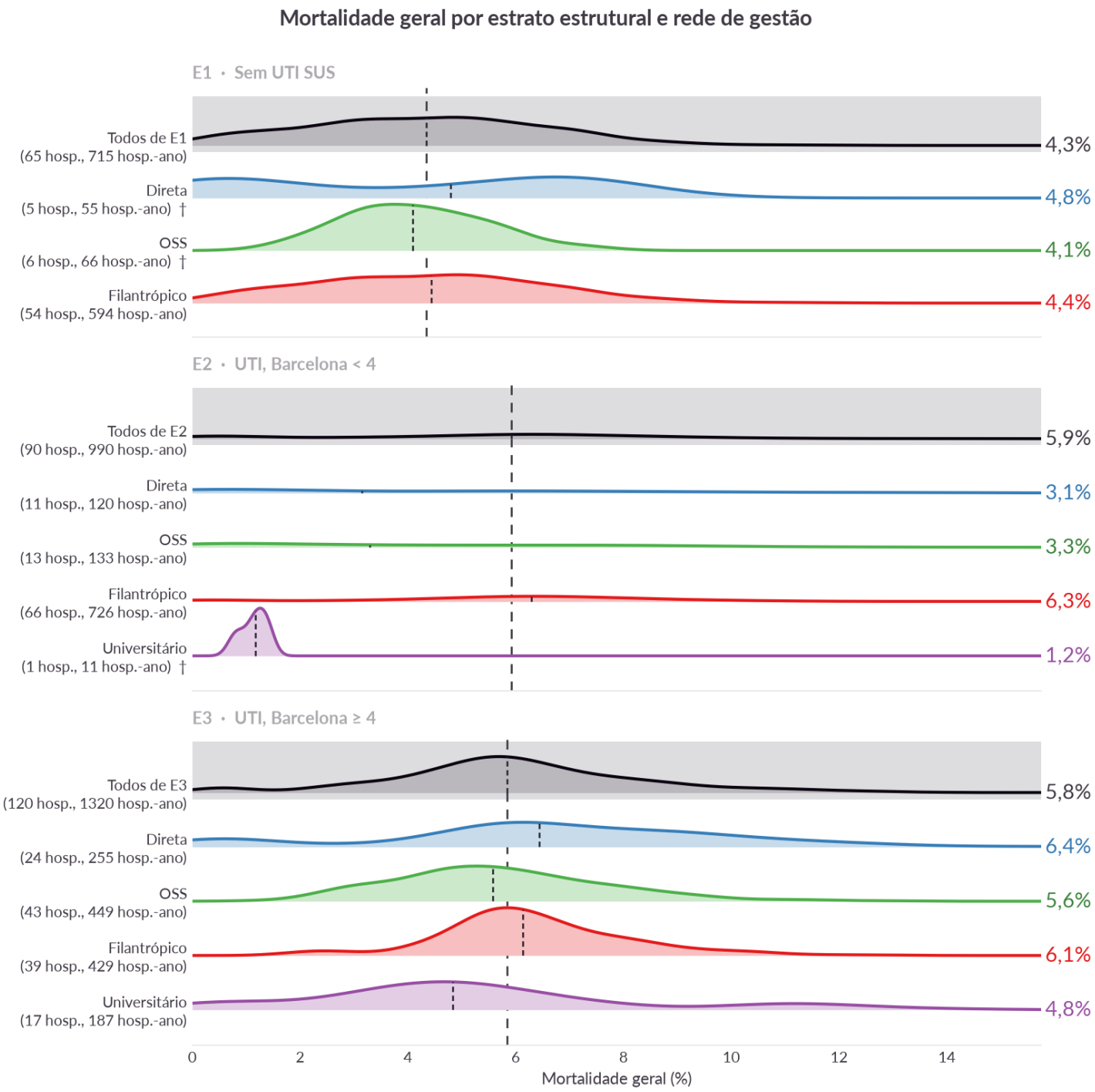


Figura B.3: Mortalidade geral por estrato estrutural e categoria de gestão.

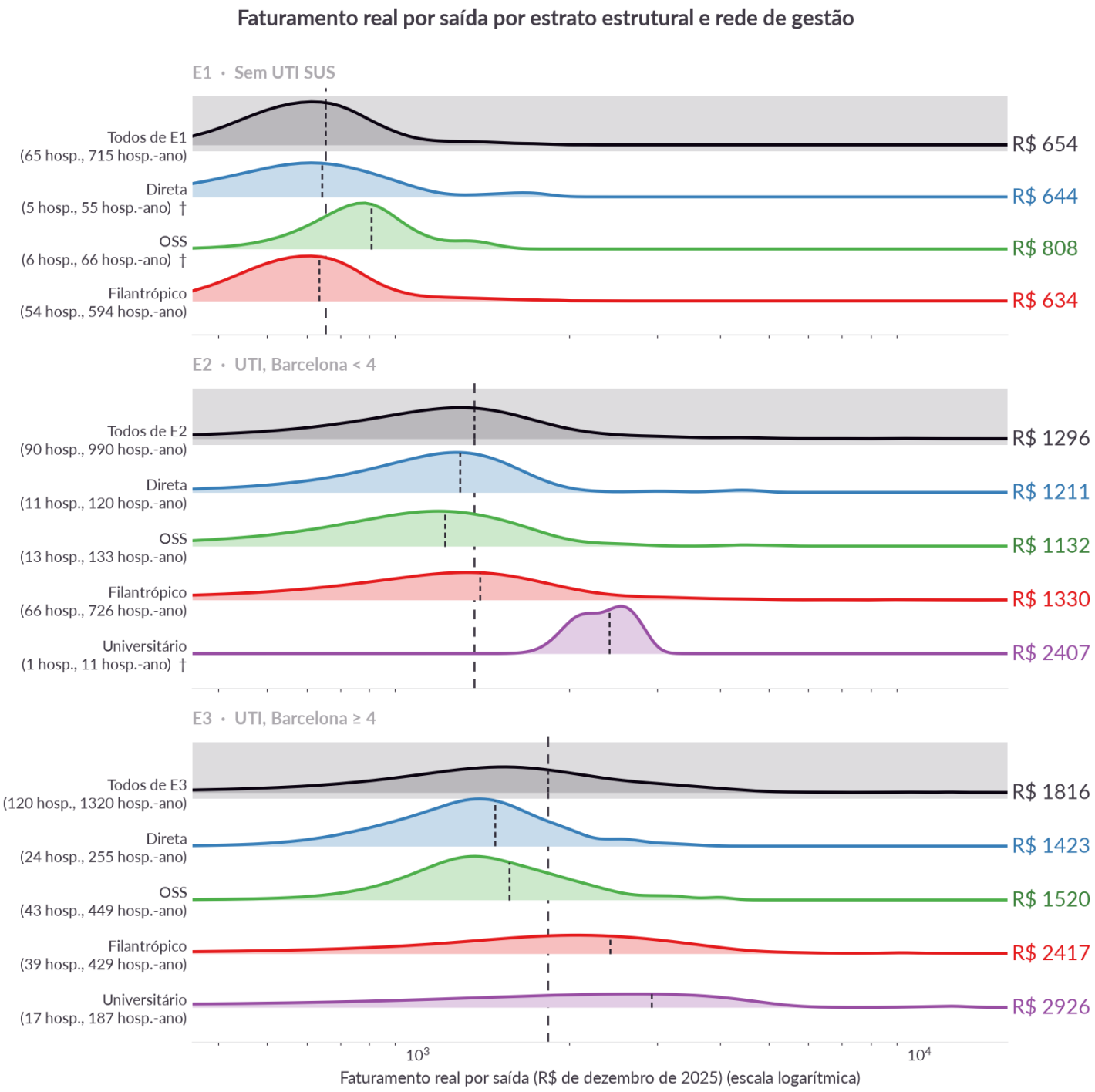


Figura B.4: Faturamento real por saída (R$ de dez/2025) por estrato estrutural e categoria de gestão, em escala logarítmica.

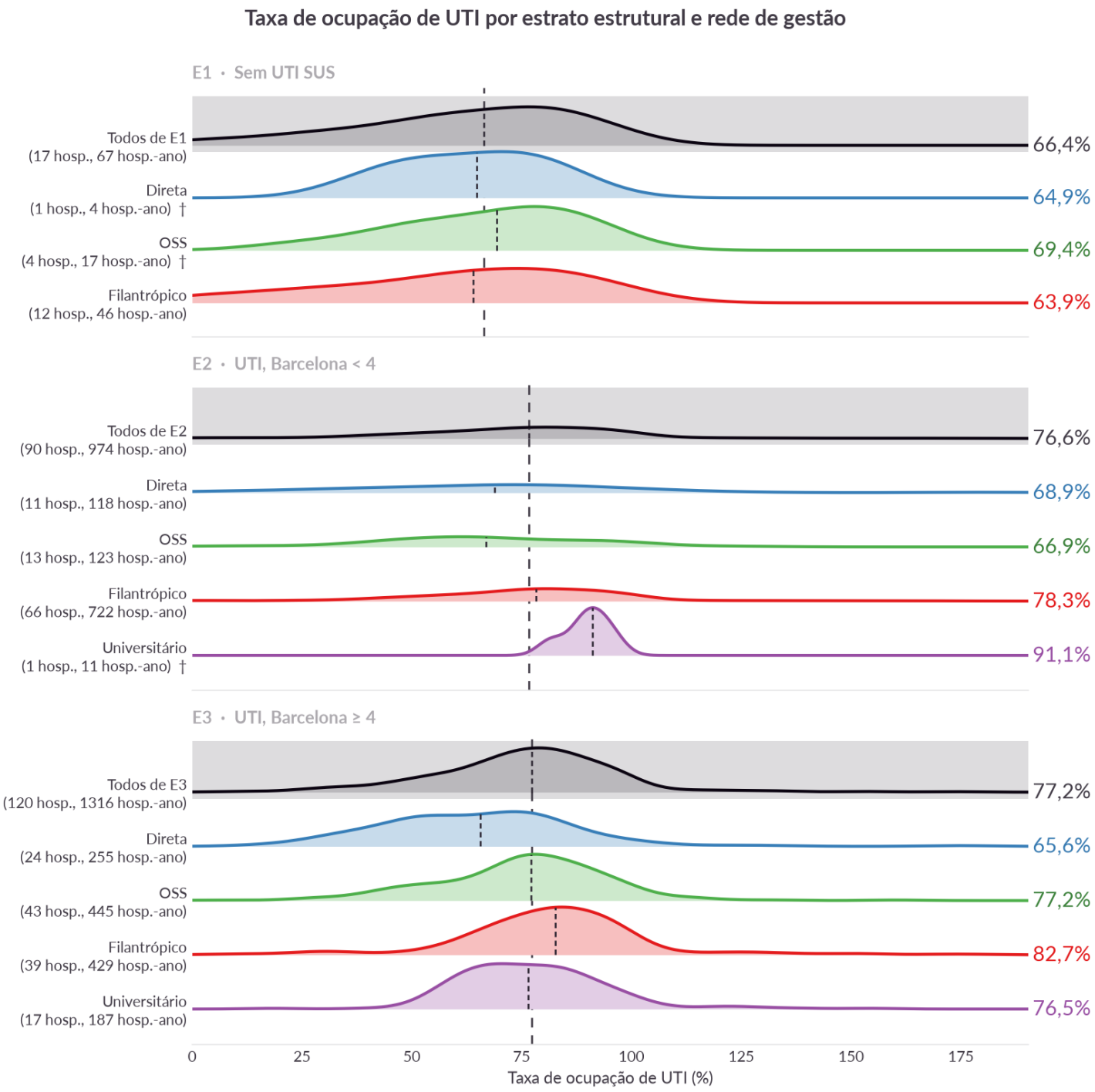


Figura B.5: Taxa de ocupação de UTI por estrato estrutural e categoria de gestão (apenas hospitais com leito de UTI SUS cadastrado; ver Seção 1.3).

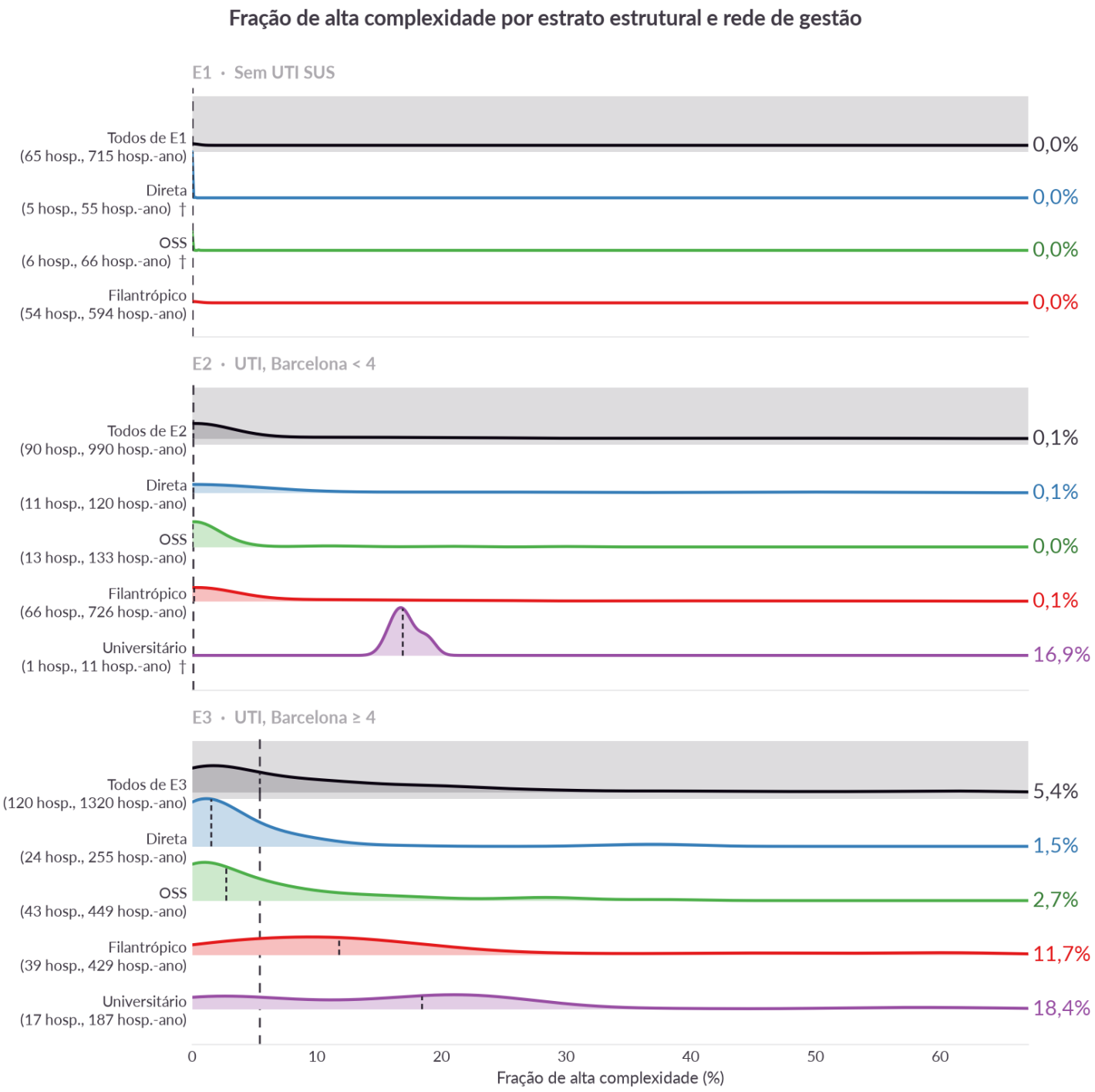


Figura B.6: Fração de alta complexidade por estrato estrutural e categoria de gestão.

Os três estratos ano a ano

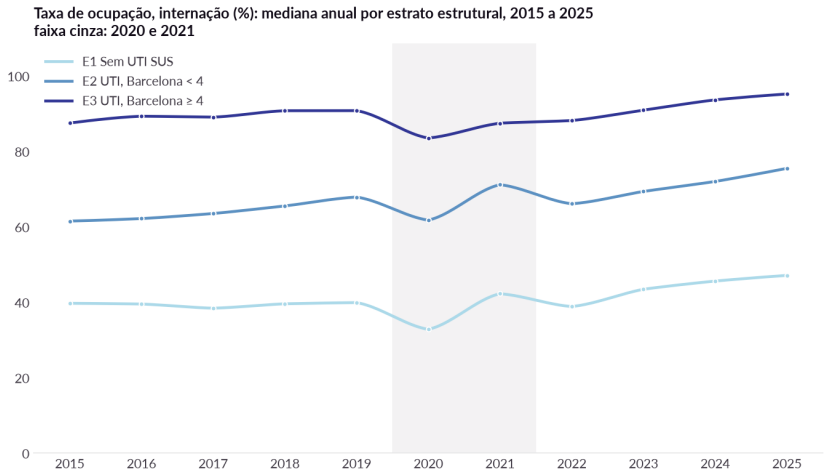


Figura B.7: Taxa de ocupação de internação: mediana anual por estrato estrutural. **Nas seis figuras deste grupo, o que importa é se as três linhas correm separadas a década inteira ou se encostam**: onde correm separadas, o estrato é divisão estável da rede e não retrato de um ano. A unidade é o hospital-ano, e todas as redes entram juntas em cada estrato. A curva de E1 na ocupação de UTI sai tracejada porque ali só existem os 67 hospitais-ano do piscar cadastral.

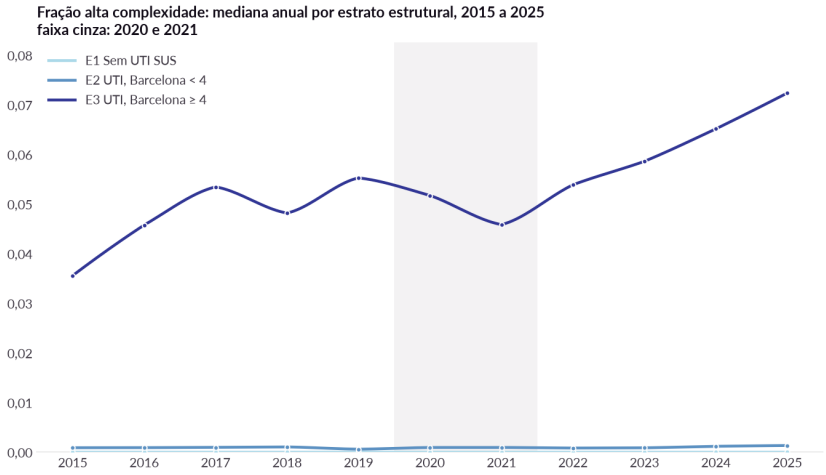


Figura B.8: Fração de alta complexidade: mediana anual por estrato estrutural. As linhas de E1 e E2 correm coladas ao eixo a década inteira: a alta complexidade, na rede paulista, é assunto de E3.

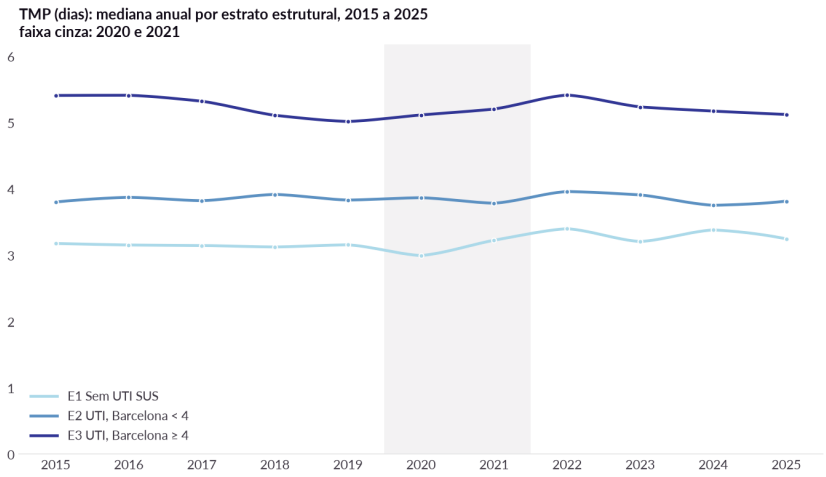


Figura B.9: Tempo médio de permanência: mediana anual por estrato estrutural.

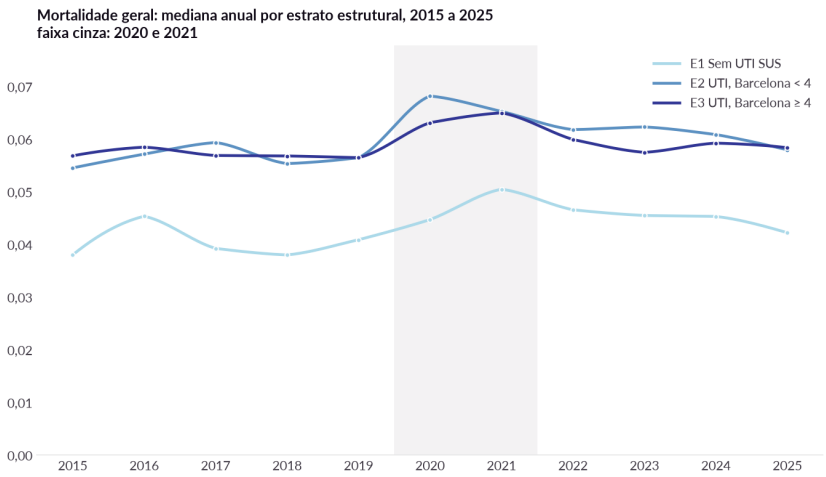


Figura B.10: Mortalidade geral: mediana anual por estrato estrutural.

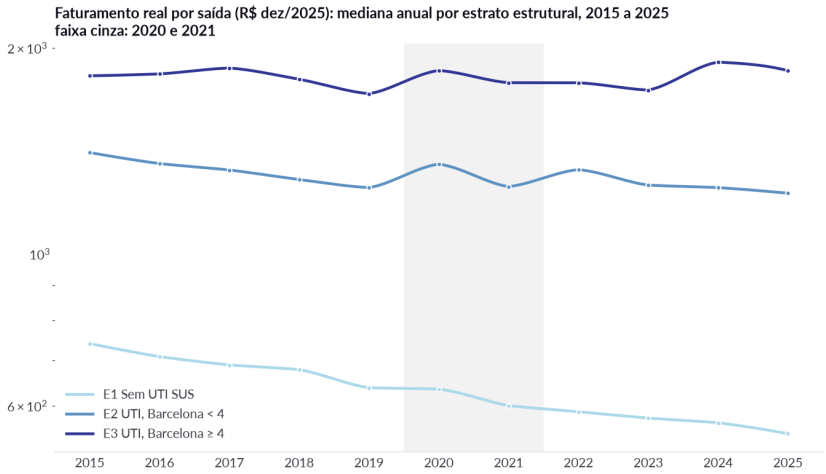


Figura B.11: Faturamento real por saída (R$ de dez/2025): mediana anual por estrato estrutural, em escala logarítmica.

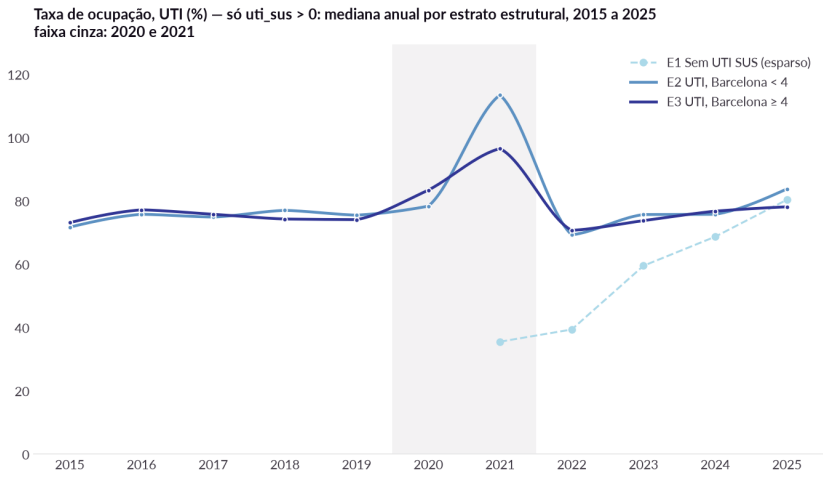


Figura B.12: Taxa de ocupação de UTI: mediana anual por estrato estrutural (apenas hospitais com leito de UTI SUS cadastrado; ver Seção 1.3).

A leitura ano a ano acrescenta duas coisas. O **TMP e o faturamento por saída** correm em três faixas separadas e paralelas os onze anos inteiros: são as métricas em que os estratos são mais estáveis como grupos. Já a **mortalidade e as saídas por leito** mostram E2 e E3 trocando de posição repetidamente: na mortalidade as duas curvas se cruzam **seis vezes** em onze anos, e nas saídas por leito o E2 fica acima do E3 em **seis dos onze anos, inclusive nos três últimos**. O gradiente estrutural é firme na estrutura e no preço unitário, e frouxo justamente onde se mediria desempenho.

O levantamento das 26 variáveis

A Seção 3 resume em um parágrafo o que este levantamento apurou. Aqui está o levantamento inteiro: os três estratos cruzados com **as 26 variáveis do painel que admitem leitura descritiva**, e não apenas com os seis indicadores do estudo.

Duas decisões que precisam vir antes dos números

Primeira: a unidade é o hospital, não o hospital-ano. O estrato é fixo por CNES, de modo que as onze observações de um hospital são o mesmo hospital medido onze vezes. Para *descrever* os estratos o hospital-ano serve, e é o que a Tabela 11 usa; para *comparar* os estratos ele não serve, porque trata como independentes onze medidas do mesmo objeto e infla qualquer teste por um fator próximo de onze. Os testes desta parte usam uma linha por hospital (a mediana dos onze anos), com n igual a 275.

Segunda: sete das 26 variáveis são definicionais e não contam. O corte em E1, E2 e E3 é construído a partir da mediana de leitos de UTI SUS e da faixa Barcelona. Encontrar que os estratos separam bem a faixa Barcelona (η^2 de 0,71) ou a proporção de leitos de UTI (η^2 de 0,56) não é achado: é a definição do corte reaparecendo. Essas sete estão marcadas na figura, e ficam fora de toda leitura substantiva.

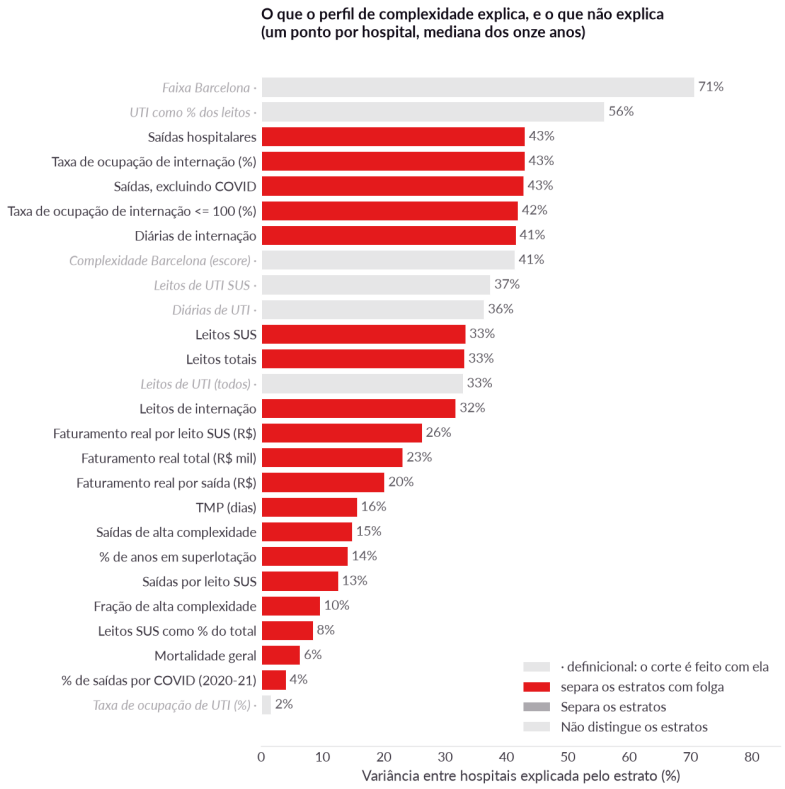


Figura B.13: Parcela da variância *entre hospitais* que o estrato explica, em cada uma das 26 variáveis. As barras em cinza são as definicionais: o corte é construído com elas. Quanto mais comprida a barra, mais o perfil de complexidade determina aquela variável; leia de cima para baixo pulando as barras cinzas, que são a definição do corte. Cada barra é uma variável do painel e o comprimento é o η^2: a fatia da diferença entre hospitais que o degrau da escada explica sozinho, sobre uma linha por hospital (n igual a 275). A cor diz se a diferença entre os três grupos é grande demais para ser acaso.

O achado central: o gradiente é estrutural, quase não é clínico

A tabela a seguir tem duas colunas que precisam de tradução, e elas são simples de entender uma vez ditas em português.

A coluna η^2 responde: *de tudo o que faz um hospital ser diferente do outro neste indicador, quanto o degrau da escada já explica sozinho?* Ela vai de 0 a 1. Um η^2 de 0,43 na taxa de ocupação quer dizer que saber apenas em qual degrau o hospital está já explica 43% da diferença de ocupação entre dois hospitais quaisquer da rede, e que os outros 57% dependem de tudo o mais: gestão, região, perfil de paciente, sorte. Quanto mais alto, mais o degrau *define* o hospital naquele indicador.

A coluna p_{23} responde outra coisa: *a diferença entre o segundo e o terceiro degrau é real ou pode ser acaso?* Ela é o resultado de um teste que compara os dois grupos e devolve um número entre 0 e 1. Perto de zero significa "esta diferença é grande demais para ser coincidência"; acima de 0,05, significa "os dois grupos são indistinguíveis com os dados que temos". O teste usado compara a posição dos hospitais na fila em vez das médias, o que é o certo aqui porque vários destes indicadores têm caudas longas que distorceriam a média. E, como a tabela faz três comparações de uma vez (E1 contra E2, E1 contra E3, E2 contra E3), o número foi ajustado para levar isso em conta: quem faz várias comparações acaba encontrando alguma "diferença" por puro acaso, e o ajuste desconta esse efeito. A última coluna, **Ordena?**, resume tudo num sim ou não: os três degraus sobem na ordem esperada e sem empate?

Tabela B.1: As duas pontas do ordenamento, entre as 20 variáveis não definicionais. Os valores são medianas por hospital. η^2 é a fatia da diferença entre hospitais que o degrau da escada explica sozinho, e p_{23} mede se a diferença entre o segundo e o terceiro degrau é real ou pode ser acaso, com o ajuste para as três comparações feitas. **É por a unidade ser o hospital, e não o hospital-ano, que os valores de ocupação, TMP e faturamento por saída não coincidem com os da Tabela 11.**

Variável	E1	E2	E3	η^2	p_{23}	Ordena?
o que o estrato explica						
Taxa de ocupação, internação (%)	39,0	66,1	90,7	0,44	<0,001	sim
Saídas hospitalares	2.224	4.267	10.555	0,43	<0,001	sim
Diárias de internação	7.037	16.839	53.226	0,42	<0,001	sim
Leitos SUS	54	72	175	0,33	<0,001	sim
Faturamento real total (R$ mil)	1.374	5.281	18.986	0,23	<0,001	sim
Faturamento real por saída (R$)	645	1.279	1.806	0,20	<0,001	sim
TMP (dias)	3,15	3,82	5,28	0,16	<0,001	sim
o que ele quase não explica						
Fração de alta complexidade	0,000	0,001	0,053	0,09	<0,001	sim
Leitos SUS como % do total	79,5	63,9	81,1	0,07	0,003	não
Mortalidade geral	0,042	0,060	0,058	**0,07**	**0,545**	não
% de saídas por COVID (2020-21)	9,6	8,8	5,2	0,04	0,004	inverte

A diferença entre a metade de cima e a metade de baixo da tabela é o achado deste levantamento. Em cima estão os indicadores de tamanho e de operação, leitos, saídas, diárias, faturamento, ocupação, e neles o degrau da escada explica de 16% a 44% do que separa um hospital do outro. Embaixo estão os indicadores de resultado, e ali o mesmo degrau explica pouco: na mortalidade, apenas 7%.

Traduzido para quem decide: **saber em que degrau um hospital está permite prever com folga o tamanho dele e o ritmo com que ele opera, e quase não permite prever quantos dos seus pacientes morrem.** A escada organiza capacidade instalada. Ela não organiza desfecho clínico.

E na mortalidade a escada nem sequer sobe. Os valores medianos são 4,3% no primeiro degrau, 5,9% no segundo e 5,8% no terceiro: o terceiro fica *abaixo* do segundo, e o teste diz que os dois são indistinguíveis (p_{23} de 0,391, muito acima de 0,05). O que separa a mortalidade, portanto, é uma coisa só: **ter ou não ter terapia intensiva**. Entre os hospitais que têm, subir na escala de complexidade não mexe no resultado. É a mesma conclusão que a Tabela 11 já sugeria pelo empate dos números, agora com o teste feito e a diferença medida.

Três padrões que só aparecem com o painel largo

Primeiro: a produtividade por leito satura em E2. As saídas por leito SUS vão de 44,1 em E1 para 62,3 em E2 e *recuam* para 59,3 em E3, e a diferença entre os dois últimos degraus é pequena demais para se separar do acaso. O ordenamento se quebra aqui, e quebra num lugar interessante: toda a estrutura adicional de E3, que é mais que o dobro de leitos, **não compra mais giro por leito**. O que E3 entrega a mais é volume absoluto e complexidade do caso, não eficiência física do leito.

Segundo: a composição público-privada não segue a escada. A proporção de leitos SUS sobre o total é de 80,5% em E1, cai para 63,7% em E2 e volta a 81,2% em E3. O estrato do meio é o mais misto, e é o único em que um terço dos leitos atende fora do SUS. A não-monotonicidade é modesta em tamanho (η^2 de 0,08) mas é sistemática, e vale como advertência: o degrau intermediário não é "E3 menor", é um objeto de natureza diferente. É também a razão pela qual a escolha do denominador de leitos SUS, discutida na introdução, não é neutra.

Terceiro: a pandemia entrou pela ponta de baixo da escada. A fração de saídas por COVID no biênio 2020–2021 é de 9,8% em E1, 8,7% em E2 e 5,2% em E3, e é o **único ordenamento invertido** de todo o levantamento. Os hospitais de menor capacidade instalada absorveram proporcionalmente mais COVID que os de maior, o que é coerente com uma rede que reservou a capacidade de referência para o caso não pandêmico, mas o dado aqui é descritivo e não sustenta afirmação sobre política de regulação de leitos.

Três leituras do corte

As três figuras a seguir são três leituras do mesmo corte: escala contra intensidade tecnológica, a taxa de ocupação de internação separada nas suas duas perguntas, e giro contra permanência. Cada uma tem uma marca por hospital, e não por hospital-ano: o ponto é a mediana dos onze anos daquele hospital.

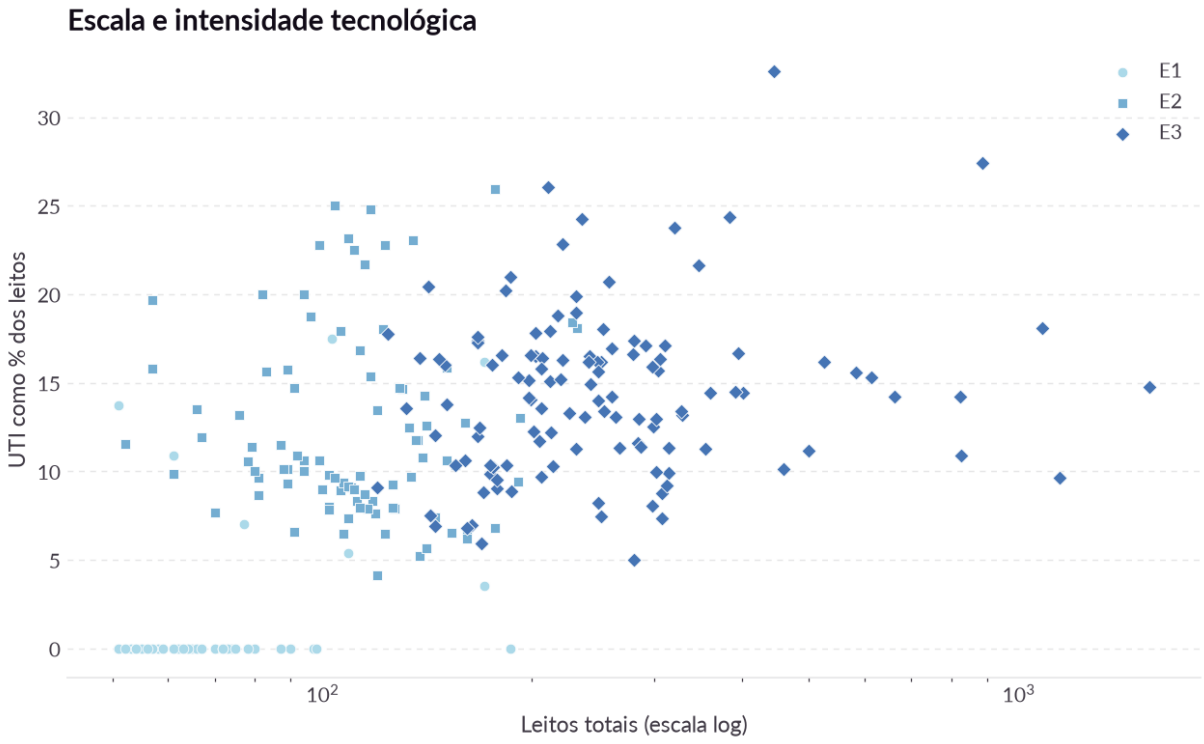


Figura B.14: Escala e intensidade tecnológica. Cada ponto é um hospital: no eixo horizontal, o total de leitos, em escala logarítmica; no vertical, quanto desses leitos é de UTI. Os hospitais de E1, na base do gráfico, são os que não têm UTI SUS.

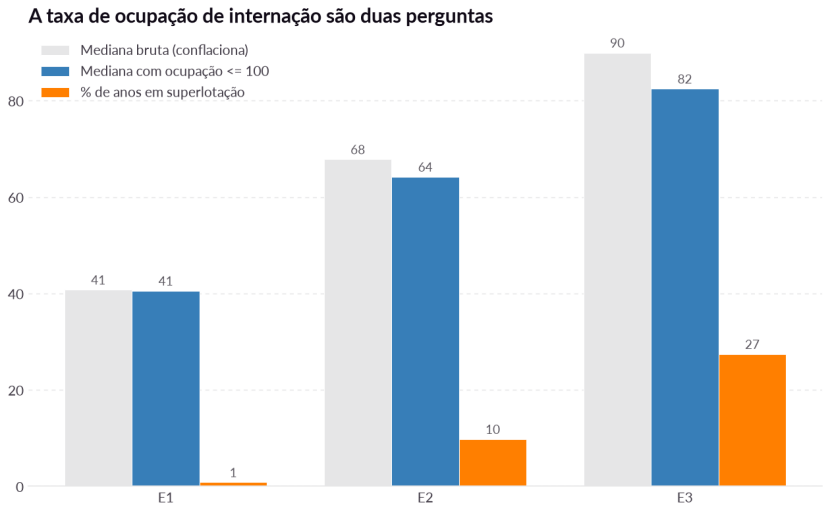


Figura B.15: A taxa de ocupação de internação são duas perguntas: quão cheio o hospital opera, e com que frequência ele passa da própria capacidade. A barra cinza mistura as duas; a azul responde a primeira e a laranja, a segunda. **Compare as barras cinza e azul de cada estrato**: quando elas se afastam, a mediana bruta está sendo puxada pela frequência de superlotação, e não pelo nível de ocupação. Em E1 coincidem; em E3 há sete pontos entre elas. Para cada estrato: a mediana bruta da ocupação de internação (em cinza), a mediana só dos hospitais-ano com ocupação até 100% (em azul) e a proporção de hospitais-ano acima de 100% (em laranja).

A mediana bruta vai de 41% em E1 a 90% em E3, mas parte disso não é ocupação: é superlotação entrando no numerador. Separadas as duas, o nível de ocupação abaixo de 100% vai de 41% a 83% e a frequência de superlotação vai de **1% dos hospitais-ano em E1 para 9% em E2 e 28% em E3**. A distância entre a barra cinza e a roxa é de zero ponto em E1 e de sete pontos em E3. A separação formal das duas grandezas, com as definições e a identidade que as liga, está na Subseção 3.3.

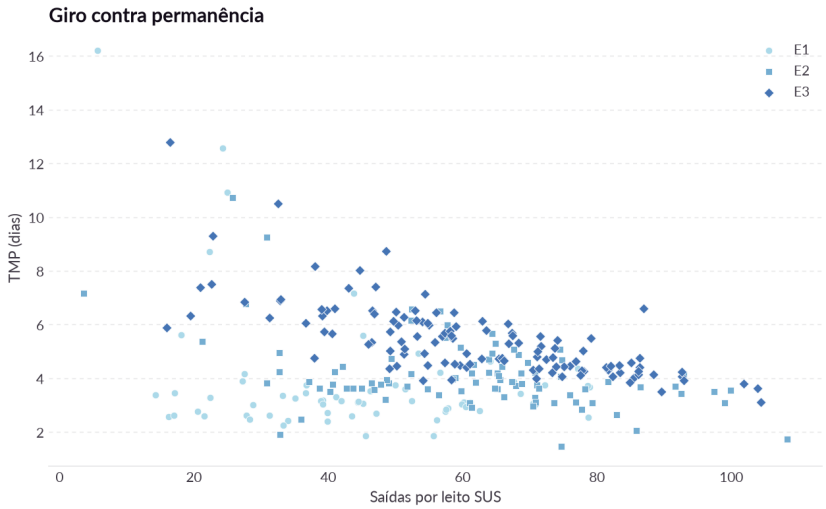


Figura B.16: Giro contra permanência. Quanto mais à direita, mais saídas o hospital produz por leito; quanto mais abaixo, menos tempo cada paciente fica internado. A nuvem desce da esquerda para a direita porque as duas coisas são a mesma: quem segura menos o leito, gira mais.

Alcance, recorrência e série anual da superlotação

As duas figuras a seguir sustentam, em forma completa, o que a Subseção 3.3 cita condensado.

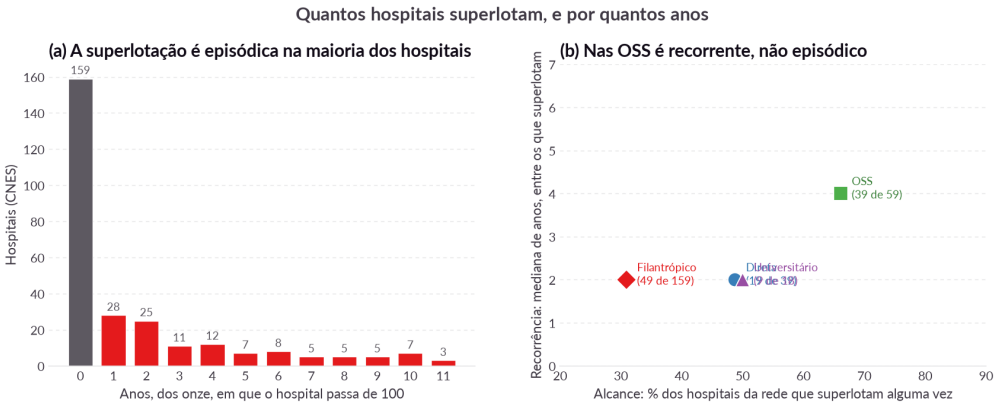


Figura B.17: Alcance e recorrência da superlotação. Episódica no painel como um todo (mediana de três anos entre os afetados), ela é recorrente nas OSS, onde atinge 66,1% dos hospitais por uma mediana de 4 dos onze anos. À esquerda, a barra cinza da posição zero são os hospitais que nunca superlotam, e é de longe a maior. Entre os que superlotam, as barras caem depressa: o padrão é episódico. À direita, mais à direita significa mais hospitais da rede superlotando alguma vez, e mais alto, por mais anos. À esquerda, contagem de hospitais (CNES) por número de anos, de zero a onze, com ocupação acima de 100%; a unidade é o hospital, e a barra do zero está em cinza por não ser superlotação. À direita, uma marca por rede: no eixo horizontal o **alcance** (% dos hospitais da rede que superlotam ao menos uma vez) e no vertical a **recorrência** (mediana de anos entre os que superlotam).

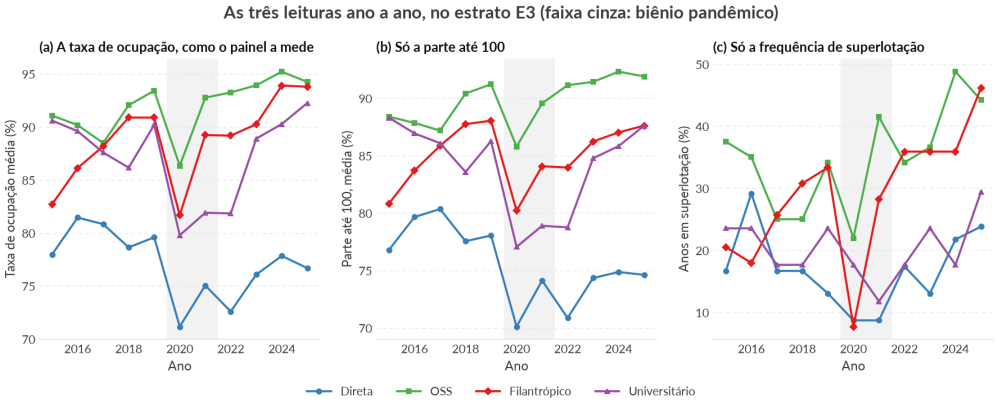


Figura B.18: A taxa de ocupação, a sua parte até 100% e a frequência de superlotação ano a ano no estrato E3, por categoria de gestão. A faixa cinza é o biênio pandêmico. Compare os três painéis pela linha da Direta, a mais baixa em todos: no painel (b) ela cai fundo em 2020, e no (c) encosta no zero e fica. Só a do meio tem teto em 100%. Três painéis com o mesmo eixo horizontal e uma linha por rede dentro de E3: em (a) a média anual da ocupação ℓ; em (b) a média da parte até 100%, τ; em (c) a % de hospitais-ano em superlotação. A unidade é o hospital-ano e a faixa cinza marca 2020 e 2021.

C Roteiro-base e módulos de entrevista da fase qualitativa

Este apêndice traz o instrumento de campo da fase qualitativa: o roteiro-base comum aos blocos de gestão e os módulos específicos por perfil. Saiu do corpo do documento por proporção, são quase dez páginas de perguntas, e porque é material de aplicação, não de leitura. O desenho da fase, os critérios de seleção e a lista de entrevistados estão na Seção 4.

C.1 Roteiro-base comum aos blocos de gestão (a, b, c e d)

O roteiro-base cobre seis domínios e dura de cinquenta a sessenta minutos. Vale para os entrevistados dos blocos a, b e c do núcleo e, se realizados, dos pares casados sugeridos (bloco d). As perguntas são abertas; os itens entre colchetes são estímulos de aprofundamento para o entrevistador.

C.1.1 Governança e desenho institucional

1. Como se organiza a direção do hospital: quem decide o quê entre a diretoria local, a mantenedora ou OSS e a Secretaria? [organograma real e formal; conselhos; tempo de mandato da direção]

   Achado que a pergunta testa: a eficiência técnica maior das OSS é traço robusto da rede; a hipótese é que o desenho de governança seja o canal.

2. Que decisões precisam de autorização externa ao hospital e quanto tempo levam, do pedido à resposta? [contratação, compra acima de um teto, abertura de leito]

   Achado que a pergunta testa: o regime operacional mais intenso das OSS sugere menor fricção decisória; a pergunta mede a fricção diretamente.

3. Com que frequência a direção examina indicadores assistenciais e o que acontece quando um indicador piora? [rotina de reunião; quem responde pelo indicador]

   Achado que a pergunta testa: desviantes positivos mantêm eficiência alta por onze anos; persistência sugere rotina gerencial, não sorte.

C.1.2 Autonomia de recursos humanos e compras

1. Como o hospital contrata e desliga pessoal assistencial, e quanto tempo passa entre a necessidade identificada e o profissional trabalhando? [concurso e CLT; terceirização; banco de horas]

   Achado que a pergunta testa: a produção das OSS é cerca de 32,9% maior para estrutura comparável (leitura transversal); a elasticidade de RH é o mecanismo candidato.

2. Como funcionam as compras e a manutenção de equipamentos: prazos típicos, o que mais trava? [licitação e compra direta; estoque; equipamento parado]

   Achado que a pergunta testa: o faturamento real por saída não difere entre categorias; se as OSS produzem mais com faturamento igual, a diferença deve estar no uso dos insumos, não no preço.

3. Qual é a rotatividade das equipes médica e de enfermagem, e o que a explica? [vínculos múltiplos; plantões; salário relativo]

   Achado que a pergunta testa: a estabilidade de equipe é explicação concorrente à gestão para a eficiência persistente dos desviantes positivos.

C.1.3 Contrato de gestão e metas

1. Existe contrato, convênio ou instrumento com metas quantitativas? Quais indicadores, quem apura, e o que acontece quando a meta não é cumprida? [glosa; aditivo; renegociação]

   Achado que a pergunta testa: o contrato de gestão é a diferença institucional formal entre OSS e administração direta; a alta de 32,9% na produção (transversal) é o efeito que ele teria de explicar, e a queda de 6,8% no TMP (within), a direção que ele teria de justificar.

2. As metas chegam ao cotidiano clínico? Dê um exemplo de decisão de ponta (alta, agenda cirúrgica, escala) que mudou por causa de meta. [quem traduz a meta para a equipe]

   Achado que a pergunta testa: o TMP menor nas OSS é evidência dentro do hospital, apoiada em quatro conversores e sem margem que exclua o zero; a pergunta busca o elo micro entre contrato e permanência.

C.1.4 Relação com a Secretaria e financiamento

1. Como é a interação com a Secretaria, estadual ou municipal: cobrança, apoio técnico, regulação de fila? Com que frequência? [câmaras técnicas; visitas; sistemas]

   Achado que a pergunta testa: categorias públicas e OSS respondem à mesma Secretaria com resultados diferentes; a pergunta separa o vínculo formal da relação praticada.

2. Como o dinheiro chega e o que acontece numa crise de caixa? [teto MAC; incentivos; atraso de repasse; quem socorre]

   Achado que a pergunta testa: o faturamento real por saída não difere entre categorias: se o financiamento é semelhante, a diferença de desempenho não é explicada por mais dinheiro.

C.1.5 Gestão de leitos e fluxo do paciente

1. Descreva a rotina de altas: horário, critérios, quem decide, existe reunião diária de leitos? [alta assistida; previsão de alta na admissão]

   Achado que a pergunta testa: o TMP cerca de 10% menor nas OSS torna a rotina de gestão de altas o mecanismo mais direto que a entrevista pode verificar.

2. Quem controla a fila de internação e a ocupação do leito (NIR, regulação própria, CROSS)? Como se decide quem entra? [leito de retaguarda; internação social]

   Achado que a pergunta testa: o giro alto dos desviantes positivos exige controle fino de entrada e saída; a pergunta identifica o instrumento.

3. Que parte da cirurgia migrou para o regime ambulatorial ou hospital-dia, e o que impediu de migrar mais? [centro cirúrgico; anestesia; retorno]

   Achado que a pergunta testa: produção maior com TMP menor é compatível com substituição de internação por ambulatório; a pergunta testa essa composição.

C.1.6 Resposta à pandemia (2020 e 2021)

1. O que mudou em leitos, equipes e fluxo em 2020 e 2021, e quanto da expansão foi física de fato e quanto foi apenas cadastro? [leitos de campanha; UTI improvisada; registro no CNES]

   Achado que a pergunta testa: as séries de 2020 e 2021 têm extremos de ocupação de UTI e denominadores frágeis; a distinção entre leito real e leito cadastrado é decisiva para a leitura desses anos.

2. O que a pandemia deixou de permanente na operação do hospital? [telessaúde; protocolos; equipes]

   Achado que a pergunta testa: a estimação de robustez sem 2020 e 2021 preserva os achados principais; a pergunta explora se houve mudança estrutural que os dados posteriores já refletem.

C.2 Módulos específicos por perfil

C.2.1 Módulo A: conversores da Direta para OSS (bloco a)

Reconstituir a linha do tempo da transição: quando a conversão começou a ser discutida, quando o contrato foi assinado, quando a OSS assumiu de fato. Atenção metodológica: em Sorocaba a melhora dos indicadores começou *antes* da conversão formal, e é indispensável perguntar o que já estava em curso no período anterior (intervenção da Secretaria, troca de direção, obra, mudança de perfil), pois a resposta separa o efeito da gestão OSS de uma tendência pré-existente.

1. Conte a linha do tempo da transição para OSS: primeira discussão, decisão, assinatura, assunção. O que aconteceu no hospital em cada etapa? [greves; judicialização; transição de direção]

   Achado que a pergunta testa: as datas de conversão adotadas (2019 e três em 2025) vêm do cadastro; a linha do tempo real pode antecedê-las e reinterpretar o que se lê das trajetórias.

2. O que mudou concretamente no primeiro ano de OSS: rotinas, chefias, sistemas, escalas? O que não mudou? [primeiros noventa dias; o que a OSS trouxe pronto]

   Achado que a pergunta testa: o TMP cai depois da conversão, mas a queda não sobrevive ao teste de tendências anteriores (Subseção 3.7): resta direção, não efeito medido. A pergunta busca a prática que explicaria uma queda rápida, se ela existir.

3. Quanto da equipe assistencial e das chefias permaneceu após a conversão? [estatutários cedidos; recontratação CLT]

   Achado que a pergunta testa: a continuidade de equipe distingue efeito de gestão de efeito de composição: se a equipe é a mesma, a mudança é de método, não de pessoas.

4. Quais metas o contrato de gestão fixou no início e como elas mudaram? Alguma meta era vista como inatingível? [metas de produção e de qualidade]

   Achado que a pergunta testa: a alta de 32,9% na produção (transversal) e a queda de 6,8% no TMP (within) fazem das metas contratuais a explicação institucional candidata.

5. (Somente Sorocaba) Os indicadores já vinham melhorando antes da conversão formal. O que estava acontecendo no hospital nos dois ou três anos anteriores? [gestor interino; plano de saneamento; antecipação da OSS]

   Achado que a pergunta testa: a melhora pré-conversão observada nesse hospital ameaça a leitura causal do estudo de eventos; a resposta decide entre antecipação, tendência ou seleção.

6. O que mais mudou no hospital no mesmo período da troca de gestão? Prédio, equipamento, perfil de atendimento, contrato de serviços, corpo clínico? [pedir linha do tempo de tudo que mudou, não só da gestão]

   Achado que a pergunta testa: em Sorocaba a conversão veio depois de uma crise de gestão documentada (Subseção 3.7); a pergunta busca separar o efeito da gestão do que mudou junto com ela.

7. Quais serviços já eram terceirizados ou operados por convênio *antes* da conversão, pronto-socorro, UTI, anestesia, exames, limpeza, manutenção? Desde quando? [pedir a lista completa]

   Achado que a pergunta testa: em Taipas e Vila Penteado, pronto-socorro, UTI e anestesia já eram terceirizados sob o rótulo Direta; se o ponto de partida já era misto, o contraste medido entre os dois regimes é menor do que o rótulo sugere.

C.2.2 Módulo B: desviantes positivos (bloco b)

O objetivo é extrair práticas concretas e transferíveis por trás do giro alto e da eficiência persistente, com ceticismo ativo: pedir sempre o exemplo, o documento, a rotina, sem aceitar declaração de princípios.

1. O hospital está no quartil superior de eficiência da rede há onze anos. Na sua leitura, quais três práticas explicam isso? Para cada uma: desde quando, quem implantou, o que custou? [pedir exemplos datados]

   Achado que a pergunta testa: a persistência no quartil superior ao longo de onze anos afasta oscilação de um ano isolado; deve haver prática real por trás.

2. Como funciona, passo a passo, a gestão de altas num dia típico? [reunião de leitos; previsão de alta; alta aos sábados]

   Achado que a pergunta testa: giro alto com TMP baixo é a assinatura operacional dos desviantes positivos.

3. Que procedimentos o hospital faz em regime ambulatorial que vizinhos comparáveis internam? [cirurgia ambulatorial; hospital-dia; protocolos]

   Achado que a pergunta testa: a produção alta com leitos comparáveis sugere substituição ambulatorial; a pergunta lista os procedimentos.

4. Como o hospital se relaciona com a regulação de vagas: aceita tudo que a central manda? Recusa o quê, e com que argumento? [seleção de casos; perfil de demanda]

   Achado que a pergunta testa: a eficiência alta pode ser gestão ou seleção de pacientes mais leves; a pergunta confronta a hipótese de seleção, a ler junto com a complexidade Barcelona do hospital e com o marcador financeiro×físico da ficha de cada hospital.

C.2.3 Módulo C: desviantes negativos (bloco c)

Simétrico ao módulo B, mas centrado nas restrições percebidas. O tom não é de auditoria: o objetivo é entender o que impede o giro, na visão de quem opera, e confrontar depois com as restrições objetivas do painel.

1. Quais são hoje os três maiores obstáculos para o hospital girar mais os leitos? [financiamento; RH; perfil de demanda; física do prédio]

   Achado que a pergunta testa: o hospital está no quartil inferior persistente de DEA; a pergunta colhe a explicação nativa antes de confrontá-la com os dados.

2. Descreva o paciente típico que fica internado mais tempo do que precisaria. Por que ele não sai? [internação social; retaguarda; exame que não sai]

   Achado que a pergunta testa: TMP alto com ocupação alta indica leito ocupado por paciente que não precisaria dele; a pergunta identifica o gargalo.

3. O financiamento cobre o custo do que o hospital produz? Onde aperta primeiro? [tabela SUS; folha; incentivos]

   Achado que a pergunta testa: o faturamento real por saída não difere entre categorias na rede; se a restrição percebida é financeira, ela precisa ser conciliada com esse achado.

4. Se o hospital pudesse mudar uma única regra (de RH, compra ou contrato), qual mudaria e o que aconteceria? [pergunta projetiva]

   Achado que a pergunta testa: a resposta revela qual margem de autonomia o gestor acredita que falta, comparável em espelho com o que as OSS dizem ter.

C.2.4 Módulo D: pares casados (bloco d, sugeridos)

As perguntas dos domínios de recursos humanos e compras, contrato e metas, e leitos e fluxo do roteiro-base devem ser feitas de forma espelhada e com a mesma ordem nos dois hospitais do par, para permitir comparação direta das respostas. Acrescentar:

1. Num dia típico, quem decide a abertura de um leito extra, a contratação de um plantonista e a compra urgente de um insumo, e em quanto tempo? [responder para os três casos]

   Achado que a pergunta testa: o par tem faixa Barcelona, porte e leitos parecidos com eficiência divergente; a velocidade decisória é a diferença de gestão mais plausível com estrutura igual.

2. Como é montada a escala médica do fim de semana e o que acontece com as altas de sexta a domingo? [alta no fim de semana; plantão de sexta]

   Achado que a pergunta testa: diferenças de TMP entre pares estruturalmente parecidos costumam se concentrar no fim de semana; pergunta espelhada nos dois hospitais do par.

C.3 Logística e esforço

A seleção soma **65 hospitais únicos**, todos de **entrevista plena**: roteiro-base de cinquenta a sessenta minutos mais o módulo específico de vinte a trinta minutos. Nos quinze pares casados do bloco 3, *o par vale aos pares*: entrevistar só um dos dois lados perde o contraste que justifica o bloco. Recomenda-se gravar com consentimento, transcrever integralmente e codificar as respostas contra a lista de achados deste roteiro, para que a fase qualitativa feche o ciclo: cada mecanismo declarado nas entrevistas deve ser reexaminável no painel. Toda a lista, no entanto, permanece subordinada ao ponto de partida desta seção: a escolha final dos hospitais e das perguntas é da pesquisadora principal.

D Como estimamos os efeitos: a fronteira de eficiência e os demais indicadores

D.1 A fronteira de eficiência (DEA): a fórmula e como ela vira nota

Este é o primeiro dos dois estágios do método. O segundo, que compara categorias de gestão sobre os demais indicadores, está descrito na parte seguinte; esta explica como o documento constrói a **nota de eficiência** que a Subseção 1.7, a Subseção 3.4 e a Seção 4 usam para posicionar e ordenar os hospitais.

A fronteira é um problema de programação linear, um por hospital-ano. Para cada hospital-ano o, com vetor de insumos X_o e vetor de produtos Y_o, o escore de Farrell orientado a produto resolve

$$\theta_o \;=\; \max_{\theta,\,\lambda}\ \theta \quad \text{sujeito a} \quad \sum_j \lambda_j X_j \le X_o, \quad \sum_j \lambda_j Y_j \ge \theta\, Y_o, \quad \sum_j \lambda_j = 1, \quad \lambda_j \ge 0,$$

em que j percorre todos os hospitais-ano do mesmo ano e do mesmo universo (E3, a rede inteira, e assim por diante): a fronteira é reestimada ano a ano, e não sobre o painel inteiro de uma vez, porque agrupar os onze anos misturaria tecnologia, preço relativo e composição de caso de anos diferentes. A restrição $\sum_j \lambda_j = 1$ é o que faz o modelo comparar cada hospital só com combinações de hospitais de **escala parecida** (o modelo BCC, de retornos variáveis à escala); removê-la dá o modelo CCR, de retornos constantes, que este documento também estima e usa como checagem de robustez, e não como fronteira publicada. Por construção $\theta_o \ge 1$: um hospital sobre a fronteira tem $\theta_o = 1$, e quanto mais distante dela, maior o θ_o.

Os insumos são leito SUS, leito de terapia intensiva (com o piso de meio leito para quem tem UTI habilitada e uso positivo) e dias de internação sem COVID; os produtos são as saídas totais e as saídas de alta complexidade. Nenhum valor monetário entra na conta: a razão de o faturamento ter saído dos insumos está na Subseção 1.9.

A nota que o documento publica é o inverso do escore, $\text{nota}_o = 1/\theta_o \in (0, 1]$, corrigido do viés de amostra finita pelo bootstrap de Simar e Wilson (algoritmo 1, 2.000 réplicas por ano, com a mesma semente entre especificações): a fronteira estimada com um número finito de hospitais tende a superestimar a eficiência de quem está perto dela, e o bootstrap desconta essa tendência. Nota 1 significa que o hospital está, naquele ano, sobre a fronteira do seu universo; nota 0,7 significa que ele produziria cerca de 43% a mais com o mesmo insumo ($1/0,7$), se operasse como os melhores hospitais de escala comparável.

A nota individual de um ano não é a comparação que o documento sustenta. O que se publica é o contraste entre categorias de gestão sobre a **nota mediana dos onze anos** de cada hospital, com a mesma salvaguarda de agrupamento por hospital e o mesmo controle de porte e complexidade estrutural das demais estimativas (parte seguinte). É essa mediana, também, que ordena os hospitais na Seção 4, para escolher quem entrevistar: um hospital de nota alta é aquele cuja mediana de onze anos fica no quarto de cima do seu universo, e persistente é o que fica lá em pelo menos seis desses onze anos.

D.2 Os demais indicadores: molde por indicador e salvaguardas

Esta parte reúne o método de estimação dos demais indicadores – mortalidade, tempo de permanência, faturamento, produção e as duas ocupações – e as salvaguardas que valem para todos os seus modelos. **Estimar**, aqui, é usar modelos estatísticos para medir quanto de cada diferença entre hospitais pode ser atribuído ao modelo de gestão, depois de descontar complexidade, porte e ano. A ideia central é simples: comparar hospitais como se estivessem em igualdade de condições. Um hospital OSS de grande porte e alta complexidade não pode ser comparado diretamente com uma Santa Casa pequena; o modelo faz esse desconto de forma sistemática, para todos os hospitais ao mesmo tempo.

Cada indicador recebeu a família de modelo decidida empiricamente na Subseção 1.2.2, e a leitura substantiva dos resultados não depende dessa escolha. **Em uma linha, os moldes são estes**: a mortalidade em regressão Beta com inflação em zero; a fração de alta complexidade em

ZOIB, que separa quem não faz nada de alta complexidade, quem só faz e a variação contínua entre os dois; o faturamento e o tempo de permanência no logaritmo; a produção em Binomial Negativa; e a ocupação de internação no logaritmo, aparada no percentil 99, que corresponde a 125,1%. O que vale registrar aqui é que faturamento e tempo de permanência são analisados no logaritmo, comparando cada hospital com ele mesmo ao longo do tempo, os chamados **efeitos fixos**, e que essa é a especificação que sustenta os dois achados dentro do hospital deste documento.

Quatro salvaguardas valem para todos os modelos. Primeira: o faturamento entra sempre **em valores reais**, deflacionado pelo IPCA para preços de 2025, porque a Subseção 1.6 mostrou que o crescimento nominal do faturamento era, na íntegra, inflação. Segunda: as duas observações de denominador frágil do Hospital Infante D Henrique (CNES 2097613, São José do Rio Preto, 2020 e 2021, com 13 e 4 saídas fora da COVID) ficam fora de todas as equações. Terceira: as ocupações extremas são limitadas ao percentil 99 (125,1% na internação e 171,2% na UTI), preservando a informação de sobrecarga real e removendo o erro de cadastro documentado do biênio pandêmico. Quarta e mais importante: **todas as margens de erro são calculadas agrupando por hospital**, reconhecendo que 11 anos do mesmo CNES não são 11 informações independentes; sem esse agrupamento, os efeitos pareceriam muito mais precisos do que de fato são.

Um cuidado adicional merece explicação. Como a variação dos indicadores está majoritariamente *entre* hospitais e não *dentro* deles ao longo do tempo (a Seção 1.5 documenta parcelas de variação interna entre 5,9% e 16,4% em cinco dos seis indicadores, com a ocupação de UTI como exceção isolada, em 68,8%), o contraste entre gestões pode ser lido de duas maneiras: comparando hospitais diferentes entre si, ou acompanhando ao longo do tempo os quatro hospitais que trocaram de gestão. Na mortalidade, as duas leituras são estimadas ao mesmo tempo e saem separadas, cada uma no seu coeficiente, em vez de misturadas num só (é a especificação de Mundlak); no faturamento e no tempo de permanência, os efeitos fixos de hospital deixam apenas a segunda leitura, a de cada hospital comparado consigo mesmo.

E Robustez e diagnóstico dos modelos

Duas baterias de verificação fecham o método de estimação, e uma terceira nota registra a escolha de molde do indicador de UTI.

Sem o biênio pandêmico. Todos os modelos foram reestimados excluindo 2020 e 2021, os anos em que a casuística e os denominadores sofreram os choques documentados na Subseção 1.6. A Figura E.1 compara os contrastes OSS vs Direta nas duas amostras: as diferenças são mínimas (o tempo de permanência passa de 6,8% para 7,5% de queda, a produção de 32,9% para 33,5% de alta, e assim por diante). **Nenhum dos contrastes principais depende dos anos de pandemia.**

Tabela E.1: Contraste OSS *versus* Direta estimado no painel completo e na amostra que exclui 2020 e 2021, nos sete modelos principais. Cada bloco traz o **efeito** já traduzido para a unidade de leitura, ao lado do valor bruto do modelo e da sua margem de erro. A leitura pretendida é a comparação entre os dois blocos: quanto mais parecidos, menos o resultado depende dos anos de pandemia. Cada linha é um dos sete modelos. **Efeito** traduz o resultado para a unidade do gestor; **EP** é a margem de erro, agrupada por hospital. Nenhum efeito muda de sinal. A ocupação de UTI aparece em **duas linhas** porque foi calculada de duas maneiras: a adotada no documento, escolhida pelos testes de aderência de cada família, e a mesma conta das outras seis, para que a coluna se leia de cima a baixo na mesma régua.

	Painel completo			Sem 2020 e 2021		
Modelo	Efeito	Coef.	EP	Efeito	Coef.	EP
Mortalidade (geral)	−0,62 p.p.	−0,1197	0,1007	−0,89 p.p.	−0,1750	0,1262
Fração alta complexidade	sem deslocamento	−0,0528	0,1664	sem deslocamento	−0,0580	0,1661
Faturamento real por saída	+2,0%	0,0199	0,0676	+2,6%	0,0252	0,0698
Tempo de permanência	−6,8%	−0,0709	0,0589	−7,5%	−0,0777	0,0622
Produção (saídas)	+32,9%	0,2841	0,0656	+33,5%	0,2887	0,0650
Taxa de ocupação, internação	+9,9%	0,0944	0,0670	+9,3%	0,0886	0,0660
Ocupação de UTI	+11,1%	0,1050	0,0630	+12,0%	0,1130	0,0624
cálculo alternativo	+8,9%	0,0854	0,0515	+11,3%	0,1071	0,0512

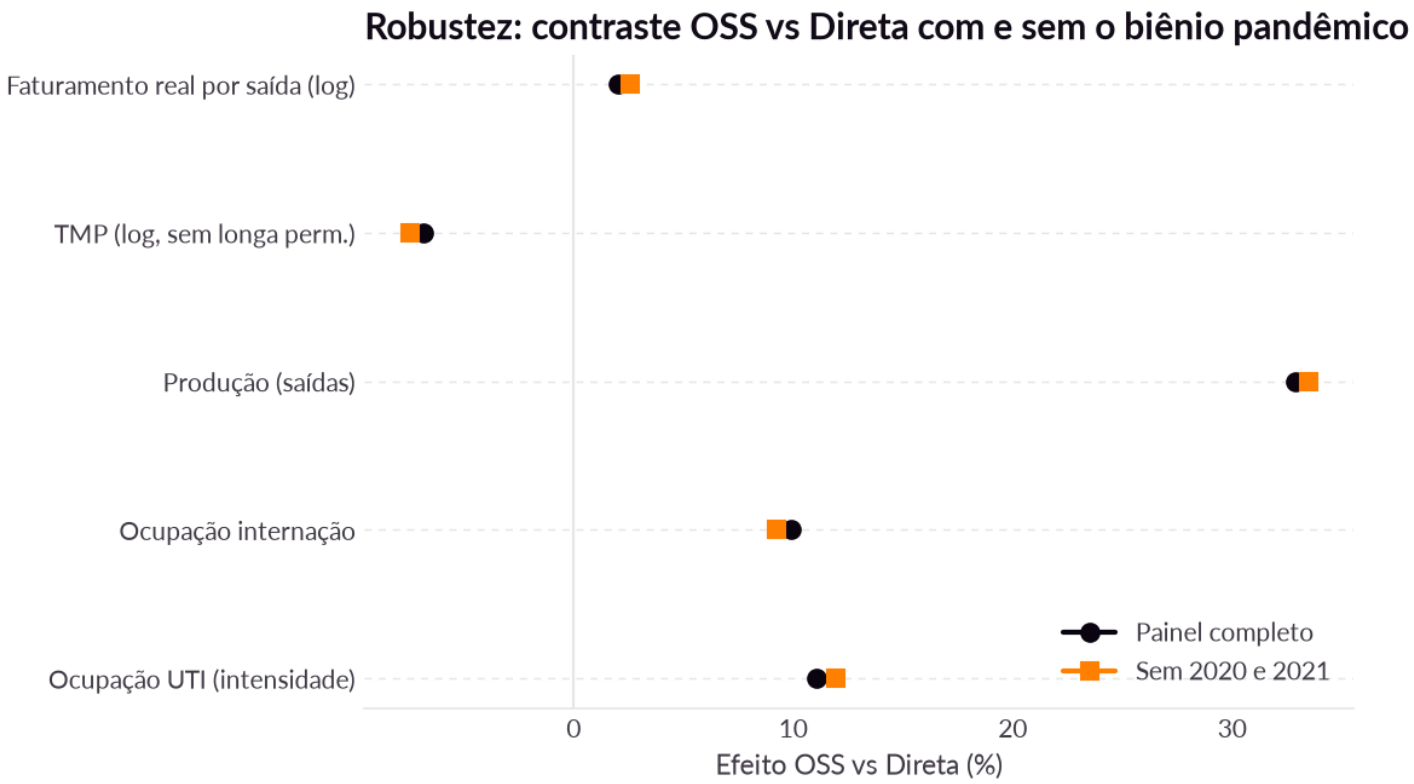


Figura E.1: Contraste OSS vs Direta estimado no painel completo e na amostra sem 2020 e 2021, para os modelos em escala percentual. Cada linha traz duas estimativas do mesmo efeito: o **círculo escuro** usa todos os anos e o **quadrado laranja** exclui 2020 e 2021. Quanto mais próximos, mais robusto o resultado.

Aderência dos modelos. A segunda bateria confere se cada modelo de fato descreve os dados que ele resume. **Todos passam**: o resíduo quantílico de cada modelo se alinha à diagonal com correlação de 0,976 na mortalidade, 0,989 na fração de alta complexidade, 0,968 na produção, 0,970 no faturamento e 0,959 no tempo de permanência. **A exceção honesta é a intensidade de ocupação da UTI**, em 0,807 no modelo em logaritmo, e é dela que trata o parágrafo abaixo.

A intensidade de uso de UTI. Este indicador é calculado com um molde que acomoda os hospitais de UTI quase parada, que de outro modo distorceriam a conta; **reestimado com a família Gama, o alinhamento do resíduo sobe de 0,807 para 0,954**. O resultado é uso de UTI **11,1% maior nas OSS**, com margem que comporta não haver diferença nenhuma, e uma variante do cálculo dá 8,9%. As duas são estimativas alternativas: o valor que prevalece é o do modelo em duas partes da Subseção 1.8.

Fecham o quadro as ressalvas permanentes de leitura, todas já enunciadas por extenso e aqui apenas relembradas: a identificação do efeito de gestão dentro de hospital repousa nos **quatro conversores** (Subseção 3.7), de modo que os efeitos devem ser lidos como ordens de grandeza; e a evidência da conversão carrega a contaminação de tendências anteriores que a Subseção 3.7 documenta, e que **alcança os cinco indicadores**, inclusive o tempo de permanência.

F A sensibilidade do contraste de eficiência: um universo e cinco escolhas do que descontar

A Subseção 3.4 publica o contraste institucional de eficiência num universo só, o grupo de maior capacidade instalada inteiro, com **120 hospitais** e as quatro redes de gestão. **Este apêndice põe lado a lado as cinco escolhas do que descontar antes de comparar**: a da manchete, que desconta complexidade, porte e ano; e quatro sensibilidades, que acrescentam a ela a gravidade dos casos, a razão de mortalidade, a fração de internações cirúrgicas, e as três ao mesmo tempo. **São vinte leituras ao todo**, e elas estão aqui inteiras porque a escolha entre as especificações foi fixada antes de o resultado de qualquer uma delas ser conhecido: reportar as cinco é o que impede a escolha de andar atrás do sinal.

Tabela F.1: As cinco leituras do contraste entre as quatro redes, e o que cada uma separa da média. As linhas são as escolhas do que se desconta antes de comparar e as colunas, as redes. **Cada célula diz de que lado da média a rede fica**, e "não se separa" quer dizer que os dados admitem para ela tanto cenários acima quanto abaixo.

O que se desconta	Direta	OSS	Filantrópico	Universitário
Complexidade, porte e ano	**mais longe**	**mais perto**	**mais perto**	não se separa
e a gravidade dos casos	**mais longe**	não se separa	**mais perto**	não se separa
e a razão de mortalidade	**mais longe**	**mais perto**	**mais perto**	não se separa
e a fração de cirurgias	**mais longe**	**mais perto**	**mais perto**	não se separa
e as três ao mesmo tempo	**mais longe**	não se separa	**mais perto**	não se separa

A primeira linha é a leitura que a Subseção 3.4 afirma; as quatro seguintes são as sensibilidades que ela declara. **"Mais longe" e "mais perto" são posições em relação à média das quatro redes**, e não em relação a uma delas: nenhuma rede serve de referência às outras.

Dois contrastes atravessam as cinco leituras. A administração direta aparece mais distante da melhor prática do que a média nas **cinco**, e o Filantrópico aparece mais perto nas **cinco**. **Um terceiro aparece e desaparece**: as Organizações Sociais ficam mais perto da média em três das cinco leituras, e voltam para junto dela nas duas que descontam a gravidade dos casos. O hospital universitário não se separa em nenhuma.

Vale registrar qual leitura menos mudou, porque é ela que responde à objeção de que trocar a régua teria fabricado o resultado: a que desconta a gravidade dos casos dá hoje exatamente o que dava com a medida anterior, a administração direta mais longe e o Filantrópico mais perto. O que a troca de régua acrescentou foi a posição das Organizações Sociais nas outras leituras, e não o achado do Filantrópico.

As três leituras da comparação, lado a lado: a administração Direta fica mais longe da média nas três, e é a única rede cuja posição não depende de qual delas se adote

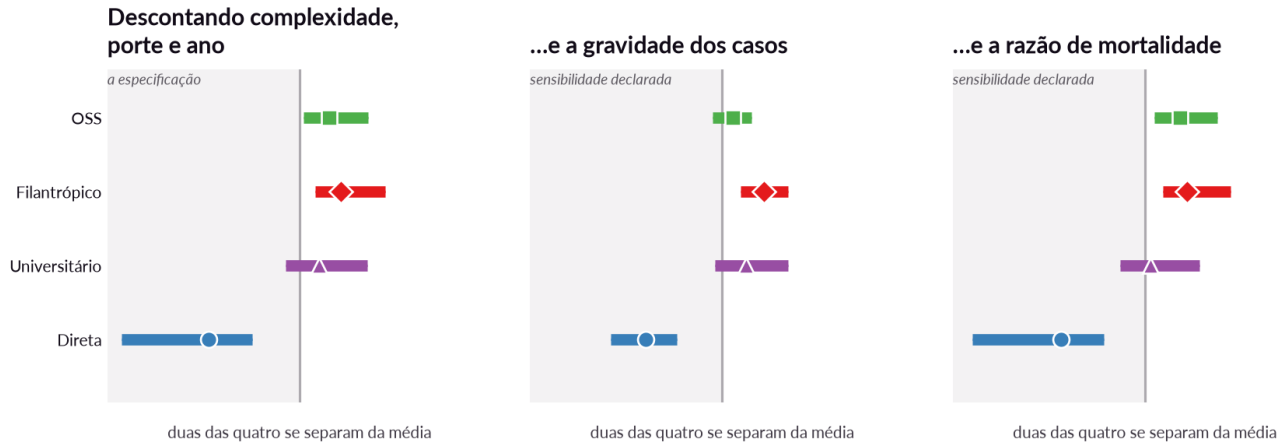


Figura F.1: As cinco leituras da comparação entre as quatro redes, lado a lado. As redes ficam na mesma ordem nos cinco painéis. São as mesmas vinte células da tabela acima, desenhadas. Cada faixa cobre as posições que os dados admitem para a rede em relação à média das quatro. **O que se lê é de que lado da linha vertical a faixa fica**: à esquerda, mais longe da melhor prática que a média; à direita, mais perto; atravessando a linha, a rede não se separa. **Duas redes ficam inteiras de um lado nos cinco painéis**, a administração Direta à esquerda e o Filantrópico à direita. O eixo não tem número de propósito: esta escala não tem tradução em unidade de gestão.

A dianteira das Organizações Sociais aparece na própria grade, e é uma novidade desta medida. Ela está em três das cinco leituras, e desaparece justamente nas duas que descontam a gravidade dos casos, o que quer dizer que parte da vantagem delas é a gravidade que elas atendem. Enquanto o faturamento entrava na conta como recurso consumido, essa dianteira não aparecia em leitura nenhuma desta grade.

Havia, na medida anterior, um quarto lugar em que ela aparecia, e ele fica registrado aqui porque o documento o citou: o universo de comparabilidade estrita, com **79** hospitais em três redes, aqueles cujo modelo de gestão é observado direto no cadastro, sem reclassificação por pesquisa externa. **Ali, e sem o desconto de gravidade, as Organizações Sociais apareciam mais perto da melhor prática do que a média das três**, e a administração direta, mais longe. **Aquela leitura é da régua antiga**, que tinha o faturamento entre os recursos consumidos, e não foi reestimada: ela não se soma nem se compara às cinco desta grade.

Três diferenças independentes separam aquela leitura destas, e nenhuma delas foi desenhada para atingir a posição de rede alguma. A primeira é o rótulo: aqui, quarenta e três hospitais municipais entram com o modelo de gestão apurado hospital a hospital em fonte externa, o que traz vinte e quatro deles para dentro da comparação. A segunda é o desconto pela gravidade dos casos, que corre sobre exatamente os mesmos hospitais. A terceira é o conjunto de referência, que aqui inclui o hospital universitário. **Uma mexe em quem entra, a outra no que se desconta e a terceira em contra quem se mede**, e as três chegam ao mesmo lugar: uma rede cujo ponto central fica do lado da eficiência e cuja faixa alcança a média.

O universo de 79 não está nesta grade, e a razão é de forma. Ele é um recorte de três redes por construção, porque o rótulo do hospital universitário não vem da base administrativa e sim de uma relação montada uma a uma, e não existe versão dele nas quatro sem uma estimação própria. Pô-lo como linha de uma tabela cujas colunas são quatro redes produziria uma célula vazia, e célula vazia numa grade de sensibilidade é lida como ausência de efeito, e não como ausência de conta. **Ele fica registrado aqui, em palavras, com o que diz**, que é o que a honestidade de reporte exige.

A diferença entre as cinco leituras é o que foi descontado, e não o que foi estimado. A fronteira, a semente e o número de réplicas são os mesmos nas cinco; o que muda de uma linha para a outra é o que entra na conta antes de comparar as redes.

As sensibilidades desta grade acrescentam um termo cada, e só isso. A **N1** acrescenta as diárias de UTI por saída, padronizadas, que são o desconto de gravidade; a **N4**, a razão entre a mortalidade observada e a esperada pelo perfil de procedimentos; a **N8**, a fração de internações cirúrgicas. A última linha acrescenta as três ao mesmo tempo. **O cálculo da fronteira é o mesmo nas cinco leituras**: o que muda de uma linha da grade para a outra é o que entra na conta que compara as redes, depois de a nota já estar estimada.

Uma ressalva acompanha a fração de cirurgias. Operar mais pode ser sinal de eficiência ou de mistura de casos, e as redes diferem bastante nisso, de modo que descontar essa fração absorve parte do próprio contraste que a grade quer medir. **Por isso ela é reportada e não governa**: a leitura que a Subseção 3.4 afirma continua sendo a primeira linha da grade.

G Método e ressalvas da Seção 2

A Seção 2 avalia a Tabela SUS Paulista com um bloco alcançado e dois conjuntos de comparação. Este apêndice traz o método dessa avaliação e as ressalvas que ela impõe: quem está de cada lado e por quê, o que sustenta cada número publicado lá, e o que esta base não consegue responder.

G.1 Quem a tabela alcança, e contra quem a Seção 2 compara

O bloco alcançado pela tabela são os 159 hospitais filantrópicos do painel, e a razão de serem eles é de mecanismo: é a rede que fatura produção pela tabela de procedimentos, e é por esse canal que uma tabela de pagamento a alcança. **Não é uma lista nominal da Secretaria**, que esta pesquisa não tem: é a rede inteira, e o texto diz isso em vez de sugerir uma precisão que a fonte não dá.

A categoria universitária fica fora desta avaliação, dos dois lados: sem saber quais hospitais de ensino a tabela alcança, o grupo não pode ser lido nem como alcançado nem como comparação, porque as duas leituras dependem exatamente do que não se sabe. O caso que decidiu isso está logo abaixo. O recorte que fecha aquela seção inclui a categoria por outro critério, resolvendo *por nome* os dois hospitais que decidiram a questão.

O primeiro conjunto de comparação são as redes de orçamento global. Os hospitais geridos por organizações sociais e os de administração direta são custeados por contrato com orçamento global, e não por reembolso de internação. Uma tabela que remunera procedimento não os alcança pelo mesmo caminho por onde alcança quem fatura produção, e é isso que os torna termo de comparação. É também a razão pela qual eles entram como *conjunto*, sem que nenhuma das duas redes sirva de referência sozinha.

O segundo conjunto de comparação não é de mecanismo: é o que a regra do programa exclui. Os hospitais **municipais** ficaram de fora da primeira versão da tabela, que cobria filantrópicos e Santas Casas, e só foram incluídos por decreto de maio de 2026, com a primeira parcela paga em setembro daquele ano. **Dentro da janela deste painel, que termina em 2025, eles nunca foram alcançados**, e isso é regra escrita do programa, e não inferência sobre como o dinheiro circula. **É o conjunto de comparação com a justificativa mais forte que esta avaliação tem**, e a distância entre o que os dois conjuntos dizem é, ela própria, um resultado.

G.2 Por que a categoria universitária sai da avaliação

O que decidiu foi um par de hospitais. O Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Universitário da USP serviam de contraprova, e não servem: a Secretaria de Estado da Saúde publica a Unicamp em **segundo lugar** entre as dez instituições que mais aumentaram internações sob a tabela, com 8.818 internações a mais e R$ 86,9 milhões recebidos, de modo que ela é **alcançada** pela tabela; o que lhe faltou em 2025 foi pagamento, e não cobertura. A situação do Hospital Universitário da USP não está estabelecida em fonte alguma. **Com um dos dois confirmadamente alcançado e o outro por estabelecer, qualquer movimento da dupla admite as duas leituras opostas**, e por isso ela não sustenta argumento nenhum daquela seção, em direção nenhuma.

E o que vale para a dupla vale para a categoria. Se não se sabe quais hospitais de ensino a tabela alcança, o grupo não pode ser lido nem como alcançado nem como comparação, porque as duas leituras dependem exatamente do que não se sabe. **A categoria sai dos dois lados da avaliação**, e o que sobra é uma avaliação com um bloco alcançado e dois conjuntos de comparação, cada um com a sua justificativa.

Um recorte próprio parte exatamente de onde este parágrafo para. A Subseção 2.3 resolve os dois hospitais *por nome*, em vez de depender do que a categoria toda tem em comum, e por isso pode incluí-los sem contradizer o que se acabou de dizer. Ela não substitui o bloco daquela avaliação, e o resultado dela é o que justifica os dois viverem lado a lado: acrescentar os universitários não muda a leitura.

G.3 O que sustenta cada número

Duas verificações independentes sustentam o resultado do volume, e uma terceira o qualifica. A primeira é a condição de leitura: contra as redes de orçamento global, **as trajetórias anteriores ao marco são paralelas**, e é o único desenho daquela seção em que essa condição se verifica em vez de se supor. A segunda é aritmética: **a identidade contábil fecha**, e a decomposição do faturamento em volume e valor por saída soma exatamente o que se mede em cada um. Some-se a elas a resistência a um hospital do lado alcançado: tirando um dos 159 por vez, a diferença fica entre **12,0% e 13,5%**, sem exceção.

A condição de leitura, por extenso. A reta ajustada aos anos anteriores a 2024 fica praticamente plana na produção e no faturamento, e em nenhuma das duas ela se separa de uma reta horizontal. **É a condição que falta em todos os outros indicadores daquela seção**, e é o que separa este resultado dos demais.

E a alta complexidade é lida em contagem, e não em fração. A contagem responde quantos casos o hospital fez; a fração responde que parte do que ele fez era de alta complexidade. **Com o volume do bloco crescendo, uma produção que sobe muito aparece na fração como movimento de quase nada**, e foi por isso que a medida mudou ali. A Seção 1, a estimação e a distância até a melhor prática continuam com a fração, e os dois números não são comparáveis entre si.

A identidade contábil, por extenso. Fora do biênio de pandemia o painel não tem procedimento de covid, e por isso vale uma identidade simples: **o faturamento do ano é a produção multiplicada pelo faturamento por saída**. Medidos os três na mesma amostra, os efeitos se somam, e a soma foi conferida.

A qualificação do conjunto de comparação, conjunto a conjunto. Medida contra os hospitais geridos por organizações sociais, a diferença de 2025 nos filantrópicos é de **11,1%**; contra a administração direta, de **8,4%**; contra as duas juntas, de **10,0%**. A de 2024 fica entre **1,7% e 3,4%** nessas três leituras, e só se separa do acaso na comparação com as organizações sociais.

E o resultado não depende de um hospital de comparação. Tirando um por vez, os 55, a diferença de 2025 fica entre **8,6% e 10,7%**, e em nenhuma das cinquenta e cinco reestimações ela deixa de se separar do acaso.

E há uma segunda razão para não ler produtividade naquela conta, e ela é aritmética. O denominador se move: **73 dos 275 hospitais do painel** variam os seus leitos SUS em quinze por cento ou mais entre o período anterior ao marco e o posterior. **Congelando o leito de cada hospital no valor de 2023, a produtividade devolve exatamente o resultado do volume**, que é **2,7% em 2024 e 10,0% em 2025**, porque com o denominador parado a produtividade é o volume. **E a diferença entre os dois números diz para que lado o denominador andou**: o volume sobe 10,0% e a produção por leito sobe 6,7%, o que quer dizer que os leitos SUS do bloco alcançado cresceram em relação aos das redes de comparação. **Os 73 hospitais variam capacidade para os dois lados**, e ler a dispersão deles como encolhimento seria ler o sinal trocado.

G.4 O que esta avaliação não consegue dizer

Esta parte reúne as ressalvas de método da Seção 2, e elas estão aqui, e não no meio de cada resultado, por decisão de leitura: quem quer a resposta a lê antes, e quem quer o método o encontra junto.

O canal financeiro pelo qual a tabela agiria não é observável nesta base, e essa é a limitação central. O complemento estadual é pago por **convênio**, com recursos do Tesouro estadual, por fora da tabela federal que o registro de internação traz. O valor por internação que esta base enxerga não se move, por mais que a receita do hospital mude. Não é um resultado sobre a política: é o limite do que uma base de internações consegue enxergar de uma mudança de financiamento que não passa pelo campo que ela registra.

E o tamanho desse caminho está documentado. O Estado repassou por ele **R$ 4,3 bilhões em 2024**, oitenta por cento a mais do que no ano anterior. **Nenhum resultado daquela**

seção pode ser lido como resposta a um preço que se possa medir aqui, porque o preço que mudou não está medido aqui.

A tabela não cobriu o mesmo conjunto nos dois anos, e isso muda a leitura da data. Ela nasceu alcançando pouco mais de uma centena de instituições e passou de **setecentas** no ano seguinte. Um bloco que só reage no segundo ano e um bloco que só foi alcançado no segundo ano produzem exatamente o mesmo desenho numa série anual. Separá-los exigiria saber em que mês cada hospital entrou, e esta base não traz o mês.

O marco é de janeiro e o dado é anual. A origem traz uma linha de resumo por hospital e por ano, sem campo de mês, e o mesmo vale para os registros de internação que sustentam o perfil de atendimento. O período anterior tem nove anos e o posterior tem dois. **Não existe, com estes dados, teste de salto em janeiro.** O que existe é a pergunta de se 2024 e 2025 se descolam da trajetória que cada hospital já vinha desenhando.

O tamanho do resultado do volume depende de contra quem se compara, e a faixa é larga. Percorridos os oito conjuntos de comparação possíveis, o resultado de 2025 vai de **5,9% a 11,1%**, e **separa-se do acaso em cinco dos oito**. Os três em que não separa são a administração Direta estadual sozinha, com **8,4%**, a administração Direta somada à de titularidade municipal, com **6,0%**, e os hospitais de titularidade municipal, com **5,9%**. Estes últimos são o grupo de comparação mais limpo da avaliação, porque a regra do programa os deixou de fora até 2026, e **contra eles a trajetória anterior ao marco também é plana**: o desenho é válido e devolve um resultado mais fraco.

Dois desses conjuntos existem para responder a uma pergunta sobre a norma, e vale dizer qual. A resolução que institui a tabela define o universo dela como os estabelecimentos da rede complementar, conveniados ou contratados, e **não nomeia as organizações sociais**: hospital estadual sob contrato de gestão é rede própria do Estado, e não rede complementar. **Se essa leitura estiver errada e as organizações sociais também forem alcançadas**, elas teriam de sair da comparação, e o que resta são a administração Direta estadual mais os hospitais de titularidade municipal. Contra esse conjunto o resultado de 2025 é de **6,7%**, ele se separa do acaso e **a trajetória anterior ao marco é plana**. **O achado do volume sobrevive às duas leituras**, e o que muda entre elas é o tamanho.

As duas redes de orçamento global entram como conjunto, e a razão é esta. Contra as organizações sociais a trajetória anterior ao marco é plana e o degrau de 2025 se sustenta; contra a administração direta ela não é, e corre a **2,4% ao ano** em favor dos filantrópicos. **A administração direta é a única rede que internou menos em 2025 do que em 2015**: ela estava **13%** acima do seu próprio nível de 2023 em 2015 e está **6%** acima em 2025. Um conjunto de comparação que encolhe ao longo da série não separa degrau de tendência.

E a trajetória plana do conjunto é a média de duas que correm em sentidos contrários. Contra as organizações sociais a trajetória anterior ao marco corre a **0,5% ao ano** em favor delas, e contra a administração direta corre a **2,4% ao ano** em favor dos filantrópicos; postas no mesmo conjunto, as duas devolvem os **0,6% ao ano** que autorizam a leitura. **Plana por compensação não é o mesmo que paralela**, e o mesmo vale para o conjunto que junta a administração Direta estadual aos hospitais de titularidade municipal.

A trajetória anterior ao marco não é plana no preço, e é por isso que a metade de preço da decomposição não sustenta leitura causal. O valor por saída dos hospitais filantrópicos vinha caindo em relação ao das redes de comparação ao longo de toda a série, e 2023, que é a base, é o ponto mais baixo dessa queda. **Um degrau medido contra o fundo de uma trajetória descendente não se distingue de uma volta ao patamar anterior.** No volume acontece o contrário, e as trajetórias anteriores **são paralelas**: é essa diferença que autoriza ler um e não o outro.

A produtividade por leito já vinha subindo antes da tabela, e é isso que impede lê-la como resposta a ela. A reta ajustada aos anos anteriores a 2024 sobe **1,68% ao ano** em favor dos hospitais filantrópicos, e a condição que autoriza ler um degrau é justamente que essa reta seja plana. **O mesmo vale para a taxa de ocupação**, que vinha subindo **0,70 ponto ao ano**.

Nos dois casos o movimento de 2025 existe e é grande; o que não existe é o desenho que o atribua à tabela.

O teste de marco falso chega à mesma conclusão por outro caminho. Ele consiste em repetir o exercício inteiro fingindo que a tabela entrou em vigor num ano em que nada aconteceu, **usando apenas os anos anteriores a 2024**, e ele corre na conta que junta todo o período anterior num bloco só, e não na que a Subseção 2.2 publica. Repetido com a tabela entrando em 2019, o resultado é **7,9% acima**; com ela entrando em 2022, **11,8% acima**. Os dois **marcos falsos** encontram o que o marco verdadeiro encontra, e o de 2022 encontra mais. O que o exercício mede não é a tabela: é uma trajetória de recuperação de produtividade que já corria antes dela, e que qualquer ano escolhido como marco teria capturado igual. **O mesmo teste aplicado ao volume de internações não derruba o resultado**, e é essa diferença de comportamento entre os dois indicadores que dá crédito ao que resta.

A cirurgia tem a mesma fronteira que o volume, e ela precisa ser dita. Medida contra os hospitais de titularidade municipal, a diferença de 2025 é de **9,4%** e é grande o bastante para ser afirmada; **a trajetória anterior ao marco, porém, não é plana ali**, e corre a **1,8%** ao ano *contra* os hospitais filantrópicos, que vinham perdendo terreno para os municipais ao longo de toda a série anterior. O desenho não identifica o efeito contra esse conjunto, e o que a subseção anterior afirma da cirurgia vale contra as redes de orçamento global.

E a produtividade por leito não se comporta do mesmo jeito nos dois conjuntos de comparação. Contra as redes de orçamento global a trajetória anterior sobe, e por isso o degrau de 2025 não se lê. **Contra os hospitais de titularidade municipal a trajetória anterior das saídas por leito é plana**, e corre a **0,59%** ao ano, com o degrau de 2025 em **10,4%** e grande o bastante para ser afirmado. **É a única leitura desta seção em que o conjunto de comparação mais limpo devolve um resultado mais forte do que o conjunto por mecanismo**, e é o contrário do que acontece com o volume.

Esta avaliação não afirma esse resultado, e a razão é que falta um teste. O marco falso que derruba a produtividade **não foi rodado contra os hospitais de titularidade municipal**: ele corre sobre os hospitais filantrópicos e as redes de orçamento global, e é contra estas que ele derruba. **Afirmar a leitura municipal exigiria submetê-la ao mesmo teste que derrubou a outra**, e enquanto ele não existir o que fica registrado é a leitura, e não o veredito.

Nos outros dois indicadores a comparação municipal não acrescenta nada, e vale dizer que foi olhada. A produção de alta complexidade dos hospitais filantrópicos fica **abaixo** da dos municipais em 2025, e a diferença é pequena demais para ser afirmada; a taxa de ocupação fica **2,44 pontos** acima, e também não se separa do acaso. **Nos dois a trajetória anterior ao marco é plana**, de modo que o desenho vale e o que ele devolve é ausência de movimento.

E a contagem agregada tem um limite próprio, que precisa ser nomeado. O reajuste de alta complexidade da tabela se concentra em **ortopedia**, e os sete códigos de **cuidados prolongados** que a resolução levou a R$ 235,00 são de **média** complexidade no registro de internação. **Nenhum dos dois pode aparecer numa contagem de alta complexidade**, por construção e não por ausência de efeito. O desenho que os alcança é por código de procedimento dentro do mesmo hospital, e ele espera os anexos das duas resoluções.

Os anos de pandemia ficam fora da leitura principal. A queda de 2020 e a recuperação de 2021 são grandes o bastante para dominar qualquer contraste de período, e mantê-las faria toda unidade parecer ter respondido ao marco. **No volume e no faturamento a variante que as mantém foi rodada, e ela não move o resultado**: a diferença de 2025 fica nos mesmos **10,0%** e **13,3%**. **Nos dois indicadores medidos em contagem essa variante não existe**, porque os dois anos são descartados antes da estimativa, e por isso nada do que a seção afirma deles depende de tê-los mantido ou não.

Três levantamentos fecham exatamente o que esta base deixa aberto, e vale nomeá-los com precisão para que o campo não volte com outra coisa: o **mês** em que cada unidade passou a receber pela tabela, o **valor** do convênio que ela recebeu em cada ano, e o **teto contratual** que esse valor comprometeu. **O primeiro é o que separa decisão que demorou de cobertura que chegou depois**, porque com o mês de entrada o desenho deixa de tratar todos os hospitais

como alcançados na mesma data. **O segundo troca presença por intensidade**, e faz a avaliação perguntar quanto se recebeu em vez de se recebeu. **O terceiro é o que distingue quem ampliou produção de quem esbarrou no próprio teto**, que é a explicação mais citada e a menos documentada.

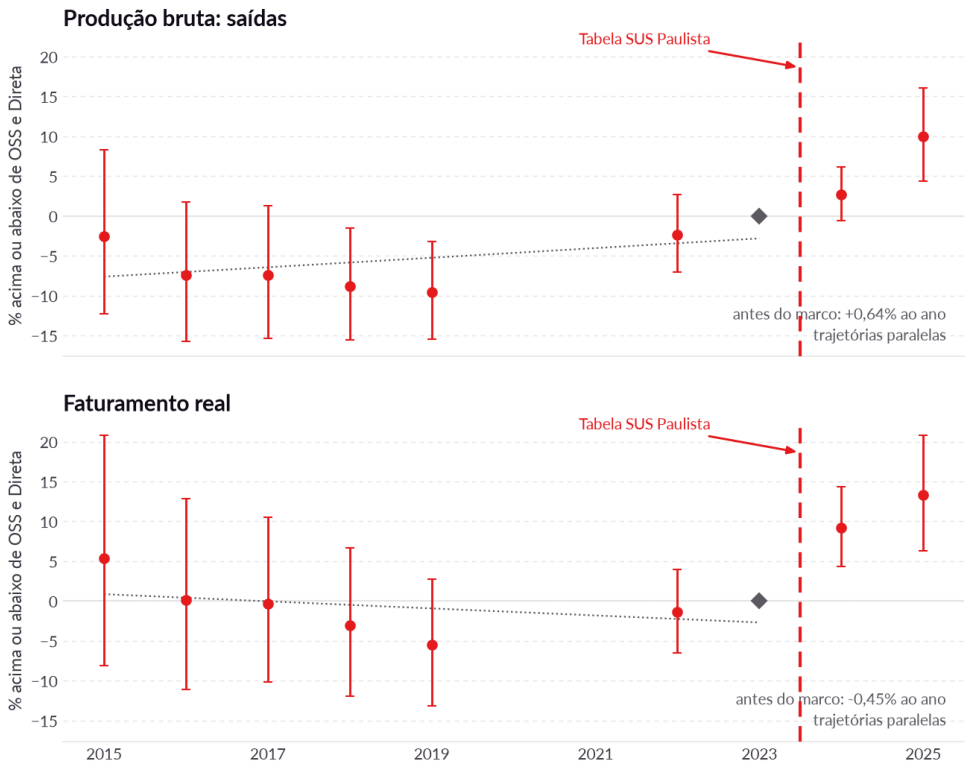
O segundo desses três é também o que falta para fechar o recorte próprio. O **valor agregado repassado** pela tabela a cada hospital do recorte vem do banco do revisor, e não está no repositório. **A estrutura para recebê-lo está pronta**, na aba própria da planilha de entrega, com a célula marcada como aguardando o dado em vez de vazia ou preenchida por estimativa.

O bloco alcançado desta avaliação é definido por rede, e não por lista nominal, e a razão é de acesso. A Secretaria de Estado da Saúde mantém painel próprio com os valores pagos por instituição, e o acesso a ele passa por autenticação que esta pesquisa não tem. **O mês de entrada de cada unidade não consta de nenhuma fonte pública localizada**, e é por isso que a distinção entre resposta tardia e cobertura tardia continua aberta.

G.5 O desenho de comparação, por extenso

Esta subseção reúne o que a Seção 2 deixou de publicar no corpo enquanto o dado de repasse por hospital não chega. O que está aqui é o desenho de comparação: a conta que estima a distância entre o bloco alcançado e os conjuntos de comparação, a decomposição que se apoia nela e as verificações que a cercam. **O corpo ficou com o que os hospitais fizeram, e com a régua de comparação ao lado de cada número**; aqui fica o que autoriza, ou não, ler aquela distância como efeito.

O crescimento é degrau ou continuação de tendência? É a pergunta que decide a leitura, e ela tem resposta.



Cada ponto é a distância entre os hospitais filantrópicos e os de orçamento global naquele ano, tomando 2023 como partida. A reta pontilhada é a tendência ajustada aos anos anteriores ao marco.

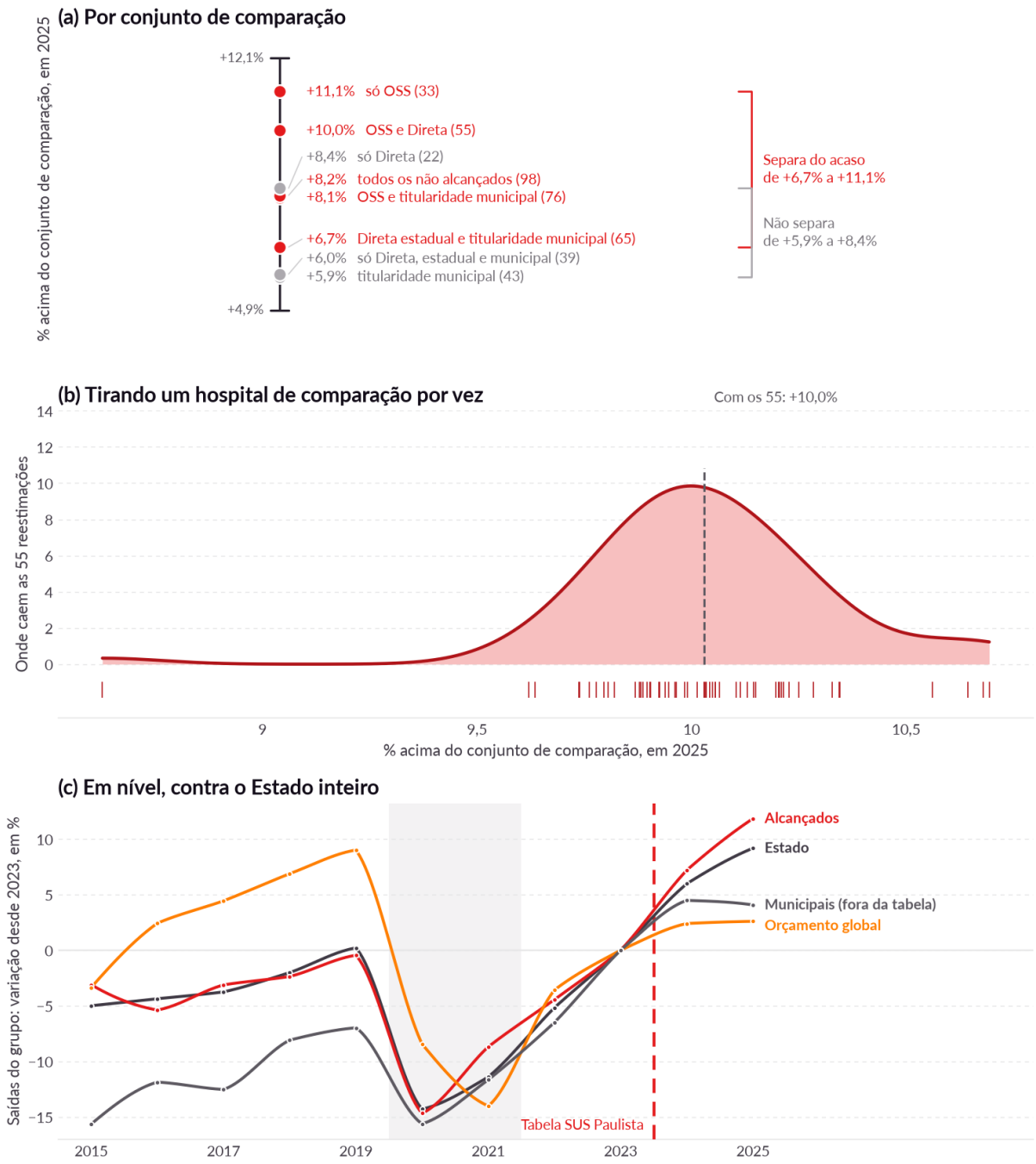
Figura G.1: A produção bruta e o faturamento real dos hospitais filantrópicos contra as redes de orçamento global, ano a ano, tomando 2023 como ponto de partida, com a tendência anterior ao marco ajustada em cada painel. Cada ponto é um ano e mede a distância entre os hospitais filantrópicos e as redes de orçamento global. O losango de 2023 está em zero por construção. Ponto **acima** da linha é bloco que internou ou faturou mais em relação a 2023; abaixo, menos. As barras dizem quanta imprecisão há em cada ano. **A reta pontilhada é a tendência ajustada aos anos anteriores ao marco**: plana quer dizer que os grupos vinham paralelos, e o que aparece depois do tracejado é movimento novo; inclinada quer dizer que o afastamento já corria. A distância de cada ano compara cada hospital consigo mesmo ao longo do tempo, descontando o que é comum a todos naquele ano. A imprecisão é agrupada por hospital. **A tendência anterior é a reta ajustada aos coeficientes dos anos que antecedem o marco**, e o que se testa nela é a inclinação.

As trajetórias anteriores ao marco são paralelas, nos dois indicadores, e é isso que autoriza ler o que vem depois. É o único desenho desta seção em que a condição de leitura se verifica em vez de se supor.

O volume não dá degrau no ano do marco: ele dá no ano seguinte. Em 2024 os hospitais filantrópicos estão **2,7% acima** das redes de comparação, e essa diferença não se separa do acaso; em 2025 estão **10,0% acima**, e essa se separa. **O faturamento se comporta de outro jeito**: sobe **9,2% já em 2024** e **13,3% em 2025**, e os dois se separam.

O que subiu foi preço ou volume? A conta fecha, e a resposta muda entre os dois anos: em 2024 o que subiu foi sobretudo o valor de cada saída, e em 2025 foi sobretudo o número de saídas. Os 9,2% de 2024 se repartem em **2,7% de volume e 6,3% de valor por saída**; os 13,3% de 2025 se repartem em **10,0% de volume e 3,0% de valor por saída**. **A leitura de gestão é direta**: o primeiro ano aparece como internação mais bem paga, o segundo como internação a mais.

A metade de volume dessa conta é a que sobrevive ao teste que autoriza a leitura, e a metade de preço não sobrevive. A primeira vem de trajetórias anteriores paralelas e se lê como movimento novo; a segunda vem de um valor por saída que vinha caindo em relação ao das redes de comparação ao longo de toda a série, e por isso **fica registrada como descrição, e não como efeito da tabela**.



Em (a) e (b) o ponto e a curva são a distância entre o bloco alcançado e o conjunto de comparação em 2025, tomando 2023 como partida. Em (c) cada linha é a soma das saídas do grupo no ano.

Figura G.2: A robustez do resultado de volume: por conjunto de comparação, tirando um hospital por vez, e em nível contra o Estado inteiro. Três verificações do mesmo resultado. Em **(a)**, a distância de 2025 contra cada conjunto de comparação: **barra escura separa-se do acaso, barra clara não**. Em **(b)**, a mesma distância tirando um hospital de comparação por vez, com a tracejada no valor com todos dentro. Em **(c)**, as saídas de cada grupo em variação desde 2023, e o Estado inteiro na linha escura. O painel (c) soma as saídas de cada grupo em cada ano, e a linha do Estado soma as de todos os hospitais paulistas presentes nos onze anos. **A rede de cada hospital é a de 2023 e não muda ao longo da série**: sem isso, quem troca de rede levaria a produção de uma linha para a outra e a troca de rótulo apareceria como perda de volume.

E medida contra os hospitais de titularidade municipal, que a regra do programa manteve de fora durante toda a janela, a diferença não se sustenta. Em 2024 ela é de **0,6%** e em 2025 de **5,9%**, e nenhuma das duas se separa do acaso. **Este é o conjunto de comparação**

com a justificativa mais forte que a avaliação tem, porque a exclusão dele vem da norma do programa e não de um argumento sobre como o dinheiro circula.

A leitura honesta disso não é que a tabela não teve efeito. É que os hospitais de titularidade municipal também internaram mais em 2024 e 2025 sem receber pela tabela, e um crescimento que aparece nos dois lados não pode ser creditado ao que os separa. **O que a série anual permite dizer é que o volume cresceu no Estado, que o crescimento é maior em quem a tabela alcança, e que a diferença entre os dois grupos que a norma de fato separa é pequena demais para ser afirmada.**